

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

ИСТОРИЯ СТОМАТОЛОГИИ
Учебное пособие
для самостоятельной внеаудиторной
работы студентов

УФА
2014

УДК 616.31(09)(07)
ББК 56.6г я7
И 90

Рецензенты:

К.м.н., доцент, заведующий кафедрой общественного здоровья и здравоохранения ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава России *М.Л. Сиротко*

К.м.н., доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения ГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России *Ю.Н. Панфилова*

И 90 История стоматологии: Уч. пос. для самостоятельной внеаудиторной работы студентов / Н.Х. Шарафутдинова, А.У. Киньябулатов, М.Ю. Павлова. – Уфа: Изд-во ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России, 2014. – 258 с.

Учебное пособие подготовлено в соответствии с типовой программой дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение» (2005 г.), на основании рабочей программы (2008 г.), действующего учебного плана (2000 г.) и в соответствии с требованием государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования (2000 г.) по специальностям: 060101(65) лечебное дело, 060103(65) педиатрия, 060104(65) медико-профилактическое дело, 060105(65) стоматология, 060109(65) сестринское дело.

Необходимость издания пособия обусловлена происходящими процессами реформирования здравоохранения. В этой связи в данном пособии систематизированы и обобщены материалы по истории стоматологии России, СССР, Республики Башкортостан, представлены методы исторического и биографического анализа. В учебном пособии излагается информационный блок, даны контрольные вопросы, тесты, список основной и дополнительной литературы.

Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальностям 060101(65) — лечебное дело, 060103(65) — педиатрия, 060104 (65) — медико-профилактическое дело, 060105(65) — стоматология, 060109(65) — сестринское дело.

Рекомендовано в печать по решению Координационного научно-методического совета и утверждено решением Редакционно-издательского совета ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России.

УДК 616.31(09)(07)
ББК 56.6г я7

© ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России, 2014

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	4
1. Зубоврачевание в Киевской Руси (XI – XIII вв.) и Московском государстве (XV – XVII вв.).....	5
2. Зубоврачевание в России в XVIII веке.....	10
3. Зубоврачевание в России в XIX веке.....	16
4. Стоматология XX века.....	42
4.1. Становление и развитие стоматологии.....	42
4.2. Подготовка специалистов стоматологического профиля — зубных врачей и врачей-стоматологов.....	68
4.3. Подготовка зубных техников.....	77
4.4. Научные проблемы стоматологии XX века.....	80
4.4.1. Терапевтическая стоматология.....	80
4.4.2. Хирургическая стоматология.....	103
4.4.3. Ортодонтия.....	129
4.4.4. Ортопедическая стоматология.....	153
4.4.5. Профилактика в стоматологии.....	196
5. Медицинское обслуживание населения и зубоврачевание в Башкирии до 1917 г.....	195
6. Развитие стоматологической службы в Башкирской АССР (Республики Башкортостан) с 1917 года.....	201
Заключение.....	213
Контрольные вопросы.....	239
Тестовые задания.....	245
Эталоны ответов.....	255
Рекомендуемая литература.....	257

ВВЕДЕНИЕ

В нашей стране всё большее значение придаётся развитию специализированной медицинской помощи населению, и, в частности, развитию стоматологической помощи. История развития стоматологической помощи Республики Башкортостан неразрывно связана с историей развития Уфимской и Оренбургской губерний.

Учитывая высокую распространённость заболеваний органов полости рта, в Российской Федерации расширяется сеть стоматологических учреждений, открываются специализированные учебные заведения, факультеты и курсы для подготовки квалифицированных кадров врачей-стоматологов.

Большим событием в развитии стоматологии Республики Башкортостан явилось открытие в 1976 году стоматологического факультета Башкирского государственного медицинского института имени 15-летия ВЛКСМ (с 1995 году — Башкирский государственный медицинский университет) и в 2011 году Научно-исследовательского института стоматологии Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ).

Ведущими стоматологами Республики Башкортостан совместно с БГМУ и Министерством здравоохранения Республики Башкортостан проводится значительная работа по становлению и организации стоматологической помощи. Проводится также и научно-исследовательская работа по изучению распространённости стоматологических заболеваний на территории республики, организации профилактики и лечения болезней полости рта и лица. Широко проводится диспансеризация и комплексное лечение больных с наиболее часто встречающейся и тяжёлой врождённой и приобретенной патологией челюстно-лицевой области, разрабатываются новые формы организации, совершенствуются методы оперативных и ортопедических вмешательств при различных тяжёлых заболеваниях и т.д.

В настоящем учебном пособии приведены основные исторические и биографические данные по истории стоматологии Российской Федерации и Республики Башкортостан.

1. ЗУБОВРАЧЕВАНИЕ В КИЕВСКОЙ РУСИ (XI–XIII ВВ.) И МОСКОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕ (XV–XVII ВВ.)

Славянские племена (восточные славяне) с VI века расселялись на восточно-европейской равнине, которые в IX веке объединились в феодальное государство – Киевскую Русь, игравшую выдающуюся роль в политической и культурной жизни Европы того времени. Составной частью феодальной надстройки Киевской Руси, в конце X–XI веков, было христианство (988), которое приняло врачевание под свое непосредственное покровительство. Святой Антипа — единственный святой, исцеляющий зубные боли. При веровании в высшие силы главными способами лечения были молитвы, заговоры, заклинания. Примером такого лечения может быть заговор от зубной боли: «Как земляника эта засыхает и завядает, так чтобы у раба божия зубы замирали и занемели, чтобы черви и пути занемели, по сей день, по сей час».

Древнеславянские заговоры являются истинными корнями русской народной медицины. В заговорах часто болезнь сметается веником, лечится омовением водой, встречается образ чудесного мужа, который стрелами отгоняет всякие болезни. Иногда в этой же роли выступает сам Христос со святыми. В заговорах от зубной боли постоянно говорится о месяце в небе: «Месяц ты месяц, серебряные рожки, золотые твои ножки. Сойди ты, месяц,ними мою зубную скорбь. Унеси боль под облака. Моя скорбь ни мала, ни тяжка, а твоя сила могуча. Вот зуб, вот два, вот три. Все твои, возьми мою скорбь».

Очень распространено было лечение при помощи дерева. Дереву можно передать свою болезнь или, наоборот, получить от него силу, особенно часто прибегали к дубу. При зубной боли отыскивали в лесу старый дуб, рядом с которым били ключи, сдирали с его веток кору и, вымочив ее в роднике, носили в ладанке. При зубной боли грызли дерево. Причиной «гниения зубов» или «червоточины» народные врачеватели, кроме сверхъ-

естественных сил, считали наличие «червя», простуду (Н.П. Александров, 1997). Поэтому при лечении зубов прибегали как к молитвам, так и к лекарственным средствам растительного, животного и минерального происхождения. Иногда боль снимали кровопусканием, применением слабительных средств.

Врачеванием занимались, как народные врачеватели — лечцы, так и врачи-профессионалы — лекари. Зубную боль утоляли знахари, цирюльники, коновалы. Специальных медицинских книг от Киевской Руси до нас не дошло, но их существование вполне вероятно. Травники и лечебники, которые появились с началом письменности, были обобщением опыта народных врачевателей. Внучка Владимира Мономаха Евпраксия Зоя, вышедшая в 1122 году замуж за византийского императора, изучая медицину по трудам Гиппократу, Ибн-Сины и др., написала трактат по медицине под названием «Мази госпожи Зои-царицы», состоящий из пяти разделов: «Гигиена вообще», «Гигиена брака, беременной и новорожденного», «Гигиена питания», «Наружные болезни», «Внутренние болезни». В трактате имеются сведения и по зубоврачеванию: описывается прорезывание зубов у младенцев и меры, которые при этом необходимо принимать, лечение зубной боли, даются советы по устранению запаха изо рта, приводятся методы лечения различных заболеваний полости рта.

Примером таких советов служат следующие: «...когда у ребенка начнется рост зубов, пусть ему намажут места вырастания зубов маслом из левкоев и воском или пусть натрут животным маслом, чистым и свежим, смешанным с сахаром», «...если же случится во рту и на языке жжение и жар, то, взяв три драхмы очищенной чечевицы, две драхмы сухих роз, по три драхмы сухого кориандра, семян портулака и шампиньона, половину драхмы камфары и растерев хорошо, сделай подобие дорожной пыли и натри во рту и на языке», «...для того чтобы сделать зубы белыми, возьми по две драхмы жженных отрубей и белой соли, все это растерев хорошо, натри зубы», «...при качающихся зубах возьми по две драхмы клещевины,

квасцов и кожуры гранатов, все это растерев и перемешав, натри корни зубов; воздерживайся от всякой очень острой пищи, от разгрызания миндаля, грецких орехов и фундука», «...при дурном запахе изо рта, растерев руту, положи ее в инжир и, изжарив, дай есть очень горячим», или «при дурном запахе изо рта следует жевать блошиную мяту или семена сельдерея или куманики, листья винограда или душистое вино», даны рекомендации по лечению «съеденных зубов», «дряхлых десен и при кровоточащих зубах, при качающихся зубах, дурно пахнущих, гниющих и при всяком другом страдании зубов: разотри с вином рог оленя, затем обмажь кругом шатающийся зуб и он перестанет качаться», «средство при сильнейших зубных болях: дикого винограда, перца, колотых квасцов, смолы — все это измельчить и принимать с виноградом без косточек и обмазывать кругом зубы». «При качающихся зубах и причиняющих боль: квасцы колотые и корни мыльнянки растереть и держать во рту, пока боль не уймется или раскалить железо на огне, окунуть в уксус и этот уксус держать во рту и им полоскать. При болезни полости рта, при воспалении глотки растереть листья оливы и залить растительным маслом и смазывать. При потрескавшихся губах измельчить клещевину, смешав с медом — намазывать», еще «... при трещинах на губах или на лице: олений мозг, мастику, растительное масло, белый воск смешав, намажь — испытанное».

Трактат Евпраксии Зои хранится во Флорентийской библиотеке Лоренцо Медичи, а микрофильм рукописи, полученный в 1955 году профессором Б.Д. Петровым, переведен и находится в Российской государственной библиотеке.

С образованием Московского государства, в особенности с начала XVI века, отмечается заметное развитие медицины. Войны, экономические и политические изменения способствовали возникновению зачатков государственной медицины.

Открытие Аптекарского приказа (1620), высшего государственного медицинского учреждения, которое осуществляло руководство всем меди-

цинским и аптечным делом в России, положило начало государственной организации здравоохранения. Документы Аптекарского приказа хранятся в Центральном государственном архиве древних актов (ЦГАДА, ф. 143). В штат Аптекарского приказа входили доктора, лекари, цирюльники, аптекари, лекарские ученики, травники, зелейники, алхимики, переводчики. Докторами назывались лица, получившие высшее медицинское образование в заграничных учебных заведениях и лечившие внутренние болезни. Лекари занимались хирургическими операциями и лечением наружных болезней. В документах это различие выражено следующим образом: «... дохтур совет дает и приказывает, а сам тому неискусен. А лекарь прикладывает и лекарством лечит, и сам ненаучен». Цирюльники занимались хирургией, так как лечили «раны сеченые и стреляные, и колотые и нечистую болезнь». Медицинская помощь оказывалась в первую очередь царской семье и только в отдельных случаях служилым людям и членам их семей. Среди докторов было много иностранцев, приезжавших в Россию без знания языка, иногда и без всяких знаний, основной целью многих из них было стремление обогатиться. Основная масса населения пользовалась услугами народных врачей.

Значительная часть документов Аптекарского приказа отражает уровень медицинских знаний XVII века. К таким документам относятся «сказки» докторов и лекарей об освидетельствовании больных и раненых и способах их лечения. Чаще всего упоминается лечение, в том числе и зубной боли, с помощью лекарственных средств растительного происхождения: «... корень деветильник белый, растет на лугах, годен будут, у кого зубная боль и пухнут десны, и того корня малую часть на зубах держать».

В XVII веке появились сведения о челюстно-лицевых ранениях военного времени. В Аптекарский приказ направлялись списки пострадавших с указанием характера ранения, вида оружия, которое было при этом применено. Сохранились записи с описанием таких ранений. Данные 1645 года: «Драгун Фатюшка Денисов ранен в левую бровь, а пулька в нем»,

«Карп Нагибин ранен в правую щоку из ружья», «Мишка Иванов сечен саблею по шее», «Якимка Фадеев ранен в голову — рублен саблею возле левое ухо», «Гришка Афанасьев ранен саблею, отрублен нос и верхние губы и зубы передние рана тяжела», «Ивашка Андронов ранен в голову: пушечным ядром переломило висок левой в трех местах. Раны тяжелы», «Алешка Федотов ранен: опалило лицо из пушки и нос сшибло». Раненых осматривали, диагноз как таковой отсутствовал, выделяли симптомы и назначали симптоматическое лечение, которое включало: накладывание компрессов на раны, повязок с мазями, извлечение инородных предметов из ран, вправление вывихов, лечение переломов, кровопускание, а также лечение травами, лекарственными средствами животного и минерального происхождения.

В документах Аптекарского приказа за 1692 год сохранилась опись медицинских инструментов, по которой можно судить о характере хирургических операций: «ланцеты кровопущанные», «клещи», «буравы», «ножницы двойные, что раны разрезают», «пилы, что зубы трут» и др.

Хирургические операции в XVII веке получили довольно широкое распространение, особенно в связи с необходимостью оказывать помощь раненым на местах военных действий. В армии бывали случаи массового заболевания цингой, что вызывало необходимость принимать меры по борьбе с ней. Поэтому в специальной царской грамоте, направленной в 1672 году князю А.А. Голицину в Казань, для лечения цинги предлагалось: «... изготовить двести ведер сосновых вершин, намоча в вине, да в Нижнем Новгороде изготовить сто ведер, и послать то вино в Астрахань, и давать то вино в Астрахани служилым людям от цинги». В военных гарнизонах обычным делом была раздача всем чинам противцинготных средств, которые способствовали оздоровлению и лечению воинов: солод, пиво, винный уксус, сбитень.

Медицинскую помощь оказывали врачи, приглашенные из-за границы, и выпускники Лекарской школы (с 1654 г.), а также различные народ-

ные врачеватели: зелейники, травники, рудометы (кровопуски), зубоволоки, костоправы, камнесечцы, повивальные бабки, мастера очных, кильных дел и др. «Зубоволоки» умели накладывать на «червоточину» в зубах пломбы, укреплять зубы проволочными «шинами», удалять зубы с использованием «пеликанов», «ключей» (козья ножка), «дандагмы» (разновидность одонгагры). Все это подготовило почву для развития медицины и зубоврачевания в России в XVIII веке.

2. ЗУБОВРАЧЕВАНИЕ В РОССИИ В XVIII ВЕКЕ

Реформы Петра I сыграли прогрессивную роль в развитии производительных сил и национальной культуры в России, в укреплении централизованного феодального государства, в которых значительное место было уделено медицинскому делу. Царствование Петра I «... было одной из тех, совершенно неизбежных в процессе социального развития эпох, когда постепенно накапливающиеся количественные изменения превращаются в качественные. Такое превращение всегда совершается посредством скачков». Экономическое развитие России в XVIII веке сопровождалось подъемом русской культуры, науки и искусства. Значительные изменения произошли и в медицине. Нехватка врачей для медицинского обслуживания военных, дворянства, а также работающих на фабриках и заводах, расположенных далеко от центра страны, привела к необходимости открытия сухопутных и морских госпиталей.

В подготовке врачебных кадров и развитии медицины в России XVIII века большую роль сыграли госпитальные школы, открытые на базе этих госпиталей, Академия наук (1725) и медицинский факультет Московского университета (1764). Первая госпитальная школа была открыта в Москве, за Яузой рекой (1707) в месте, «пристойном для лечения болящих людей». Госпитальные школы были настоящие высшие учебные заведе-

ния. «Это был первообраз русского, не существующего еще университета, правда, с одним медицинским факультетом», - писал врач и историограф московского госпиталя А.Н. Алелеков.

Учащиеся госпитальных школ изучали анатомию, физиологию, оперативную хирургию, фармакологию, неврологию, зубоврачевание с челюстно-лицевой хирургией и челюстно-лицевой травматологией. В госпитале было установлено обязательное вскрытие трупов больных, умерших в госпитале.

Среди анатомических препаратов встречались и образцы с патологией зубочелюстной системы, а среди инструментов находились инструменты для проведения зубоврачебных операций на голове, губах, деснах, языке. В библиотеках госпитальных школ были книги и диссертации по вопросам зубоврачевания. Первым руководителем госпитальной школы открытой в Москве, был голландский врач Н.Л. Бидлоо. Им был написан труд «Наставления для изучающих хирургию в анатомическом театре». Это настоящий учебник по хирургии с описанием различных операций, перечнем необходимых при этом инструментов, рисунками. В «Наставлениях» изложены сведения по проведению челюстно-лицевых операций на слизистой оболочке полости рта, на губах, твердом небе, языке, а также описаны показания и противопоказания к этим операциям. В разделе «Об операции зубов» подробно рассматривается строение зубов, сроки прорезывания, иннервация, назначение и функция разных групп зубов, дана методика их удаления и инструментарий, необходимый при этом, описываются различные болезни зубов.

Зубоврачеванием в этот период в России занимались выпускники госпитальных школ, дантисты, цирюльники, знахари. В 1710 году было введено звание «зубной врач», чтобы получить его, дантистам и цирюльникам, обучавшимся путем ученичества у полковых лекарей, а также в госпиталях и больницах, необходимо было сдать экзамен в Медицинской канцелярии (Аптекарский приказ в 1719 году был реорганизован в Меди-

цинскую канцелярию, а в 1763 году – в Медицинскую коллегию, с правом присвоения, с 1764 года, степени доктора медицины), позднее в Медицинской коллегии, университете, Медико-хирургической академии. После сдачи экзамена, получив звание «зубной врач», они должны были уметь делать операции в малой хирургии (удаление зубов относилось к малой хирургии). Кроме дипломированных цирюльников и дантистов, которые относились к среднему медицинскому персоналу, было много таких, которые не имели не только медицинского, но и общего образования, занимались шарлатанством в медицине. Это были, в основном, иностранцы, которые работали парикмахерами, вырезали мозоли, делали кровопускание, удаляли и заговаривали зубы. Хотя медицинская практика для таких лиц в 1721 году была запрещена, многие из них, из корыстных побуждений, обходили этот запрет.

Петр I, являясь членом Парижской академии наук, имел обширные знания в области техники, был хорошо знаком с естественными науками, интересовался медициной и понимал ее огромное значение. Знакомство царя с работами голландского анатома Ф. Рюйша оказало плодотворное влияние на развитие анатомии в России. Посещая Голландию (1698 и 1717), Петр I слушал лекции по анатомии, присутствовал на вскрытиях и операциях. В 1717 году он приобрел анатомическую коллекцию Ф. Рюйша, положив начало фондам первого русского музея, Кунсткамеры, ныне Музей антропологии и этнографии в С.-Петербурге.

Петр I перевязывал раны, производил некоторые хирургические операции: пункцию живота, кровопускание и «...со временем приобрел он в том столько навыку, что весьма искусно умел анатомировать тело, пускать кровь, вырывал зубы и делал то с великою охотою». Он постоянно носил с собой два набора инструментов: математический и хирургический (где находились пеликан и щипцы для удаления зубов). В С.-Петербургском музее антропологии хранится «Реестр зубам, дерганым императором Петром I». В коллекции содержится 73 зуба, удаленных лично императором,

причем большинство зубов относится к молярам, т. е. к группе трудноудаляемых. Однако, несмотря на искривленность корней, переломов не отмечено, что свидетельствует о хорошем владении техникой удаления и знанием анатомии зубов.

В 1718 году Петром I была открыта «инструментальная изба» для изготовления хирургических инструментов, где лично для него были изготовлены медицинские инструменты. В настоящее время эти инструменты хранятся в Эрмитаже. В России готовили кадры среднего медицинского персонала – фельдшеров, которые обучались в фельдшерских школах (1741). Они получали знания по анатомо-физиологическим особенностям зубочелюстной системы, осваивали элементы зубоврачебной практики по оказанию помощи при вывихе нижней челюсти, переломах челюстей, при зубной боли, при удалении зубов.

После открытия Московского университета (1755), основателями которого были М. В. Ломоносов и граф И. И. Шувалов, зубоврачебную помощь, помимо врачей, выпускников госпитальных школ, стали оказывать лекари, получившие медицинское образование в университете (на медицинском факультете, 1764). Специальной сдачи экзамена для занятий зубоврачеванием от них не требовалось. Большое значение в подготовке русских врачей, имеющих обширные знания в области зубоврачевания и челюстно-лицевой хирургии, имели первые пособия на русском языке для врачей, посвятивших себя этим разделам медицины. Главный хирург С.-Петербургского адмиралтейского госпиталя М.Н. Шеин перевел с латинского языка на русский «Основательные наставления хирургическіе медицинскія и рукопроизводныя въ пользу учащимся» Захария Платнера (1761), в которых подробно изложена анатомия зубов и челюстей, описаны болезни зубов: кариес, стираемость и расшатанность зубов и др. В наставлениях выделялись как внешние, так и внутренние причины кариозной болезни, зависящие от общего состояния организма. Лечение кариеса было рекомендовано проводить путем очищения кариозных полостей, а корни зубов пломбировать золотом или свинцом.

3. Платнер разработал показания к удалению зубов, перечислил необходимый для этого инструментарий, описал методы остановки послеэкстракционного кровотечения при пластических операциях на небе, операциях по поводу опухолей челюстей. Производство подобных операций подчеркивает высокую квалификацию врачей и знание элементов челюстно-лицевой хирургии. Большой вклад в обеспечение учащихся госпитальных школ русскими учебными руководствами внес выдающийся деятель отечественной медицины профессор акушерства Н.М. Максимович-Амбодик. Им было написано большое количество словарей по различным разделам медицины, ботаники, учебных руководств по физиологии, акушерству. Он сделал перевод с немецкого учебника И.Ф. Шрейбера «Руководство к познанию и врачеванию болезней человеческих наружных и внутренних» (1781), в котором описана цинга и ее проявления в полости рта, врожденные аномалии полости рта, расщелины твердого нёба. Н.М. Максимович-Амбодик перевел книгу И.И. Пленка «Врачебное наставление о любострастных болезнях» (1790). Книга посвящена клинике, диагностике и лечению сифилиса, в том числе, лечению проявлений сифилиса в полости рта.

Из оригинальных работ Н.М. Максимовича-Амбодика большое значение имела его диссертационная работа «Искусство повивания или наука о бабичьем деле» (1784- 1786). Несмотря на то, что работа посвящена подготовке акушеров, в ней подробно изложены болезни зубов, десен женщины в период беременности и после родов, даны основы детского зубо врачевания, рекомендации по сохранению зубов младенцев. В руководстве описаны такие заболевания как молочница, заячья губа, дефекты уздечки языка. Автор отметил сроки прорезывания и выпадения молочных зубов. Лечение заячьей губы Н.М. Максимович-Амбодик проводил с помощью хирургического вмешательства. Изучая этиологию и патогенез пульпитов, ученый обращал внимание на раздражение чувствительных нервных окончаний, находящихся в зубных тканях. Лечение боли, по мнению автора, может быть местным и общим, для чего он использовал слабительные со-

ли, отвлекающие средства, при наличии кариозной полости ученый использовал коричное, камфарное и гвоздичное масла и др.

Выдающийся деятель отечественной медицины А.Г. Бахерахт (1724-1806) издал монографию «Практические рассуждения о цинготной болезни» (1786), в которой отметил значение алиментарного фактора в этиологии цинги, описал клинические проявления этого заболевания, для лечения рекомендовал полоскание полости рта отваром сосновых шишек и употребление лимонного и апельсинового соков. Воспалившиеся десны он иссекал хирургическим путем. На основании его работ было составлено наставление по профилактике цинги на флоте, в котором предусматривались медицинские осмотры моряков перед выходом в море. А.Г. Бахерахт был хорошо знаком и с практическим зубоврачеванием, оказывая бесплатную помощь неимущим.

К диссертациям на зубоврачебные темы можно отнести работы Якова Европеуса «О скорбуте» (1765) - о проявлении цинги в полости рта, М.С. Крутеня «О жевании» (1765), в которой дано толкование такого сложного физиологического акта, как жевание. Автор проанализировал жевательную функцию каждой группы мышц, языка, роль слюноотделения в процессе жевания.

К концу XVIII века, в связи с ростом требований к подготовке врачебных кадров, госпитальные школы были преобразованы в Медико-хирургические училища (1786), а затем в медико-хирургические академии (1798).

Несмотря на развитие зубоврачевания в XVIII веке, основная масса населения была лишена этого вида помощи. Имушие слои населения городов получали помощь у частнопрактикующих врачей (в большинстве случаев дантистов-иностранцев), лекарей - выпускников госпитальных школ и медико-хирургических училищ, беднота же пользовалась услугами цирюльников, знахарей и других лиц, не имевших медицинского образования. Зубоврачебная помощь в сельской местности практически отсутствовала.

3. ЗУБОВРАЧЕВАНИЕ В РОССИИ В XIX ВЕКЕ

Медицина в России в первой половине XIX века развивалась в условиях нарастания капиталистических отношений. Передовые врачи России успешно продолжали развивать материалистическое понимание основных проблем медицины: взаимоотношения между организмом и средой, целостности организма, единства физического и психического. Разработка вопросов охраны здоровья, и предупреждения болезней, борьбы с заразными заболеваниями, совершенствования методов обучения студентов, роста отечественных кадров характеризуют достижения научной и практической медицины первой половины XIX века.

В 1809 году впервые начал издаваться «Российский медицинский список», содержащий сведения о специалистах в области медицины, в том числе и зубоврачевания (всего в нем числилось 18 дантистов). Первым в этом списке значится Илья Лузгин, которого следует считать одним из первых зубных врачей в России. Число дантистов, по данным «Российского медицинского списка», возрастало медленно: в 1811 году их было 24, в 1818г. - 29, в 1822г. - 33, в 1824 г. - 36, в 1825 г. - 40, в 1826 г. - 44. Среди дантистов первой женщиной была Мария Назон (1829), полька по происхождению.

Строгого разделения на «дантистов» и «зубных лекарей» не было. Дантисты и зубные лекари обучались путем ученичества у таких же неопытных дантистов и лекарей, в основном за границей. Некоторые из них приобретали специальность в России.

В 1810 году для медицинских чиновников были изданы «Правила об экзаменах», которыми было введено звание «зубной лекарь», взамен прежнего, «зубной врач». Кроме лекарей, выпускников медико-хирургической академии и университетов зубоврачебная помощь оказывалась подлекарями, фельдшерами, зубными врачами (зубными лекарями), дантистами, цирюльниками и знахарями. С 1838 года стало распространяться обучение

дантистов путем ученичества и в России. Для получения зубоврачебной практики зубным врачам и дантистам необходимо было сдать соответствующий экзамен, при наличии свидетельства об ученичестве (по «Правилам ... » 1838 года). До 1808 года экзамен принимали в С.-Петербурге и в Москве, а с 1808 года — Медико-хирургические академии и университеты всей России получили право принимать экзамены и присваивать соответствующее медицинское звание, в том числе «зубной лекарь». Экзамен сдавали по анатомии челюстей, зубов, болезням зубов, десен и лекарственным средствам, применяемым в зубной практике. Кроме того, необходимо было уметь делать некоторые зубоврачебные операции и вставлять искусственные зубы.

После сдачи экзамена выдавалось разрешение на тот или иной вид зубоврачебной практики в пределах России с правом или без права выпи-сывания лекарственных средств для приема внутрь, с правом или без права удалять зубы, или только лечить или вставлять зубы, или заниматься зубо-врачебной практикой, но только в каком-нибудь одном городе. Требования программы были очень высокими (обязательное знание латыни), поэтому среди русских молодых людей было немного желающих заниматься зубо-врачеванием.

Согласно «Правилам врачей, фармацевтов, ветеринаров, дантистов и повивальных бабок», утвержденным в 1845 году, медицинские звания подразделялись следующим разом:

- учено-практические (лекарь, доктор медицины, доктор медицины и хирургии);
- учено-служебные (уездный врач, члены врачебной управы, акушер и оператор, инспектор врачебной управы);
- специально-практические (дантист, повивальная бабка).

Для получения того или иного звания необходимо было держать со-ответствующий экзамен. Лекари сдавали экзамены по оперативной хирур-гии и хирургической анатомии и должны были знать все большие и малые операции.

Доктор медицины, кроме того, был обязан написать и защитить диссертацию. Доктор медицины и хирургии публично проводил две сложные операции. Оператору на экзамене было необходимо сделать одну сложную операцию.

Таким образом, в первой половине XIX века было узаконено обязательное выполнение лекарями операций. Лекари имели право лечить все болезни без исключения и производить все операции. Поэтому многие русские лекари, занимаясь хирургией, хорошо знали как челюстно-лицевую хирургию, так и практическое зубоврачевание. Для занятий зубо-врачебной практикой они не нуждались в дополнительном дипломе.

Зубоврачебную помощь, в основном, оказывали дантисты и зубные лекари, которые обслуживали придворную знать, высшие учебные заведения и некоторые закрытые учреждения. Имея широкую частную практику, они, в основном, занимались протезированием. Подлекари, лекарские помощники, фельдшеры и цирюльники производили малые операции, к числу которых относилась и экстракция зубов. Эта группа медицинских работников сыграла определенную роль в практическом зубоврачевании, так как она обслуживала неимущие слои городского, сельского населения и армию.

В первой половине XIX века наука в России, в том числе и медицинская, начала бурно развиваться. Зубоврачевание развивалось в рамках хирургии, поэтому сведения по вопросам зубоврачевания содержатся в литературе этого профиля. Особую роль в развитии медицины сыграли С.-Петербургская Медико-хирургическая академия и Московский университет, в которых сформировались первые в России научные медицинские школы: анатомическая школа П.А. Загорского и хирургическая школа И.Ф. Буша.

Эти школы воспитали целую плеяду талантливых хирургов, крупнейших ученых, прославивших отечественную медицину. Большой вклад в развитие анатомии, хирургии и зубоврачевания внесли П.А. Загорский,

И.В. Буяльский, Х.Х. Саломон, П.А. Наранович, Н.И. Пирогов и др.

П.А. Загорский (1764-1846) - основоположник научной анатомической школы, труды которого имели огромное значение для развития не только отечественной анатомии, но и других медицинских наук, в том числе и зубоврачевания. В его учебнике «Сокращенная анатомия» (1802) описано строение челюстно-лицевой области: анатомия зубов, жевательной мускулатуры (ее функциональное назначение), слюнных желез, языка, даны основы кровоснабжения и иннервации челюстно-лицевой области.

И.Ф. Буш заложил основы хирургической подготовки врачей и создал первую крупнейшую отечественную хирургическую школу. Он основал и развил научные традиции, которые подготовили стремительный взлет хирургии России, связанный с именем Н.И. Пирогова. Деятельность И.Ф. Буша имела огромное значение для преподавания хирургии, в том числе челюстно-лицевой. Многие операции, выполненные в хирургической клинике, руководимой им, относятся к области зубоврачевания. Новаторское значение имела и организованная им теоретическая подготовка лекарей, обеспечившая прочные знания, в том числе, в области зубоврачевания. В 1807 году вышло в свет «Руководство к преподаванию хирургии» И.Ф. Буша, которое выдержало пять изданий, и было единственным руководством по хирургии на русском языке. В этом труде освещены вопросы зубоврачевания по терапевтической, хирургической и зубопротезной помощи. Автор подробно изложил хирургию полости рта, носа, губ, щек, представил клиническую картину и лечение заячьей губы, номы, остеомиелита челюстей, эпюлисов, слюннокаменной болезни. В «Руководстве» описаны различные заболевания слизистой оболочки полости рта и языка: язвы, сыпи на слизистой оболочке полости рта, трещины, воспалительные заболевания языка и их лечение. Значительное внимание в «Руководстве» уделено удалению зубов. Разработаны показания и противопоказания к экстракции зубов, даны правила удаления зубов, представлено описание инструментария, применяемого при этом, описана реплантация зубов и показания к ней.

Особый интерес представляет взгляд И.Ф. Буша на этиологию, клинику и лечение кариеса зубов. Причинами возникновения кариеса он считал, как общие заболевания организма, так и местные воздействия. К местным факторам, кроме механических причин (трещин, повреждений эмали), он относил и «зубную нечистоту», т. е. микробный фактор, в современной трактовке. Такое понимание причин возникновения кариеса свидетельствует о замечательном научном предвидении И.Ф. Буша. Он подметил все тонкости клинического проявления кариеса зубов. Касаясь вопроса распространения кариозной болезни, ученый отметил, что это заболевание встречается «чаще в молодом возрасте, нежели в старости». При лечении зубов он обрабатывал кариозные полости «радирующим орудием» с последующим заполнением их коричневым маслом или листовым золотом. При пульпите, после выжигания раскаленной иглой пульпы зуба, И.Ф. Буш рекомендовал пломбирование. Ученый описал верхушечные периодонтиты, расшатанность зубов.

В руководстве изложены вопросы зубопротезирования: съемное, несъемное и сложное протезирование. При несъемном протезировании промежуточные части он фиксировал проволокой к соседним зубам. При съемном — фиксация протеза осуществлялась при помощи пружин, прижимающих его к альвеолярному отростку, или металлических штифтов, которые вводились в альвеолярный отросток. При сложном протезировании он применял obturаторы из мягкой губки, кожи, серебра. Автор подробно изложил вопросы ортодонтии: описал причины неправильного прорезывания зубов, способы его исправления. К причинам неправильного прорезывания И.Ф. Буш относил: ненормальное расположение зубных зачатков, чрезмерную «узость или широту» альвеолярного отростка, раннее или позднее прорезывание постоянных зубов, травмы и осложненный кариес. Большую роль он отводил общему состоянию организма ребенка в период формирования и прорезывания зубов. Неправильно прорезавшиеся одиночные зубы он исправлял фиксацией их нитками к соседним зубам.

При значительных аномалиях прикуса, И.Ф. Буш применял направляющий ортодонтический аппарат.

Велик вклад И.В. Буяльского, анатома и хирурга, в зубоврачевание. Большой интерес для современных врачей-стоматологов представляют его «Анатомико-хирургические таблицы», в которых представлена техника производства многих операций, в том числе и зубоврачебных. Им впервые в России была проведена операция односторонней резекции верхней челюсти по поводу новообразования, пластические операции — восстановление нижней губы из кожи подбородка. Деятельность И.В. Буяльского на поприще разработки медицинского инструментария имела большое значение для развития хирургии. Он один из первых хирургов России, который при производстве операций, применил эфирный наркоз, крахмальную повязку при переломах костей, использовал хлорную известь, как средство предохранения от осложнений при операциях.

Первое оригинальное руководство по оперативной хирургии на русском языке было написано Х.Х. Саломоном, в некоторых разделах которого описаны челюстно-лицевые операции: трансплантация при некоторых хирургических операциях, методика их проведения, техника производства операций на голове.

Это было одно из первых учебных руководств по этому разделу хирургии.

Ученик и помощник И.В. Буяльского П.А. Наранович внёс большой вклад в усовершенствование инструментария, в том числе и зубоврачебного. Являясь незаурядным хирургом, П.А. Наранович произвел большое количество операций, среди которых были и зубоврачебные: оперативное лечение околоушной слюнной железы, гемангиомы верхней губы.

В 1820 году московский профессор А.И. Поль произвел по собственной методике резекцию нижней челюсти.

Н.И. Пирогов — гениальный ученый, хирург и анатом, исследования которого положили начало анатомо-экспериментальному, функциональ-

ному направлению в хирургии, военно-полевой хирургии и хирургической анатомии. Он, в 1847 году, спустя две недели после Ф.И. Иноземцева, провел под эфирным наркозом операцию по поводу рака молочной железы и первый в России применил массовый наркоз в военно-полевых условиях. Н.И. Пирогов был хирургом-новатором, хирургом-экспериментатором. Он приобрел большой опыт в производстве пластических операций на лице и был пионером в этой области хирургии. В 1835 году в лекции по ринопластике, на основании своего богатого практического опыта, ученый обосновал ценность пластических операций на лице, обеспечивающих не только ликвидацию физических недостатков, но и нормализацию психических сторон жизнедеятельности человека. Лекция была хорошо иллюстрирована схемами, которые демонстрировали методы кожной ринопластики в зависимости от характера и степени повреждения, с предпочтением пластики на ножке. Николай Иванович сформулировал основные законы трансплантации. За 20 лет, с 1836 по 1856 годы, Н.И. Пирогов сделал около 40 ринопластик, в то время как во всем мире до 1836 года была сделана всего 71 операция.

Популяризация Н.И. Пироговым зубоврачебной тематики среди врачей способствовала их интересу к этому разделу хирургии, повышению у них соответствующих знаний и побуждала к занятиям практическим зубо-врачеванием. В 1841 году в сообщении «О резекции верхней челюсти по поводу кариеса с неблагоприятным исходом» он поделился своим опытом хирургического лечения остеомиелита верхней челюсти. В 1850 году ученый доложил материалы по теме: «Операция рака гайморовой пещеры».

Н.И. Пирогов великолепно владел техникой различных операций, в том числе, и в полости рта. За время работы в клинике госпитальной хирургии в С.-Петербургской медико-хирургической академии Н.И. Пирогов сделал более 130 челюстно-лицевых операций (не считая удалений зубов). Сюда вошло 36 резекций челюстей по поводу новообразований, 5 операций вырезывания опухолей подъязычной слюнной железы, 25 операций

иссечения нижней губы по поводу рака, 7 операций по поводу заячьей губы, 1 операция по поводу кисты нижней челюсти, около 40 ринопластик, 20 хейлопластик и 1 пластическая операция на лице. Им было опубликовано большое количество научных работ, касающихся зубоврачевания, многие из которых до сих пор представляют интерес для стоматологов. В 1855 году вышла в свет работа ученого «Рак нижней губы», где приведены результаты подробного патологоанатомического исследования эпителиального рака нижней губы и описаны хирургические методы лечения этого заболевания. Исполняя обязанности управляющего С.-Петербургским заводом военно-врачебных заготовлений (бывшая «инструментальная изба»), Н.И. Пирогов создал различные типы хирургических наборов, в которых есть инструменты для челюстно-лицевых операций, зубоврачебный инструментарий. Даже батальонные наборы Н. И. Пирогова включали ключ зубной с тремя и двумя винтами и рукояткой, щипцы зубные кривые и «козью ножку». По заказу Н.И. Пирогова был сделан ранец с хирургическими инструментами, куда входили: зубной ключ, аппарат для перевязки переломов нижней челюсти, Т-образная головная повязка лицевая, носовая и другие предметы.

Анатомическое понятие «треугольник Пирогова» известен каждому современному стоматологу благодаря замечательному труду «Хирургическая анатомия артериальных стволов и фасций», в котором Н.И. Пирогов описал доступ к язычной артерии, лежащей в треугольном пространстве.

Интересна тематика лекций, относящихся к зубоврачеванию, прочитанных Н.И. Пироговым слушателям академии.

1. «Перевязка art. carotidis, subclavie, anonimal», 1843.
2. «О ношении небной занавески», 1844.
3. «Об образовании искусственных губ», 1844.
4. «О подъязычной опухоли (granula) и операции при этой болезни», 1846.
5. «О выпиливании верхней челюсти», 1847.

6. «О сшивании губ», 1848.

7. «О страдании челюстей вследствие поражения зубов», 1846, 1849, 1850, 1851.

8. «О раковидных язвах губ», 1848, 1849, 1850, 1851.

9. «О страдании желез губ», 1848.

10. «Перевязка art. carotis et lingualis», 1848.

Н.И. Пирогов внес неоценимый вклад в развитие медицины вообще и зубоврачевания в частности.

И.П. Павлов так охарактеризовал деятельность Н.И. Пирогова: «Ясными глазами гениального человека, на самых первых порах, при первом прикосновении к своей специальности — хирургии, он открыл естественно-научные основы этой науки: нормальную и патологическую анатомии и физиологический опыт и в короткое время настолько на этой почве установился, что сделался творцом в области».

Челюстно-лицевые операции проводили и другие хирурги, работавшие в Медико-хирургической академии. Так в 1838 году, в отчете Медико-хирургической академии о 150 важнейших операциях, проведенных А.И. Овером, дается писание 5 полных и частичных «отнятий» верхней и нижней челюстей.

В первой половине XIX в. появляется много печатных работ рядовых русских врачей. Среди них особого внимания заслуживает труд А.М. Соболева «Дентистика или зубное искусство о лечении зубных болезней с приложением детской гигиены».

А.М. Соболев родился в 1793 году, медицинское образование получил в С.-Петербургской Медико-хирургической академии, по окончании которой был произведен в лекари и направлен в саперный батальон. После 5 лет службы в воинских частях, он был переведен на госпитальную работу. С 1821 года А.М. Соболев работал в госпиталях, а в 1833 году был зачислен на должность врача медицинской полиции. Прослужив 21 год в должности рядового врача, А.М. Соболев в 1854 году ушел в отставку.

В 1829 году он издал книгу «Дентистика», в предисловии к которой пишет, что дентистика — это наука, один из разделов медицины, тесно связанная с другими медицинскими дисциплинами и подчинена тем же законам развития. В задачу этой науки входит профилактика и лечение заболеваний зубов и полости рта. Книга А.М. Соболева — это настоящая энциклопедия передовых знаний в зубоврачевании того времени и в настоящее время представляет собой библиографическую ценность. В ней представлены все разделы зубоврачевания: терапия, хирургия, ортопедия и ортодонтия, профилактика заболеваний зубов.

Первая часть книги, основная — дентистика, включает в себя ряд разделов: «анатомическое описание зубов, разделение зубов, существо зубов, финифть зубов, о пользе зубов в жизни человека, о болезнях зубов вообще, о причинах болезни зубов, простуда зубов, нечистота зубов, зубной камень, шаткость зубов, костоедица зубов, зубная боль, флюс, наросты на деснах, ноздреватость десен, десневые свищи, неправильное прорезывание зубов, извлечение зубов, случаи, где нужно зуб извлечь, обстоятельства, возбуждающие извлечение зубов, орудия для извлечения зубов употребляемые, трудное прорезывание зубов у младенцев». Одно только перечисление разделов воспроизводит картину подробного исследования автором зубочелюстной системы. А.М. Соболев высказал мысль о единстве зубочелюстной системы и ее связи с другими частями организма. К причинам заболеваний зубов автор относил: сырой климат, чрезмерное питание, заболевания желудочно-кишечного тракта, частое употребление сладостей, кислот, условия труда. Основное внимание в профилактике болезней зубов он уделял закаливанию организма.

Лечение зубов, по мнению автора, должно быть комплексным: изменение жилищно-бытовых условий, климата, работы, соблюдение диеты (свежая мясная и растительная пища, лимоны, клюква, брусника, персики и т.д.). Описывая расшатанность зубов, А.М. Соболев отмечает воспалительные процессы в десне, как проявление цинготной болезни. Причинами

расшатанности, по его мнению, являются наследственные, алиментарные факторы и недостаток «чистого и здорового воздуха». Кроме консервативных методов лечения расшатанности зубов, автор предлагал хирургические (удаление сильно расшатанных зубов) и ортопедические (фиксация зубов с помощью деревянных или костяных пластинок, к которым крепятся расшатанные зубы ниткой и проволокой). А.М. Соболев сформулировал показания и противопоказания к удалению зубов, способы остановки кровотечения после этой операции, перечислил необходимый инструментарий (английский ключ, щипцы прямые для передних зубов и изогнутые для коренных, крючок, пеликан, «козья ножка»). Об обезболивании автор не упоминает, на практике обезболивание будет применено после 1847 года.

Из местных средств лечения А.М. Соболев рекомендовал полоскание дубовой корой, чернильными орешками. При описании кариеса (костоедце) зубов он затрагивал вопросы этиологии, клиники и лечения этого заболевания. В этиологии основное внимание автор придавал общим заболеваниям организма, не отрицая при этом наследственных факторов, в возможность изменения которых он твердо верил. К причинам возникновения кариеса автор относил социально-экономические факторы: тяжелые жилищно-бытовые условия (сырые и темные помещения), работа на вредных производствах и т. д.

Такая оценка этиологических факторов, вызывающих заболевание зубов, является прогрессивной для того времени, если учесть, что во второй половине XVIII и в начале XIX века в Западной Европе господствовала узколокалистическая теория кариеса.

В разделе, посвященном ортодонтии, излагая причины неправильно-го прорезывания зубов, методы лечения, автор предложил классификацию аномалий прикуса.

Вторая часть книги А.М. Соболева называется «Детская гигиена». В ней даны правила ухода за детьми с момента их рождения, чтобы сохранить их здоровыми, с зубами устойчивыми к кариесу. Основными профи-

лактическими мероприятиями к укреплению здоровья детей, в том числе и зубочелюстной системы, автор считал соблюдение режима питания и общегигиенических правил.

В первой половине XIX века появляется ряд переводных и оригинальных работ по зубоврачеванию, в их числе перевод А. Никитина (1821) с немецкого языка монографии К.Ф. Грефе по ринопластике, книги Б. Гана «Распознавание и лечение золотушной и английской болезни и трудного прорезывания зубов у детей» (1829), в которой описана диагностика, клиника и лечение затрудненного прорезывания зубов.

В 1838 году была издана книга «С.-Петербургский зубной врач», написанная зубным врачом Б.С. Вагенгеймом, иностранцем по происхождению, поступившим на русскую службу. Он правдиво отразил уровень зубоврачебной помощи в России в первой половине XIX века, который не только не уступал уровню зубоврачевания на Западе, но и в некоторых отношениях даже превосходил его. В книге дана краткая история зубоврачевания, анатомия, физиология зубов, пломбирование и протезирование зубов (в частности, фарфором), а также раскрыты физиологические механизмы зубной боли. Для предупреждения заболеваний зубов особое внимание автор уделял осмотру зубов, полости рта. Профилактические осмотры с последующей санацией полости рта уже тогда проводились во всех петербургских высших учебных заведениях. Б.С. Вагенгейм указал возраст, в котором целесообразно проводить санационные осмотры и определил сроки для их проведения.

В середине XIX века в зубоврачебном образовании произошли коренные изменения. Вместо существовавшей подготовки дантистов путем ученичества появились специальные школы для подготовки квалифицированных зубных врачей. Первая в мире школа для обучения зубных врачей была открыта в 1840 году в Балтиморе (США). Позднее аналогичные школы были открыты и в других странах: Англии — в 1857 году, Франции — в 1880 году, Швейцарии — в 1881, Германии — в 1884.

Происшедшие во второй половине XIX века социально-экономические сдвиги, дали толчок к крупнейшим открытиям в естественных науках (физика, химия, биология и др.).

Развитие новых научных направлений в медицине (материалистическое, функционально-экспериментальное), совершенствование методов обезболивания, внедрение асептики и антисептики позволило усложнить оперативные вмешательства, разработать новые методы лечения, обосновать новые взгляды на этиологию и патогенез многих заболеваний. В конце XIX века вопрос специального одонтологического (зубоврачебного) образования привлекал внимание многих ученых, врачей, дантистов, зубных врачей. На введении высшего одонтологического (зубоврачебного) образования настаивали Н.В. Склифосовский, А.К. Лимберг, С.П. Коломнин, А.И. Кудряшов, Ф.А. Звержховский. За открытие частных зубоврачебных школ выступали дантисты А.П. Синицын, В.И. Хрущов, Ф.И. Важинский и др.

В 1881 году в С.-Петербурге Ф.И. Важинский открыл, первую в России, частную зубоврачебную школу. В школу принимались лица, окончившие 4 класса гимназии, затем требования стали возрастать, и уже с 1891 года образовательный ценз поднялся до 6-ти классов среднего учебного заведения. Обучение в школе продолжалось 2,5 года. Окончившие школу могли держать экзамен в Медико-хирургической академии или на медицинском факультете университета и получать звание зубного врача с правом выписывания лекарства.

В 1891 году был издан закон «О преобразовании обучения зубоврачебного искусства». Он устанавливал два звания для специалистов по зубоврачеванию: дантист и зубной врач. Звание «дантиста» присваивалось обучавшимся путем ученичества в частных кабинетах, звание «зубного врача» — обучавшимся в частных зубоврачебных школах, деятельность которых с 1891 года определялась «Нормальным уставом». Новый устав не предусматривал прекращения подготовки дантистов путем ученичества,

которое продолжалось в течении всего XIX столетия (до 7 мая 1900 г.). Дантист мог получить звание «зубной врач», сдав экзамены в зубоврачебной школе.

Первая зубоврачебная школа в Москве была открыта И.М. Коварским в 1892 году. И.М. Коварский, закончив Рижскую гимназию, в 1879 году поступил на медицинский факультет Московского университета, после окончания которого, работал в хирургическом отделении Московской Мариинской больницы. Решив избрать своей специальностью зубоврачевание, И.М. Коварский в 1889 году поехал в Германию, где закончил зубоврачебную школу. Вернувшись из-за границы, он проводит большую организационную работу для открытия в Москве первой зубоврачебной школы: подготовка помещения для занятий, приобретение оборудования, разработка программы обучения, подбор преподавателей, имеющих ученую степень, согласно Уставу, утвержденному медицинским советом Министерства внутренних дел от 25 мая 1891 года.

В сентябре 1892 года состоялось открытие Первой московской зубоврачебной школы, которую 27 лет возглавлял И.М. Коварский. Первоначально школа размещалась на Петровке, затем в Каретном ряду. В дни декабрьского вооруженного восстания 1905 года в здании школы было организовано оказание помощи раненым. После разгрома восстания, зубоврачебная школа была закрыта, как неблагонадежное учреждение.

Зубоврачебные школы открывались только в университетских городах. С открытием школ увеличилось количество частных зубоврачебных кабинетов в других городах. В 1898 году в России было 9 зубоврачебных школ.

Открытие первых русских школ положило начало качественно новому периоду в истории подготовки зубоврачебных кадров. Однако реформа зубоврачебного образования не решила основного вопроса — организации государственных одонтологических факультетов, закрепив «частнопредпринимательский характер зубоврачебных школ». В связи с открытием

первых отечественных зубоврачебных школ, появление учебника И.И. Хрущова (1850-1916) «Полный зубоврачебный курс» (1886) было особенно важным. В нем на основе теории и практики были изложены все разделы зубоврачевания. Велика заслуга И.И. Хрущова в создании зубо-врачебного оборудования, которое он с успехом демонстрировал на Всероссийской выставке в 1896 году в Н.-Новгороде.

Зубопротезированием в этот период занимались дантисты, зубные врачи, окончившие зубоврачебные школы, ибо согласно закону «всякий, желающий посвятить себя зубоврачебной деятельности, должен выучиться не только лечению зубов, их пломбированию, но и протезированию». Специальных учебных заведений для подготовки зубных техников не было. По ремесленному уставу того времени, они были причислены к ювелирному цеху и получали знания по специальности индивидуальным обучением у практиков или в частных зуботехнических мастерских. Порядок подготовки зуботехнических кадров ни одним законом не был установлен. Существовало только разъяснение медицинского совета (1886), по которому «лица, именующие себя зубными техниками, не вправе самостоятельно изготавливать искусственные зубы, а могут заниматься этим лишь по заказу дантиста или под его ответственностью».

Попытки отдельных лиц в начале XX века создать специальные школы для подготовки зуботехнических кадров были отклонены правительством, но было разрешено открытие ремесленных зуботехнических мастерских, которые выпускали «мастеров зуботехнического ремесла». Такие мастерские были открыты в Москве, Одессе и других городах.

В 1907 году Сенат предоставил право ремесленным управам производить испытания и выдавать дипломы на звание «мастера зуботехнического дела», причем никакой общеобразовательной и медицинской подготовки для этого не требовалось.

Пока зубоврачебная помощь оставалась в частных руках, о государственных зуботехнических лабораториях и подготовке зуботехнических

кадров вопрос не поднимался. Первая зуботехническая школа была открыта на базе зубоврачебной школы И.М. Коварского только в 1919 году и возглавил её М.О. Коварский. Для развития зубоврачевания этого периода большое значение имела деятельность хирургов Военно-медицинской академии. Вопросам зубоврачевания много внимания уделял заведующий кафедрой теоретической хирургии академик П.П. Заблоцкий-Десятовский (1816-1892). Особый интерес для зубных врачей имела его работа «О болезнях рта и соседних ему частей» (1856), где было описано заболевания губ, десен, твердого и мягкого нёба, языка, челюстей. Им была разработана техника операций при остеомиелитах челюстей, опухолях, двухсторонних расщелинах нёба. Непосредственное отношение к зубоврачеванию имела работа П.П. Заблоцкого-Десятовского «О болезнях челюстной пазухи» (1854), в которой описана патология гайморовой полости, лечение гайморитов. Вопросу пластических операций челюстно-лицевой области посвящена его статья «Об искусстве лечить безобразие лица по способу французскому» (1843). В популярной статье П.П. Заблоцкого-Десятовского «О сохранении зубов в здоровом состоянии» (1855), автор говорит о вреде зубных порошков из угля и хинина.

Деятельность С.П. Коломнина (1842-1886) — заведующего кафедрой хирургической клиники Медико-хирургической академии была тесно связана с зубоврачеванием. В статье «О резекции верхней челюсти по поводу опухолей» (1882) С.П. Коломнин поделился своим опытом применения интратрахеального наркоза. С.П. Коломнин неоднократно возглавлял комиссии по реорганизации зубоврачебного образования.

Выдающийся хирург Н.А. Вельяминов разработал новые методы лечения огнестрельных ранений, принципы оказания первой помощи, определяющей успехи дальнейшего лечения. Он, одним из первых в мире, предложил индивидуальный перевязочный пакет, как «обязательную противогнилостную повязку не только в госпиталях и лазаретах, но и на поле сражения». В 1896 году он сделал доклад на тему: «К вопросу об операциях в полости рта».

Во второй половине XIX века появились сообщения о производстве зубоврачебных операций: Э.В. Каде (1862), К.Ф. Гепнер (1886) проводят операции по уранопластике, М.С. Субботин (1873) оперирует на нижней челюсти по поводу рака, а в 1894 году он докладывает «Об операции волчьей пасти и ее значении для речи и питания».

Вопросы зубоврачевания нашли отражение не только в трудах хирургов, но и в работах других специалистов. В 1894 году прозектор М.А. Батуев (1855-1917) опубликовал монографию «К морфологии коронки зубов человека и животных».

Большое значение для развития детского зубоврачевания имела деятельность многих сотрудников кафедры педиатрии Военно-медицинской академии. В учебной программе по детским болезням 1862 года был специальный раздел основ детского зубоврачевания, который включал: стоматиты катаральные, дифтеритические, скорбутные, язвенные, описание затрудненного прорезывания зубов и осложнений при этом. Программа 1869 года содержала более широкий круг вопросов по детскому зубоврачеванию: болезни полости рта, болезни слюнных желез, врожденные пороки развития губ и рта, стоматиты, молочницу, ному.

Много внимания детскому зубоврачеванию уделял профессор Н.П. Гундобин (1860-1908), хорошо знакомый с его практическими разделами. В 1894 году вышла в свет его работа «О прорезывании зубов у детей», в которой был проанализирован сложный физиологический процесс в организме ребенка, связанный с прорезыванием зубов.

Некоторые диссертационные работы этого времени оказали значительное влияние на развитие зубоврачевания. Диссертация А.Х. Пандера «De dentium structure» (1856), выполненная под руководством гистолога И.А. Маркузена, известного своими работами в области эмбриогенеза, в том числе гистогенеза зубов, посвящена изучению структуры зубных тканей.

Для развития теоретического и практического зубоврачевания боль-

шое значение имела диссертация В.М. Антоневича «О реплантации и трансплантации зубов» (1885), которая была первым оригинальным исследованием не только в отечественной, но и в мировой литературе по данной проблеме.

В конце XIX века появился ряд работ, посвященных изучению ферментативной способности пищеварительного тракта, в том числе и полости рта. В 1870 году В.В. Пашутиным (1845-1901), создателем первой крупной патофизиологической школы в России, была защищена диссертация на тему: «Некоторые опыты над ферментами, превращающими в глюкозу крахмал и тростниковый сахар». Диссертация была выполнена в лаборатории И.М. Сеченова. Этой же проблеме была посвящена диссертация И.П. Коровина (1843-1908) «К вопросу об уподоблении крахмальной пищи грудными детьми» (1874), одна из первых работ по физиологии пищеварения.

Изучению заболевания пульпы зуба при различных общих недугах организма была посвящена диссертация А.И. Кудряшова (1894). Автор нанес удар по господствовавшим то время идеалистическим концепциям этиологии кариеса зубов. Он впервые указал на наличие в пульпе клеток ретикуло-эндотелиальной системы.

Лечение зубов с воспаленной пульпой было описано в диссертации И.А. Краузе (1897), результаты которой интересны современным стоматологам, занимающимся лечением пульпитов биологическим методом.

Кроме перечисленных диссертаций, было защищено много других, которые посвящены различным вопросам зубо врачевания. Выдающегося деятеля отечественной медицины Н.В. Склифосовского по праву можно назвать основоположником высшего зубо врачебного образования в России, который многое сделал для совершенствования как медицинского образования, так и зубо врачебного. Н.В. Склифосовский настаивал на включении зубо врачевания, как науки и самостоятельного раздела медицины, в программу высших медицинских учебных заведений. В 1879 году, в Москве на 6 съезде русских естествоиспытателей и врачей, ученый сделал

доклад «О прочности зубов у обитателей столицы», в котором на основе клинико-статистического метода, указал на связь между заболеваемостью зубов кариесом и внешней средой, подчеркнув эффективность профилактических мер воздействием на организм в целом. Одной из мер профилактики он считал рациональную диету.

На этом же съезде, по предложению Н.В. Склифосовского, единогласно было принято решение о создании само стоятельных клинических доцентур по зубным болезням. Н.В. Склифосовский был не только прекрасным диагностом, но и непревзойденным хирургом, владевшим техникой производства многих операций, в том числе и зубоврачебных. Операции при больших дефектах лица, выполненные Н.В. Склифосовским, были значительным вкладом в развитие челюстно-лицевой хирургии. Он, впервые в мире, применил местное обезболивание раствором кокаина при операции по поводу расщелины твердого нёба. Им был сконструирован аппарат, позволяющий поддерживать наркоз во время операции на челюстях и в полости рта, что позволило ему произвести такую редкую операцию, как резекция обеих половин верхней челюсти с одновременным ортопедическим лечением. До этого в литературе было описано всего 12 подобных операций.

Большой интерес представляет работа Н.В. Склифосовского по лечению неподвижности нижней челюсти. Он разработал классификацию анкилозов нижнечелюстного сустава и предложил методику создания искусственного сустава в шейках суставных отростков. Его работа «Вырезывание языка после предварительной перевязки артерий», в которой он описал новый метод оперативного вмешательства, позволяющий подойти к корню языка через подъязычную область, перевязав с обеих сторон язычные артерии в «треугольниках Пирогова», представляет интерес и сегодня. Исследования о расстройстве функции глотания и речи и об утрате вкуса после этой операции имеют прямое отношение к физиологии. Такие операции относятся к разделу сложных вмешательств и до Н.В. Склифосовского

ником не проводились. Он разработал правила ухода за послеоперационными больными, их кормления и транспортировки.

В работе «Восстановление седлообразно запавшего носа» ученый проанализировал результаты оперативных вмешательств, проведенных им по методу профессора П.И. Дьяконова.

Ученый уделял огромное внимание зубоврачеванию, способствовал его развитию как науки, занимался вопросами подготовки зубоврачебных кадров. Он был лично знаком с большинством известных зубных врачей С.-Петербурга:

А.К. Лимбергом, П.Ф. Федоровым, Ф.А. Звержховским, Е.Ф. Вонгль-Свидерской и др.

Н.В. Склифосовский высоко ценил преподавательскую деятельность А.К. Лимберга, первого русского профессора по зубоврачеванию и основателя детского зубоврачевания в России, который научно обосновал значение санации полости рта, снижающей процент осложнений кариеса и удалений зубов. А.К. Лимберг в 1886 году организовал первую в России бесплатную школьную зубоврачебную амбулаторию. На заседании «Российского общества народного здоровья» 12 марта 1889 года в докладе «О зубах учащихся и организации зубоврачебной помощи в школах» А.К. Лимберг указал: «Деятельность зубных врачей ограничивается пломбированием, выдергиванием больных и вставлением искусственных зубов. Профилактика и диететика не прилагаются к полости рта. Это забытый отдел. Он останется забытым до тех пор, пока не найдет себе научных возделывателей».

Пятилетний опыт работы зубоврачебных амбулаторий показал значительное уменьшение количества удалений после проведения санации.

Проблема профилактики и лечения кариеса зубов, нашла отражение в диссертации А.К. Лимберга «Современная профилактика и терапия кариеса зубов» (1891), где автор представил клиническую классификацию кариеса зубов, систематизировал диагностику и изложил принципы лече-

ния этого заболевания. Впервые в мире им был разработан метод плановой санации полости рта у детей, введены профилактические осмотры детей с заполнением санационных карт. Метод профилактики, предложенный А.К. Лимбергом, нашел широкое применение в практике здравоохранения советского периода.

Под руководством А.К. Лимберга были проведены I и II одонтологические съезды в России (1896,1899), на которых ставились и обсуждались вопросы профилактики заболеваний зубов у детей дошкольного и школьного возраста, лечения детей с врожденными расщелинами, а также предупреждения и лечения аномалий челюстей. Он был активным участником многих международных съездов (Париж, Берлин, Вашингтон и др.). Общественность и научный мир высоко оценили деятельность А.К. Лимберга, избрав его почетным членом многих отечественных и зарубежных обществ.

В 1885 году на медицинском факультете Московского университета, по инициативе Н.В. Склифосовского, при факультетской хирургической клинике, руководимой им была создана первая в России доцентура по одонтологии. Первым приват-доцентом стал Н.Н. Знаменский (1856-1915).

Закончив в 1880 году Московский университет, Н.Н. Знаменский в 1881 году Советом университета был избран попечителем Московского учебного округа в должности сверхштатного ординатора хирургического отделения факультетской клиники. С этого времени он работает под непосредственным руководством декана факультета профессора Н.В. Склифосовского. В 1884 году Н.Н. Знаменский защитил диссертацию по хирургии на степень доктора медицины. В этом же году он был принят в число приват-доцентов Московского университета для преподавания курса зубных болезней. Ученый провел большую подготовительную работу по созданию учебной базы для практических занятий по одонтологии, оснастил её оборудованием, инструментарием, пломбирочными, перевязочными, зубопротезными и другими материалами. Н.Н. Знаменский составил учебную

программу по одонтологии, одобренную и утвержденную Н.В. Склифосовским. Программа предусматривала изучение анатомии, физиологии, освоение методов исследования полости рта. Раздел «Болезни зубов» включал анатомию, гистологию зубов, описание заболеваний челюстей и ячеистого отростка, слизистой оболочки полости рта, языка, слюнных желез. Студенты и врачи, под руководством специалистов по одонтологии, должны были осваивать консервативное и оперативное лечение кариеса зубов и его осложнений, технику экстракции зубов, методы реплантации, имплантации и трансплантации. Н.Н. Знаменский писал: «Требуется знание производства различных операций на живых людях; следовательно, от него (дантиста-одонтолога) требуется знание известного отдела оперативной хирургии. Он должен, таким образом, отражать на себе, в своей деятельности, то направление, какое имеет современная хирургия». Далее он отмечает: «Принципы Листера и в одонтологии должны быть точно так же строго проводимы, как они проводятся в современной хирургии». Таким образом, Н.Н. Знаменский одонтологию тесно связывал с общей хирургией.

В 1894 году медицинскому факультету Московского университета было разрешено проводить экзамены на звание зубного врача для лиц, окончивших зубоврачебные школы. Практические испытания по протезной технике и пломбированию зубов было поручено принимать Н.Н. Знаменскому, а клинические испытания – ординарному профессору Л.Л. Левшину. В 1893 году в доцентуру был зачислен Г.И. Вильга, который, посвятив себя зубоврачеванию, стал видным специалистом в этой области медицины. В 1903 году он защитил докторскую диссертацию «О зубах в судебно-медицинском отношении», которая долгие годы в России была единственным руководством для врачей и судебно-медицинских экспертов.

В 1905 году практические занятия на доцентском курсе по одонтологии проводили уже три приват-доцента, доктора медицины: Н.Н. Знаменский, Г.И. Вильга и М.Б. Янковский.

Г.И. Вильга был активным организатором Всероссийских одонтоло-

гических съездов в Москве (1908) и в Харькове (1911). Ученый, пропагандируя одонтологию среди врачей различных специальностей, на VI одонтологическом съезде сказал: «...одонтология, ставши на научную почву, стал равной другим отраслям медицины». В докладе «Альвеолярная пиорея и ее лечение» он представил анализ причин этого заболевания, изложил различные методы лечения и профилактики. На VIII съезде общества русских врачей, по инициативе Г.И. Вильги, были прочитаны три доклада по вопросам зубо врачевания (В.П. Бекаревич, Г.И. Вильга, М.М. Чемоданов). Г.И. Вильга организовал журнал «Одонтологическое обозрение». В 1909 году он открыл в Москве зубо врачебную школу, которая с 1918 года стала учебно-вспомогательной базой кафедры хирургии челюстей и полости рта с одонтологической клиникой Московского университета. Г.И. Вильга был одним из организаторов стационарной стоматологической помощи.

В 1892 году была открыта доцентура по зубным болезням в Военно-медицинской академии С.-Петербурга. Ее основателем был приват-доцент П.Ф. Федоров, возглавлявший ее в течение 22 лет. Создание и деятельность одонтологических доцентур имело исключительное значение для оформления одонтологии, как самостоятельной научной и учебной дисциплины.

Первая самостоятельная кафедра одонтологии в России была открыта в 1892 году при клиническом институте усовершенствования врачей в С.-Петербурге. Цикл лекций по одонтологии читал А.К. Лимберг.

В создании первых одонтологических кафедр большое участие принимало «С.-Петербургское общество дантистов и зубных врачей».

В 1899 году при С.-Петербургском женском институте (ныне С.-Петербургский государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова) А.К. Лимбергом была организована одонтологическая кафедра, которой из-за болезни, он руководил всего один год (1900-1901). Очень продолжительное время обязанности заведующего исполнял

С.Я. Чистович, которого в 1901 году сменил Ф.А. Звержховский и стоял во главе кафедры до 1919 года. Ф.А. Звержховский получил высшее медицинское образование в Медико-хирургической академии, в 1907 году он защитил диссертацию «К вопросу об эмпиеме гайморовой полости». Из научного наследия Ф.А. Звержховского особого внимания заслуживает его многотомный (5 томов) труд «Основы дентиатрии». Это серия лекций по одонтологии для врачей и студентов.

Во время Первой мировой войны Ф.А. Звержховский был назначен инспектором челюстных лазаретов, а с сентября 1916 по март 1917 года находился в действующей армии и руководил организацией и работой госпиталя для челюстно-лицевых раненых в Бухаресте.

В 1906 году кафедра была преобразована в доцентский курс при кафедре госпитальной хирургии. С этого же года женскому институту было дано право принимать экзамены на звание зубного врача у лиц, окончивших зубоврачебные школы.

В 1883 году в С.-Петербурге были созданы «Первое общество дантистов России» и «С.-Петербургское общество дантистов и врачей, занимающихся зубоврачеванием». «Первое общество» было основано Ф.И. Важинским, а «С.-Петербургское общество дантистов и врачей, занимающихся зубоврачеванием» — А.К. Лимбергом, на котором в апреле 1884 года он сделал доклад «О необходимости обязательного высшего образования зубных врачей в России», опубликованном затем в журнале «Врач». С 1898 года «С.-Петербургское общество дантистов и врачей, занимающихся зубоврачеванием» стало называться «С.-Петербургским зубоврачебным обществом».

В 1891 году было организовано «Московское одонтологическое общество», в которое входили Г.И. Вильга, П.Г. Дауге, И.М. Коварский, М.М. Чемоданов и др. Первые научные одонтологические общества повлияли на развитие зубоврачевания в России. Они спланировали кадры зубных врачей, организовывали и проводили научные зубоврачебные (одон-

тологические) съезды, способствовали развитию научного зубоврачевания. Кроме научных, были созданы и профессиональные общества, на которых решались многие социальные вопросы. В 1899 году было организовано «Российское одонтологическое общество».

В становлении зубоврачебной науки большое значение имел первый русский одонтологический периодический печатный орган «Зубоврачебный вестник» (1885), основателем которого был дантист А.П. Сеницын, а главным редактором — Ф.А. Звержховский. Создание журнала явилось поворотным моментом в истории развития одонтологии в России. Журнал, который просуществовал до 1917 года, стал своеобразным организационным центром, вокруг которого объединилось большое количество зубных врачей, работавших на периферии. «Зубоврачебный вестник» способствовал подготовке и организации одонтологических съездов, научной пропаганде, отображая развитие науки и зубоврачебного дела в России.

В Москве с 1899 по 1915 годы выходил журнал «Одонтологическое обозрение» под редакцией И.М. Коварского и Г.А. Ефрона, а в С.-Петербурге в 1906 году А.В. Фишер начал издавать журнал «Зубоврачебное дело».

В 1896 году в Нижнем Новгороде состоялся I съезд русских дантистов. Всего до революции состоялось шесть одонтологических съездов (1896, 1899, 1905, 1907, 1912) и пять Всероссийских делегатских съездов Союза зубных врачей, созданного в 1905 году по инициативе Г.И. Вильги, П.Г. Дауге, А.В. Фишера. Эти съезды сыграли исключительную роль в развитии научной мысли по одонтологии, в подготовке кадров и организации общественной зубоврачебной помощи в России. На них обсуждались актуальные проблемы зубоврачевания: развитие обезболивания, методы хирургических вмешательств, болезни зубов и их связь с общим состоянием организма и мн. др.

Обеспеченность населения, особенно сельского, зубоврачебной помощью была низкой. Эту помощь оно получало в земских больницах и

фельдшерских пунктах. Зубоврачебную помощь в городах оказывали, в основном, вольнопрактикующие специалисты, иностранцы, приехавшие в Россию за легким заработком. Зубные врачи работали в частных зубоврачебных кабинетах или частных лечебницах. Зубоврачебная помощь в таких лечебницах была более квалифицированной, чем в кабинетах. Наряду с вольнопрактикующими специалистами, росло число врачей при государственных учреждениях. Армия обслуживалась лекарями, фельдшерами.

В Москве, по переписи 1850 года, население составляло около 350 тысяч, на 15 тысяч приходился 1 зубной врач, к 1902 году на 140 млн. населения России был 221 специалист по зубоврачеванию, т.е. 1 врач приходился на 60 тысяч человек. А на все уездные города Московской губернии было всего 2 врача.

Итак, за тысячелетнюю историю Российского государства только в конце XIX века зубоврачевание стало оформляться, как самостоятельная медицинская дисциплина, выделившаяся из хирургии. Благодаря бурному развитию естественных наук, появляются новые направления в медицине, базирующиеся на открытиях в области физиологии и экспериментальных исследованиях. Разработка асептики и антисептики, наркоза стала толчком к развитию хирургии, а стало быть, и зубоврачевания. Открытие частных зубоврачебных школ сыграло положительную роль в подготовке дипломированных специалистов по зубоврачеванию. Но число зубных врачей по-прежнему оставалось ничтожным. Так, в 1909 году только 2,3 % больных, обратившихся за зубоврачебной помощью, были приняты зубными врачами, остальные 97,7% — фельдшерами и врачами других специальностей.

Организация зубоврачебных обществ, проведение съездов, появление периодических и научных изданий, открытие одонтологических центров и кафедр — все это способствовало развитию научного зубоврачевания. Борьба за введение высшего одонтологического образования, в то время, не увенчалась успехом.

4. СТОМАТОЛОГИЯ XX ВЕКА

4.1. Становление и развитие стоматологии

Начало XX века в России ознаменовалось небывалым ростом промышленности. Внешняя торговля стала прибыльной. Российская империя экспортировала треть товарной продукции зерновых и стала самым крупным в мире поставщиком зерна. За пять лет (1908-1913) промышленное производство возросло на 54 %, общее число рабочих увеличилось на 31 %. Передовые промышленники открывали на своих предприятиях ремесленные училища для подготовки квалифицированных кадров. Одновременно с этим нарастало недовольство рабочих и крестьян тяжелыми условиями труда, его низкой оплатой, продолжительностью рабочего дня. Крестьяне требовали земельной реформы. В стране назревала революционная ситуация.

В 1906-1907 годах Министерство народного просвещения разработало проект нового положения для зубо врачебных школ, в котором предполагалось увеличение сроков обучения с 2,5 до 3,5 лет. Медицинская общественность России, правление Российского зубо врачебного союза, указывая на несовершенство проекта Министерства народного просвещения, выдвинула свой проект зубо врачебного образования, в котором предусматривалось открытие в университетских городах правительственных и частных зубо врачебных институтов с 4-го дичным сроком обучения и расширенной программой изучения различных медицинских дисциплин. Оба проекта рассматривались в комиссии по народному образованию Государственной думы. Проект правления Российского зубо врачебного союза не выражал правительственного мнения и поэтому был отвергнут. В 1914 году был утвержден новый проект Министерства народного просвещения, но и он не приобрел силы закона. До октябрьского переворота 1917 года оставался в силе проект Министерства народного просвещения 1907 года. Зубо врачебные кадры по-прежнему готовились в частных зубо врачебных

школах. Специальной подготовки врачей, занимавшихся протезированием, не проводилось.

После революционных событий 1905 года Первая Московская зубо-врачебная школа была закрыта. И.М. Коварский разработал проект новой школы, строительство которой началось в Москве, на Долгоруковской улице, дом 18 (в настоящее время это здание — один из корпусов Московского государственного медико-стоматологического университета). Школа была открыта в 1906 году. В ней были оборудованы 2 аудитории, клиническое и экстракционное отделения, амбулатория для приема и лечения больных, химико-бактериологическая лаборатория, зубопротезная мастерская, первый в России рентгеновский кабинет. Преподавателями в школе были опытные врачи и профессора медицинского факультета Московского университета: анатомию читал Н.В. Алтухов, физиологию — Л.З. Мороховец, хирургию — Ф.А. Рейн, П.В. Циклинская — одна из первых женщин-профессоров России преподавала бактериологию, В.П. Карпов — гистологию, В.С. Богословский — фармакологию и рецептуру, доктор Л.А. Говсеев — одонтологию (впоследствии создавший первую кафедру одонтологии и челюстно-лицевой хирургии при Московском университете), приват-доцент А.П. Левицкий преподавал общую и частную хирургию, И.М. Коварский — протезное и оперативное зубо лечение, М.М. Чемоданов вел занятия по дентиатрии и зубо-врачебной клинике, В.И. Перельман — протезную технику. Первое отечественное руководство В.И. Перельмана «Протезная техника», под редакцией И.М. Коварского, было издано в 1910 году. Учащиеся школы посещали анатомический театр Московского университета, где проводили экстракцию зубов на трупах.

Под руководством И.М. Коварского была разработана программа обучения, написаны учебные пособия. В 1914 году А.И. Абрикосовым, под редакцией И.М. Коварского, была издана монография «Патологическая анатомия полости рта и зубов».

И.М. Коварский много внимания уделял научным проблемам зубо-

врачевания. Он опубликовал работу «К вопросу о сущности и лечении альвеолярной пиореи», в которой лечение пиореи он сводил к полному удалению зубного камня на шейке и корне зуба, выскабливанию некротического края альвеолы, что соответствует современным рекомендациям при лечении пародонтоза (пародонтита). Удаление зубов, лечение пульпитов, препарирование проводилось при обезболивании раствором новокаина.

Обучение продолжалось 2,5 года. Завершив обучение, сдавали экзамены на медицинском факультете Московского университета, после чего им присваивалось звание «Зубной врач». Свидетельство о сдаче экзаменов и присвоении звания «зубного врача» подписывалось ректором МГУ и деканом медицинского факультета.

В 1912 году при Первой московской зубоврачебной школе впервые были открыты курсы усовершенствования для зубных врачей.

Выпускником школы И.М. Коварского (1897) был П.Г. Дауге (в 1893 г. он обучался в зубоврачебном институте Берлинского университета, в 1894 году в С.-Петербурге в зубоврачебной школе Е.Ф. Вонгль-Свидерской), вместе с которым проходила вся дальнейшая общественная деятельность И.М. Коварского: организация Московского одонтологического общества (1898), учреждение и руководство «Российским зубоврачебным союзом», разработка реформы зубоврачебного образования, организация делегатских съездов «Зубоврачебного профессионального союза». За 27 лет своего существования Первая Московская зубоврачебная школа подготовила около 2500 зубных врачей, что было существенным вкладом в развитие зубоврачевания.

Если в 1898 году в России функционировало 9 зубоврачебных школ, то к 1916 году их было около 20. Армия обслуживалась лекарями и фельдшерами. К 1910 году во всех госпиталях были открыты зубоврачебные кабинеты.

С началом Первой мировой войны были прекращены поставки зубоврачебного оборудования из-за рубежа. И.М. Коварский, Л.А. Говсеев, Ро-

зентблум открыли первую Московскую лабораторию «КОГОРО» по изготовлению зубоврачебного инструментария, снабжавшую зубоврачебные кабинеты инструментарием отечественного производства.

Как любая война, Первая мировая принесла много жертв и разрушений. Среди ранений были и челюстно-лицевые повреждения, которые требовали специализированной помощи. Для таких раненых были открыты челюстно-лицевые лазареты. Первый такой лазарет был открыт в 1914 году на средства одонтологического общества при Свято-Троицкой общине Красного Креста. Главным врачом лазарета был Ф.А. Звержховский, а старшим хирургом — профессор Р.Р. Вреден, которых в последующем сменили Г.А. Ефрон и П.П. Львов. Один из госпиталей возглавлял Д.А. Энтин.

В этот период начинается заметное сближение зубных врачей и хирургов в понимании принципов оказания медицинской помощи раненым в челюстно-лицевую область. В 1915 году на благотворительные средства были созданы госпитали в Петрограде, Москве, Киеве, Смоленске и др. городах. В конце того же года зубным врачом Киевского военного округа С.С. Тигерштедтом была разработана рациональная система иммобилизации при переломах челюстей с использованием гнутых алюминиевых шин, получившая большую популярность в Первую мировую войну, в его работе «Военно-полевая система лечения и протезирования огнестрельных челюстных ранений» (1916) было обосновано новое направление в лечении повреждений челюстей. К.П. Тарасов и С.С. Тигерштедт, для оказания первой помощи раненым на передовых позициях, организовали «летучие отряды».

К 1916 году на фронте было организовано несколько зубоврачебных пунктов. Всего насчитывалось 34 зубоврачебных кабинета с 39 зубными врачами, которые должны были обслуживать многомиллионную армию.

По свидетельству В.А. Оппеля — автора системы этапного лечения раненых в полевой санитарной службе царской армии и в большинстве ты-

ловых госпиталей, челюстно-лицевых раненых оперировали только в зависимости от наличия инфекционных осложнений.

В подвижных лазаретах, оперированных с повреждениями костей лица, было 10 %, в госпиталях тыла - 20 %. Возвращение в строй этой категории раненых в войне 1914-1917 годов не превышало 21,7 %.

Г.И. Вильга в книге «Помощь на фронте раненым в челюсть» (1919) наметил основные принципы организации помощи при челюстно-лицевых ранениях. Он дал характеристику ранений и обосновал методы лечения.

Октябрьская революция 1917 года ознаменовала коренной поворот в развитии страны и становлении нового здравоохранения.

26 октября 1917 года в Петроградском военно-революционном комитете был создан медико-санитарный отдел — первая организация по управлению здравоохранением в Советской республике. Возглавил отдел М.И. Барсуков.

При различных наркоматах (путей сообщения, внутренних дел, просвещения, социального обеспечения и др.) были организованы врачебные коллегии, которые 2 декабря 1917 года опубликовали совместное «Обращение к медицинскому персоналу республики о борьбе с заболеваемостью, смертностью и антисанитарными условиями жизни широких масс населения», которое стало программным документом для развития здравоохранения.

24 января 1918 года был издан декрет Совета народных комиссаров (СНК) РСФСР «О Совете врачебных коллегий», руководить Советом был назначен А.Н. Винокуров. Совет врачебных коллегий стал высшим медицинским органом республики.

В июле 1918 года в Москве состоялся V Всероссийский съезд Советов, на котором была принята Конституция РСФСР. 11 июля 1918 года В.И. Ленин подписал Декрет СНК РСФСР «Об учреждении Народного комиссариата здравоохранения», ставшего первым в мире Министерством здравоохранения. В положении о Наркомздраве подчеркивалось, что он

«является центральным медицинским органом, руководящим всем медико-санитарным делом» в РСФСР. Народным комиссаром здравоохранения стал Н.А. Семашко, его заместителем — З.П. Соловьев, а членами коллегии были назначены П.Г. Дауге, А.П. Голубков, В.М. Бонч-Бруевич (Величкина) и Е.П. Первухин. Наркомздраву было поручено объединение всех медицинских коллегий.

17 июля 1918 года коллегия Народного комиссариата здравоохранения приняла «положение о зубоврачебной подсекции комиссариата и ученой одонтологической комиссии» при ней. Возглавил зубоврачебную подсекцию зубной врач П.Г. Дауге.

Для решения научно-методических вопросов, связанных с организацией зубоврачебной помощи в стране, П.Г. Дауге привлек группу ученых, передовых врачей и общественных деятелей: А.И. Евдокимова, Е.М. Гофунга, И.Г. Лукомского, А.А. Лимберга, М.О. Коварского, Н.И. Агапова, Н.А. Астахова, П.П. Львова, Г.А. Ефрона и др.

Задачи, стоящие перед здравоохранением и зубоврачеванием, были огромны. Зубоврачебная подсекция должна была разработать и провести в жизнь все мероприятия по реформе зубоврачебного дела в республике. Основным вопросом, который надо было срочно решать, был вопрос организации зубоврачебной помощи населению страны, потребность в которой была очень велика. Оказывалась она, в основном, частнопрактикующими врачами и была платной, пользоваться ею могли только обеспеченные граждане. Революцию и новую власть медицинская интеллигенция, в том числе и зубные врачи, приняли настороженно, что привело к саботажу врачей и закрытию частных кабинетов. Организация государственных зубоврачебных кабинетов и лабораторий требовала времени и немалых материальных затрат, средств на покрытие которых у государства не было, поэтому для создания государственных учреждений было решено использовать частные зубоврачебные кабинеты.

14 сентября 1918 года было издано «Постановление относительно

использования частных зубоврачебных кабинетов в интересах трудящегося населения», на основании которого все зубные врачи были обязаны оказывать трудящимся бесплатную зубоврачебную помощь. 17 сентября 1918 года вышло еще одно постановление «Об учете зубоврачебных и зуботехнических принадлежностей и материалов». Учет имущества выявил практически полное его отсутствие.

В конце сентября 1918 года зубоврачебная подсекция разработала проект «Положения о национализации зубоврачебной помощи в Советской республике», согласно которого все частные кабинеты с их оборудованием, переходили в руки государства.

26 декабря 1918 года НКЗ было издано постановление «О государственной организации зубоврачебной помощи в республике», которое и сыграло основную роль в становлении зубоврачевания советского периода.

18 февраля 1919 года на основании декрета Совнаркома РСФСР, под контролем и управлением Наркомздрава, были объединены все медицинские учреждения, находящиеся в ведении различных ведомств и организаций, в том числе и страховых. С этого времени началось слияние страховой медицины, существовавшей с 1912 года, с государственной, а потом и полное исчезновение страховой медицины.

Начавшаяся в 1918 году Гражданская война, приостановила реализацию разработанных зубоврачебной подсекцией лечебных, организационных и профилактических мероприятий в области зубоврачевания.

Введение в 1921 году новой экономической политики сказалось и на организации зубоврачебной помощи населению. В условиях НЭПа расходы на здравоохранение должны были покрываться, как государственными средствами, так и местными. Основные изменения касались перевода лечебных учреждений на местный бюджет, за исключением небольшой части амбулаторий крупных городов, поликлиник, обслуживающих школьников, а также рабочих государственных предприятий, работающих на восстановление народного хозяйства страны, которые оставались на государственном обеспечении.

Переход на местные средства, из-за недостатка государственного финансирования, «неблагоприятно, болезненно, а местами губительно отразился на работе органов здравоохранения». В связи с этим были разработаны временные нормы зубопротезной помощи, согласно которым, участникам войны проводилось внеочередное бесплатное протезирование. Бесплатная медицинская и зубопротезная помощь оказывалась только застрахованным гражданам. Платную зубопротезную помощь можно было получить в государственных лабораториях на принципах себестоимости.

10 июля 1922 года постановлением Народного комиссариата здравоохранения «Об использовании зубоврачебного имущества» был закреплён проект «Положения о национализации зубоврачебной помощи в Советской республике» (1918). Постановление подтверждало, что зубоврачебное имущество «как фактически поступившее в ведение органов государственной власти, является имуществом государственным и ни в коем случае возврату в частное владение не подлежит». С этого времени частнопрактикующая зубоврачебная помощь прекратила свое существование.

Для сохранения лечебных учреждений Народный комиссариат здравоохранения часть из них передал на содержание промышленным предприятиям и страховым органам, в результате чего возникла сеть зубоврачебных амбулаторий при заводах, государственных учреждениях, работающих на хозрасчете (1922). Это было хоть и временное, но все же отступление от основных принципов здравоохранения советского периода. П.Г. Дауге (1923) отметил, что между бурно растущим спросом на все виды квалифицированной реальной возможностью его удовлетворения, существует колоссальная пропасть, которую в ближайшем будущем удастся смягчить лишь в ограниченной степени.

6 июня 1928 года, на III Всесоюзном одонтологическом съезде, в докладе «Уроки 10-летнего государственного зубоврачебного строительства», П.Г. Дауге отметил успехи в организации стоматологической помощи. По данным на 1 января 1928 года, общее число зубных врачей в

РСФСР, состоящих на государственной службе, составляло приблизительно 4600 человек, росло число посещений к зубным врачам, увеличилось количество зубоврачебных амбулаторий.

Реорганизация зубоврачебного образования и зубоврачебной помощи началась и в соседних республиках. После окончания Гражданской войны, в январе 1920 года, был создан Наркомздрав УССР, который издал приказы «Об организации зубоврачебной секции при губернских отделах здравоохранения» и «О государственной организации зубоврачебной помощи в Украинской республике». В республике начала развиваться сеть государственных зубоврачебных учреждений, стали готовиться кадры. В этой работе активное участие принимали профессора Е.М. Гофунг, Г.А. Маслов, К.П. Тарасов и др. К концу 1927 года Украине насчитывалось 1409 зубных врачей.

В годы индустриализации страны и коллективизации сельского хозяйства было издано постановление ЦК ВКП (б) «О медицинском обслуживании рабочих и крестьян», принятое 22 декабря 1929 года, в котором отмечались, как успехи в здравоохранении, так и его недостатки: отставание развития здравоохранения от роста народного хозяйства и потребностей трудящихся. Всего по СССР, в государственной сети, количество зубных врачей к 1935 году достигло 11 599. Значительно расширилась и сеть зубоврачебных учреждений, которая на тот период составила по Союзу 6961 учреждение (кроме ведомственных учреждений РККА).

Большую организационную и научно-методическую работу по совершенствованию зубоврачебной помощи и внедрению научных достижений стоматологии в практику проводили Государственный институт стоматологии и одонтологии (ГИСО), Ленинградский стоматологический учебно-практический институт, научно-исследовательский институт в Одессе.

В мае 1937 года в Московском стоматологическом институте состоялось совещание, на котором был обсужден план развития стоматологиче-

ской помощи. В совещании приняли участие представители Наркомздрава СССР и РСФСР, Московских областного и городского отделов здравоохранения, Украинской, Белорусской, Грузинской ССР. Принятые решения были направлены на обеспечение стоматологической помощью населения промышленных районов и сельской местности, на увеличение сети стоматологических учреждений и соответствующих кадров, развитие челюстной хирургии и ортопедии, улучшение оборудования для стоматологических поликлиник и лабораторий.

Военные события на Дальнем Востоке (1938-1939) и в Финляндии (1939-1940) были первым испытанием для молодой отрасли медицины — стоматологии. Если во время империалистической войны 1914-1918 годов смертность лиц, раненых в челюстно-лицевую область, составляла 53 %, то во время боевых операций у Халхин-Гол этот процент в войсковом районе равнялся лишь 0,4 %. Во время советско-финского конфликта (1939-1940) смертность раненых в челюстно-лицевую область колебалась в войсковом районе от 0,4 до 1,1 %.

По данным профессора Д.А. Энтина (1940), 63 % раненым в челюстно-лицевую область, специализированная помощь была оказана в войсковом районе. В период военных действий стоматологи разрабатывали научные основы лечения челюстно-лицевых ранений, используя различные конструкции аппаратов и протезов для фиксации переломов челюстей, совершенствуя методы борьбы с осложнениями таких ранений и др.

Для организации качественной и своевременной помощи лицам с челюстно-лицевыми ранениями был произведен учет существующих клиник и специалистов, разработан норматив помощи для различных медицинских учреждений, предложены стандартные шины для оказания первой помощи и транспортировки раненых. Деятельность стоматологов по оказанию помощи раненым в челюстно-лицевую область в условиях войны проходила в тесном взаимодействии с работой челюстно-лицевых хирургов, ортопедов, оториноларингологов, офтальмологов, нейрохирургов и др. специалистов по показаниям.

Стоматологи справились с возложенными на них задачами, и по словам профессора И.Г. Лукомского: «Самая молодая медицинская специальность в нашем Союзе — стоматология — на полях сражения в Монголии, Польше и Финляндии держала экзамен на аттестат зрелости, и этот аттестат зрелости с отличием должен быть выдан нашей специальности».

Опыт, приобретенный стоматологами в период военных событий на Дальнем Востоке и в Финляндии, послужил основой для дальнейшего совершенствования стоматологической помощи. К началу Великой Отечественной войны уже была создана система доврачебной, первой врачебной, квалифицированной и специализированной стоматологической помощи при ранениях лица и челюстей, разработаны таблицы специального оснащения, образцы шин и т. п. С первых дней войны стало ясно, что она принимает затяжной характер. По сравнению с предыдущими войнами, изменился характер ведения боя, усложнилась военная техника, увеличилась ее поражающая сила, в военных действиях участвовало огромное количество живой силы. Необходимо было срочно менять тактику организации медицинской помощи, в том числе, и стоматологической. «Всякая война заставляет хирургов и травматологов в сравнительно короткий срок переоценивать те ценности, которые накапливались иногда в течение многих лет в предвоенный период», - писал доцент В.Ю. Курляндский в 1944 году.

Стоматологическую помощь в Красной Армии возглавил генерал-майор медицинской службы Д.А. Энтин – один из основоположников военной стоматологии в нашей стране, который предложил целый комплекс мероприятий по улучшению этого вида помощи.

Стоматологической службой на Военно-морском флоте руководил В.М. Уваров. Флагманскими стоматологами были С.М. Давидсон, А.П. Клименков, И.Л. Лившиц. Главными стоматологами и фронтов были Л.Р. Балон, М.К. Гейкин, Я.М. Збарж, И.П. Калинейко, Л.Ю. Кацнельсон, А.А. Кьяндский, А.М. Рарог, В.В. Фиалковский и др. Главными стоматоло-

гами армий — Е.И. Гаврилов, Н.Н. Ежкин, В.П. Забелин, Г.М. Иващенко, В.И. Кулаженко, П.И. Попудренко, на госпитальных базах фронтов — В.И. Заусаев, М.А. Макиенко, Г.И. Семенченко и др. В блокированном Ленинграде организацией стоматологической помощи занимались А.А. Лимберг и П.П. Львов. В сентябре 1941 года все эвакуогоспитали тыловых районов страны были переданы в ведение Наркомздрава СССР и ВЦСПС. Для руководства ими были созданы управления эвакуогоспиталей, возглавляемые опытными специалистами. Организаторами и руководителями стоматологической помощи в системе эвакуогоспиталей Наркомздрава СССР были И.Г. Лукомский, А.И. Евдокимов, Б.Н. Бынин и др.

В основе организации лечебно-эвакуационного обеспечения на фронте и в тылу было проведение единой системы этапного лечения раненых и эвакуацией их по назначению, сортировкой, последовательностью и преемственностью медицинской помощи на каждом этапе.

Основными пунктами этапного лечения являлись: медико-санитарный батальон, челюстно-лицевые отделения специализированных хирургических полевых подвижных госпиталей (СХППГ), госпитальные базы армии и фронта. Раненые, нуждающиеся в длительном лечении, эвакуировались за пределы фронта. На совещаниях стоматологической подсекции ученого медицинского совета при Главном военном санитарном управлении РККА, на научных армейских и фронтовых конференциях, пленумах госпитального совета Наркомздрава СССР был изучен положительный опыт лечения раненых, намечены пути его немедленного внедрения в практическую деятельность медицинской службы различных фронтов.

Коллективный анализ лечения раненых в челюстно-лицевую область дал возможность рационально решить ряд вопросов военной челюстно-лицевой хирургии и ортопедии. Было признано эффективным раннее оперативное вправление отломков при лечении переломов челюстей в случаях безуспешного или малоэффективного эластического вытяжения. Нашли широкое применение активные методы хирургического лечения при огне-

стрельном остеомиелите челюстей, ранние пластические операции при наличии свежих рубцов и в только что закончившихся воспалительных процессах (Г.А. Васильев, Н.М. Михельсон, М.В. Мухин и др.). По показаниям проводились местные пластические операции при первичной хирургической обработке ран, при гранулирующих ранах (Л.Р. Балон, В.И. Кулаженко и др.). Хирурги-стоматологи пересмотрели сроки костно-пластических операций на нижней челюсти с 6-12 месяцев до 2-4 месяцев после ранения, а иногда сразу после заживления раны и исчезновения признаков воспаления (Э.А. Александрова, Е.М. Жак, М.П. Жаков, Н.М. Михельсон, М.В. Мухин, И.М. Оксман и др.).

В 1943 году А.А. Лимберг предложил использовать для костной пластики нижней челюсти расщепленный отрезок ребра. Его метод получил широкое распространение в челюстно-лицевой хирургии. В 1946 году вышла в свет его книга «Математические основы местной пластики на поверхности человеческого тела», которая была удостоена Сталинской премии. Необходимо отметить работы И.А. Бегельмана, М.М. Великановой, И.П. Калинейко, К.Ф. Крайзера, А.А. Кьяндского и др. по клинике, диагностике, лечению и профилактике осложнений при огнестрельных ранениях челюстно-лицевой области. Заслуживают внимания оперативные методы по ускоренной частичной ринопластике (Э.А. Александрова, 1943) и тотальной ринопластике с применением филатовского стебля (Ф.М. Хитров, 1947), последняя методика получила мировую известность. Совершенствование способов образования и применения стебельчатого лоскута Филатова было проведено многими авторами (Л.М. Обухова, 1940-1948; Е.М. Жак, 1944; А.Г. Лапчинский, 1944 и др.)

В военные годы были разработаны новые методы оперативных вмешательств при закрытии свищей (Г.А. Васильев, А.А. Лимберг, В.М. Уваров), разрешен ряд вопросов, связанных с нарушением акта глотания, что позволило понять механизм аспирационных пневмоний при челюстно-лицевых ранениях и упростить способы кормления таких раненых (И.С. Рубинов).

Стоматологи-ортопеды работали в содружестве со стоматологами-хирургами, направляя свои усилия на восстановление анатомической формы и функции органов челюстно-лицевой области. Ортопедическое лечение переломов челюстей проводилось в комплексе с другими приемами лечения, к которым, в первую очередь, следует отнести хирургические вмешательства, восстановительную терапию, в том числе и физиотерапию, что создавало условия для достижения наибольшего успеха в лечении.

Аппарат, предложенный В.Ф. Рудько и носящий его имя, внедрен в практику для лечения переломов нижней челюсти, долгое время и после войны применялся при лечении указанной патологии. Затем появились многочисленные модификации, которые применяются и в настоящее время.

Стоматологи разработали новые хирургические приемы, направленные на ускорение сроков лечения и предупреждения осложнений. В специализированных госпиталях, кроме стоматологов, работали невропатологи, офтальмологи, оториноларингологи, нейрохирурги и другие специалисты, что давало возможность оказывать высококвалифицированную и узко специализированную помощь, достигая при этом хороших, как косметических, так и функциональных результатов.

В челюстно-лицевых эвакуационных госпиталях системы Наркомздрава СССР за год Великой Отечественной войны был накоплен богатый клинический опыт, который требовал анализа и обобщения. Этой задаче была посвящена научная конференция работников челюстных госпиталей, созванная Управлением эвакуационных госпиталей Наркомздрава РСФСР и состоявшаяся в Москве 13-15 сентября 1942 года, на которой была дана оценка основных методов лечения раненных в лицевую область. В докладе «Клинические итоги деятельности челюстных госпиталей» Б.Н. Бынин указал, что при лечении переломов челюстей не полностью были использованы богатые возможности ортопедических методов лечения, что приводило к возникновению контрактур, псевдоартрозам, неправильно сросшимся переломам и пр. На конференции было отмечено преимущество одночелюстного шини-

рования огнестрельных переломов челюстей, которое обеспечивало скорейшее выздоровление и возвращение раненых в строй.

В первые годы войны, для межчелюстной фиксации применялись, в основном, проволочные шины. Однако опыт показал несовершенство этого метода, а анализ результатов лечения раненых подтвердил, что контрактура развивалась почти в 35% случаев, наблюдался большой процент неправильно сросшихся отломков. Поэтому стоматологи стали и разрабатывать новые, более совершенные методы лечения таких ранений. Стало развиваться функциональное направление при лечении переломов челюстей, основы которого были разработаны В.Ю. Курляндским и изложены им в докторской диссертации (1943) и книге «Функциональный метод лечения огнестрельных переломов челюстей», вышедшей в 1944 году. Ученый обобщил и проанализировал накопленный опыт лечения огнестрельных переломов челюстей, научно обосновал преимущества одночелюстного шинирования, разработал показания к его применению предложил комплекс общей и специальной лечебной физкультуры при челюстно-лицевых ранениях с применением механотерапевтических аппаратов.

В 1944 году на IV пленуме ученого медицинского совета по челюстно-лицевой хирургии при медико-санитарном управлении Военно-морского флота с докладом «Ошибки в лечении челюстно-лицевых раненых» выступил профессор И.Г. Лукомский, который отметил, что в 1943 году результаты лечения такого вида ранений, по основным показателям, стали значительно лучшими, чем в 1942 году. Функциональное лечение таких раненых привело к положительному результату. В годы Великой Отечественной войны в челюстно-лицевых госпиталях госпитальной базы фронта и тыловых районов при обширных повреждениях лица изготавливали протезы носа, уха и других частей лица, используя для этого различные пластические массы, внедренные в ортопедическую стоматологию незадолго до войны (Б.Н. Бынин, С.С. Шведов, Д.Н. Цитрин и др.).

Стоматологи разрабатывали оригинальные методы лечения челюст-

но-лицевых ранений, применяли оригинальные конструкции репонирующих, шинирующих, формирующих и заменяющих шин, аппаратов и протезов. Для лечения и предупреждения осложнений применялись специальные аппараты для механотерапии и протезы при ложных суставах, микростомиях, неправильно сросшихся переломах. Разнообразие клинической картины ранений и заболеваний требовало разработки многочисленных модификаций методов ортопедического лечения челюстно-лицевых повреждений, изобретения различных аппаратов, шин и протезов.

Все это достигалось высокой теоретической и клинической квалификацией врачей, а также индивидуальным подходом к раненому. Большой вклад в разработку новых методов лечения внесли А.Л. Грозовский, Я.М. Збарж, В.Ю. Курляндский, Н.М. Михельсон, И.М. Оксман, З.Н. Померанцева-Урбанская, Л.Е. Шаргородский, З.Я. Шур и др., которые предложили оригинальные способы челюстного протезирования, индивидуальные конструкции челюстных протезов, фиксирующие аппараты и протезы лица. Многие из них нашли широко применение при лечении огнестрельных травм лица, как в годы Великой Отечественной войны, так и в послевоенный период.

Вся стоматологическая помощь в военные годы в стране была направлена, главным образом, на лечение челюстно-лицевых раненых. В тылу стоматологическая помощь оказывалась, в первую очередь, рабочим и служащим, работающим на оборонную промышленность. Поэтому на крупных оборонных предприятиях создавались медико-санитарные части (МСЧ), в состав которых входили закрытые стационары, поликлиники или амбулатории, стоматологические кабинеты, стоматологические отделения с зубопротезным и лабораториями.

Объем медицинской помощи гражданскому населению во время войны был сокращен из-за разрушения медицинских учреждений на оккупированных территориях страны. В связи с временной оккупацией немцами Харькова и блокадой Ленинграда, где располагались заводы по произ-

водству зубоврачебных материалов, значительно ухудшилось снабжение ими медицинских учреждений.

За военные годы здравоохранение лишилось 6 000 больниц, 33 000 поликлиник, диспансеров и амбулаторий, 976 санаториев и 655 домов отдыха, 1125 санэпидстанций, 60 фабрик и заводов медицинской промышленности. На фронте и в тылу самоотверженно трудились свыше 200 000 врачей, полумиллионная армия средних медицинских работников. Специалисты оказали помощь более 10 млн. раненым. Благодаря четко продуманной и организованной сети специализированных лечебных учреждений в действующей армии и в тылу, было полностью излечено и возвращено в строй 85,1 % раненых в челюстно-лицевую область, а в группе с изолированными повреждениями мягких тканей лица — 95,5%. По количеству возвращенных в строй, среди других групп раненых, раненные в лицо, заняли первое место.

Профессор М.В. Мухин писал, что «такого большого числа вернувшихся в строй не было ни в одной из предыдущих войн и ни в одной армии государств, участвовавших во Второй Мировой войне» (1967). В декабре 1943 года на коллегии Наркомздрава СССР были обсуждены основные направления развития стоматологической помощи в стране на ближайшие годы. Приказ Наркомздрава СССР № 654 предписывал к 25 января 1944 года укомплектовать все вакантные должности зубными врачами и стоматологами за счет врачей, работавших в годы Великой Отечественной войны не по специальности. Предусматривалось организовать при стоматологических институтах клиническую ординатуру для подготовки специалистов. Приказ обязывал также медицинскую промышленность в ближайшее время обеспечить сеть зубоврачебных и зуботехнических учреждений всеми необходимыми материалами и инструментарием.

В 1945 году состоялась Всесоюзная конференция стоматологов, на которой был подведен итог колоссального опыта работы стоматологов на фронтах и в тылу страны. Обобщению опыта лечения раненых с челюстно-

лицевым повреждениями в условиях военных действий были посвящены многочисленные публикации. Большое значение имели научные работы тех лет: «Военная челюстно-лицевая хирургия» Д.А. Энтина (1941), «Огнестрельные ранения лица и челюстей и их лечение» А.А. Лимберга (1941), «Лечение челюстно-лицевых повреждений в тыловых госпиталях» В.М. Уварова (1942), «Травматические остеомиелиты» И.Г. Лукомского (1942), «Пластические операции на лице» А.Э. Рауэра и Н.М. Михельсона (1943), «Восстановительная хирургия лица и других органов» Г.Р. Курбанова (1944), «Шинирование челюстно-лицевых раненых в госпиталях армейского и фронтового тыла» И.А. Бегельмана и М.П. Фиделя (1944), «Функциональный метод лечения огнестрельных переломов челюстей» В.Ю. Курляндского (1944).

Особое место занимает коллективный труд «Огнестрельные ранения и повреждения лица и челюстей», опубликованный в книге «Опыт советской медицины в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», в написании которого принимали участие виднейшие специалисты страны.

Военные медики с честью выполнили свой гражданский и профессиональный долг. Самоотверженный труд многих медицинских работников был отмечен орденами и медалями, а зубной врач Б.П. Бегоулев стал первым среди Героем Советского Союза.

Впервые послевоенные годы основное внимание было уделено ликвидации санитарных последствий войны, в том числе восстановлению разрушенных фашистскими захватчиками стоматологических учреждений.

Решение вопросов врачебно-трудовой экспертизы и правильное определение путей и возможностей трудоустройства и приспособления к труду инвалидов имеет исключительное значение. Приказ министра здравоохранения СССР N417 от 3 июля 1946 года предписывал медицинское обслуживание инвалидов Великой Отечественной войны возложить на Главное управление госпиталей. В ряде городов страны были открыты госпитали для лечения инвалидов Великой Отечественной войны. Одной

из главных задач, которую необходимо было решать стоматологической службе — это долечивание и трудовая реабилитация инвалидов Великой Отечественной войны. В.Ю. Курляндский: « ... снижение инвалидности является благороднейшей задачей исследователя». В 1948 году был издан его труд «Клиника и экспертиза трудоспособности при заболеваниях и повреждениях лица и челюстей», который был первой попыткой проанализировать и обобщить большой материал, накопившийся у отечественных специалистов и лично у автора по экспертизе трудоспособности и реабилитации инвалидов.

С конца 1943 года, непрерывно росло число восстановленных и вновь организованных стоматологических учреждений. К 1 января 1945 года их было уже 92 % в городах и 80 % в сельской местности, по сравнению с довоенным уровнем. Зубопротезные отделения были восстановлены на 60 % в городах и на 32 % в сельской местности.

В 1946 году в Москве при челюстно-лицевом госпитале, был организован стоматологический центр, в котором был сформирован стоматологический совет. В состав совета вошли профессора Б.Н. Бынин, Г.А. Васильев, А.Е. Верлоцкий, А.И. Евдокимов, И.Г. Лукомский, Н.М. Михельсон, Е.Е. Платонов, А.Э. Рауэр, И.М. Старобинский и другие специалисты. Центр проводил организационно-методическую работу среди районных и городских стоматологов. В послевоенный период Министерством здравоохранения СССР были изданы приказы и инструктивно-методические письма, направленные на организацию и улучшение и стоматологической службы в стране.

В июле 1949 года вышел приказ министра здравоохранения СССР N549 «Об улучшении стоматологической помощи населению», который обязывал устранить недостатки в работе стоматологической службы в РСФСР. На тот момент в республике было более 300 районов, в которых не было ни одного не только стоматолога, но и зубного врача. В союзных республиках некоторые районы были полностью лишены стоматологиче-

ской помощи (Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан и др.). Больные были вынуждены ехать в Москву или другие крупные города, где они могли получить только консультативную помощь и рекомендации лечиться по месту жительства.

4 февраля 1950 года Министерство здравоохранения СССР издало приказ, на основании которого были разработаны штатные нормативы медицинского персонала стоматологических поликлиник, отделений и кабинетов, нормы нагрузки для врачей-стоматологов.

25 октября 1951 года Министерство здравоохранения СССР разработало инструктивно-методическое письмо «О качественных показателях работы стоматологических поликлиник, отделений, кабинетов». В 1951 году был издан приказ министра здравоохранения СССР N977 «О предельных ценах на зубные протезы, ортопедической помощи детям и подросткам», согласно которому ортодонтическая помощь детям и подросткам должна оказываться бесплатно, за счет ассигнований из бюджета.

За десять послевоенных лет число стоматологических поликлиник, отделений и кабинетов в СССР увеличилось в 1,2 раза и в сельских местностях — в 2,5 раза, число зубопротезных учреждений увеличилось в городах в 3,5 раза, а в сельских местностях — 8,6 раза. В 1961 году Совет министров СССР вынес постановление «О мерах по улучшению стоматологической помощи населению», реализация которых была воплощена Приказом министра здравоохранения СССР N 386 от 2 сентября 1961 года. Расширение сети стоматологических учреждений и рост численности стоматологических кадров обусловил дальнейшее расширение объема стоматологической помощи населению, увеличение числа посещений к врачам-стоматологам.

5 июля 1968 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление N 517 «О мерах по дальнейшему улучшению здравоохранения и развитию медицинской науки в стране», в котором предусматривалось дальнейшее улучшение стоматологической помощи населению страны за

счет дальнейшего роста сети лечебных стоматологических учреждений, строительства крупных специализированных стоматологических поликлиник, зубоврачебных лабораторий, оснащенных по последнему слову техники, совершенствования организационных форм стоматологической помощи.

В 1970 году был принят закон «Основы законодательства СССР и союзных республик о здравоохранении», который был призван способствовать дальнейшему улучшению охраны здоровья народа. Задачи здравоохранения в области стоматологии 1971-1975 годы были отражены в докладе министра здравоохранения СССР академика Б.В. Петровского на Всесоюзном совещании актива работников здравоохранения (1971): «Нужно обратить особое внимание на развитие стоматологических поликлиник и стоматологических отделений, быстрее внедрять в практику стоматологических учреждений современные материалы и методы обезболивания, лечения и протезирования, улучшить профилактику и, прежде всего, среди детей».

К 1972 году насчитывалось 783 самостоятельные стоматологические поликлиники, 13922 — отделения и кабинета в городах, 10781 — в сельской местности. Подъем материального и культурного уровня населения, успехи в развитии науки и техники повысили требования к оказанию медицинской помощи.

В 1971-1975 годах материальная база здравоохранения и медицинской науки получила дальнейшее развитие. 5 ноября 1976 года вышло в свет постановление Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему улучшению стоматологической помощи населению» и приказ министра здравоохранения СССР от 10 декабря 1976 года за N 1166 «О мерах по дальнейшему улучшению стоматологической помощи населению». Предусматривалось открыть еще 466 стоматологических поликлиник, ввести в строй 4390 стоматологических отделений и кабинетов, 702 зубопротезных отделения и кабинета, больше половины из них — в сельской местности.

Все последующие годы вплоть до 90-х годов XX столетия обеспечение стоматологической помощью шло по пути увеличения кадров и количества стоматологических учреждений.

Большие перспективы развития ортодонтической помощи определены постановлением Совета министров СССР 1976 года «О мерах по дальнейшему улучшению стоматологической помощи населению». Основные положения в организации ортодонтической помощи детям и подросткам были изложены в соответствующих приказах министерств здравоохранения СССР, РСФСР, в инструктивных письмах министерств здравоохранения, резолюциях съездов, заседаний, пленумов, симпозиумов, конференций.

Приказом МЗ СССР «О мерах по дальнейшему улучшению стоматологической помощи населению» от 12 июня 1984 года N 670 предусмотрено:

- обеспечить дальнейшее развитие сети стоматологических поликлиник, отделений, кабинетов, особенно детских;
- укомплектовать стоматологические поликлиники, отделения, кабинеты врачами и средним медицинским персоналом в соответствии с установленными штатными нормативами и обеспечить систематическое повышение квалификации;
- обеспечить организацию стоматологических кабинетов на всех промышленных предприятиях и высших учебных заведениях;
- обеспечить внедрение комплексной программы профилактики кариеса зубов;
- принять неотложные меры в работе фтораторных установок;
- обеспечить плановую санацию полости рта детям, подросткам, взрослым;
- принять меры к внедрению в практику современных методов местного и общего обезболивания.

В целях развития стоматологической помощи населению, упорядочения системы учета труда врачей стоматологического профиля и ориен-

тации их работы на конечные результаты приказом МЗ СССР «О переходе на новую систему учета труда врачей стоматологического профиля и совершенствовании формы организации стоматологического приема» от 25 января 1988 года N50 введена система учета труда врачей, основанная на измерении объема их работы в условных единицах трудоемкости (УЕТ).

В связи с широко развивающимся процессом освоения новых технологий профилактики, диагностики и лечения стоматологических заболеваний, внедрения современных материалов, инструментов, аппаратуры и в целях повышения эффективности работы и улучшения качества стоматологической помощи населению был издан приказ МЗ РФ «О совершенствовании системы учета труда врачей стоматологического профиля» от 2 октября 1997 года N289.

Для ускорения развития стоматологической помощи населению приказом МЗ СССР «О комплексной программе развития стоматологической помощи населению» от 18 ноября 1988 года N830 утверждена комплексная программа развития стоматологической помощи в стране до 2000 года, в которой предусмотрено:

- увеличение численности врачей-стоматологов из расчета 5,9 должностей на 10 тыс. населения;
- увеличение числа стоматологических поликлиник, в том числе хозрасчетных;
- развитие стационарной стоматологической помощи;
- развитие материально-технической базы стоматологической службы;
- открытие новых стоматологических факультетов, факультетов усовершенствования врачей, подготовка научных и педагогических кадров;
- развитие детской стоматологии, особенно ортодонтической помощи;
- разработка и выпуск новых пломбировочных материалов;
- увеличение объема помощи при заболеваниях пародонта и слизистой оболочки полости рта;
- широкое внедрение анестезиологических пособий в стоматологическую практику;

- создание центров по оказанию помощи больным с врожденными и приобретенными пороками развития;
- разработка и внедрение мероприятий по профилактике и ранней диагностике злокачественных новообразований челюстно-лицевой области;
- укрепление ортопедических отделений и зуботехнических лабораторий;
- совершенствование методов диагностики (рентгенография, функциональная диагностика).

90-е годы XX столетия были годами коренных изменений в государственном устройстве страны. Произошел распад СССР. Все бывшие республики СССР получили самостоятельность и стали суверенными государствами. Россия стала Российской Федерацией. Деятельность лечебно-профилактических учреждений в Российской Федерации в том числе и стоматологических, независимо от их организационно-правовой основы и формы собственности, регламентируется Основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года N 5487-1. Стоматологическую службу в России планирует и контролирует Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию Российской Федерации.

С распадом СССР, формированием рыночных отношений в России, в организации, управлении и структуре стоматологической службы страны произошли серьезные изменения. В 1991 году был введен в действие Федеральный закон РФ «О медицинском страховании граждан РФ», в 1993 году Федеральный закон «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан», ориентировавшие функционирование здравоохранения в системе рыночных отношений.

Этот год официально считается началом периода реформирования системы здравоохранения РФ. Предпосылками к принятию этих законов служили недостатки финансирования здравоохранения, бесплатная бюджетная медицина, увеличивающаяся обращаемость за медицинской помо-

щью при увеличении количества врачей, объема проводимых исследований и числа медицинских услуг. Рост количества показателей деятельности здравоохранения не способствовал улучшению показателей качества медицинской помощи (Ю.П. Лисицын, Е.Н. Савельева, Ю.А. Таранов, 2001; М.В. Айвазова, В.О. Гурдус, В.В. Петухова, Н.В. Нестеренко, 2001). Введение новой системы финансирования и организации здравоохранения предполагало оказание медицинской помощи и профилактических мероприятий гражданам за счет государственных и накопленных личных денежных средств граждан.

В качестве основы реформирования здравоохранения закон утверждал систему социального страхования в виде системы обязательного медицинского страхования (ОМС) и добровольного медицинского страхования (ДМС). Закон направлял деятельность медицинских учреждений на получение прибыли от оказания медицинских услуг. Более того, деятельность лечебных учреждений в создавшихся условиях считается «предпринимательской» на условиях ДМС и «иной», т.е. частной предпринимательской (ст. 2, ФЗ РФ №1499-1 от 28 июня 1991 года; ФЗ №220 от 9 января 1996 года).

Закон был направлен на достижение главной цели реформирования здравоохранения — получения дополнительных источников финансирования и улучшения качества медицинской помощи населению в рамках программы государственных гарантий (В.З. Кучеренко, 1997; М.И. Шуховцев, 2000).

В основу государственного управления здравоохранением РФ были заложены следующие организационные принципы:

1. Всеобщность — гарантированное право на бесплатное получение медицинских услуг, включенных в программу ОМС всех граждан, независимо от пола, возраста, состояния здоровья, места жительства, уровня личного дохода. Нормы ОМС распространяются на работающих граждан с момента заключения с ними договора.

2. Государственность — государство является непосредственным страхователем для неработающей части населения (учащиеся, студенты, пенсионеры).

3. Некоммерческий характер — средства ОМС не могут стать доходом или прибылью юридических и физических лиц, являющихся учредителями страховых медицинских компаний.

4. Общественная солидарность и социальная справедливость. Все граждане имеют равные права на получение медицинской помощи за счет средств ОМС. Страховые платежи по ОМС увеличиваются за счет средств ОМС.

Согласно ФЗ РФ «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации» (1991), обязательное медицинское страхование является всеобщим для населения России и реализуется в соответствии с программами (федеральными, территориальными), которые гарантируют объем и условия оказания медицинской и лекарственной помощи гражданам.

Приказом МЗ МП РФ «О правилах предоставления платных медицинских услуг населению» от 29 марта 1996 года N 109 объявлено Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил предоставления платных медицинских услуг населению медицинскими учреждениями» от 13 января 1996 года N 27» и рекомендовано руководителям органов здравоохранения субъектов РФ принять меры по его выполнению.

Изданию приказа МЗ МП РФ «Об организации стоматологических учреждений в новых экономических условиях хозяйствования» от 6 августа 1996 года N 312 предшествовало недостаточное бюджетное финансирование стоматологических учреждений, невозможность фондов ОМС компенсировать дефицит бюджета, что привело к снижению уровня удовлетворения потребности в стоматологической помощи и ее качества, сдерживало внедрение в практику новых технологий. Руководителям органов управления здравоохранением было рекомендовано предусмотреть:

- бюджетное финансирование стоматологических учреждений в зависимости от выполненного объема работы, выполненного в УЕТ;

- расходы, не восстанавливаемые бюджетом или фондом ОМС, компенсировать за счет хозяйственной деятельности в рабочее время;
- вести отдельный учет и накопление имущества, приобретенного в результате хозяйственной деятельности;
- вести раздельный статистический и финансовый учет в зависимости от источников финансирования.

Главной задачей стоматологии на современном этапе является создание качественной гарантированной бесплатной стоматологической помощи населению, чего необходимо активное реформирование стоматологии, повышение уровня подготовки кадров врачей стоматологического профиля, внедрение в стоматологическую практику новейших достижений науки и техники с использованием современных технологических исследований.

4.2. Подготовка специалистов стоматологического профиля — зубных врачей и врачей-стоматологов

1 октября 1918 года вышел декрет Народного комиссариата здравоохранения и Народного комиссариата просвещения о реформе зубоврачебного образования, в котором говорилось: «Отныне зубоврачебное образование будет неразрывно связано со всей системой высшего медицинского образования».

На медицинских факультетах некоторых университетов стали создавать одонтологические отделения, в состав которых предусматривалось включение трех профильных кафедр: патологии и терапии зубных болезней, протезной техники и хирургии челюстей и полости рта. Но из-за отсутствия материальной базы и квалифицированных преподавателей, открыть одонтологические отделения в те годы не удалось.

24 марта 1920 года было издано постановление Наркомздрава и Наркомпроса о создании на медицинских факультетах государственных

университетов кафедр одонтологии с соответствующими клиниками, на которых предполагалось преподавание специального курса по всем разделам стоматологии.

В 1919 году профессором Н.А. Астаховым была организована кафедра одонтологии в Донецком медицинском институте, в 1920 году профессор Л.А. Говсеев создал кафедру одонтологии полости рта и челюстной хирургии на медицинском факультете I Московского государственного университета, а в Казанском медицинском институте кафедру одонтологии и стоматологии открыл профессор П.А. Глушков. В последующие годы одонтологические кафедры при медицинских факультетах были открыты в Астрахани, Воронеже, Иркутске, Ленинграде, Минске, Тифлисе и др. городах. Среди руководителей кафедр были: Н.И. Агапов, Г.И. Вильга, С.Н. Вайсблат, А.И. Евдокимов, А.И. Едиберидзе, П.Н. Карташов, К.И. Коган, А.А. Лимберг, И.Г. Лукомский, П.П. Львов, И.М. Старобинский, Г.Л. Фельдман, Д.Л. Энтин и др. ученые.

В 1919 году был организован Государственный одонтологический институт в Киеве, преобразованный позднее в одонтологический факультет Киевского медицинского института. Первым деканом факультета был заведующий кафедрой одонтологии и зубного протезирования профессор К.П. Тарасов.

В 1921 году был организован Государственный одонтологический факультет в Харьковском государственном медицинском институте, где занял должность декана факультета. Одонтологические факультеты на Украине, созданные в 1921 году, в 1930 году были реорганизованы в стоматологические институты.

На одонтологических факультетах Украины стоматологические кадры стали готовить в течение 3,5 лет. Количество зубных врачей увеличивалось, а качество подготовки из-за недостаточных общемедицинских знаний было невысоким. Против организации одонтологических факультетов выступал П.Г. Дауге, который так характеризовал одонтологические фа-

культеты: «Одонтологический факультет был и остался реформированной зубоврачебной школой, получившей громкую вывеску, но не изменившей своего внутреннего облика. Кончивший одонтологический факультет специалист является, в силу вещей, узким специалистом в своей области (не врачом в широком смысле этого слова), но, несомненно, с несколько повышенной биологической и общемедицинской подготовкой по сравнению с зубным врачом старой формации». Специалистов по одонтологии на медицинских факультетах готовили путем прохождения специального курса стажировки в одонтологических клиниках и других лечебных учреждениях. Такую специализацию позднее проводил Государственный институт зубоврачевания (ГИЗ), также некоторые крупные показательные зубоврачебные учреждения областных и республиканских центров. Реформа зубоврачебного образования предусматривала повышение уровня медицинских знаний зубных врачей путем усовершенствования.

Первые курсы усовершенствования были открыты в 1919 году в Москве. Курсанты, а это были зубные врачи, ранее закончившие частные зубоврачебные школы, в течение 2 месяцев слушали лекции, выполняли практические занятия по всем разделам зубоврачевания.

20 марта 1922 года в «Бюллетене Народного комиссариата здравоохранения» было опубликовано Положение о Государственном институте зубоврачевания, подписанное 25 февраля 1922 года народным комиссаром здравоохранения Н.А. Семашко.

2 апреля 1922 года было издано постановление коллегии Наркомздрава РСФСР о создании Государственного института зубоврачевания (ГИЗ), переименованного в 1927 году в Государственный институт стоматологии и одонтологии (ГИСО), а в 1932 году — в Государственный научно-исследовательский институт стоматологии и одонтологии (ГНИИСО). Директором ГИЗа был назначен профессор М.Б. Янковский, после смерти которого в 1923 году, институт возглавил А.И. Евдокимов.

Согласно положению о Государственном институте зубоврачевания,

на него возлагались следующие основные функции: «Подготовка из среды зубработников квалифицированных специалистов в области зубоврачевания; проведение научных исследований; объединение в научно-лечебных целях всех лечебных учреждений стоматологического профиля; организация постоянных и прерывистых курсов усовершенствования вспомогательных и технических кабинетов или отделений; разработка новых форм общественного зубоврачевания; создание совета института (директор, заведующий отделением и председатель зубоврачебной секции НКЗ РСФСР) в качестве высшего научно-административного органа ГИЗа».

Оценивая итоги пятилетней деятельности ГИЗа Н.А. Семашко в 1927 году отмечал, что в стенах ГИЗа подготовлено немало научных работников, которые двигают вперед дело научного и практического зубоврачевания; в нем могли на курсах усовершенствования пополнить и развить свои знания многие и многие сотни зубных врачей. Специализация и усовершенствование зубных врачей проводилась и в научно-практических стоматологических институтах Киева, Харькова, Одессы, Горького, Минска.

В 1927 году в Ленинграде был открыт Научно-практический институт, организатором и директором которого был кандидат медицинских наук, доцент З.Б. Пирятинский.

30 марта 1927 года Наркомздрав издал распоряжение, в котором говорилось: «НКЗ считает возможным допустить квалифицированного техника к вспомогательным манипуляциям во рту, связанным со снятием слепка, определением системы протеза, прикуса и цвета зубов, с примеркой и сдачей протеза, причем ответственность за выполнение этих этапов в процессе протезирования целиком возлагается на врача (зубного). Также вспомогательные манипуляции разрешаются исключительно под руководством врача (зубного)».

22 июня 1930 года ЦК Союза Медсантруд, Наркомздрав, Московский областной отдел труда и Московский отдел здравоохранения вынесли решение о немедленном открытии четырехмесячных курсов по переквали-

фикации техников в зубных протезистов. С 15 ноября 1930 года при I Московском государственном университете начали функционировать девяти-месячные курсы по переквалификации зубных техников в зубных протезистов. Научным руководителем курсов стал профессор И.Г. Лукомский.

Подобные курсы были организованы и в других городах страны. Ими руководили профессора Н.И. Агапов, Е.М. Гофунг и др. Возросшая потребность населения в специализированной стоматологической помощи повлекла за собой принятие решений комиссариатов здравоохранения ряда союзных республик (БССР — 1931 г., РСФСР — 1932 г. и др.) об открытии зубоврачебных школ с трехгодичным сроком обучения.

Анализ материалов по развитию стоматологического образования показал, что до 1935 года в стране не было единой системы подготовки кадров стоматологического профиля. На Всероссийском совещании по зубоврачебному образованию (1935) было отмечено, что «в РСФСР существует зубоврачебное образование только как среднее медицинское образование, на Украине — только как высшее медицинское образование, на местах зубных врачей готовят всякий по-своему: существуют курсы по подготовке зубных врачей из лиц со средним медицинским образованием шестимесячные, восьмимесячные, годовые, организованы курсы по переподготовке людей без всякого медицинского образования в течение нескольких месяцев. Одним словом каждый решает этот вопрос по-своему». Существующая система специализации врачей, окончивших медицинские факультеты, не решала проблема подготовки будущих врачей-стоматологов.

9 июня 1935 года был издан приказ Наркомздрава «О мероприятиях по подготовке к открытию стоматологических институтов», в котором были разработаны меры по подготовке стоматологических кадров. Специалисты стоматологического профиля стали готовить в стоматологических институтах с четырехлетним сроком обучения, при образовательном цензе для поступающих, в объеме полной средней школы. Стоматологические институты были открыты в крупных городах России.

В 1935 году на базе ГНИИСО был организован Московский стоматологический институт (МСИ), основной задачей которого стала подготовка врачей-стоматологов преимущественно для Российской Федерации. В 1939 году в МСИ состоялся первый выпуск врачей-стоматологов (79 человек). В 1941 году дипломы врачей-стоматологов получил 261 выпускник. В 1939 году ГНИИСО и МСИ были объединены в один институт — Московский государственный стоматологический институт (МГСИ).

Помимо подготовки стоматологов в институтах, зубных врачей продолжали готовить путем усовершенствования. Приказ Наркомздрава от 10 июня 1935 года предусматривал создание годичных курсов усовершенствования зубных врачей, имеющих 10-летний стаж практической работы и определенные заслуги в научной или общественно-политической области. С 1936 года обучение проводилось в течение 2 лет, а затем срок обучения был увеличен до 2,5 лет. Курсы прекратили свое существование в мае 1939 года.

На основании постановления Совета народных комиссаров СССР от 8 сентября 1936 года «О подготовке средних зубоврачебных и фармацевтических кадров» зубных врачей стали готовить в зубоврачебных школах с трехлетним сроком обучения и образовательным цензом не ниже 7 классов. Таким образом, была узаконена двухсистемная подготовка специалистов стоматологического профиля (зубные врачи и врачи-стоматологи).

В 1946 году на кафедрах МГСИ была открыта клиническая ординатура. 20 сентября 1949 года, по приказу Минздрава СССР за №783, стоматологические институты были реорганизованы в медицинские стоматологические институты с пятилетним сроком обучения, что позволило улучшить качество подготовки стоматологических кадров в нашей стране.

В 1950 году в ММСИ открыли аспирантуру. Обучение врачей в клинической ординатуре и подготовка научных работников в аспирантуре дали возможность выпускать специалистов высокой квалификации. В 50-е годы XX века в систему высшего стоматологического образования было

введено заочно-очное и вечернее обучение. В Московском медицинском стоматологическом институте (ММСИ) были созданы соответствующие факультеты, на ряде стоматологических факультетов — отделения. Заочно-очное обучение вводилось для зубных врачей, имеющих стаж работы по специальности не менее трех лет, по окончании института выпускники получали диплом врача-стоматолога. На вечерний факультет принимали лиц с законченным средним медицинским образованием.

Большую роль в подготовке стоматологических кадров сыграло Постановление Совета министров СССР 12 августа 1961 года «О мерах по улучшению стоматологической помощи населению». В сентябре 1961 года, по Приказу министра здравоохранения СССР № 386, министрам здравоохранения союзных республик было предложено разработать планы конкретных мероприятий по развитию стоматологической помощи населению своих республик на 1962-1965 года. Приказом предусматривалось открытие или расширение стоматологических факультетов медицинских институтов, зубоучебных и зуботехнических отделений медицинских училищ для обеспечения подготовки врачей-стоматологов, зубных врачей, зубных техников.

В результате разработанных и осуществленных министерством здравоохранения СССР мероприятий был резко увеличен прием, а затем и выпуск врачей стоматологического профиля.

На IV Всесоюзном съезде стоматологов (1962) было отмечено, что «унификация учебного плана позволила Министерству здравоохранения СССР создать единые программы по тематическим дисциплинам для студентов всех факультетов, в том числе стоматологических». Это имело огромное значение для подготовки высококвалифицированных врачей-стоматологов.

К началу 1980 года в СССР было два медицинских стоматологических института (Москва, Полтава) и два научно-исследовательских института (ЦНИИС в Москве и НИИ стоматологии в Одессе), в системе Мини-

стерства здравоохранения СССР функционировало 38 стоматологических факультетов в медицинских вузах.

Важную роль в организации стоматологической помощи играет, организованный в 1962 году Центральный научно-исследовательский институт стоматологии (ЦНИИС, директор — профессор А.И. Рыбаков, в настоящее время профессор А.А. Кулаков), который координирует работы по научно-практическим проблемам стоматологии в СССР.

Большую работу по совершенствованию стоматологической помощи населению, внедрению новых методов профилактики и лечения стоматологических заболеваний проводили научные медицинские стоматологические общества. История их создания относится к дореволюционному периоду. Новым этапом в истории деятельности научных стоматологических обществ является создание Всесоюзного научного медицинского общества (1958). К 1962 г. были оформлены Всесоюзное и республиканские общества стоматологов.

В подготовке высококвалифицированных специалистов играют институты усовершенствования врачей, в четырнадцати из которых есть кафедры стоматологического профиля. Факультет усовершенствования врачей-стоматологов, впервые созданный в 1968 году при Московском медицинском стоматологическом институте, имеет самый богатый опыт подготовки врачебных и научных кадров.

С 1971 года ММСИ (с 1999 г. — МГМСУ) проводит циклы усовершенствования преподавателей стоматологических кафедр медицинских вузов. Приказом министра здравоохранения СССР от 23 сентября 1974 года с 1 сентября 1976/77 учебного года стоматологические факультеты были переведены на новый учебный план, согласно которому вводилась первичная специализация врачей-стоматологов в период обучения — субординатура и одногодичная постдипломная специализация выпускников — интернатура.

Важным событием для стоматологической общественности страны было Постановление Совета министров СССР от 5 ноября 1976 года «О

мерах по дальнейшему улучшению стоматологической помощи населению», в котором намечалось открытие новых факультетов (Ижевск, Красноярск, Новосибирск, Тюмень, Уфа, Хабаровск), увеличение приема студентов на существующие стоматологические факультеты.

Группа сотрудников Московского медицинского стоматологического института (С.И. Варенников, Н.И. Винникова, А.П. Воронов, Е.С. Ирошникова, Н.Н. Каспарова, Г.И. Лернер, В.И. Лукашова, И.Ф. Ромачева, В.Ф. Рудько, Г.Н. Троянский) создала проект модели врача-стоматолога. Создание модели врача-стоматолога позволило наметить мероприятия по ее внедрению в учебный процесс стоматологических вузов и факультетов страны.

Признанием успехов стоматологии советского периода явилось решение Всемирной организации здравоохранения организовать на базе Московского медицинского стоматологического института им. Н.А. Семашко (ММСИ) центр ВОЗ по подготовке стоматологического персонала в целях дальнейшего совершенствования подготовки стоматологических кадров. Приказом министра здравоохранения СССР от 8 января 1980 года руководство работой центра было возложено на ректора ММСИ, член-корреспондента АМН СССР, профессора К.М. Лакина.

В 1999 году по приказу Минобразования от 24.08.1999 года № 1405 и приказу Минздрава РФ от 10.08.1999 года № 229 ММСИ был преобразован в Московский государственный медико-стоматологический университет (МГМСУ), в котором в 2001 году был открыт факультет клинической психологии, в 2003 году — НИМСИ (научно-исследовательский медико-стоматологический институт), а в 2004 году стал функционировать экономический факультет. Задачи и функции университета были значительно расширены, как в области научных исследований, так и в практической деятельности. МГМСУ — головной университет по высшему стоматологическому образованию в стране (ректор — профессор О.О. Янушевич, президент — академик РАМН, профессор Н.Д. Ющук).

В МГМСУ разработана «Концепция совершенствования стоматологического образования в России» (1999), в основе которой лежит подготовка врача-стоматолога общей практики. После распада СССР, на территории Российской Федерации функционируют 42 стоматологических факультета и 6 факультетов при классических университетах. По официальным данным, в 2000 году в России насчитывалось 64 330 специалистов стоматологического профиля, из них 43 330 (67,3 %) стоматологов и 21 000 (32,6 %) зубных врачей. Среди всех специалистов стоматологического профиля более 44 000 (69,2 %) терапевтов и детских врачей, 11 579 (18 %) — врачей-ортопедов, 5 982 (9,3 %) — челюстно-лицевых хирургов, ортоднтов — 2 256 (3,5 %).

4.3. Подготовка зубных техников

Зубоврачебная подсекция Наркомздрава РСФСР не раз ставила вопрос об организации подготовки зубных техников. В 1919 году было решено зуботехнические кадры в стране готовить в зуботехнических школах. Ученая одонтологическая комиссия выработала положение, в котором говорилось: «Зуботехнические школы учреждаются с целью создания опытных, научно подготовленных специалистов в деле протезирования». 18 июля 1919 года Наркомздрав издал постановление об открытии зуботехнических школ, утвердив «Положение о зуботехнической школе» и планы преподавания. В программу было введено изучение анатомии, химии, физики, металлургии и протезной техники. Зубоврачебная подсекция и коллегия Наркомздрава РСФСР, в конце 1919 года, утвердили «Права и обязанности зубных техников». Первая зуботехническая школа была открыта в конце 1919 года в Москве по адресу Долгоруковская ул., д. 18, в бывшей зубоврачебной школе И.М. Коварского. Директором ее был назначен М.О. Коварский. В 1920 году были открыты зуботехнические школы в Ленинграде, Одессе, Саратове и др. городах страны.

Программа преподавания была рассчитана на 2,5 года обучения.

В циркулярах Наркомздрава от 2 января 1924 года и от 11 января 1926 года для подготовки зуботехнических кадров предусматривалось создание учебных заведений нового типа. Кроме такой формы подготовки зубных техников, существовала и иная. В 1929 году в Орехово-Зуеве, Ростове-на-Дону, Тбилиси, Харькове и др. городах были созданы опытно-показательные зуботехнические курсы. Продолжительность обучения на них была 2 года.

В марте 1931 года состоялся первый выпуск зубных техников во Всеукраинском зубопротезном техникуме в Одессе. Главными вопросами для зуботехнических работников того времени были вопросы о правах и обязанностях зубных техников, реорганизации работы зуботехнических лабораторий, оплаты труда, разделения труда. Эти проблемы были разрешены лишь к 30-м годам XX века.

В 1936 году вышло постановление СНК СССР «О подготовке средних медицинских зубоврачебных и фармацевтических кадров». Подготовка зубных техников проводилась в зуботехнических двухгодичных школах, поступающие должны были иметь 7 классов образования.

После Великой Отечественной войны зуботехнические школы были переданы в ведение министерств здравоохранения союзных республик. Изменилась организационная структура школ, и они превратились в самостоятельные медицинские учебные заведения, в которых при каждой школе было зуботехническое отделение, что обеспечивало планомерную подготовку зуботехнических кадров. Срок обучения на зуботехнических отделениях составлял 2 года с образованием при поступлении в объеме 7 классов средней школы.

Часть зубных техников, работавших в стоматологических поликлиниках, не имела зуботехнического образования, поэтому Министерство здравоохранения СССР 31 декабря 1947 года утвердило положение об экстернате, который позволял повысить общеобразовательный и профессиональный уровень зубных техников. Для прохождения его зачислялись ли-

ца, имеющие образование не ниже 7 классов средней школы и производственный стаж в качестве зубного техника не менее 2-х лет. Экзамены и зачеты разрешалось сдавать в течение трех лет с момента подписания приказа о зачислении экстерном.

В 1952 году вышел приказ министра здравоохранения СССР «Об организации вечерних отделений для подготовки без отрыва от производства средних медицинских работников». Этим приказом устанавливался трехлетний срок обучения, а имеющим стаж работы по специальности не менее трех лет — 2 года. С 1 июня 1952 года был прекращён дальнейший прием экстернов в средние медицинские и фармацевтические школы.

В последующие годы подготовка зуботехнических кадров велась на зуботехнических отделениях зубоврачебных школ (Калинин, Киев, Ленинград, Москва, Одесса, Рига, Смоленск, Ташкент, Тбилиси, Томск, Харьков и др.), а позднее на зуботехнических отделениях при медицинских училищах. На зуботехнические отделения стали принимать лиц, имеющих образование в объеме 10 классов средней школы, обучение продолжалось в течение двух лет.

В подготовке зуботехнических кадров так же, как и кадров стоматологов, огромное значение сыграло постановление Совета министров СССР от 12 августа 1961 года «О мерах по улучшению стоматологической помощи населению», в котором предусматривалось увеличение приема учащихся на зуботехнические отделения. По существующим нормативам на одну должность врача-ортопеда положено две должности техника. С увеличением числа врачей-ортопедов увеличилось и количество зубных техников.

Ортодонтические работы должны были выполнять зубные техники всех категорий согласно приложению №9 к приказу министра здравоохранения СССР №496 от 9 сентября 1964 года «Квалификационные характеристики зубных техников, полировщиков и литейщиков учреждений (отделов, отделений, лабораторий) зубопротезирования».

На основании приказа министра здравоохранения СССР № 446 от 9 сентября 1964 года изготовление ортодонтических аппаратов отнесено к зубопротезированию, поэтому оплата труда зубных техников, полировщиков и литейщиков в учреждениях, находящихся на государственном бюджете, производилась по сдельно-премиальной системе. Министерство здравоохранения СССР перед министерствами здравоохранения союзных республик поставило задачу значительно увеличить число зубных техников в стране. Большую помощь зуботехническим отделениям медицинских училищ оказывали стоматологические факультеты медицинских институтов, превращая их в базовые училища. Примером этого может быть долготное сотрудничество между медицинским училищем № 1 Москвы и Московским медицинским стоматологическим институтом, ныне МГМСУ.

В 1996 году, под руководством доцента Л.И. Гиллера, в ММСИ была открыта кафедра стоматологии общей практики с курсом подготовки зубных техников, которую с 1999 года возглавляет С.Д. Арутюнов. Дальнейшее сотрудничество на договорных условиях двух названных выше учреждений предусматривает в ближайшие годы подготовку, кроме того, и средних медицинских работников с профилизацией для стоматологических учреждений. Это обусловлено тем, что при рациональной организации труда стоматолога (часть манипуляций предполагается возложить на специально обученную медицинскую сестру) объем помощи населению в области стоматологии может быть увеличен, что равносильно дополнительной подготовке нескольких тысяч врачей-стоматологов. К 2000 году в стране насчитывалось около 22 000 зубных техников.

4.4. Научные проблемы стоматологии XX века

4.4.1. Терапевтическая стоматология.

Терапевтическая стоматология занимается изучением этиологии и патогенеза заболеваний зубов и околозубных тканей, болезней слизистой оболочки полости рта, их диагностикой, разработкой методов лечения и

профилактики. Одним из самых распространенных заболеваний жителей планеты является кариес зубов. В странах с хорошо развитой экономикой и высоким уровнем жизни 7-9 человек из десяти нуждаются в лечении зубов. Кариес зубов — это проблема социальная.

Поэтому интерес к этой проблеме достаточно велик, разрешить ее пытаются ученые всего мира. Кариес зубов — заболевание, которое насчитывает сотни тысяч лет. Во всех общественно-экономических формациях есть свидетельства (данные палеонтологии, палеопатологии, письменные источники, научные исследования и др.) наличия кариеса у людей, методов его лечения и попыток установить природу этого заболевания.

«Кариес зубов определяется как локальный патологический процесс внешнего происхождения, имеющий место после прорезывания зубов, при котором происходит размягчение твердых тканей зубов, ведущий к образованию полости». Такое определение кариеса зубов было принято Всемирной организацией здравоохранения в 1963 году.

Выработке такой формулировки предшествовали многочисленные исследования этиологии и патогенеза кариеса учеными многих стран.

Существуют сотни гипотез и теорий этиологии и патогенеза кариеса, разработанных зарубежными и отечественными учеными, но это всего лишь шаги к разрешению данной проблемы. Е.В. Боровский в 2004 году дал современное определение кариеса зубов: «Кариес — патологический процесс, проявляющийся после прорезывания зубов, при котором происходят деминерализация и размягчение твердых тканей зуба с последующим образованием полости».

Экспериментальные исследования кариеса зубов в нашей стране начали проводиться еще в 20-30-е годы XX столетия. Большое внимание изучению этиологии и патогенеза кариеса зубов уделяли Н.И. Агапов, Е.М. Гофунг, П.Г. Дауге, А.И. Евдокимов, И.Г. Лукомский, И.О. Новик, Е.Е. Платонов, Д.А. Энтин и др.

Одной из теорий возникновения кариеса зубов является физико-

химическая теория (профессор Д.А. Энтин). В 1938 году ученый установил различие в свойствах слюны у кариес-резистентных лиц и у лиц, с пораженными кариесом зубами. Зуб, по мнению Д.А. Энтина, является полупроницаемой перепонкой, а транссудат крови и слюны, являющийся для зуба внутренней и внешней средой, может обусловить благоприятное или неблагоприятное взаимодействие между зубом и средой. При благоприятных условиях обеспечивается нормальное питание эмали и дентина, благодаря чему формируются зубы, резистентные к кариесу. При неблагоприятных условиях нарушается питание зуба, что ведет к образованию кариеса.

Эта теория кариеса послужила толчком для исследований проницаемости твердых тканей зуба для различных веществ. В 1948 году вышла монография И.Г. Лукомского «Кариес зуба», в которой автор на основании клинического и экспериментального опыта дал анализ существовавших теорий кариеса, выдвинув «биологическую теорию кариеса зубов».

Ученый выделил внешние (экзогенные) факторы (недостаток витаминов В1 и D, солей кальция, фосфора, фтора, ультрафиолетовых лучей) и внутренние (эндогенные) — кровь, влияющие на развитие кариеса. Нарушение внешних факторов приводит к изменению минерального и белкового обмена в организме, а это приводит к эндогенным изменениям, влияющим на трофику эмали и дентина. В результате в твердых тканях зуба развиваются процессы, приводящие к дисминерализации сначала эмали, затем и дентина, что образует кариозную полость. Важную роль в возникновении кариеса автор отводил фтору, поэтому впервые для профилактики кариеса И.Г. Лукомский (1946) предложил местную обработку зубов фторсодержащей пастой.

Ученые кафедры биохимии ММСИ, под руководством А.Э. Шарпенак профессора А.Э. Шарпенака (Е.В. Александрова, В.Р. Бобылева, Л.Д. Горожанина, И.И. Грачева, В.П. Дзичковская, Н.В. Николаева), провели экспериментальные работы по изучению этиологии кариеса и пришли к заключению, что возникновение кариеса — это результат нарушения

белкового обмена в зубе, а это ведет к накоплению в организме и в зубе пировиноградной кислоты, развитию процесса протеолиза, обеднению зуба белками, что и вызывает возникновение кариеса.

Профессор Е.Е. Платонов (1957, 1961, 1962, 1965) и сотрудники его кафедры (А.А. Соленова, 1966; Н.Н. Сторожева, 1967; Е.В. Боровский, 1967; В.К. Патрикеев, 1968; В.А. Гомерштейн, 1968; Б.В. Котомин, 1970; Б.П. Лисовецкий, 1971 и др.) длительное время занимались проблемой этиологии и патогенеза кариеса зубов.

Применяя новейшие методы исследования, Е.Е. Платонов и Е.В. Боровский, изучали содержание микро- и макроэлементов в твердых тканях зуба. Исследования проводились совместно с различными научными учреждениями Москвы (ЦНИИС, Институт биологической и медицинской химии, ЦНИИ туберкулеза, МГУ и др.), с кафедрами ММСИ (патологическая физиология, рентгенология и радиология, внутренние болезни, гистология, патологическая анатомия и др.).

Наиболее эффективным оказалось научное сотрудничество с кафедрой патологической физиологии (зав. — академик АМН СССР, профессор Н.А. Федоров, позднее профессор В.В. Михайлов, профессор А.И. Воложин) и лабораторией патологической физиологии ЦНИИСа (зав. — профессор А.А. Прохончуков).

Внедрение в 1950 году Н.А. Федоровым метода радиоактивных изотопов позволило экспериментально изучить такие важнейшие вопросы физиологии и биохимии твердых тканей зуба, как влияние нервной трофики, эндокринной системы на жизнеспособность эмали, выявить роль слюны и функции слюнных желез, витаминов, минерального и белкового обмена в проницаемости тканей зуба и др. (1950, 1953, 1959).

Результаты исследований показали, что нарушение минерального, белкового и углеводного обмена — это один из ведущих патогенетических факторов в механизме развития экспериментального алиментарного кариеса зубов (А.А. Прохончуков, Н.А. Жижина, В.В. Паникаровский, 1963;

Н.А. Федоров, А.А. Прохончуков, 1964; А.А. Грабецкий, 1966; В.С. Куликова, М.Г. Хованская, 1966; М.М. Персии, 1966, 1967; М.С. Голинская, 1966; Р.П. Подорожная, 1966; А.А. Прохончуков, Н.А. Жижина, 1967).

Патологию твердых тканей зуба у лабораторных животных ученые получили воздействием на центральную нервную систему и ее периферические отделы (Д.А. Энтин, 1929; П.П. Астанин, Л.И. Каушанский, 1931; Д.А. Энтин, Л.И. Каушанский, 1935), повреждением одонтопластов (И.Г. Лукомский, Г.А. Васильев, 1929), изменением алиментарных факторов (Л.И. Каушанский, 1935), в том числе авитаминозами (Н.Г. Серебренникова, 1935; А.А. Михайлова, 1936), созданием хронической кишечной интоксикации (Л.И. Каушанский, 1938), воздействием на эндокринную систему (И.О. Новик, 1940; А.Ю. Либина, 1940) и другими факторами.

Содержание белых крыс на сахарозо-казеиновой кариесогенной диете в лабораторных условиях привело к получению алиментарного кариеса (С.А. Никитин, М.Г. Бугаева, 1954) в нескольких поколениях животных.

Модель экспериментального пульпита на крысах разрабатывали В.В. Паникаровский, А.А. Прохончуков, Н.А. Жижина и А.С. Григорян (1966).

Экспериментальное направление исследований этиологии и патогенеза кариеса зубов в 70-х годах XX века развивал коллектив исследователей ЦНИИСа, под руководством профессора А.А. Прохончукова, в сотрудничестве с кафедрой терапевтической стоматологии ММСИ во главе с профессором Е.В. Боровским. Исследователями было выявлено, что радиоактивные изотопы, в зависимости от возраста животных, состояния их здоровья, вида изотопа, по-разному включаются в эмаль и дентин зубов крыс. Е.В. Боровский получил данные, которые позволили ему предположить, что поступление минеральных солей в пораженную кариесом эмаль (реминерализация) происходит из слюны.

Работы А.А. Прохончукова и Е.В. Боровского раскрыли тонкие механизмы исчезновения минеральных солей из эмали и их поступление в дентин. Применение новых биофизических методов исследования — мик-

рентгенографии и рентгеновской микроскопии, позволило получить важные для понимания патогенеза кариеса зубов и его патогенетической профилактики, результаты. Данные свидетельствовали, что в возникновении и развитии кариеса зубов, превалируют три процесса: деминерализации, дисминерализации и реминерализации, что позволило по-новому трактовать некоторые вопросы этиологии и патогенеза кариеса зубов.

В.К. Леонтьев одним из первых раскрыл механизм деминерализации эмали, тактильной чувствительности зубов, создал молекулярную модель строения эмали зубов, искусственную слюну, разработал методы электрометрической диагностики зубов.

А.А. Прохончуков, Е.В. Боровский, А.В. Гранин, Г.Н. Пахомов выявили, что кариес у разных людей и даже у одних и тех же людей в разные периоды их жизни проявляется по-разному, как клинически, так и морфологически. Преобладание в определенный момент процесса деминерализации, дисминерализации или реминерализации зависит от состояния организма, питания, качества и количества слюны и других факторов. Приостановка кариозного процесса, а также обратное его развитие, возможно при высокой активности процесса реминерализации.

Согласно рекомендации ВОЗ, для оценки эпидемиологии кариеса зубов используются показатели: распространенность, заболеваемость и интенсивность. К причинам возникновения кариеса на современном этапе относят процессы деминерализации и реминерализации. Эти процессы развиваются под воздействием различных факторов: питания, перенесенным заболеваниями, влиянию внешних воздействий на ткани зуба, действию микроорганизмов.

Учитывая, что мягкие и твердые ткани зубов сорбируют из слюны полезные и необходимые элементы и соединения (Е.В. Боровский, А.В. Гранин, А.И. Марченко, А.А. Прохончуков и др.), ученые направили свои усилия на разработку лечебно-профилактических составов паст с полезными для организма компонентами. В результате были предложены

пасты с фторидом натрия. Большое внимание было уделено разработке специальных медикаментозных средств для профилактики кариеса зубов. В ЦНИИСе для этих целей были разработаны фторсодержащие таблетки (И.Г. Гинзбург), лак, гели для покрытия зубов (Н.В.Морозова, М. Татжит-дидинова).

Изучив фторсодержащие медикаментозные средства, стоматологи стали активно применять, для предупреждения кариеса зубов, электрофорез с растворами фторида натрия.

При изучении распространенности кариеса проводились работы, выявляющие взаимосвязь между его распространенностью и содержанием фтора в водоисточниках страны — на Украине (Р.Д. Габович, 1950; И.О. Новик, 1953), Латвийской ССР (В.Я. Вигдорчик, 1954; Л.Б. Тремайне, 1962), в Азербайджанской ССР (А.А. Ахмедов, 1962; Г.В. Базиян и др., 1965), в Ленинграде (И.И. Палкин, Н.И. Колегов, 1964), Калинин (Н.А. Абакумова, 1965), ряде городов Среднего Поволжья (Г.Д. Овруцкий, Н.И. Петухов, 1963), на Кольском полуострове (Б.Г. Афанасьев, 1960) и ряде других регионов Советского Союза.

На пленуме Всесоюзного общества стоматологов в Алма-Ате в 1964 году был подведен итог этой работы, который выявил обратную зависимость между содержанием фтора в воде и распространенностью кариеса.

Г.Н. Пахомов с помощью рентгеноструктурного анализа уточнил морфологические особенности изменений твердых тканей зуба при кариесе в стадии пятна. Совместно с Е.В. Боровским им было разработано и предложено для практического применения, в виде аппликаций, средство для профилактики кариеса зубов — реминерализующий раствор, который был получен из трубчатых костей крупного рогатого скота. Применение этого средства дало хороший результат.

В.К. Патрикеев, на кафедре терапевтической стоматологии ММСИ, изучая особенности проявления и течения флюороза у людей, его взаимосвязь и влияние на развитие кариеса зубов, развернул первую электронно-

микроскопическую лабораторию для проведения исследований по ультраструктуре эмали и дентина зубов при некариозных поражениях. Его ученики продолжили исследования ученого (Ю.М. Максимовский).

Проблемам развития кариеса зубов посвящал свои труды профессор П.А. Леус.

Академиком АМН СССР, профессором А.И. Рыбаковым и профессором А.В. Граниным была разработана методика патогенетической профилактики кариеса, которая была апробирована в первых классах некоторых московских школ. Комплекс применяемых мероприятий, базировался на основных общемедицинских принципах профилактики любой патологии, в том числе и кариеса зубов.

Над проблемой кариеса зубов в 70-е годы плодотворно трудились ученые-стоматологи всего Советского Союза.

Успешно работала школа казанских стоматологов, под руководством профессора Г.Д. Овруцкого, разрабатывая вопросы аллергии и реактивности организма при патологии полости рта. Учеными впервые были получены данные о зависимости развития и течения кариеса зубов от иммунобиологического состояния организма, были раскрыты механизмы влияния фтора на организм.

Украинские стоматологи (Н.А. Кодола, И.О. Новик, Р.Г. Синицын, Ю.А. Федоров) изучали содержание микро- и макроэлементов в тканях зуба на разных стадиях его развития, морфологию эмали при применении некоторых биофизических методов исследования в детской стоматологии. При создании новых косметических и лечебно-профилактических средств гигиены полости рта ученые включали соединения фтора и кальция.

Работы в этом направлении проводились на кафедре при терапевтической стоматологии Донецкого медицинского института под руководством В.Т. Окушко, который выявил ведущую роль акселерации в распространности кариеса зубов у современного человека.

Исследования профессора И.А. Бегельмана в Одесском НИИ стома-

тологии привели к заключению, что с возрастом сопротивляемость к кариесу резко возрастает.

В 1970 году Л.И. Рыбаковым была обнародована рабочая концепция патогенеза кариеса зубов, в основу которого были положены возрастные особенности формирования и развития зубочелюстной системы человека, влияние внешних и внутренних факторов на развитие кариеса зубов. Им впервые было введено понятие «пусковой механизм», который предопределяет развитие кариеса у того или иного человека.

Труды А.И. Рыбакова по изучению эпидемиологии кариеса зубов в нашей стране позволили проследить взаимосвязь кариеса зубов с патологией внутренних органов. Наряду с разработкой вопросов, связанных непосредственно с этиологией, патогенезом, клиникой, диагностикой, лечением и профилактикой кариеса зубов, разрабатывались вопросы, связанные с осложнениями кариеса зубов (пульпит и периодонтит).

Профессор М.И. Грошиков на кафедре пропедевтики терапевтической стоматологии ММСИ в течение многих лет занимался всесторонним изучением пульпита и периодонтита. Широко известен его метод пломбирования зубов фосфатцементом с включением биомицина. С помощью радиоактивных изотопов, был обоснован метод заверхушечного пломбирования каналов зубов при периодонтитах (М.И. Грошиков, А.А. Прохончуков, 1963). Изучая на крысах распределение биомицина в зубах и челюстных костях, М.И. Грошиков (1965) использовал полученные данные, как обоснование для применения этого антибиотика при лечении периодонтитов.

В экспериментах на собаках было изучено влияние различных антибиотиков на воспаленную пульпу (Т.Т. Школяр, Н.А. Мухин, 1963; Б.Н. Зайцев, 1964; К.Т. Сомова, 1964; И.И. Медведева, 1966).

Результаты исследований позволили при лечении пульпитов более активно применять антибиотики. Благодаря широкому внедрению антибиотиков, сульфаниламидных и кортикостероидных препаратов в меди-

цинскую практику, их стали применять и в стоматологии: биомицин, пенициллин, стрептомицин (М.И. Грошиков, А.С. Заславский, Т.Т. Школяр и др.). Для замешивания антибиотиков применялась различная основа (дистиллированная вода, различные масла, новокаин, бальзам Шостаковского и др.). Со временем стоматологи начали комбинировать сульфаниламиды с антибиотиками и другими медикаментами, расширяя тем самым спектр их влияния на микрофлору зуба (с сульфаниламидными препаратами — Т.Т. Школяр, с препаратами кальция — А.С. Заславский, со стероидными препаратами — И.И. Медведева).

Дальнейшее развитие стоматологии шло по пути поиска новых препаратов для сохранения жизнеспособности пульпы. Поиск завершился успешно: при воспалении пульпы стали широко применять кальцийсодержащие препараты, что определило принципиально новый подход к лечению.

Пломбирование кариозных полостей является завершающим этапом в лечении зубов при том или ином заболевании. Эффективность пломбирования изучалась как клинически, так и экспериментально, вскрывались его недостатки и разрабатывались методы их устранения (В.И. Крупников, 1935; И.А. Бегельман, 1939; М.Я. Берри, 1954, 1955; Т.Т. Школяр, С.А. Зверева, 1954; Н.Ф. Данилевский, 1956; В.Я. Синицын, 1956; и др.). С появлением быстротвердеющей пластмассы (1952) внимание к вопросам пломбирования заметно повысилось. Ряд работ был посвящен изучению свойств быстротвердеющей пластмассы, ее клиническому испытанию (В.С. Иванов, 1961; И.И. Батрак, 1965 и др.). Было выявлено, что наряду с положительными свойствами, новый пломбировочный материал обладал недостатками: изменение объема, раздражение пульпы, плохая прилипаемость (Н.Ф. Данилевский, Н.А. Кодола, А.И. Марченко, 1958), все это привело к необходимости применения в глубоких полостях защитных прокладок (М.С. Липец (1955), Б.Р. Вайнштейн и Ш. И. Городецкий (1961), А.А. Альшиц (1964)).

В 1962 году на IV Всесоюзном съезде стоматологов были обсуждены проблемы кариеса зубов, клиническое обоснование различных методов диагностики и лечения патологии зубов у детей (Т.Ф. Виноградова), разработка новых пломбировочных материалов (силицина — Г.Д. Овруцкий, других материалов — А.И. Рыбаков, В.С. Иванов, Б.Я. Горовой).

Разработка рецептов новых пломбировочных материалов и проверка качества пломбирования ими зубов открыли путь в клиническую практику полимеров на основе эпоксидных смол, амальгам, галлия и др. (Б.Я. Горовой, В.С. Иванов, Д.М. Каральник, А.И. Рыбаков, Т.Ф. Стрелюхина, М.З. Штейнгарт и др.). Со временем появились пломбировочные материалы нового поколения. В настоящее время исследования по изучению кариеса зубов продолжаются (Е.В. Боровский, В.С. Иванов, В.К. Леонтьев и др.), применяются новые методы лечения кариеса, разрабатываются новые пломбировочные материалы с улучшенными свойствами (хорошая прилипаемость, нетоксичность, быстрое отверждение, разнообразная расцветка и др.), новые технологии их изготовления, внедряются новые лекарственные препараты, применяются современные методы обезболивания.

Проблема патологии пародонта по степени значимости занимает второе место после кариеса зубов. По данным ВОЗ, заболеваниями пародонта страдает 40 % населения мира (А.И. Евдокимов, 1961; А.И. Рыбаков, 1966).

Современные научные исследования определяют эту патологию у 70 % населения. Разработкой этой проблемы занимаются терапевты-стоматологи, ортопеды, хирурги-стоматологи. Это широкая общемедицинская проблема. Термин «амфодонт» впервые в 1905 году предложил Н.Н. Несмеянов в своей диссертации «Альвеолярная пиорея зубов (амфодонтиты)». Позднее вместо термина «альвеолярная пиорея» вошел в практику термин «пародонтоз», предложенный зарубежными авторами.

В 60-е годы XX века на кафедре терапевтической стоматологии ММСИ (зав. — проф. Е.Е. Платонов) было принято новое собирательное

определение, которым обозначали патологию пародонта — пародонтопатия. Следует отметить, что этот термин уже был широко распространен в ГДР, НРБ, ПНР, СРР, ЧССР и некоторых других странах. Различная терминология заболеваний, классификаций (А.И. Евдокимов, 1938, 1961; И.О. Новик 1958, 1964; И.М. Старобинский 1960, 1966; и др.), методов лечения существовала до VI Всесоюзного съезда стоматологов (Ленинград, 1975) не только в учреждениях Москвы, но и в других городах Советского Союза. На съезде было решено упорядочить все обозначения, разработать единую классификацию и выработать эффективные единообразные методы лечения.

В 80-е годы XX столетия на кафедре госпитальной терапевтической стоматологии ММСИ А.И. Евдокимов(1883-1979) были подробно изучены патоморфология, клинические проявления заболеваний пародонта, что потребовало пересмотра существовавшего в нашей стране воззрения о наличии одной нозологической формы — пародонтоза — только первично дистрофического процесса в костной ткани, с последующим воспалением десны. Гингивит рассматривали как симптом пародонтоза. Между тем, исследования сотрудников кафедры свидетельствуют в пользу ведущего значения воспаления в тканях пародонта и наличия самостоятельных заболеваний первично воспалительного характера (гингивит, пародонтит) наряду с пародонтозом — заболеванием первично дистрофической природы. В структуре пародонтальных заболеваний преобладают гингивит и пародонтит. Ученые ММСИ предприняли попытку пересмотра классификации болезней пародонта с учетом собственных исследований и рекомендаций ВОЗ. В 1980 году была опубликована классификация болезней пародонта (Т.И. Лемецкая, 1980), в которой были выделены воспалительные заболевания пародонта — гингивит, пародонтит и дистрофические — пародонтоз, пародонтолиз, опухоли и опухолевидные заболевания. Эта классификация легла в основу классификации, принятой в 1983 году на XVI пленуме Всесоюзного общества стоматологов и рекомендованной для применения в научной, педагогической и лечебной работе.

Большое внимание проблеме пародонтоза уделяли отечественные исследователи: С.И. Вайс, Г.А. Васильев, Е.М. Гофунг, М.О. Коварский, А.И. Евдокимов, И.Г. Лукомский, П.П. Львов, И.О. Новик, Е.Е. Платонов, И.М. Старобинский, Д.А. Энтин.

Профессор Е.М. Гофунг рассматривал пародонтоз как своеобразное хроническое заболевание пародонта эндо- и экзогенного происхождения, сопровождающееся прогрессирующей деструкцией костной альвеолы и альвеолярного края челюсти, ослаблением околозубной связки, расшатыванием и выпадением зубов. Среди многочисленных исследований этой патологии особое место занимают работы А.И. Евдокимова. Выступая на III Всесоюзном одонтологическом съезде (1928) с докладом «Альвеолярная пиорея и обуславливающие ее факторы», А.И. Евдокимов заложил основы научного подхода к изучению заболеваний пародонта — пародонтоза. На основании своих исследований и исследований учеников (П.Ф. Беликов, О.Г. Кюзель, В.Ф. Гроссе, Е.М. Приказчикова, Б.И. Мигунов и др.) он сформулировал сосудистую теорию этиологии и патогенеза пародонтоза.

Суть изменений сосудов при развитии пародонтоза, по мнению А.И. Евдокимова, сводится к их сужению и нарушению их проницаемости, изменению эластичности за счет прорастания в стенки сосудов избыточного количества соединительной ткани, отложения гиалина. Как выяснилось, изменения сосудов при пародонтозе, аналогичны таковым при атеросклерозе. К разработке этой проблемы были привлечены ученые различных специальностей: физиологи биохимики, микробиологи, анатомы, гигиенисты, гистологи и др.

Наряду с исследованиями А.И. Евдокимова, эту проблему с различных позиций решали многие ученые. Профессор П.П. Львов установил связь между пародонтозом и функцией эндокринных желез. Профессор Л.М. Линденбаум отметил при пародонтозе развитие гиперергического состояния.

Начиная с 1924 года, работы по изучению пародонтоза велись на ка-

федрах стоматологии Военно-медицинской академии и Ленинградского стоматологического института под руководством профессора Д.А. Энтина, который в послевоенные годы заложил патогенетические основы лечения пародонтоза.

Профессору П.А. Глушкову первому удалось описать симптомокомплекс альвеолярной пиореи у животных, полученный в лабораторных условиях. В 1933 году была издана его работа «К вопросу о нейротрофической природе альвеолярной пиореи». Ему же принадлежит инициатива лечения альвеолярной пиореи с применением новокаиновой блокады.

Е.Е. Платонов в клинко-экспериментальных условиях обнаружил первичные изменения не в сосудистой системе, а в нервных волокнах пародонта, что привело ученого к заключению: патология пародонта патогенетически связана с нарушением нервной трофики мягких и твердых тканей. Ученый утверждал, что при пародонтозе первостепенное значение имеет нарушение нервной трофики и обменных процессов в тканях челюстно-лицевой области.

Последователи Е.Е. Платонова исследовали состояние тканей пародонта у лиц с различными заболеваниями внутренних органов (С.А. Арефьева, 1959; П.Н. Андрианов, 1965; Н.Н. Гаража, 1965; И.М. Любомирова, Л.А. Вилкова, 1966; Ю.В. Бархатов, В.М. Сташек, 1967; Е.А. Ардабацкая, В.Е. Руднева, 1971; и др.), при аномалиях прикуса (Н.М. Чупрынина, 1958, и др.), при морфологических изменениях пародонта (Т.И. Лемецкая, 1962; О.В. Герасина, 1967; С.А. Арефьева, 1967; В.Е. Руднева, 1971; и др.), при различном содержании микроэлементов в твердых тканях зуба (Л.Н. Неживенко, 1961; Н.Н. Сторожева, 1963; Р.П. Лазарев, 1968, и др.).

Большое внимание изучению патологии пародонта уделяли ученые Украины. Этими работами руководил профессор И.О. Новик, результаты исследований были изложены в его книге «Клиника и лечение пародонтоза» (1958, 1964).

Значительную работу по изучению патологии пародонта у женщин, в

различные периоды их жизни, провели украинские ученые: Г.С. Чучмай и Е.В. Удовицкая, Н.Ф. Данилевский, И.Д. Бульда. Тематика этих работ представляет собой комплексное исследование роли гормонов, ферментов, витаминов в патогенезе пародонтоза.

Профессор И.Д. Бульда особое внимание уделял такому важному, долгое время игнорировавшемуся фактору, каким является гигиена полости рта. Автор обосновал необходимость применения гигиенических средств при пародонтозе. Результаты этих исследований были широко внедрены в клиническую практику. Гигиеническое направление при лечении пародонтоза широко развивалось Ю.А. Федоровым и В.В. Володкиной в Одесском научно-исследовательском институте стоматологии. Ю.А. Федоров предложил средства гигиены полости рта (эликсиры, зубные пасты), которые оказались эффективными при лечении пародонтоза. Позднее был налажен их промышленный выпуск.

Украинские стоматологи применяли физические методы для лечения и профилактики пародонтоза (гидромассаж, массаж, электрофорез с различными соединениями, использование минеральных вод).

В Киевском медицинском институте под руководством профессора Н.Ф. Данилевского было выявлено значение дефицита витамина Е при возникновении пародонтоза. Ученые создали экспериментальную модель этого заболевания, результаты исследований легли в основу рабочей классификации пародонтоза, в которой была обоснована необходимость выделения обострившихся и хронических форм пародонтоза. При лечении пародонтоза была апробирована методика применения протеолитических ферментов (трипсина и химиотрипсина) в сочетании с антибиотиками и сульфаниламидными препаратами. Метод получил широкое распространение в стоматологических учреждениях страны. Проблема пародонтоза нашла отражение в работах профессора В.И. Кулаженко и его учеников. В.И. Кулаженко отметил, что компенсаторные возможности тканей пародонта, пораженного атрофическим процессом, снижены или совсем отсут-

ствуют в результате атрофии лунок зубов и потери опоры со стороны соседних зубов.

В.И. Кулаженко разработал методику вакуумного лечения пародонтита, им же был сконструирован аппарат для вакуумкюретажа десневых карманов при пародонтите. Метод нашел признание и широко применялся в стоматологических поликлиниках нашей страны и за рубежом.

Длительное время украинские ученые успешно изучали особенности развития, диагностики и лечения пародонтита у детей (И.О. Новик, Г.В. Вишняк). Богатый опыт изучения этиологии и патогенеза пародонтита, клиники, диагностики и лечения его, был обобщен профессором И.О. Новиком в книге «Пародонтит», а также в главе «Пародонтит» «Руководства по терапевтической стоматологии».

Вопросы патогенеза, клиники и лечения пародонтита разрабатывались в Калининском медицинском институте профессором Е.И. Гавриловым и его учениками, которые считали, что дифференцировать пародонтит необходимо с первичным травматическим синдромом. Лечение таких больных должно быть основано на биомеханических принципах.

С 1953 года методы ортопедического лечения в комплексной терапии пародонтита были в центре внимания учёных Полтавского (бывшего Харьковского) медицинского стоматологического института. Под руководством доцента М.Р. Мареев (Л.П. Григорьева, Н.А. Добитко, В.П. Климова, Л.Н. Манзюк, В.Л. Устименко и др.) было проведено комплексное лечение больных пародонтитом. В качестве ортопедической терапии были использованы несъемные шины, шины-протезы, дуговые протезы, съемные капповые шины и шины-протезы.

В.Ю. Курляндский впервые в истории стоматологии заявил, что при определенных условиях под влиянием функции в альвеолярных отростках возникают патологические состояния, по симптоматике и проявлению сходные с пародонтитом. На основании сравнения пародонтита и сходных с ним форм заболеваний ученый установил, что пародонтит — процесс ге-

нерализованный и заболевание распространяется на обе челюсти, при сходных формах симптомы проявляются локализованно. Кроме того, пародонтоз проявляется под действием эндогенных факторов. Характерной особенностью пародонтоза, по его мнению, является развитие вторичных травматических наслоений на основное поражение, что приводит к неравномерному течению заболевания вследствие развития травматических узлов.

Осложнения, возникшие при этом, играют ведущую роль. В зависимости от степени развития патологического процесса в опорном аппарате зубов, учитывая компенсаторные возможности и его резервные силы, В.Ю. Курляндский предложил использовать блокирование зубов как метод лечения. Ученый предложил метод расчета остаточной жевательной мощности отдельных зубов, зубных рядов и зубочелюстной системы в целом, с учетом поражения опорного аппарата зубов с помощью пародонтограммы (одонтопаро-донтограммы, 1958). Анализ одонтопародонтограммы создает условия для оценки статуса, механизма образования патологического процесса, позволяет наметить пути его ликвидации, оценить прогноз его течения.

Клинические и рентгенологические проявления функциональной патологии зубочелюстной системы сходны с симптомами проявления пародонтоза, что дало основание для разработки дифференциальной диагностики различных заболеваний и открыло возможности для патогенетической терапии.

С 1961 года вопросы диагностики и лечения больных пародонтозом нашли отражение в работах профессора Я.М. Збаржа на кафедре ортопедической стоматологии Львовского, а позднее Архангельского медицинских институтов.

Итоги работы научно-исследовательских коллективов по проблеме «Пародонтоз» подвел VI Всесоюзный съезд стоматологов, который состоялся 21-24 мая 1975 года в Ленинграде. В резолюции VI Всесоюзного съезда стоматологов было записано, что необходимо больше уделять вни-

мания ортопедическому и хирургическому разделам комплексного лечения пародонтоза, разрабатывать научные основы организации пародонтологической помощи.

На съезде были обсуждены основные аспекты этой сложной и важной для здравоохранения проблемы: вопросы терминологии и классификации, этиологии и патогенеза, диагностики, профилактики и лечения болезней пародонта. В рекомендациях съезда отмечалось, что необходимо считать целесообразным для обозначения дистрофически-воспалительных процессов в тканях пародонта введение единого термина «пародонтоз», в качестве рабочей классификации болезней пародонта. Съезд рекомендовал классификацию, выдвинутую ЦНИИС и ММСИ.

Было предложено широко внедрять комплексную терапию с применением ортопедических и хирургических мероприятий, которая бы повышала результативность лечения, внедрять систему профилактики на основе ее общих принципов. При проведении научных исследований по изучению пародонтоза необходимо учитывать медико-географические особенности распространенности этой патологии.

В 1977 году в работе «Критерии излечиваемости пародонта» А.И. Евдокимов и Т.В. Никитина предложили свою концепцию развития пародонтоза, в которой отметили, что понятие «излечиваемость пародонтоза» оценивается, в зависимости от стадии развития патологического процесса и возможных его исходах.

Авторы подробно описали терапевтические и хирургические методы лечения пародонтоза с применением, на любой стадии развития заболевания, стимуляции реактивности организма, используя средства неспецифической (биостимуляторы, белковые анаболики, микробные полисахариды, аутогемотерапия) и специфической (анаболические стероиды, остеогенная цитотоксическая сыворотка, тирокальцитонин) терапии. Особое место при этом было отведено тирокальцитонину, который оказывает противовоспалительное и противоотечное действие, что в сочетании со способностью

тормозить резорбцию ткани позволяет добиваться оптимального эффекта при лечении пародонтоза (Т.В. Никитина и др., 1973). Для восстановления функциональной активности соединительнотканевых компонентов пародонта, авторы рекомендовали шире использовать ферменты, мукополисахариды (гепарин), биологически активные вещества (фтор, кальций, ферроцирон), а также антиатеросклеротические препараты (астероид, препараты йода, метионин, липокаин и др.) в сочетании с рациональным питанием (растительная диета, овощи, фрукты, творог, сыр, ограничение белковой пищи). Было отмечено, что комплексное лечение позволяет в 65-85 % случаев добиться благоприятных исходов.

В 1977 году В.Н. Копейкин в монографии «Ортопедическое лечение заболеваний пародонта» представил современные методы исследования пародонта, изучил процессы перераспределения напряжений в челюстных костях. В основе функционирования тканей пародонта, по мнению ученого, лежат связи между строением и особенностями биохимических процессов. В докторской диссертации «Клинико-экспериментальное обоснование ортопедических методов лечения пародонтоза» (1980) ученый выявил взаимосвязь между морфологическим строением и биохимическими процессами, лежащими в основе функционирования тканей пародонта. В.Н. Копейкин сконцентрировал внимание на этиологических и патогенетических аспектах диагностики пародонтоза.

В настоящее время значение бактериального происхождения воспалительных изменений в пародонте ставится в зависимость от нейросоматических, генетических, иммунных и других нарушений. Поэтому, выбор методов лечения предусматривает необходимость сочетанного воздействия на микрофлору налета на организм больного в целом. Кроме того, ученые выделяют как консервативные, так и хирургические методы лечения. К консервативному лечению относят профессиональную гигиену полости рта, местную и системную антибактериальную терапию, воздействие на патогенетические звенья воспаления. Профессиональная гигиена явля-

ется основным этапом лечения, который должен предшествовать другим методам терапии (хирургическим, ортодонтическим, ортопедическим и др.). В настоящее время наблюдается тенденция минимального хирургического вмешательства.

Современные эпидемиологические данные свидетельствуют, что патологические изменения у детей и взрослых возникают из-за плохой гигиены полости рта, некачественных пломб и протезов, зубочелюстных деформаций, окклюзионной травмы, нарушения строения тканей преддверия полости рта, особенностей ротового дыхания, употребляемых лекарственных препаратов, перенесенных и сопутствующих заболеваний, экстремальных факторов, приводящих к снижению иммунитета и др.

В настоящее время А.И. Грудянов и Г.М. Барер (1994) показали, что только у 12 % населения пародонт здоровый, у 53 % отмечены начальные воспалительные явления, а у 12 % — поражения средней и тяжелой степени. У лиц старше 35 лет доля начальных изменений пародонта прогрессивно уменьшается на 26-15 % при одновременном росте изменений средней и тяжелой степени. Многочисленные эпидемиологические исследования отечественных и зарубежных авторов показывают, чаще всего патология пародонта встречается в молодом возрасте — гингивит, а после 30 лет — пародонтит. По данным ВОЗ (1990), высокий уровень заболеваний пародонта в 53 странах мира отмечен в возрастной группе 15-19 лет (55-99%) и в возрасте 35-44 лет (65-98%). На эпидемиологию заболеваний пародонта влияют различные факторы: социальные (возраст, пол, раса, социально-экономическое положение), местные условия полости рта (микробы, окклюзионная травма, дефекты пломбирования, протезирования, ортодонтического лечения), вредные привычки (несоблюдение правил гигиены полости рта, курение и др.), системные факторы (гормональные изменения пародонта период полового созревания, беременности, менопаузы), прием лекарственных средств (стероидные препараты, иммунодепрессанты), соли тяжелых металлов.

Распространенность заболеваний пародонта в обществе не снижается, а значимость изучения этого раздела стоматологии и потребность в подготовке высококвалифицированных специалистов возрастает. Прогнозом лечения воспаления в пародонте является стойкая ремиссия. Применение поддерживающей терапии направлено на нормализацию обменных процессов. Новые методы лечения воспаления пародонта приближают ученых к разгадке этого заболевания.

В 2005 году в МГМСУ была открыта кафедра пародонтологии и гериатрической стоматологии ФПКС (зав. кафедрой, профессор О.О. Янушевич).

Важнейшей патологией полости рта, которая требует к себе пристального внимания, является патология слизистой оболочки полости рта. Изучением этиологии, патогенеза, диагностики, клиники и лечения заболеваний слизистой оболочки полости рта ученые занимались с давних пор.

Решение этой проблемы возможно только при тесном взаимодействии дерматологов, стоматологов, патофизиологов, морфологов и других специалистов. Комплексный подход к изучению данной проблемы позволил в 60-е годы XX столетия значительно расширить диапазон знаний в этой области. Этому способствовали работы А.И. Евдокимова, И.Г. Лукомского, А.Л. Машкиллейсона, Б.И. Мигунова, Б.М. Пашкова, А.И. Рыбакова, Л.И. Фалина и др.

Симптомы заболеваний слизистой оболочки полости проявляются непосредственно в полости рта и могут быть симптомами общесоматических заболеваний. Диагностика таких заболеваний довольно сложна. С течением времени накапливался опыт лечения и диагностики этой патологии. Первые классификации заболеваний слизистой оболочки полости рта описаны в учебниках по терапевтической стоматологии Е.М. Гофунга и Д.А. Энтина (1939), И.Г. Лукомского (1945), Я.С. Пеккера (1950), Н.И. Агапова (1959) и др.

Большую роль в изучении патологии слизистой оболочки полости рта сыграла научная дермато-стоматологическая школа ММСИ, возглавля-

емая заслуженным деятелем науки РСФСР, профессором Б.М. Пашковым, которая воспитала целую плеяду специалистов в этой области. Ученики и последователи Б.М. Пашкова (Т.Н. Антонова, А.Л. Машкиллейсон, Г.Д. Савкина, Б.Г. Стоянов и др.) усовершенствовали существовавшие методы диагностики и лечения, разработали и внедрили в практику новые.

Учениками Б.М. Пашкова были изучены поражения слизистой оболочки полости рта и губ при некоторых дерматозах и сифилисе (А.Л. Машкиллейсон), разработана диагностика и лечение предопухолевых изменений слизистой оболочки полости рта, пузырчатки (Н.Д. Шеклаков).

Большое значение для понимания патогенеза некоторых заболеваний слизистой оболочки полости рта, имели исследования профессора П.Г. Снякина по изучению ее функциональной мобильности. Эти разработки легли в основу дальнейшего изучения этих проблем на кафедре терапевтической стоматологии ММСИ, что позволило результаты этих исследований изложить в главе «Заболевания слизистой оболочки полости рта» в учебнике по терапевтической стоматологии.

Работы по изучению заболеваний слизистой оболочки полости рта проводились и в ЦНИИСе, где в 1964 году был открыт первый в стране терапевтический стационар на 20 коек. Институтом был накоплен большой опыт по диагностике и лечению заболеваний слизистой оболочки полости рта.

Кафедра терапевтической стоматологии ЦОЛИУ врачей базировалась в ЦНИИСе, исследования сотрудников этой кафедры были тесно связаны с исследованиями, проводимыми в ЦНИИСе.

Труд А.И. Рыбакова «Стоматиты» (1964) обобщил результаты исследований по проблеме, связанной с патологией слизистой оболочки полости рта.

В 1965 году состоялся I Всероссийский съезд стоматологов, посвященный проблемам патологии слизистой оболочки полости рта. Съезд наметил направления исследований по этой важной проблеме, разработал меры по улучшению научно-исследовательской работы и внедрению ее результатов в практику здравоохранения. Изучение патологии слизистой

оболочки полости рта проводилось на основе и в тесной связи с патофизиологией, патоморфологией, биохимией, микробиологией и др. науками. Итогом этих работ было выявление роли вирусов в этиологии некоторых заболеваний слизистой оболочки полости рта и разработка методов их патогенетического лечения.

Многие научные коллективы СССР посвятили свои исследования этой проблеме. Украинские профессора А.И. Марченко, И.О. Новик разрабатывали вопросы этиологии, патогенеза, диагностики и лечения заболеваний слизистой оболочки полости рта, а также особенности всасывания различных веществ слизистой оболочкой полости рта. Профессор Г.Д. Овруцкий (Казань) изучал изменения общей иммунологической реактивности организма в связи заболеваниями слизистой оболочки полости рта. Местные проявления и особенности течения заболеваний слизистой оболочки полости изучал профессор В.А. Епишев (Узбекистан). Влияние профессиональных вредностей на слизистую оболочку полости рта исследовал профессор Р.Я. Пеккер (Кемерово). Различные проявления патологии слизистой оболочки полости рта разрабатывались и в других медицинских институтах: Калининском — профессор Т.Т. Школяр, Смоленском — профессор М.В. Бусыгина. Основное направление научных работ профессора М.В. Бусыгиной было изучение состояния слизистой оболочки полости рта при хронической инфекции и интоксикации организма: при лепре, туберкулезе, хронической алкогольной и одонтогенной интоксикации. Классификация заболеваний слизистой оболочки полости рта имеет огромное значение в практике врача, т.к. позволяет ориентироваться в многообразии нозологических форм, правильной постановке диагноза, выборе рациональной терапии и проведении профилактических мероприятий. В 1978 году А.И. Рыбаковым и Г.В. Банченко была предложена систематизация патологических состояний.

4.4.2. Хирургическая стоматология.

Проблема ротового сепсиса — всегда была предметом пристального внимания хирургов-стоматологов. Одонтогенные воспалительные заболевания челюстно-лицевой области занимают значительное место в хирургической стоматологии, составляя от 75 до 95 % всех воспалительных процессов. Среди них наиболее часто встречаются острый и хронический периодонтиты, обострение хронического периодонтита, острый гнойный периостит челюсти, острый остеомиелит челюсти, абсцесс, флегмона, лимфаденит

В 1925 году на II Всероссийском одонтологическом съезде профессор С.Н. Вайсблат выступил с докладом о ротовом сепсисе. На III Всесоюзном одонтологическом съезде (6-12 июня 1928 г.) в число программных была включена тема «Патология и терапия апикальных периодонтитов». С основными докладами выступили: А.В. Рывкинд «Патология апикальных пародонтитов», Б.И. Гаухман «Консервативное лечение апикальных пародонтитов», А.А. Кьяндский «Хирургическое лечение апикальных пародонтитов», Я.С. Пеккер «К вопросу о роли зубной системы в этиологии затяжных септических заболеваний», Г.Н. Могильницкий «Сепсис и экстракция зуба», Н.А. Астахов «Основные выводы из клиники периапикальных заболеваний» и др. Н.А. Астахов в докладе отметил: «...проблема так называемого орального сепсиса, имеющая тесное отношение к нашей программной теме, носит характер еще далеко не законченной в научном отношении трактовки и переживает в данный момент ту острую стадию экспериментально-лабораторных увлечений, в которой с окончательными выводами нам, клиницистам, необходимо повременить». С докладами об остеомиелите челюстей на съезде выступили профессора И.Г. Лукомский, П.П. Львов, В.М. Уваров и др.

П.П. Львов в докладе «Одонтогенные остеомиелиты челюстей» заострил вопрос на остром инфекционном остеомиелите нижней челюсти одонтогенного происхождения по причине его большей частоты, тяжести

течения и значения для клиники. Ученый предложил клиническую классификацию остеомиелитов, подробно остановившись на постановке диагноза и методах их лечения.

В.М. Уваров на большом клиническом стационарном и амбулаторном материале (за год 371 случай) изложил методы лечения остеомиелитов.

В 1930 году вышла монография А.И. Евдокимова «Топографическая анатомия полости рта и смежных полостей», с которой началось клинко-анатомическое направление в развитии гнойной хирургии челюстно-лицевой области. Результатом большой исследовательской работы коллектива кафедры хирургической стоматологии ММСИ, руководимой А.И. Евдокимовым, было появление новых данных об этиологии, патогенезе, дифференциальной диагностике и терапии одонтогенных остеомиелитов и периоститов челюстей.

Анализ результатов исследования большого клинко-анатомического материала позволил А.И. Евдокимову разработать классификацию флегмон и абсцессов челюстно-лицевой области. Исследование им реактивности соединительной ткани, активности щелочной фосфатазы плазмы крови, фагоцитарной реакции крови, лейкоцитарной формулы, химического состава крови и слюны и т. д. расширило представление о клинике, морфологии и патофизиологии воспалительных процессов челюстно-лицевой области.

Благоприятное течение и успешное лечение воспалительных процессов обязано:

- применению антибиотиков,
- пенициллино-новокаиновой блокаде,
- использованию глухого шва или биопластики костных полостей,
- использованию тканевой и физической терапии.

В 60-е годы XX века ученые, занимаясь клиническими и экспериментальными исследованиями, выявили причины острых гнойных процессов, особенностей их клинического проявления и лечения. Этой теме по-

святили свои труды ученые: П.М. Егоров, 1961; Н.Г. Попов, 1963; Я.М. Биберман, 1963,1975; В.А. Дунаевский, Л.П. Петрова. 1967; М.М. Соловьев, 1967, 1971; В.И. Лукьяненко, 1968; Н.А. Плотников, М.Э. Генкин, 1973; и др.

Профессор Г.А. Васильев, изучая причины одонтогенных воспалительных заболеваний верхнечелюстной пазухи, разработал патогистологическую характеристику одонтогенных гайморитов, для лечения которых было предложено использование протеолитических ферментов, закрытие перфораций дна гайморовой полости и др.

Четкое знание топографии соединительно-тканевых промежутков и фасций соответствующих участков челюстно-лицевой области позволило подробно Изучить клинику одонтогенных воспалительных заболеваний. По данным В.Ф. Войно-Ясенецкого (1946) и Г.А. Васильева (1957), гнойные процессы, фокус которых находится в подвисочной или крылонебной ямке, приводили иногда к летальным исходам. Широкое применение антибиотиков и сульфаниламидных препаратов значительно изменило течение указанной патологии (Н.М. Александров, 1954; К.А. Молчанова, 1956; А.И. Евдокимов, 1964; Ю.Г. Ломов-Опоков, 1971; и др.). Но, несмотря на это, одонтогенные гнойные воспалительные процессы, локализующиеся в подвисочной и крылонебной ямках, и в настоящее время приводят к тяжелым осложнениям. Поздняя диагностика абсцессов и флегмон околоушно-жевательной области приводит к вторичному кортикальному остеомиелиту угла и ветви нижней челюсти (Г.А. Васильев, А.И. Евдокимов, С.С. Несвижский).

Несвоевременное лечение флегмон околоушно-жевательной области, нередко приводит к секвестрации ветвей челюсти (А.И. Евдокимов, Г.А. Васильев, В.М. Уваров, П.М. Егоров и др.). Для вскрытия абсцессов и флегмон околоушно-жевательной области учеными были предложены различные методы оперативных вмешательств. Разрабатывая план оперативного вмешательства при вскрытии гнойных очагов околоушно-

жевательной области, выбор направления разреза имеет большое значение.

Клиническая картина одонтогенных воспалительных процессов челюстно-лицевой области у детей существенно отличается от проявления этих процессов у взрослых и имеет ряд особенностей (А.И. Евдокимов).

На V Всесоюзном съезде стоматологов (1968) профессор Г.И. Семенченко в докладе «Одонтогенные воспалительные процессы челюстно-лицевой области в детском возрасте» отметил, что тяжелое течение воспалительного процесса у детей приводит к быстрому переходу заболевания в хроническую форму. Своевременная диагностика заболевания, правильное и эффективное его лечение, ведут к скорейшему выздоровлению, минуя тяжелые общие и местные осложнения.

В 1973 году на заседании 12-го пленума правления Всесоюзного научного общества стоматологов академик АМН СССР, профессор А.И. Рыбаков и профессор И.И. Ермолаев в докладе «Состояние проблемы одонтогенной инфекции на современном этапе развития стоматологии» отметили рост воспалительных процессов среди населения, которые «...снова стали представлять угрозу для здоровья и жизни человека», протекая с тяжелыми осложнениями, такими, как медиастиниты и абсцессы головного мозга, «которых мы почти не знали в нашей практике в течение многих лет». По данным ученых число больных с одонтогенными остеомиелитами челюстей в структуре госпитализированных в стоматологические стационары десять лет назад в среднем было около 6 %, спустя десятилетие этот показатель вырос более, чем в два раза. Профессор Ю.И. Вернадский (1975) отметил, что число больных с одонтогенными и неодонтогенными острыми гнойными процессами (остеомиелиты, флегмоны, абсцессы, фурункулы) в 1972 году увеличилось в 4,5 раза по сравнению с 1965 годом, при этом у 80 % больных наблюдались одонтогенные формы флегмон.

На пленуме прозвучал доклад В.А. Дунаевского, Л.Р. Балона, Д.М. Соловьева — «Современные пути изучения патогенеза, клиники,

профилактики и лечении при острой одонтогенной инфекции», а Ю.И. Вернадский, А.Э. Гуцан и соавт., М.В. Костылев и соавт., Н.А. Плотников и др. представили большой материал по организации помощи больным с воспалительными процессами челюстно-лицевой области. В.В. Паникаровский и А.С. Григорян разработали новую классификацию воспалительных процессов костей лица, К.И. Молчанова и соавт. отметили изменения биохимических показателей при профилактике осложнений у больных с флегмонами челюстно-лицевой области.

Несколько докладов были посвящены новым препаратам в комплексном лечении острой и хронической одонтогенной инфекции, изменениям гемостаза при одонтогенной инфекции, принципам лечения тромбозов челюстно-лицевой области.

В последующий период было проведено значительное число клинических и экспериментальных исследований, которые внесли новые данные в патогенез, клинику и лечение острых гнойных процессов (Я.М. Биберман, 1975, 1976; А.И. Рыбаков, И.И. Ермолаев, 1975; В.А. Дунаевский, Л.Р. Балон, М.М. Соловьев, 1975; Ю.И. Вернадский, 1975; В.И. Стручков и др., 1975, 1977; П.В. Наумов, 1976; Ю.И. Вернадский, В.К. Пелипась, Г.П. Михайлик, 1976; Т.Г. Робустова, А.С. Шаяумов, 1978, 1980; Н.Н. Бажанов и др., 1979; В.А. Дунаевский и др., 1979).

В 1978 году вышла монография Ю.И. Вернадского и Н.Н. Заславского «Очерки гнойной челюстно-лицевой хирургии», в которой подробно изложены клиническая характеристика, дифференциальная диагностика и методы лечения одонтогенных воспалительных процессов челюстно-лицевой области.

А.И. Рыбаков в статье «Важная проблема современной стоматологии» (1981) подчеркнул, что вопрос лечения больных с воспалительными процессами челюстно-лицевой области является сложным, ибо «он относится уже к разряду не только стоматологических, но и общехирургических, терапевтических и инфекционных пациентов».

Проблема гнойной хирургии челюстно-лицевой области, постоянно находясь в центре внимания стоматологов, требовала и требует знаний микробиологии, фармакологии, физиотерапии и других дисциплин, и решение ее возможно только комплексными методами.

Важным звеном в лечении гнойных процессов челюстно-лицевой области является процесс реабилитации больных в послеоперационном периоде. «Накопленный опыт многих стоматологических лечебных учреждений убедительно показал, — писал А.И. Рыбаков, — что реабилитация стоматологических больных является наиболее эффективным методом послегоспитального лечения при гнойных заболеваниях челюстно-лицевой области, которую нужно широко внедрять».

Проблема травматологии и восстановительной хирургии челюстно-лицевой области была предметом обсуждения на многих съездах, пленумах научных медицинских стоматологических обществ. В 1927 году был издан учебник «Основы практической травматологии» под редакцией А.Л. Поленова, в котором раздел о травме лица был написан А.А. Лимбергом.

Большой вклад в решение этой проблемы внес А.Э. Рауэр — один из основоположников челюстно-лицевой хирургии советского периода. В 1932 году были изданы его руководство «Переломы и повреждения челюстей в мирное и военное время» и работа «Основные моменты помощи челюстным раненым на фронте», которые имели большое практическое значение для стоматологов. С именем А.Э. Рауэра связаны значительные успехи в хирургическом лечении патологии челюстно-лицевой области, он, по свидетельству Н.М. Михельсона, «был единственным хирургом в Москве, занимавшимся специально этим делом».

Кроме кафедр челюстно-лицевой хирургии в институтах усовершенствования врачей (Москва, Ленинград и др.), в 30-е годы XX столетия были открыты институты травматологии и ортопедии с челюстно-лицевыми отделениями в таких крупных городах, как Москва, Ленинград, Харьков, Свердловск и др., где оказывали специализированную помощь и разраба-

тивали методы лечения повреждений челюстно-лицевой области. Вопросы хирургической стоматологии стали предметом внимания многих исследователей.

В предвоенный период разработке основных положений травматологии и восстановительной хирургии челюстно-лицевой области посвятили свои труды: И.А. Бегельман, Г.А. Васильев, А.Е. Верлоцкий, Е.Д. Домрачева, А.И. Евдокимов, Л.А. Кьяндский, А.А. Лимберг, И.Г. Лукомский, П.П. Львов, Н.М. Михельсон, А.Э. Рауэр, В.М. Уваров, Д.А. Энтин и др.

Войну великий Н.И. Пирогов называл «травматической эпидемией», приносящей разрушения, страдания многим людям огромное количество искалеченных жизней, как физически, так и морально. После окончания Великой Отечественной войны стоматологи-хирурги, используя военный опыт, активно взялись за разработку вопросов хирургической стоматологии. Ведущую роль в их исследованиях играл коллектив кафедры хирургической стоматологии Московского государственного медицинского стоматологического института, руководимый профессором А.И. Евдокимовым (Г.А. Васильев, В.Ф. Рудько, В.И. Заусаев). Знания, накопленные челюстно-лицевой хирургией и ортопедией в период Великой Отечественной войны, значительно расширили практические границы специальности и укрепили ее теоретические основы. Челюстно-лицевые госпитали были прекрасной школой, в которой совершенствовали свое мастерство первоклассные специалисты.

Медицина советского периода проделала большую работу по восстановительному лечению инвалидов войны, среди которых значительное место занимали инвалиды, имевшие тяжелые повреждения зубочелюстной системы. Важные проблемы челюстно-лицевой травматологии и пластической хирургии были освещены в монографиях А.Э. Рауэра, Н.М. Михельсона «Пластические операции на лице», А.А. Лимберга «Восстановительная хирургия лица», Ф.М. Хитрова «Пластическое замещение дефектов лица и шеи филатовским стеблем» и др.

Тематика исследований значительно расширилась, появились новые имена ученых — Н.Н. Бажанов, К.Л. Молчанова, Н.А. Плотников, В.Ф. Чистякова и др., которые разрабатывали различные вопросы хирургической стоматологии: замещение резерцированной части нижней челюсти при адамантиномах (Ю.И. Вернадский), применение эпидермальных кожных лоскутов (М.В. Костылев), применение пластмасс (В.И. Кулаженко, М.В. Мухин и др.), применение трупного хряща (Н.М. Михельсон и др.) и др.

Большой вклад в развитие отечественной хирургической стоматологии внес Г.А. Васильев, ученик и помощник А.И. Евдокимова. Круг вопросов, который разрабатывал Г.А. Васильев, был очень широк и своими трудами он внес значительный вклад в специальность.

А.И. Евдокимов вместе с Г.А. Васильевым издали учебник по хирургической стоматологии. Несколько изданий выдержал учебник Г.А. Васильева «Хирургия зубов и полости рта» для учащихся средних медицинских учебных заведений.

Крупнейшим отечественным хирургом-стоматологом был А.А. Лимберг, который в 1935 году организовал кафедру челюстно-лицевой хирургии в Ленинградском институте усовершенствования врачей. Его работы по хирургической стоматологии, были посвящены, главным образом, вопросам пластической хирургии, а монография «Математические основы местной пластики на поверхности человеческого тела» (1946), была отмечена в 1948 году Сталинской премией II степени. Свой 40-летний опыт работы А.А. Лимберг обобщил в капитальном руководстве «Планирование местнопластических операций», изданном в 1963 году. При производстве пластических операций А.А. Лимберг значительно усовершенствовал методику формирования «Планирование местнопластических операций», изданном в 1963 году. При производстве пластических операций А.А. Лимберг значительно усовершенствовал методику формирования филатовского стебля, разработав показания к его применению, значительно расширив возможности использования его в пластической хирургии лица.

В послевоенный период ученые обосновали показания к ранней и отсроченной костной пластике нижней челюсти (А.И. Евдокимов, М.П. Жакков, Е.М. Жак, А.А. Кьяндский, А.А. Лимберг, М.М. Максудов, Е.С. Малевич, М.В. Мухин, Г.Р. Курбанов, П.В. Наумов, В.Ф. Рудько, Б.Е. Франкенберг и др).

Вопрос о целесообразности ранних пластических операций на лице особенно остро стоял в годы Великой Отечественной войны, когда главной была задача скорейшего возвращения раненых в строй. Были пересмотрены довоенные установки о сроках пластических операций, расширены показания к ранней пластике травматических дефектов лица. Об этом свидетельствуют работы А.А. Лимберга, Н.М. Михельсона, А.Э. Рауэра и др. Лечению свежих травматических дефектов лица в мирное время посвящены работы С.Б. Скопеца, Е.П. Рютиной, В.М. Масиной, Н.А. Шинбирева, Я.М. Збаржа, Б.Д. Кабакова.

В последние годы пластическая хирургия достигла больших успехов, значительно расширив области применения кожно-пластических операций. Опыт производства таких операций показал, что при своевременной и полноценной первичной хирургической обработке, можно значительно сократить сроки лечения и добиться лучших функциональных и косметических результатов.

Больные с травматическими дефектами лица, страдая от функциональных расстройств, испытывают психоэмоциональную подавленность от нарушения эстетики лица. Н.М. Михельсон пишет, что «даже маловидимый для постороннего глаза рубец часто служит предметом внимания и тревоги больного. Больной чаще придает большее значение наружному виду самого рубца, чем тем подчас тяжелым нарушениям функции какого-либо органа, которые вызваны данным рубцом». Поэтому пластика кожно-го покрова лица должна рассматриваться как неотложная операция, к выполнению которой необходимо приступать уже при первичной хирургической обработке раны. К сожалению, это понимают только хирурги-

стоматологи. Общие хирурги чаще оставляют раны лица, с изъёмом тканей, до полного заживления и только затем направляют этих больных в специализированные лечебные учреждения для пластических операций. Б.В. Каспарова (1967) в кандидатской диссертации на тему: «Первичная и ранняя пластика лица после травматических поражений» четко показала, что абсолютных противопоказаний к ранней пластике травматических дефектов лица нет. Отдаленные результаты ранней пластики травматических дефектов мягких тканей лица, выявленные при обследовании больных в сроки от 6 мес. до 10 лет, показали, что хорошие результаты были достигнуты у 88,5 % больных и лишь у 11,5 % больных они были удовлетворительными.

Ученые страны, используя опыт предшественников, разрабатывая новые методики, стали проводить операции с применением филатовского стебля: Э.А. Александрова, Л.Р. Балон, Е.В. Груздкова, Е.М. Жак, В.И. Заусаев, А.Ф. Иванов, Н.Н. Каспарова, С.В. Косых, А.А. Кьяндский, А.Т. Лапчинский, А.А. Лимберг, Ю.К. Метлицкий, Н.М. Михельсон, М.В. Мухин, Л.М. Обухова, В.Ф. Рудько, И.М. Утробин, Ф.М. Хитров и др.

Применение круглого стебельчатого лоскута, предложенного академиком В.П. Филатовым в 1916 году для замещения различных дефектов и деформаций на поверхности человеческого тела, является одним из основных методов кожной пластики. Однако пластика с применением филатовского стебля, предполагает многоэтапность оперативных вмешательств, что приводит к длительному лечению и продолжительным срокам восстановления физиологических свойств тканей лоскута в новых условиях их существования на этапах пластики.

При пластике филатовским стеблем возможны послеоперационные осложнения, в виде болезни филатовского стебля, которые, увеличивая сроки лечения больных, могут отразиться на качестве пластического материала, а, следовательно, на функциональном и косметическом эффекте лечения.

Стоматологи активно совершенствовали методы остеопластики, разрабатывали новые препараты, что привело к повышению процента приживления костных саженцев (А.И. Евдокимов, В.Ф. Рудько, М.П. Жаков, А.А. Лимберг).

Дальнейшее развитие челюстно-лицевой хирургии шло по пути разработки методов пластики мягких тканей (М.М. Великанова, М.Ф. Даценко, Г.В. Кручинский, А.А. Лимберг, Р.Д. Новоселов, А.Т. Титова, Б.Е. Франкенберг и др.), а также методов для свободной пересадки толстых расщепленных и эпидермальных кожных лоскутов (М.В. Костылев, А.А. Лимберг, Ю.К. Метлицкий, А.С. Силаева, Д.И. Танфильев и др.).

Большое число исследований было посвящено внедрению в челюстно-лицевую хирургию различных пластмасс (Ю.И. Вернадский, Е.И. Гаврилов, Г.М. Иващенко, Н.Н. Каспарова, В.И. Кулаженко, Е.С. Малевич, Н.М. Михельсон, М.В. Мухин, В.Ф. Рудько, Г.И. Семенченко, М.М. Слуцкая, В.В. Фиалковский, Д.А. Энтин и др.); трупного хряща (Н.М. Михельсон, Е.В. Груздикова, А.И. Иванова, Е.С. Малевич, А.М. Литинский, А.Г. Фетисов и др.); консервированных или свежих костных гомотрансплантатов (Б.Д. Кабаков, А.А. Кьяндский, Е.С. Малевич, П.М. Медведев, М.В. Мухин, Ф.Т. Навроцкий и др.). Значительные успехи были достигнуты в разработке способа ураностилопластики при помощи филатовского стебля при врожденных и комбинированных приобретенных дефектах нёба (В.И. Заусаев, А.Г. Лапчинский, Ф.М. Хитров и др.).

Заслуженный деятель науки РСФСР, профессор Ф.М. Хитров, возглавляя клинику хирургической стоматологии в ЦНИИСе с первых дней ее существования и до 1980 года, в 1949 году защитил докторскую диссертацию на тему: «Пластика носа филатовским стеблем после огнестрельных повреждений».

Ученым была решена проблема пластики носа с использованием тканей отдельных участков человеческого тела. Монография Ф.М. Хитрова «Пластическое замещение дефектов лица и шеи филатовским стеблем»

(1955) была отмечена премией им. С.И. Спасокукоцкого, а его классический труд «Дефекты и рубцовые заращения глотки шейного отдела пищевода, гортани и трахеи и методика их устранения» был удостоен в 1964 году Ленинской премии.

Г.А. Васильев, М.Д. Дубов, А.И. Евдокимов, А.А. Лимберг, П.П. Львов, Н.М. Михельсон и их ученики разработали способы операций при расщелинах губы и нёба и обосновали сроки их проведения. А.А. Лимберг (1928), усовершенствовав имеющиеся методы оперативных вмешательств, разработал оперативный способ, позволяющий одномоментно решать задачи, стоящие перед хирургом. Радикальную пластику нёба «по Лимбергу» можно по праву считать одним из важнейших достижений отечественной хирургии. Этот метод получил широкое признание специалистов.

Методы хирургического лечения врожденных расщелин нёба и приобретенных дефектов его у взрослых были предложены В.И. Заусаевым (1969), что позволило значительно сократить сроки лечения и обеспечить хорошие отдаленные результаты.

Аналогичные проблемы разрабатывали М.Д. Дубов (1954), И.П. Бакулин (1955, 1966), И.В. Бердюк (1964), Э.Н. Самар (1964), А.Н. Губская (1964) и др.

А.Н. Губская отметила, что профилактика вторичных деформаций челюстно-лицевой области при врожденных расщелинах губы и нёба, заключается в применении рациональных методов хейлопластики и тщательном выполнении отдельных ее этапов.

Для предупреждения недоразвития верхней челюсти после уранопластики, хирургическое вмешательство на небе у детей с изолированной расщелиной нёба, по ее мнению, надо проводить в возрасте 6-7 лет, у детей с сочетанными дефектами — в более старшем возрасте. Детям, оперированным в раннем возрасте по поводу расщелины губы и имеющим расщелину нёба, в возрасте 4-5 лет необходимо применять obturator.

Расширенный пленум Всесоюзного научного медицинского общества стоматологов и 1-я выездная сессия ЦНИИС (27-29 ноября 1963 года)

были посвящены вопросам этиологии, патогенеза, лечения врожденных расщелин верхней губы и нёба, организационным мероприятиям по диспансеризации детей с врожденными расщелинами губы и нёба, методам хирургического и ортодонтического лечения, вопросам профилактики и лечения послеоперационных деформаций губы, носа, нёба, челюстей. Разработка комплексных методов лечения, улучшающих косметический и функциональный эффект лечения губы и нёба, приобрела первостепенное значение.

На V Всесоюзном съезде стоматологов (1968) профессор В.С. Дмитриева отметила, что мало внимания в стоматологии уделяется вопросам травматологии детского возраста. Она выделила важные, по ее мнению, на тот момент мероприятия:

1. Создание специализированных детских стоматологических стационаров на базе стоматологических отделений.
2. Выработка четких установок по лечению ран мягких тканей лица и костей лицевого скелета в детском возрасте.
3. Организация единого центра для лечения детей с ожогами лица и их последствий.
4. Организация единого специализированного стационара для лечения лучевых повреждений челюстно-лицевой области у детей.
5. Подготовка врачей-стоматологов детского профиля на кафедрах детской стоматологии ЦОЛИУ врачей и ММСИ.
6. Издание пособий и руководств по лечению всех видов травмы челюстно-лицевой области у детей.

В.М. Масина (1971, ЦНИИС) провела исследование на тему «Врожденные расщелины нёба (этиология, клиника, лечение)», в котором как возможный этиологический фактор в генезе расщелин верхней губы и нёба, она выделила вирус краснухи и предложила вакцинацию женщин детородного возраста, разработала методы диагностики и лечения больных с расщелинами нёба.

Классификации врожденных расщелин лица, предложенные профессором Ю.И. Вернадским в соавт. и профессором Л.Е. Фроловой, нашли широкое применение в нашей стране.

Развитие анестезиологии, реаниматологии и совершенствование техники операций позволили производить операционные вмешательства в более раннем возрасте. Пластика верхней губы у новорожденных при врожденных расщелинах губы была предложена профессором Л.Е. Фроловой (1956) и стала проводиться в родильных домах или специализированных хирургических отделениях для новорожденных на 2-4-й или после 11-14-го дня жизни ребенка.

Б.Я. Булатовская (1975) показала целесообразность и необходимость комплексного лечения детей с врожденными расщелинами губы и нёба (хирург, ортодонт, логопед и другие специалисты) в детских садах и в специальных интернатах.

Значительное внимание хирурги уделяли вопросам оперативного лечения различных врожденных пороков развития челюстно-лицевой области (В.М. Безруков, 1965; В.И. Арцибушев, 1968; Л.А. Брусова, 1975; В.Ф. Рудько, 1976; и др.).

Профессор М.М. Соловьев в работе «Современное состояние проблемы острой одонтогенной инфекции и повреждений челюстно-лицевой области» (1981) отметил, что, несмотря на очевидные успехи, резервы по улучшению результатов и сокращению сроков лечения больных с травмой челюстей и лица еще не исчерпаны: «Искать их следует, прежде всего, в сокращении сроков, прошедших от травмы до момента оказания специализированной помощи; в совершенствовании методов закрепления отломков, особенно у больных с сочетанным и множественными переломами костей лица; в улучшении централизованного снабжения материалами, инструментами и аппаратами, необходимыми для консервативного и оперативного лечения переломов челюстей; в повсеместном внедрении системы реабилитационных мероприятий, разработанной с учетом местных условий».

В 1991 году был создан Центр детской челюстно-лицевой хирургии, который возглавил профессор В.В. Рогинский. Ученый создал новые направления в челюстно-лицевой хирургии: дистракционный остеосинтез костей лица, стереолитографическое и компьютерное моделирование. Он участвовал в создании новых композиционных биозамещающих материалов.

В настоящее время, когда не утихают локальные военные конфликты, стоматологам-хирургам приходится решать много проблем связанных с лечением сложных травматических челюстно-лицевых повреждений, из-за применении новых видов оружия большой поражающей силой и использование пуль со смещенным центром тяжести. Лучшие стоматологи-хирурги, в т.ч. специалисты хирургической стоматологической школы под руководством академика РАМН, заслуженного деятеля науки РФ, дважды лауреата Государственной премии, лауреата первой национальной премии «Призвание» для профессорско-преподавательского состава стоматологических факультетов России в номинации «Корифеи стоматологии» профессора Н.Н. Бажанова, продолжают разрабатывать новые методы оперативных вмешательств, совершенствовать виды обезболивания, сокращать сроки лечения челюстно-лицевых повреждений, внедрять новые формы реабилитации таких больных.

Новообразования, по данным Всемирной организации здравоохранения, наряду с сердечно-сосудистой патологией и гриппом наиболее широко распространены среди населения земного шара. Во многих странах, в том числе и в Советском Союзе, была создана специальная онкологическая служба. В СССР функционировала система научных и лечебно-профилактических онкологических учреждений. Руководящим и координирующим центром не только для нашей страны, но и для многих зарубежных европейских стран в области онкологии был Всесоюзный онкологический научный центр АМН СССР, возглавляемый академиком АМН СССР, профессором Н.Н. Блохиным.

Всесоюзная проблемная комиссия по онкологии координировала

научно-исследовательскую работу, связанную с изучением опухолевой патологии всех органов и систем человека, включая и вопросы стоматологии. Проблемы онкологии челюстно-лицевой области обсуждались в 1925 и 1928 годах на II и III Всесоюзных одонтологических съездах.

Профессор С.Н. Вайсблат в работах «Местная фиброзная остеодистрофия челюстей», «Профилактика и ранняя диагностика злокачественных новообразований рта» изложил клинические и рентгенологические признаки ранней диагностики злокачественных новообразований челюстей, дифференциальную диагностику фиброзной остеодистрофии и другие вопросы.

Исследования, связанные с изучением этиологии, патогенеза и лечения опухолей челюстно-лицевой области, проводились на кафедре хирургической стоматологии Ленинградского медицинского института, возглавляемой профессором В.А. Дунаевским. По его инициативе в 1969 году на базе городской онкологической больницы Ленинграда, впервые в Советском Союзе, был организован онкостоматологический стационар. Основным направлением научных исследований кафедры, помимо изучения патогенеза и совершенствования методов лечения воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области, было совершенствование методов диагностики, комплексного лечения и реабилитации больных с опухолями челюстно-лицевой области.

Среди всех доброкачественных опухолей человеческого организма особо важное место занимают ангиомы. Чаще всего они встречаются у детей. Работы по изучению гемангиом и лимфангиом лица, челюстей и органов полости рта в течение многих лет проводились на кафедре госпитальной хирургической стоматологии ММСИ под руководством А.И. Евдокимова и В.Ф. Рудько.

В 1978 году вышла в свет монография П.М. Горбушиной «Сосудистые новообразования лица, челюстей и органов полости рта», в которой был обобщен многолетний опыт кафедры и наблюдения автора за больны-

ми с сосудистыми опухолями лица, челюстей и органов полости рта. В монографии приведена клинико-морфологическая классификация сосудистых опухолей, подробно описаны разнообразные клинические проявления и морфологическая картина гемангиом, лимфангиом, фиброангиом и ангиом челюстных костей. Кроме того, в работе были приведены симптомы сопутствующих им функциональных и косметических расстройств и их лечение, рассмотрены методы хирургического и консервативного лечения сосудистых опухолей, в т.ч. метод склерозирующей терапии, проанализированы отдаленные результаты лечения больных с доброкачественными и злокачественными сосудистыми опухолями и целый ряд других вопросов.

В Тбилисском институте усовершенствования врачей, в клинике хирургической стоматологии, под руководством профессора А.И. Едиберидзе, были изучены вопросы диагностики и лечения опухолей челюстно-лицевой области. В качестве лечебных мероприятий особо важное место было отведено химиотерапии и электрокоагуляции. Для химиотерапии были применены интратату-моральные и перитуморальные инъекции склерозирующих веществ (йод, спирт, новокаин), для электрокоагуляции — аппарат для хирургической диатермии.

Большое внимание разработке этой проблемы на протяжении ряда лет уделял профессор А.А. Колесов, который обобщил эти материалы в докторской диссертации «Первичные опухоли и опухолеподобные образования челюстных костей» (1963), которые, по его данным, составляют 22 % от общего числа новообразований челюстей. Им, для удаления опухолей (выскабливания, спиливания, резекция челюсти), были предложены различные виды оперативных вмешательств. А.А. Колесов предложил проводить работу по лечению данной патологии совместно с онкологическими диспансерами.

Изучением опухолей челюстно-лицевой области на кафедре стоматологии детского возраста ММСИ занимался В.В. Рогинский, который в докторской диссертации на тему: «Доброкачественные опухоли, опухоле-

подобные и гиперпластические процессы лицевого скелета у детей» (1981), выявил распространенность данной патологии среди детей и предложил методы хирургического лечения. В.В. Рогинский разработал схему группировку, основанную на клиническом и гистогенетическом принципах, с использованием гистологических критериев и номенклатуры классификаций ВОЗ.

Ученые разрабатывали вопросы, связанные со злокачественными опухолями слюнных желез. Опыт, накопленный в этой области, изложен в трудах А.И. Пачеса (1964, 1968, 1971, 1974), Н.Я. Бродской, 1971; Н.Д. Бойкова, 1976; Н.Д. Брусеницкой, 1976; Х.С. Аль-Хайера, 1977.

В Днепропетровском медицинском институте на кафедре хирургической стоматологии, которой заведовал профессор Е.С. Малевич, научные исследования были направлены на изучение и лечение доброкачественных и злокачественных новообразований лица и органов полости рта.

Опухоли лица, челюстей и шеи в настоящее время составляют, более 13 % всех хирургических стоматологических заболеваний. Онкологические процессы области лица, полости рта, челюстей и шеи, к сожалению, имеют тенденцию к увеличению числа заболеваний.

Со временем были выработаны оптимальные принципы решения вопросов диагностики и лечения новообразований, которые спасли или продлили жизнь многим больным. На сегодняшний день в Российском онкологическом центре имени Н.Н. Блохина РАМН располагается клиническая база кафедры госпитальной хирургической стоматологии МГМСУ (зав. — профессор С.Ю. Иванов).

Стоматологическая имплантология, возродившаяся в середине XX века, переживает бурное развитие. Лечение с использованием имплантатов вызывает интерес, как у специалистов, так и у пациентов.

Оригинальным исследованием не только в отечественной, но и в мировой литературе по данной проблеме была диссертация В.М. Антоневица «О реплантации и трансплантации зубов» (1885).

Одним из первых врачей, кто начал заниматься имплантологией, был выпускник Московского университета, доктор медицины, приват-доцент Н.Н. Знаменский. Он в 1880 году, закончив медицинский факультет Московского университета, был избран на должность ординатора факультетской хирургической клиники. В 1884 году ученый защитил диссертацию на степень доктора медицины «О перевязывании почечуных узлов прямой кишки» и ему было предложено место приват-доцента для преподавания зубных болезней.

После 3-месячной командировки в Европу с целью ознакомления с состоянием одонтологии, при поддержке Н.В. Склифосовского с 1885/86 учебного года на медицинском факультете Московского университета была открыта первая в России доцентура по одонтологии, руководить которой стал Н.Н. Знаменский. Его труды по имплантологии, основанные на патанатомических и клинических наблюдениях, привлекли внимание специалистов.

Первая работа Н.Н. Знаменского под названием «Имплантация искусственных зубов» была доложена в 1891 году на IV Пироговском съезде врачей и опубликована в журнале «Медицинское обозрение».

Термины «имплантат», «имплантация», предложенные Н.Н. Знаменским, подразумевают применение предметов, изготовленных из небиологических материалов, которые вводятся в организм для длительного функционирования. В качестве имплантата были взяты искусственные зубы, изготовленные целиком из фарфора, с корнями из стеклянной массы и каучука.

27 ноября 1890 года Н.Н. Знаменский провел свой первый эксперимент.

После обезболивания 2 % раствором морфия у собаки были удалены резцы, затем, расширив каждую ячейку, в них поместили фарфоровые зубы с нарезками по периферии корня. Эксперимент завершился клиническими наблюдениями. Первый опыт имплантации зубов не получил развития, имплантаты отторглись через 20-35 дней. Несмотря на неудачу в экс-

перименте и в клинике, Н.Н. Знаменский проследил патоморфоз при имплантации. Кроме того, он первым сделал в апикальной части своего имплантата сквозное отверстие, для прорастания в него кости, назвав такую конструкцию окончатой. Эта идея нашла применение в большинстве современных конструкций внутрикостных имплантатов.

В России одонтопластика, в т.ч. реплантация, трансплантация и аллотрансплантация делали свои первые шаги только в 50-е годы XX века. На данном этапе результаты были неутешительными. Имплантируемый в челюсть материал подвергался резорбции или же отторгался.

Были сделаны попытки использовать для имплантатов пластмассу, плексиглас, хромокобальтовые сплавы. Второй этап развития имплантологии, связан с именем Э.Я. Вареса, который, изучая асептическое воспаление от введения в подкожную соединительную ткань стерильных целлюлозных трубочек, заметил, что соединительная ткань врастая в отверстия трубочек, обрастает ее по окружности, и, превращаясь в рубцовую соединительную ткань, плотно удерживает трубочку на протяжении жизни животного. Выяснилось, что соединительная ткань, вросшая в каналы пластмассового имплантата, может замещаться костной тканью.

Позднее Э.Я. Варес имплантировал в лунку удаленного зуба подготовленный искусственный зуб. После того, как в каналы вросла соединительная ткань, ученый с помощью соединительного штифта укреплял коронковую часть искусственного зуба. Гистологическое сравнение показало предпочтительность второго, двухэтапного метода.

В 1956 году, вышла работа Г.Б. Брахман, которая расширила представления о новом разделе стоматологии.

Б.Н. Бынин, И.И. Ревзин, В.И. Вишневская, Л.М. Дыхно, Б.А. Шварц, В.В. Добрин, Н.С. Ломтева, М.В. Мухин посвятили свои исследования изучению сополимеров полиметилметакрилатов для стоматологии. Были сделаны попытки использовать для имплантатов пластмассу, хромокобальтовые сплавы.

В этом же году С.П. Мудрый для двухэтапной внутрикостной имплантации использовал плексиглас.

В медицинской печати стали появляться статьи с противоречивой оценкой имплантации искусственных зубов, что привело к появлению в 1958 году Указа Минздрава СССР о запрете имплантации в отечественной стоматологии.

Тридцать лет понадобилось отечественным стоматологам, чтобы вернуться к этой проблеме. Мировая стоматология, развивая различные методы имплантации, создавала школы имплантологов, разрабатывала инструментарий и оборудование, выпустила набор имплантатов по системе Бранемарка. В 1978 году был достигнут стандарт, позволяющий получать хорошие результаты (Швеция). Следующий этап развития имплантологии СССР дал новые имена исследователей из Каунаса: профессор О.П. Суров, С.П. Чепулис, А.С. Черникис. С 1979 года начались подготовительные работы для изготовления имплантатов и инструментария. Но только в 1981 году ученые приступили к клиническим исследованиям и первым имплантациям.

В 1983 году, благодаря хорошим результатам применения титановых имплантатов, в Москве была открыта экспериментальная лаборатория зубной имплантации и протезирования.

4 марта 1986 года Минздрав СССР издал приказ № 310 «О мерах по внедрению в практику метода ортопедического лечения с использованием имплантатов», открывший пути развитию метода в масштабах СССР. Через два месяца после выхода приказа было открыто отделение имплантологии в ЦНИИС, под руководством А.И. Матвеевой.

Большой вклад в развитие отечественной имплантологии в 80-90 годах XX века внесли врачи Э.Г. Амрахов, И.В. Балуда, В.А. Воробьев, А.А. Кулаков, В.В. Лось, Б.П. Марков, М.З. Миргазизов, В.Н. Олесова, Т.Г. Робустова, С.П. Чепулис, А.С. Черникис и др. Они были первыми разработчиками отечественных имплантатов в форме корня зуба.

20 апреля 1992 года в России состоялась учредительная конференция Ассоциации специалистов стоматологической имплантации. Стали открываться центры и курсы по подготовке стоматологов-имплантологов. С 1993 года стали выпускать имплантаты, которые имеют винтовые конструкции, как для одноэтапной, так и для двухэтапной операции.

В 1994 году ММСИ была организована кафедра хирургической стоматологии и имплантологии (зав - проф. С.Ю. Иванов).

Изучение клинико-тоеретических вопросов и полученные положительные результаты при использовании плоских имплантатов нашли место в публикациях В.М. Безрукова, А.И. Матвеевой, А.А. Кулакова, А.И. Ушакова, С.Ю. Иванова. Преимуществом плоских имплантатов является возможность протезировать пациента через 3-4 недели после хирургического вмешательства. Это обстоятельство определило широкое распространение плоских имплантатов. В России с 1998 года стали широко применять плоские отечественные импланты «ВНИИМТ», «Конмет» и др.

В МГМСУ разработаны методы лечения, инструментарий, биоматериалы, функционируют курсы усовершенствования врачей. Все это создает условия для широкого внедрения дентальной имплантации в широкую стоматологическую практику.

Крупным успехам челюстно-лицевая хирургия, в значительной степени, обязана разработке новых фармакологических препаратов, новых методов использования, которые способствуют созданию благоприятных условий для выполнения любых стоматологических операций и поддержанию жизненно-важных функций организма человека.

Научный поиск ученых был направлен на совершенствование местного (С.Н. Вайсблат, М.М. Вейсбрем, М.Ф. Даденко, Н.Ф. Фетисов), смешанного (Н.Н. Бажанов, Ю.И. Вернадский, С.Н. Карпенко, И.О. Кругляков, С.Н. Вайсблат (1887-1965), Е.В. Скопец), интратрахеального и масочного ингаляционного (Н.М. Александров, Л.А. Алексеев, И.В. Бердюк, Н.Д. Лесовая, Г.Г. Митрофанов) и гексеналового (Е.В. Скопец) обезболивания.

В СССР вопросы обезболивания в стоматологии впервые глубоко и всесторонне начал разрабатывать профессор С.Н. Вайсблат, который внедрил методику внутри- и внеротовой проводниковой анестезии челюстей.

Вопросы обезболивания обсуждались на I (1923), II (1925) и III (1928) Всесоюзных одонтологических съездах (С.Н. Вайсблат, И.М. Коварский, В. М. Уваров, Д.А. Энтин и др.).

Профессор В.М. Уваров в работе «Экстраоральная мандибулярная анестезия» (1927) отметил, что местная анестезия в стоматологии всегда занимала ведущее место, и лишь в сложных случаях, хирурги прибегали к общему наркозу. Ученый, при наиболее сложных оперативных вмешательствах, предложил методы экстраоральной анестезии при невозможности применить интраоральную. На III Всесоюзном одонтологическом съезде (1928) он сделал доклад «Регионарная анестезия при остеомиелитах челюстей», в котором подчеркнул преимущества проводникового обезболивания при остеомиелитах, т. к. применение общего наркоза, особенно при септических остеомиелитах, чревато для дальнейшего развития патологии.

Профессор Д.А. Энтин в книге «Военная челюстно-лицевая хирургия» (1941) расширил показания к анестезии, как лечебному воздействию при обработке челюстно-лицевых повреждений.

М.П. Жаков (1955, 1958, 1965) при заболеваниях и травмах челюстно-лицевой области предложил применять тригеминосимпатическую лицевую блокаду новокаином; М.Ф. Даценко (1958) рекомендовал использовать масляные растворы новокаина; Д.А. Энтин (1945), С.Н. Вайсблат (1962) и др. — спиртовые растворы для пролонгирования действия анестетика.

Практическое применение нашли местные анестетики: ксилокаин, оксикаин, мезокаин, лидокаин, тримекаин и др.

Над проблемой обезболивания в челюстно-лицевой области плодотворно работали Н.Н. Бажанов, Ю.И. Вернадский, Я.Э. Бронштейн, Г.А. Васильев, С.Н. Вайсблат, М.М. Вейсбрем, А.Е. Верлоцкий, Е.М. Гофунп, М.Ф. Даценко, М.Д. Дубов, И.М. Старобинский, Н.Ф. Фетисов и др.

Ю.И. Вернадский и его сотрудники разрабатывали методы местного потенцированного обезболивания в хирургической стоматологии. В условиях челюстно-лицевых стационаров метод потенцирования местного обезболивания посредством новейших нейроплегических и ганглиоблокирующих препаратов (Ю.И. Вернадский) оказался особенно перспективным, а в условиях поликлиники — газовый наркоз с закисью азота (Н.В. Бердюк, Г.Г. Митрофанов), а также аппликационная (П.Г. Гузенко), регионарная и инфильтрационная анестезия.

При стоматологических вмешательствах, для снятия эмоциональных реакций, в поликлиниках стали применять малые транквилизаторы — атактики (Н.Н. Бажанов, 1965; М.В. Комендантова и др., 1965), звуковую анальгезию «белый шум» (Г.С. Мироненко, 1964, 1965, И.М. Оксман и др., 1965), психопрофилактику и психотерапию (В.А. Сафонов, 1964, 1966) и ряд других способов.

Профессор Б.Д. Кабаков, при хирургических вмешательствах в стационаре, в 20 % случаев применял общий эндотрахеальный наркоз. Общее обезболивание стало шире, по показаниям, применяться в амбулаторной стоматологической практике (М.В. Хмелевский, 1933; Г.Г. Митрофанов, 1956; Л.И. Алексеев, 1957; А.И. Маркин, 1966; А.Ф. Бизяев, 1969; П.В. Черных, 1971; В.С. Стародубцев, 1971; и др.). При этом виде обезболивания создаются оптимальные условия для выполнения радикальных и косметических стоматологических операций в стационарных и амбулаторных условиях. Местная анестезия, в силу индивидуальных различий амбулаторных больных, не всегда обеспечивает достаточный обезболивающий эффект и не лишена ряда недостатков, тем не менее, она является наиболее распространенным методом обезболивания в поликлиниках (В.Ф. Рудько, 1967; М.Г. Панин, 1967; Н.Н. Бажанов, 1968; Н.М. Кабилов, 1968).

Это обстоятельство послужило основанием для изучения возможностей применения общего обезболивания при непродолжительных вмешательствах в условиях стоматологической поликлиники и стационара.

В нашей стране широкое распространение получил ингаляционный наркоз. Для этой цели в поликлинических условиях были использованы закись азота, трилен, фторотан. Наиболее стабильные положительные результаты наблюдаются при применении сочетания закиси азота, фторотана и кислорода (Н.Н. Бажанов, В.Н. Александров, 1968).

На V Всесоюзном съезде стоматологов (1969) Н.Н. Бажанов и В.Н. Александров доложили о применении общего обезболивания в стоматологической поликлинической практике, что имеет свои специфические особенности, в связи с чем, был поставлен вопрос о подготовке анестезиологов и формировании анестезиологической службы в условиях поликлиники.

В 60-х годах XX столетия значительное распространение в стоматологии получили физические методы обезболивания: микрогальванический (А.С. Менабде, М.С. Лордкипанидзе, 1960; Р.Р. Керер, 1962; Г.М. Иващенко, Т.В. Никитина, 1966; М.А. Смирнов, 1966), диадинамическими токами (П.А. Батиевский, 1963), электрофорез анестезирующие вещества (Н.А. Мухин, 1965, Г.С. Мироненко, 1966)

Расширение диапазона оперативных вмешательств и внедрение в практику хирургической стоматологии современных методов обезболивания требовали максимального наблюдения за состоянием больного во время наркоза и операции. А.Ф. Бизяев во время стоматологических операций, проводимых под эндотрахеальным наркозом, предложил контролировать состояние больного непрерывной флеботонометрией. Возрос интерес к наркозу закисью азота не только в общехирургической, акушерско-гинекологической, но и в стоматологической практике. П.В. Черных (1971) показал, что наркоз закисью азота с кислородом обеспечивает достаточный болеутоляющий эффект при различных амбулаторных стоматологических вмешательствах. Техника его применения проста, не требует сложной премедикации больного, осуществляется без использования ротоглоточных obturаторов роторасширителей, что, облегчает работу стоматолога.

В.С. Стародубцев (ММСИ) изучил клинику при наркозе трихлорэти-

леном с закисью азота с кислородом в стадии анальгезии и наркоза пропанидидом (эпонтолом) при непродолжительных стоматологических вмешательствах и обобщил полученные данные в работе «Общая анестезиология при непродолжительных стоматологических вмешательствах в условиях поликлиники и стационара» (1971). Он провел сравнительную оценку влияния трихлорэтилена, фторотана, а также пропанидида (эпонтола) на гемодинамику и дыхание при отсутствии премедикации, разработал показания к применению трихлорэтилена, фторотана, пропанидида (эпонтола) при кратковременных операциях в зависимости от особенностей патологического процесса и характера вмешательства.

Профессор Л.С. Линденбаум, одним из первых в нашей стране, применил местную анестезию в терапевтической стоматологии. Уже к 1935 году он обобщил результаты наблюдения за лечением больных с пульпитами под местным обезболиванием.

Используя принципы бережного, щадящего отношения к психическим и физическим ощущениям больных, ученые продолжали поиск обезболивающих средств при терапевтическом и ортопедическом лечении (С.И. Вайс, Е.И. Гаврилов, Я.И. Гутнер, А.И. Дойников, И.М. Оксман, Е.Е. Платонов, Л.Р. Рубин, И.М. Старобинский, Л.И. Урбанович, М.М. Хотинская, А.Э. Шарпенак, О.К. Титрянц и др.). Известно, что наряду с порогом болевого ощущения существует и порог болевой реакции (реакция страха), который меняется в зависимости от внешних условий, индивидуальных особенностей организма, эмоциональной настроенности больного. В.И. Исмаилова (1966, 1967) показала, что, воздействуя на организм фармакологическими средствами, можно изменить как порог болевого ощущения, так и порог болевой реакции. Среди средств, успокаивающих и нормализующих нервную деятельность, а, следовательно, повышающих выносливость человека к болевым раздражениям, большую популярность получили транквилизаторы, которые устраняют психическую напряженность, страх, нервозность, повышенную эмоциональность и т.д.

В стоматологических поликлиниках и отделениях при наличии специалистов-анестезиологов и соответствующей аппаратуры приемлемы все ныне известные способы обезболивания. Там, где нет анестезиологов, стоматологи обязаны владеть методами психопрофилактики и психотерапии, уметь проводить местное инфильтрационное и проводниковое обезболивание с премедикацией, электроанальгезию и электрофорез. Согласно резолюции IV Всесоюзного и I Всероссийского съездов стоматологов, а также, принимая во внимание приказ министра здравоохранения СССР от 14 апреля 1966 года, все известные способы и средства местного и общего обезболивания должны использоваться не только в хирургической, но и в терапевтической и ортопедической стоматологии, используя современные технологии.

В 1977 году в ММСИ была открыта первая в стране лаборатория по изучению боли и методов обезболивания (зав. проф. И.А. Шугайлов) на базе лаборатории была открыта кафедра анестезиологии и реаниматологии ФПКС (1986) (зав. проф. И.А. Шугайлов). С 1997 года — зав. проф. С.А. Рабинович.

Современный уровень развития медицинских знаний и внедрение новейшего оборудования обеспечивает возможность проведения обезболивания при любом хирургическом вмешательстве в челюстно-лицевой области.

4.4.3. Ортодонтия.

Из разделов, составляющих современную стоматологию, стоматология детского возраста всегда была ее неотъемлемой частью. В 30-е годы XX века она выделилась в самостоятельную дисциплину, включив в себя терапевтический, ортодонтический и хирургический разделы. Ортодонтия от зубоврачевания дореволюционной России не получила никакого научного наследия. Примитивные представления об ортодонтии содержались в общих курсах по одонтологии. В двухтомном руководстве по зубоврачеванию Изачика (1915) раздел по ортодонтии, под названием «Регулировка

зубов», занимает всего 32 страницы. Значительный научный вклад отечественных ученых в ортодонтию связан с именем Л.Я. Катца.

В 1933 году А.Я. Катц, выступая на Ленинградской протезно-ортопедической конференции, с программой профилактической ортодонтии, впервые изложил план и методические основы ортодонтического лечения зубочелюстной системы функционально-действующими аппаратами. Этот год по праву можно назвать основной вехой в развитии функционального направления в ортодонтии в нашей стране.

В докторской диссертации «Архитектура нижней челюсти в связи с расположением корней и устойчивостью зубной дуги у взрослого человека» (1935) А.Я. Катц представил результаты изучения строения кости в зависимости от функциональной нагрузки, проследив закономерности регенерации костной ткани в различные периоды их роста и формирования.

В работе «Функция группы мышц, поднимающих нижнюю челюсть» (1936) А.Я. Катц изучил характер совместной деятельности жевательных мышц, а в статье «Лечение сформировавшихся аномалий прикуса», на основе обширного клинического материала, он отметил положительные результаты лечения аномалий прикуса, предложенной им функциональной аппаратурой.

А.Я. Катц и Е.Д. Лалетина в работе «Направляющие коронки с раздвигателями» описали лечение одного или нескольких смещенных верхних резцов с помощью нового оригинального несъемного ортодонтического аппарата.

В работе «Наши установки и методы лечения в зубочелюстно-лицевой ортопедии (ортодонтии)» (1939), А.Я. Катц дал определение «функциональной нормы» зубочелюстного аппарата, в основе которой лежит соотношение функциональных и анатомических особенностей жевательного аппарата с учетом относительной устойчивости его физиологического равновесия.

В отличие от ранее известных классификаций аномалий зубочелюстной системы Энгля, Симона, Хаулея и Канторовича, А.Я. Катц предложил

свою классификацию аномалий зубочелюстной системы, в которой кроме морфологических признаков аномалий, он уделял большое внимание функциональной характеристике жевательной мускулатуры.

Ученый подверг критике господствовавшие тогда в медицинской литературе взгляды зарубежных авторов на физиологию и патологию жевательного аппарата. А.Я. Катц создал новое, функциональное направление в ортодонтии, суть которого заключалась в применении аппаратуры, являющейся физиологическим раздражителем, приводящей к перестройке челюстных костей, мышц и других тканей. Это направление и стало основой отечественной профилактики в ортодонтии. Профилактические мероприятия в ортодонтии, благодаря применению направляющих функциональных аппаратов, направлены на предотвращение развития стойких деформаций зубочелюстной системы. Даже в случаях применения механически действующих аппаратов в начале лечения, по мнению А.Я. Катца, продолжать его надо функциональными аппаратами.

На ранних стадиях развития зубочелюстных аномалий А.Я. Катц и его ученики (Е.Д. Волова, А.К. Выкшемский, Е.Д. Лалетина, К.Н. Новоторова, Л.В. Рожкова) применяли щадящую аппаратуру, которая предупреждала дальнейшее развитие аномалий.

Развивая функциональное направление в ортодонтии, ученик А.Я. Катца — И.С. Рубинов в 1938 году применил новый функциональный метод исследования работы зубочелюстного аппарата — мастикациографию. В работе «Клиника и функциональная терапия аномалий прикуса с точки зрения мастикациографии» (1951) И.С. Рубинов отметил, что по данным мастикациограмм, можно наблюдать процесс перестройки жевательной функции и динамику ортодонтического лечения.

Б.К. Костур (1964), используя мастикациографию и жевательную пробу по И.С. Рубинову, установила, что в период смены зубов происходят существенные изменения жевательной функции, а в процессе прорезывания постоянных зубов, показатели жевательных движений нормализуются,

повышая степень измельчения пищи. Автор установила, что в сменном прикусе процесс жевания является эффективным лишь при наличии окклюзионных контактов.

На кафедре ортопедической стоматологии 1-го Ленинградского медицинского института им. академика И.П. Павлова, под руководством профессора Л.М. Перзашкевича, было изучено изменение жевательной функции при применении различных видов ортодонтических аппаратов и адаптации человека после завершения лечения.

Большая заслуга в развитии ортодонтии принадлежит Н.И. Агапову. В учебнике «Клиническая стоматология детского возраста» (1937) им были представлены основы ортодонтии, которые явились теоретической базой для подготовки врачей-педиатров и ортодонтотв. Лечение аномалий, в основном, проводилось ортодонтическими аппаратами, под действием которых происходили сложные процессы перестройки зубных и околозубных тканей, в зубных дугах, альвеолярных отростках, височно-челюстных суставах и других органах зубочелюстной системы. Результаты этой перестройки зависели от многих факторов, в т.ч., от возраста пациента и времени начала лечения.

А.И. Гуляева, И.Л. Злотник, Л.В. Ильина-Маркосян, А.Я. Катц, Х.А. Каламкаров, В.Ю. Курляндский, Г.А. Турובה и др. придерживались мнения о необходимости раннего ортодонтического лечения, т.е. в периоде молочного прикуса. Б.Н. Бынин, Н.Ф. Бовдзей, Я.С. Хургина утверждали, что аппаратное лечение нужно применять в периоде сменного прикуса, а при молочном прикусе следует ограничиваться лишь проведением профилактических мероприятий. Н.И. Агапов, С.С. Райзман, З.И. Штробиндер и др. считали, что в молочном и сменном прикусах, необходимо осуществлять только профилактические мероприятия. Аппаратное лечение следует проводить только в постоянном прикусе.

Для разработки возрастных показаний к ортодонтическому лечению учеными были проведены экспериментальные исследования по изучению

характера и механизма перестройки костной ткани под воздействием ортодонтической аппаратуры в различные периоды формирования зубочелюстной системы.

А.А. Аникиенко, М.М. Ванкевич, Х.А. Каламкаров, Д.А. Калвелис, А.И. Позднякова, С.С. Райзман, Г.Т. Сухарев и др., на основе экспериментов по перемещению зубов, выявили типичные изменения в тканях, окружающих зуб, что позволило при лечении зубочелюстных деформаций применять такую ортодонтическую аппаратуру, которая дает возможность учитывать внутрисистемную перестройку тканей.

Вопросы этиологии и патогенеза зубочелюстных деформаций интересовали ученых всегда.

Оригинальные исследования в этой области ортодонтии провела М.М. Ванкевич. Результаты своих наблюдений она представила в докладе на III Всесоюзном стоматологическом съезде (1928). М.М. Ванкевич обнаружила, что причиной аномалий прикуса является затрудненное дыхание из-за аденоидных разрастаний в верхних отделах дыхательных путей.

Клинические наблюдения и экспериментальные исследования, включая собственные, посвященные различным вопросам ортодонтии, были описаны С.С. Райзманом в первой отечественной монографии «Практическое руководство по ортодонтии», которая вышла в 1933 году.

В монографии изложены основы эмбриологии полости рта, указаны сроки прорезывания зубов, изучена морфология молочного и постоянного прикуса, этиология аномалий окклюзии и артикуляции. Свой труд С.С. Райзман посвятил энтузиасту и борцу за советскую стоматологию П.Г. Дауге.

С.С. Райзман провел оригинальные экспериментальные исследования на животных по изучению клинико-морфологических параллелей тканевых изменений при ортодонтическом лечении. Он моделировал зубочелюстные аномалии и проводил рентгенологические и морфологические сопоставления механизма тканевых изменений при ортодонтическом лечении.

Свои многолетние наблюдения ученый обобщил в докторской диссертации (1947). Результаты его исследований значительно изменили принципы ортодонтического лечения. В статье «Экспериментально-рентгенографические исследования челюстей» (1954) С.С. Райзман убедительно доказал, что при перемещении зуба происходит не перемещение зуба и окружающих его тканей (Оппенгейм, Кингслей, Готлиб, Шварц, Гербст), а перестройка окружающих зуб тканей. Видимость перемещения создается благодаря тому, что в зоне давления происходит деструкция кости, а в зоне натяжения — преобразование молодой костной ткани.

В диссертации «Динамика морфологических изменений зубных и околозубных тканей под воздействием ортодонтических аппаратов» (1953) Г.Т. Сухарев отметил, что при лечении зубочелюстных деформаций как механическими, так и функциональными аппаратами, изменения зубных и околозубных тканей идентичны. Характер этих изменений зависит лишь от величины и продолжительности действия силы. В работе «Диагностика аномалий жевательного аппарата (прикуса)» (1968) на основе «патогенетических признаков с учетом клинического значения количественных и качественных изменений в жевательном аппарате», ученый представил классификацию аномалий.

А.И. Позднякова в работе «Изменения в амфодонте перемещенных зубов при применении ортодонтической аппаратуры в эксперименте» (1954) сделала вывод, что рассасывание костной ткани лунки происходит на стороне давления у пришеечной части ее внутренней стенки. На противоположной стороне лунки происходит напластование молодой кости. Степень изменений в амфодонте находится в прямой зависимости от интенсивности силы, и времени действия механического аппарата.

Заслуженный врач Латвийской ССР, заслуженный деятель науки Латвийской ССР, профессор Д.А. Калвелис и его ученики Г.Ю. Пакалнс, Л.Б. Треймане, З.П. Ширика и др. много лет изучали биоморфологические основы ортодонтического лечения.

Все морфологические изменения в зубочелюстной системе при ортодонтическом лечении Д.А. Калвелис разделил на 4 этапа:

1. Морфологические изменения при перемещении зубов.
2. Тканевые преобразования в области срединного небного шва.
3. Трансформация челюстной кости в результате ее нагрузки.
4. Тканевые преобразования при сагиттальном перемещении зубных рядов и челюстей.

Ученый пришел к выводу, что тканевые изменения, при действии функциональной и механической аппаратуры, аналогичны. Анализируя характер и целесообразность применения непрерывно и прерывисто действующих аппаратов, Д.А. Калвелис отметил, что оба вида сил действуют строго периодически, с большей или меньшей продолжительностью. Изучая кровообращение в околозубных тканях, Д.А. Калвелис отметил, что в начале действия аппарата, из-за сдавления периодонта, кровообращение сначала нарушается, затем постепенно восстанавливается, поэтому тканевые изменения не успевают развиваться. Длительное нарушение кровообращения, при продолжительном действии силы, может привести к значительным деструктивным изменениям в тканях пародонта. Исходя из этого, Д.А. Калвелис рекомендовал применение такого ортодонтического лечения, при котором силы, развиваемые аппаратом, не превышают капиллярного давления.

Ученый неоднократно обращал внимание на то, что интенсивность и тяжесть тканевых преобразований при ортодонтической нагрузке на зубы зависит не только от силы и времени действия ортодонтического аппарата, его конструктивных особенностей, но и от реактивности организма, возраста, состояния здоровья.

Гистологические исследования подтвердили, что характер тканевых преобразований у человека в условиях ортодонтической клиники, тождественен с таковыми у животных в эксперименте. Это обстоятельство позволило изучать тканевые изменения опытным путем, так как гистологические исследования клинического материала весьма затруднительны.

Для рационального лечения зубочелюстных аномалий, по мнению Д.А. Калвелиса, главным является учет функциональных и морфологических изменений, выявление особенностей течения и прогноз исхода лечения. Ученый указывал на необходимость индивидуального подхода при диагностике, оценке тяжести аномалии у каждого пациента.

Большой клинический опыт позволил Д.А. Калвелису разделить признаки, характеризующие нормальное и патологическое состояние жевательного аппарата, на безусловные и относительные, а последние — на существенные и несущественные. Наибольшее внимание он уделял признакам, влияющим на структуру и функцию жевательного аппарата: вариация числа зубов, особое положение отдельных зубов, ненормальная форма зубных рядов, несоответствие величин и положения обоих зубных рядов (аномалия смыкания), своеобразное соотношение челюстей с черепно-лицевым скелетом и др. Из большого количества признаков Д.А. Калвелис выделил группу важных (относительно существенных) признаков, имеющих терапевтическое значение.

По мнению ученого, не все зубочелюстные аномалии нуждаются в лечении. Незначительное отклонение от нормы, не влияющее на функцию и внешность пациента, следует рассматривать как индивидуальную особенность, не требующую лечения, что соответствует отдельным положениям классификации зубочелюстных аномалий, принятой Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), в которую включены аномалии «требуемые и не требующие лечения».

Классификация зубочелюстных аномалий, предложенная Д.А. Калвелисом, получила всеобщее одобрение.

Г.Ю. Пакалнс, заведующий кафедрой ортопедической стоматологии Рижского медицинского института, свои многолетние поиски посвятил изучению морфологии маргинального пародонта и его изменениям при ортопедических и ортодонтических вмешательствах, в зависимости от возраста.

Профессор кафедры ортопедической стоматологии Рижского государственного медицинского института Л.Б. Треймане, работала над темой «Профилактическое значение раннего выявления основных признаков прогнатии» (1961), результаты которой не потеряли своего практического значения и по сей день. Вопросам диагностики прогнатии, с применением современных методов исследования, рациональному ее лечению, посвящены работы И.К. Иргенсон. Результаты изучения морфологии срединного небного шва при ортодонтическом расширении верхней челюсти отражены в работах Д.А. Калвелиса (1961), А.Я. Лагоновского (1967), В.Н. Володкина (1968), З.Б. Ласосаса (1968) и др.

На кафедре ортопедической стоматологии ММСИ, под руководством заслуженного деятеля науки РСФСР, профессора В.Ю. Курляндского, в 50-е годы XX столетия было проведено экспериментальное изучение изменений в околозубных тканях при перемещении зубов у собак различных возрастов.

В клинико-экспериментальных исследованиях, посвященных этому вопросу (1951-1958), ученица В.Ю. Курляндского — А.А. Аникиенко пришла к выводу, что «применение в эксперименте и клинике сил, вызывающих при вертикальном перемещении зубов неприятные и болевые ощущения, способствует целенаправленной перестройке зубочелюстной системы без возникновения процессов в зубных и околозубных тканях». Она доказала, что возрастные показания к вертикальному перемещению зубов могут быть значительно расширены. Начинать перемещение зубов лучше до полного формирования корней, раннее лечение тяжелых форм открытого прикуса более эффективно и протекает в более короткие сроки.

В 1957 году В.Ю. Курляндский опубликовал монографию «Зубочелюстные аномалии у детей и методы их лечения (ортодонтия)», в которой представлена клинико-морфологическая классификация зубочелюстных аномалий, в основе которой лежит взаимосвязь формы и функции, что имеет большое значение для клиники.

Ученый подробно изучил вопросы этиологии, профилактики, клиники и лечения аномалий зубочелюстной системы. Им были разработаны ортодонтические аппараты: коронка со съёмной наклонной плоскостью для перемещения и исправления положения зубов, аппарат со съёмной направляющей плоскостью для исправления положения небностоящих фронтальных зубов верхней челюсти, аппарат с орально расположенной ортодонтической дугой, аппараты для сужения зубного ряда верхней челюсти и сагиттального сдвига нижней челюсти.

В.Ю. Курляндский широко применял ортодонтическое лечение не только детей, но и взрослых (1956). Положительные результаты ортодонтического лечения взрослых отмечали Г.А. Кодинский, 1928; А.М. Савич, 1948.

Научное обоснование и совершенствование методов ортодонтического лечения при сформированном прикусе, развилось благодаря работам В.Ю. Курляндского, а также исследованиям В.Л. Бацвадзе (1957), Э.Е. Слободяника (1957), Ф.Я. Хорошилкиной (1958), В.И. Шилова (1958), И.В. Ужумецкене (1965) и др. В.Ю. Курляндский и его ученики научно обосновали ортодонтию сформированного прикуса.

В диссертации на тему «Ортодонтическое лечение и протезирование при недоразвитой верхней челюсти в сформированном прикусе» (1965), Л.С. Величко, под руководством В.Ю. Курляндского, выявил разновидности недоразвития верхней челюсти, разработал наиболее рациональные методы лечения, определил эффективность ортодонтического лечения недоразвитой верхней челюсти у взрослых и разработал показания к применению различных конструкций протезов.

В 1967 году О.Н. Валенкова в диссертации «Функциональная характеристика жевательной мускулатуры в норме и при некоторых аномалиях зубочелюстной системы», используя миографию, мастикациографию, миоэлектромиографию, пришла к выводу, что выявленные закономерности сократительных реакций и тонуса поверхностно расположенных жевательных

мышц, могут служить для изучения функциональной активности жевательной мускулатуры при орто-донтическом лечении больных с различными аномалиями.

Н.А. Моллаев воспроизвел в эксперименте расширение верхней челюсти и проследил динамику кальциевого обмена в тканях пародонта, небного шва и в костных тканях, отдаленных от непосредственного воздействия ортодонтического аппарата (1968). Изучая характер и динамику изменений кальциевого обмена в исследуемых тканях, в зависимости от силы и срока действия аппарата, отметил нормализацию кальциевого обмена в тех же костных тканях кроликов после расширения верхней челюсти и в период ретенции.

З.П. Чернопятова при лечении глубокого резцового перекрытия, применяя метод последовательной дезокклюзии (1969), установила высоту нижнего отдела лица с уменьшением глубины перекрытия во фронтальном участке зубных рядов.

На кафедре ортопедической стоматологии Калининского медицинского института, под руководством заслуженного деятеля науки РСФСР, профессора Е.И. Гаврилова, на кафедре ортопедической стоматологии ЦОЛИУВ под руководством профессора Х.А. Каламкарова, на кафедре стоматологии детского возраста ММСИ под руководством профессора А.А. Колесова были проведены экспериментальные работы по определению возрастных показаний к ортодонтическому лечению.

Профессор Х.А. Каламкаров в работах: «Влияние перестройки молочного прикуса функционально действующей ортодонтической аппаратурой на рост челюстных костей и формирование постоянного прикуса» (1964), «Клинико-экспериментальное изучение функциональной перегрузки зубов» (1966), «Морфологическая перестройка челюстно-лицевой системы при перемещении нижней челюсти в периоде молочного прикуса» (1966), «Морфологическая перестройка челюстно-лицевой системы при расширении верхней челюсти в периоде молочного прикуса» (1967), раз-

работал показания к применению механических и функционально действующих ортодонтических аппаратов для устранения зубочелюстных аномалий в различные возрастные периоды и их влияние на формирование и рост зубов, зубных рядов, прикуса.

Он изучал влияние перемещения молочных зубов на зачатки постоянных зубов, исследовал тканевые изменения в различных отделах челюстно-лицевой области при расширении верхней челюсти и мезиодистальных перемещениях челюсти при ортодонтическом воздействии в молочном прикусе.

Результаты клинико-экспериментальных исследований, проведенных Х.А. Каламкаровым, обобщены в его докторской диссертации на тему «Морфологические изменения в зубочелюстной системе при ортодонтических вмешательствах в период молочного и сменного прикуса» (1967), в которой автор пришел к заключению, что ортодонтические аппаратные вмешательства в периоде молочного прикуса при применении слабых сил не оказывают отрицательного воздействия на зубочелюстную систему и, в частности, на зачатки постоянных зубов. При достаточных сроках воздействия аппаратов, полученные результаты закрепляются, и исключается возможность рецидивов. Ученый обосновал раннее устранение зубочелюстных аномалий и возможность применения аппаратного лечения их в период молочного прикуса. Большую ценность имеет классификация зубочелюстных аномалий, предложенная им в 1972 году.

Существенный вклад в развитие учения о профилактике и ортодонтическом лечении зубочелюстных аномалий внесла профессор Л.В. Ильина-Маркосян. Основными направлениями, которые развивала Л.В. Ильина-Маркосян и ее ученики, являются: профилактика, диагностика и устранение нарушенной функции и формы зубочелюстно-лицевой области. На этих принципах основаны применяющиеся в клинике методы ортодонтического лечения не только детей, но и взрослых. Много лет Л. В. Ильина-Маркосян отстаивала свой принцип профилактики отклонений в развитии зубоче-

люстной системы и раннего ортодонтического лечения детей без возрастных ограничений, который был принят в большинстве клиник страны. Большое внимание Л.В. Ильина-Маркосян уделяла разработке методов диагностики (телерентгенография, электромиография и др.), новых современных методов ортодонтического и ортопедического лечения больных.

В учебнике «Зубопротезная техника» (М.Е. Васильев, А.Л. Грозовский, Л.В. Ильина-Маркосян, М.С. Тиссенбаум под редакцией и при участии Б.Н. Бынина) Л.В. Ильина-Маркосян в разделе «Зубное протезирование в детском возрасте и ортодонтия» написала: «... протезы, применяемые в детской клинике, имеют особенности, обусловленные их назначением. Основным принцип их конструкции — это профилактика. Назначение всех детских протезов — поддерживать артикуляционное равновесие и предупреждать возникновение деформации зубочелюстной системы. В то же время протезы не должны препятствовать росту челюстей и зубных дуг, который заканчивается вместе с общим развитием организма». Ею были предложены и внедрены в практику ортопедического лечения детей новые конструкции протезов и аппаратов: штифтовой зуб, раздвижной мостовидный протез, съемный частичный пластиночный протез с раздвижным винтом и другие протезы и аппараты, получившие признание клиницистов.

В 1948 году было издано первое руководство Л.В. Ильиной-Маркосян «Зубное и челюстное протезирование у детей», которое в 1952 году было издано на польском языке, а в 1956 году — на немецком.

В 1949 году в работе «Профилактическое значение зубного протезирования у детей и подростков и подготовка к нему полости рта» она пишет, что «протезирование у детей имеет цель сохранение зубов и их нормальной функции». Л.В. Ильина-Маркосян не рекомендовала «несъемные протезы с двусторонним стабильным укреплением в области фронтальных зубов девочкам до 16 лет и мальчикам до 18 лет, в области моляров — девушкам до 18 и юношам до 20 лет». Для лечения врожденных расщелин нёба Л.В. Ильина-Маркосян предложила obturator, который может быть

одновременно и расширяющим ортодонтическим аппаратом (1958). Большой интерес представляют ее работы: «Перекрестный прикус с боковым смещением нижней челюсти» (1959), «Морфологические изменения структуры челюстных костей при рахите» (1961), «О необходимости учитывать нарушения мышечного равновесия в процессе ортопедического лечения больных» (1966) и целый ряд других работ, в которых автор, впервые в отечественной литературе, проанализировала и обобщила свой многолетний клинический опыт, проявив себя незаурядным экспериментатором.

В 1962 году Л.В. Ильина-Маркосян результаты своих многолетних исследований обобщила в диссертации «Значение раннего ортопедического лечения для предупреждения стойких деформаций прикуса и лица». Она, одна из первых, поставила вопрос о необходимости участия ортодонтот, ортопедов и логопедов в диспансеризации детей с врожденной расщелиной нёба с рождения и до их совершеннолетия.

В диссертации «Аномалии положения верхних боковых резцов и клыков и методы их лечения» (1960) Ф.Я. Хорошилкина выявила разновидности аномалий, установила возрастные показания к ортодонтическому вмешательству и разработала методы их лечения. В докторской диссертации «Аномалии прикуса в антеропостериальном направлении, методы их диагностики и лечения» (1970) Ф.Я. Хорошилкина, применив новые методы исследования, определила возрастные показания к выбору методов лечения этих аномалий, разработала и внедрила в клиническую практику новые конструкции ортодонтических аппаратов.

В работе изложены методы лечения, приводящие к исправлению зубочелюстно-лицевых аномалий, устранению не только местных морфологических и функциональных нарушений, но и предупреждению таких последствий, как нарушение осанки, уменьшение жизненного объема легких, психопатии и других.

В 1972 году была издана монография Ф.Я. Хорошилкиной «Функциональные методы лечения в ортодонтии», в которой особое внимание было

уделено миогимнастике, как методу профилактики и лечения в ортодонтии, систематизированы функциональные методы лечения (метод щитовой терапии, активаторы, регуляторы функций Френкеля и др.), разработаны показания к выбору того или иного метода лечения функциональными аппаратами. В монографии «Телерентгенография в ортодонтии» (1976) Ф.Я. Хорошилкина описала метод получения телерентгенограмм, способы их расшифровки и анализа, применение этого метода в клинических и научных исследованиях и оценка результатов исследования по данным телерентгенографии. В книге «Основы конструирования и технология изготовления ортодонтических аппаратов» Ф.Я. Хорошилкина и Ю.М. Малыгин (1977) разработали классификацию ортодонтических аппаратов, описав конструктивные особенности современных аппаратов и методы их изготовления. Ф.Я. Хорошилкина опубликовала более 600 научных работ, 35 из которых монографии.

В Киевском медицинском институте на кафедре ортопедической стоматологии, под руководством профессора А.И. Бетельмана, позднее под руководством профессора С.И. Криштаба, развивалось профилактическое направление в ортодонтии. Учеными разработаны методы лечения зубочелюстных деформаций, возмещения дефектов зубных рядов у детей, совершенствование методов протезирования у детей с врожденными расщелинами нёба. При кафедре был организован кабинет профилактики и раннего лечения дефектов и деформаций зубочелюстной системы у детей.

В исследованиях профессора А.И. Бетельмана значительное место было отведено изучению этиологических факторов, особенно рахита, в развитии челюстно-лицевых деформаций у детей. В работе «Роль рахита в возникновении зубочелюстных деформаций» (1963) А.И. Бетельман продолжил мысль, высказанную ранее Н.И. Агаповым, А.Я. Катцем, Л.В. Ильиной-Маркосян и др., о том, что рахит является одним из важных этиологических факторов развития аномалий прикуса.

В книге «Ортопедическая стоматология детского возраста» (А.И. Бетельман, А.И. Позднякова, А.Д. Мухина, Ю.М. Александрова, 1965) была

дана классификация деформаций зубочелюстной системы, в которой была отражена не только морфологическая, но и функциональная характеристика деформаций. В настоящее время Ф.Я. Хорошилкиной опубликовано более 600 работ, 35 из которых монографии.

В диссертации «Материалы к патогенезу и диагностике деформаций нижней челюсти» (1969) С.И. Криштаб проследил морфогенез нижней челюсти, описал возрастные изменения и аномалии развития, привел дифференциальную диагностику отдельных форм аномалий. Ученый, на основе своих исследований, разработал показания и методы ортодонтического лечения аномалий нижней челюсти.

Вопросам этиологии и патогенеза аномалий зубочелюстной системы были посвящены работы Н.И. Агапова, Н.А. Астахова, А.Я. Катца, В.Ю. Курляндского, Д.А. Калвелиса, Л.В. Ильиной-Маркосян, И.Л. Злотника, И.М. Оксмана, М.З. Миргазизова, В.Т. Окушко, В.Т. Малькова и др.

В монографии «Ортодонтия» (1952) И.Л. Злотник разработал свою классификацию зубочелюстных деформаций. При постановке диагноза он учитывал клинические, рентгенологические и другие данные исследований, с учетом индивидуальных особенностей пациента и аномалий «с дифференцировкой их в зависимости от возраста, клинической картины и других обстоятельств». В работе «О диагностике зубочелюстных деформаций» (1956) И.Л. Злотник отметил, что при диагностике аномалий зубочелюстной системы необходимо учитывать характер деформаций (клиническая часть), локализацию их (анатомическая часть), недостаточность функции (патофизиологическая часть) и этиологию аномалий.

Исследования по различным разделам ортодонтии, начиная с 1938 года, проводились на кафедре ортопедической стоматологии Казанского медицинского института под руководством заслуженного деятеля науки ТАССР профессора И.М. Оксмана. Под его руководством была изучена связь между возникновением зубочелюстных аномалий и патологией ЛОР-органов, рахитом, туберкулезом и другими заболеваниями организма.

А.А. Погодина изучала связь аномалий зубочелюстной системы с заболеваниями носоглотки (1958).

Изучение структуры твердых и мягких тканей зуба при различных аномалиях проведено Л.М. Демнером. В кандидатской диссертации «Кариес зубов у детей, болеющих туберкулезом» (1963) ученый показал, что хроническая туберкулезная интоксикация является одной из причин развития кариеса зубов и зубочелюстных аномалий. В 1972 году Л.М. Демнер защитил докторскую диссертацию на тему «Значение хронической инфекции (туберкулеза) в патогенезе аномалий зубочелюстной системы».

Вопросам этиологии и патогенеза зубочелюстных аномалий была посвящена кандидатская диссертация Е.Н. Сухорецкой (1969), в которой автор установила, что нарушение секреции гипофиза способствует развитию сагиттальных аномалий прикуса.

Перестройке зубочелюстной системы, в частности, височно-челюстного сустава, посвящена диссертация Г.Г. Насибулина «Клинико-рентгенологические и морфологические исследования височно-челюстного сустава при ортопедических вмешательствах и сагиттальных аномалиях прикуса» (1975), в которой были выявлены морфологические реактивные изменения в височно-нижнечелюстном суставе под действием ортодонтической аппаратуры.

Диссертации учеников профессора И.М. Оксмана: С.А. Дубивко (1964), А.Н. Еловиковой (1965), М.З. Миргазизова (1966), М.Д. Санниковой (1967), А.Г. Романенко (1973), А.П. Колоткова (1969), О.М. Башаровой (1973) и др. были посвящены изучению клиники и лечения различных аномалий зубочелюстной системы.

Разработке принципов диагностики и планирования лечения зубочелюстных аномалий с использованием биометрических методов и обоснования их применения в ортодонтии была посвящена докторская диссертация заведующего кафедрой ортопедической стоматологии Кемеровского медицинского института М.З. Миргазизова (1978). Ученый представил

оригинальную диагностическую измерительную технику, позволяющую с большой точностью проводить трехмерные линейные, угловые и радиальные измерения на моделях челюстей и лица. Им были предложены новые методы исследования зубочелюстной системы: планиметрический способ анализа боковых телерентгенограмм головы, методика количественной оценки зубных рядов, прикуса и лица, способ изготовления гнатостатических моделей челюстей, метод планирования и прогнозирования лечения аномалий прикуса на основе комплексного использования гнатостатических моделей, боковых и фасных телерентгенограмм головы. Автор автоматизировал наиболее сложные и громоздкие методы исследования, в частности анализ моделей прикуса, телерентгенограмм головы. М.З. Миргазизовым получены систематизированные данные о закономерностях взаимосвязей между морфологическими элементами прикуса, лицевым скелетом и основанием черепа в норме и при аномалиях прикуса. В книге «Рентгеноцефалометрическая диагностика и планирование лечения аномалий прикуса с использованием уравнений регрессии» (1976) была представлена новая методика рентгеноцефалометрической диагностики и планирования лечения аномалий прикуса, основанная на использовании уравнений регрессии, выражающих корреляционные связи между основными элементами зубочелюстной системы. На основе методов теории информации М.З. Миргазизов дал количественную оценку информативности признаков нормы и аномалий развития зубочелюстной системы. Опыт использования методов прикладной математики в ортодонтии автор изложил в книге «Применение математической статистики и ЭВМ для обработки данных в ортодонтии» (1980).

На кафедре ортопедической стоматологии Иркутского медицинского института, под руководством доцента А.К. Недергина, была изучена саморегуляция зубочелюстных аномалий. В работе «О возможности саморегуляции зубочелюстных аномалий» (1964) Л.А. Молокова, обследовав тысячу детей, пришла к выводу, что саморегуляция зубочелюстных аномалий наблюдается в 16,8% случаев.

Большое внимание Л.К. Недергин уделял вопросам классификации и диагностики зубочелюстно-лицевых аномалий. В основе зубочелюстно-лицевых аномалий, по А.К. Недергину, лежат нарушения формы, размеров и взаимоотношения челюстей.

Одним из основных направлений в научной работе кафедры ортопедической стоматологии Воронежского медицинского института была разработка способов диагностики и лечения аномалий и пороков развития зубочелюстной системы у детей. В работе «Прогеническое состояние зубных рядов у детей и их дифференциальная диагностика и лечение» Н.Н. Циагурова показала, что при обследовании 2000 детей в возрасте от 5 до 14 лет с различными аномалиями зубочелюстной системы, прогеническое соотношение зубных рядов составляет 35 % от общего количества аномалий. На основании клинических, антропометрических, фотометрических, рентгенологических и функциональных исследований детей было выделено 5 клинических форм прогенических соотношений зубных рядов, что позволило более точно проводить дифференциальную диагностику и назначать обоснованное лечение.

В диссертации А.К. Ярового «Возрастные особенности функций жевания у детей с нормальным жевательным аппаратом и ее изменения при аномалиях развития зубочелюстной системы» было выявлено, что функция жевания у детей с нормальным жевательным аппаратом подвержена непрерывным изменениям, различным по величине и характеру в разные возрастные периоды. С ростом ребенка сокращается продолжительность жевания, затрачивается меньшее количество жевательных движений, повышается жевательная эффективность. Происходят существенные изменения в характере движения нижней челюсти. Однако наряду с тенденцией улучшения функции жевания с увеличением возраста ребенка у детей 6, 10 и 12 лет показатели состояния функции жевания значительно ниже, чем у младших по возрасту детей.

В кандидатской диссертации А.К. Крицкого «Применение функционального глоточного obturator для восстановления речи у детей с врож-

денными расщелинами нёба» было установлено большое количество экзогенных и эндогенных факторов, вероятных причин расщелин нёба.

У всех больных с расщелинами нёба было обнаружено понижение слуха, что затрудняет контроль над регуляцией тембра голоса, выработку правильных артикуляционных стереотипов и удлиняет сроки логопедических занятий. Использование компенсаторной функциональной активности мышц глотки было положено в основу конструирования функционально-глоточного obturator, при котором закрытие носоглотки в процессе речи и глотания осуществляется за счет получения точного контакта между стенками глотки и неподвижной obturating частью. Его образование способствует изготовлению глоточной части по функциональному оттиску, полученному при помощи специальной термопластической массы и оформленному посредством 6 специальных проб, позволяющих отобразить микрорельеф слизистой оболочки и функциональное положение стенок глотки и мягкого нёба. Эта оригинальная работа имеет большое практическое значение.

В кандидатской диссертации В.А. Сломовой «Механографическая характеристика функции жевания» описаны, разработанные автором, методы исследования функциональных движений нижней челюсти, позволяющие дать оценку трехмерным жевательным движениям и характеризующие состояние зубочелюстной системы, как в норме, так и при аномалиях.

Автором было сконструировано и изготовлено специальное устройство для записи движений нижней челюсти и пульт управления, которые в комплексе с регистрирующими устройствами, составили механограф, что значительно упростило запись трехмерных жевательных движений.

Значительная работа по изучению этиологии, патогенеза, клиники и лечения аномалий зубочелюстной системы проводилась в Одесском научно-исследовательском институте стоматологии, где отдел ортодонтии в 1958-1965 годах возглавлял Э.Я. Варес, впоследствии заведующий кафедрой ортопедической стоматологии Львовского медицинского института. В

1965 году в работе «Имплантация инородных тел с целью изучения закономерности роста челюстных костей, и некоторые критические замечания по этому вопросу» Э.Я. Варес обобщил накопленный по этому вопросу опыт и дал оценку метода имплантации, а с 1961 года он проводил исследования закономерности роста челюстных костей, используя рентгенологический метод. В 1967 году ученый защитил докторскую диссертацию «Закономерности роста челюстных костей и их значение для практики ортодонтии», в которой он объяснил механизм и закономерности роста челюстных костей у человека. Многие положения его диссертации вошли в практику. Главное научное направление, над которым работал Э.Я. Варес с сотрудниками, регуляция роста челюстей, что является основным фактором успешного ортодонтического лечения. Логическим завершением работы по этому направлению были исследования, посвященные изучению возможностей ортопедического перемещения среднего отдела лица путем раскрытия швов на границе висцерального и мозгового отделов черепа. Экспериментально была доказана и в клинических условиях проверена возможность раскрытия швов лицевых и других костей средней части лица, что имеет большое практическое значение при устранении нарушений в среднем отделе лица.

В Харьковском институте усовершенствования врачей, под руководством профессора М.А. Нападова, были разработаны и внедрены в практику новые конструкции и технология изготовления ортодонтических аппаратов из самотвердеющих пластмасс, применены психотерапевтические приемы в ортодонтии. Докторская диссертация на тему «Некоторые виды зубочелюстных деформаций, их профилактика, диагностика и лечение» была защищена М.А. Нападковым в 1968 году. В диссертации были разработаны принципы диагностики зубочелюстных деформаций у детей с применением антропометрических и графических методов, обоснованы понятия нормы и патологии прикуса. При протезировании детей с дефектами зубных рядов им были предложены упрощенные конструкции протезов с

применением современных самотвердеющих пластмасс. Впервые в СССР М.А. Нападковым были изданы атласы по ортодонтии: «Ортодонтический атлас», «Этиология, патогенез и профилактика деформаций зубочелюстной системы» (1967) и «Ортодонтическая аппаратура» (1968).

Исследования в области ортодонтии проводились на кафедрах ортопедической стоматологии Полтавского медицинского стоматологического института (зав. кафедрой профессор Г.Б. Шилова), которая в 1971 году защитила докторскую диссертацию на тему «Некоторые физиологические реакции организма ребенка при лечении аномалий ортодонтическими аппаратами».

Ортодонтическое лечение Г.Б. Шилова рассматривает, как воздействие на весь организм. При лечении ортодонтическими аппаратами и в период адаптации к ним у больных вырабатываются определенные физиологические стереотипы. Реакция организма ребенка на аппарат и ортодонтическое лечение во многом зависит от особенностей его нервной системы, что необходимо учитывать врачу-ортодонт.

Помимо ортодонтических и ортопедических методов лечения аномалий зубочелюстной системы в нашей стране применяли и хирургические методы.

Профессор А.А. Лимберг в 1923 году на I Всероссийском одонтологическом съезде выступил с докладом «К вопросу о пластической остеотомии нижней челюсти с целью исправления аномалии прикуса и контуров лица» и одним из первых в России предложил хирургические методы лечения резко выраженных зубочелюстных аномалий.

Хирургическим методам лечения зубочелюстных аномалий были посвящены работы И.М. Старобинского (1925), П.А. Глушкова (1928), Е.Е. Бабицкой (1930), З.И. Штробиндера (1931), М.С. Асе (1936) и других.

В последующие годы методы хирургического лечения аномалий зубочелюстной системы разрабатывались В.А. Богацким, В.С. Дмитриевой, А.Я. Катцем, А.А. Лимбергом, А.Э. Рауэром, В.Ф. Рудько, Г.И. Семенченко и др.

В 1963 году в ММСИ была организована первая в СССР кафедра стоматологии детского возраста, которую возглавил А.А. Колесов, а в 1968 году — кафедра стоматологии детского возраста в ЦИУ врачей под руководством профессора Т.Ф. Виноградовой. Позднее кафедры стоматологии детского возраста были созданы в Пермском (зав. кафедрой — проф. Е.Ю. Симановская), Калининском (зав. кафедрой — проф. Р.Д. Новоселов), Полтавском (зав. кафедрой — Л.П. Григорьева), Ленинградском (зав. кафедрой — проф. М.М. Соловьев), Львовском (зав. кафедрой — проф. Н.И. Смоляр), Минском (зав. кафедрой — проф. Э.М. Мельниченко). В настоящее время в Российской Федерации насчитывается 27 кафедр.

В последние десятилетия произошло много изменений в ортодонтии. Важным из них является внедрение в ортодонтическую практику современных несъемных ортодонтических аппаратов (брекет-систем) при лечении детей и взрослых пациентов с заболеваниями тканей пародонта в сочетании с деформациями лицевого скелета. Г.Б. Оспанова — одна из первых специалистов нашей страны, кто внедрил эти аппараты. Под ее руководством на базе ЦНИИ стоматологии разработаны отечественные брекет-системы, ортодонтические дуги с эффектом «памяти формы», ортодонтический инструментарий и налажен их промышленный выпуск. Г.Б. Оспанова — автор более 70 научных работ, посвященных актуальным вопросам организации ортодонтической помощи, профилактики и лечения пациентов с зубочелюстными и лицевыми деформациями и аномалиями. В 1989 году на базе ММСИ совместно с фирмой «Шой-Дентал» (ФРГ) был создан центр по ортодонтии «Ортодент». Директором центра был назначен профессор Л.С. Персин. В задачи центра входило: внедрение современных технологий в стоматологическую практику, обучение и стажировка отечественных и зарубежных студентов, проведение симпозиумов и курсов, организация и проведение выставок, Л.С. Персин (род. 1948) разработка компьютерных программ по диагностике и лечению зубочелюстных аномалий.

В 1989 году Л.С. Персин в докторской диссертации «Клинико-рентгенологическая и функциональная характеристика зубочелюстной системы у детей с дистальной окклюзией зубных рядов» отразил взаимосвязь морфологических и функциональных нарушений в зубочелюстной системе. На основе многофакторного анализа были определены варианты параметров телерентгенограмм, которые обуславливают возникновение дистальной окклюзии зубных рядов. Ученый разработал способ оценки координированной деятельности мышц-антагонистов и синергистов.

В 1990 году в ММСИ была создана кафедра ортодонтии и детского протезирования, заведовать которой стал профессор Л.С. Персии, ныне член-корреспондент РАМН. Основным научным направлением кафедры является комплексная диагностика зубочелюстных аномалий, разработка современных методов лечения аномалий зубов, зубных рядов, внедрение компьютерной техники. В отделении функциональной диагностики разработаны и применяются различные методы диагностики, позволяющие оценить функциональное состояние мышц челюстно-лицевой области (электромиография, миоэлектрометрия), височно-нижнечелюстных суставов (аксиография, фоноаксиография), пародонта зубов (периотестометрия).

Кафедра располагает компьютерными программами для анализа антропометрических, функциональных, телерентгенографических показателей зубочелюстной системы, позволившими компьютеризировать ведение историй болезни. Сотрудником кафедры В.А. Тугариным, совместно с производственной фирмой «Ортодент-Т», разработана технология лечения зубочелюстных аномалий с помощью брекет-системы.

В развитии ортодонтии нашли отражение новейшие достижения Науки и техники: математическое моделирование для диагностики и прогнозирования результатов лечения, объемная телерентгенография, позволяющая оценить единое изображение мягких и твердых тканей череп. Применяется метод «оптического слепка»: с помощью специальной камеры сканируется протезное поле, а после компьютерной обработки получа-

ют объемное изображение. Проводится медико-генетическое консультирование.

Важнейшим этапом в развитии отечественной ортодонтии является создание в 1995 году Ассоциации ортодонтов России, которая объединила более 200 ортодонтов. Первым президентом был избран профессор Л.С. Персии. В 1996 году на II съезде ортодонтов было уже более 400 участников ближнего и дальнего зарубежья. В 2001 году Ассоциация была переименована в Профессиональную организацию ортодонтов России.

История развития отечественной ортодонтии показывает, что за сравнительно короткий промежуток времени, отечественные ученые создали прочную теоретическую основу современной ортодонтии с ее передовым профилактическим направлением. Большие задачи стоят перед учеными и практикующими врачами по внедрению в практику ортодонтии достижений науки и уникального опыта работы врачей-ортодонтов. Особенно перспективным остается внедрение в практику ортодонтии методов диспансеризации.

4.4.4. Ортопедическая стоматология.

Ортопедическая стоматология (до 1936 года — зубопротезирование), как медицинская наука, начала формироваться в первые годы советской власти, тогда же наметилось несколько научных направлений исследований: анатомо-физиологическое, клинико-экспериментальное и техническое, которые тесно связаны между собой.

В первые годы после революции, во время Гражданской войны основной задачей, стоящей перед зубопротезированием, было удовлетворение минимальных запросов населения в зубных протезах при ограниченных возможностях лечебных учреждений и огромном числе нуждающихся в этом виде помощи. С расширением зубоврачебной сети, улучшением ее технического оснащения и совершенствованием медицинских знаний, показания к зубному протезированию расширялись и начали соответствовать научно-обоснованному лечению.

В 20-е годы XX столетия проблемами массового протезирования челюстей занимались: Г.Г. Беркович, Е.М. Гофунг, А.М. Гузиков, И.Г. Лукомский, Д.А. Энтин и др.

«Разработка основ патофизиологии ротового пищеварения должна лечь в основу выработки показаний к массовому протезированию. Вместо научно-обоснованных показаний и противопоказаний к протезированию мы имеем домашние рассуждения о том, что вставить зубы всегда лучше, чем не вставить», — так писал И.Г. Лукомский в работе «Вопросы массового протезирования» (1932).

Научные показания к протезированию зубов и челюстей основываются на данных о степени функциональных нарушений в зубочелюстной системе. В 1927 году, впервые в стране, для определения функциональной недостаточности зубных рядов при патологии жевательного аппарата, Н.И. Агапов применил статический метод исследования зубочелюстного аппарата. Ученый, учитывая количество и мощность корней отдельных зубов, величину их режущего края и жевательной поверхности, расположение зуба в зубном ряду, предложил функциональную способность интактного жевательного аппарата брать за 100 %. Функциональная ценность каждого зуба оценивалась соответствующим коэффициентом в процентах, в зависимости от величины его жевательной поверхности. Степень поражения зубочелюстной системы устанавливалась путем вычитания коэффициентов отсутствующих зубов и их антагонистов из общей суммы коэффициентов жевательной эффективности. Несмотря на некоторые недостатки, этот метод применялся в зубопротезировании для расчета степени поражения зубочелюстной системы при восстановлении жевательной функции.

Свою схему учета степени поражения жевательного аппарата и определения нуждаемости в протезировании предложил Б.Б. Брандсбург (1933). Взяв цифровую систему Дюшанса, основанную на принципе сравнения всех зубов с малым резцом, который был принят за единицу жевательной выносливости зуба, автор рассчитал коэффициенты работы каждого зуба.

Ученый выделил три степени поражения зубных рядов, в зависимости от потери их рабочей силы.

I степень — потеря рабочей силы больше, чем наполовину — абсолютное показание к протезированию.

II степень — потеря рабочей силы менее, чем наполовину- протезирование показано.

III степень — предполагает утрату 0,25 % или менее рабочей силы зубных рядов, срочное протезирование не показано.

Утрата двух и более резцов, по профессиональным и косметическим признакам, является абсолютным показанием к протезированию.

С накоплением знаний по физиологии и патологии полости рта, при изучении влияния пережевывания пищи на функцию желудочно-кишечного тракта, появилась необходимость в разработке функциональных методов исследования патологии зубочелюстной системы.

С.Е. Гельман в 30-х годах XX столетия, впервые в нашей стране, исследовал степень функциональной недостаточности зубочелюстной системы путем применения функциональной жевательной пробы. Изучая физиологию акта жевания в норме и при потере зубов, он определил зависимость функции жевания от наличия дефектов зубных рядов. В статье «О показаниях и противопоказаниях к зубопротезированию» (1935), ученый подтвердил, что на первом месте стоят показания к зубопротезированию при потере жевательной мощности более чем на 60 %, на втором месте — при потере 20-50 %, при потере менее 20 % — протезирование не показано, отсутствие передних зубов служит достаточным основанием для протезирования в косметических целях.

Для определения степени расстройства жевательного аппарата, а тем самым выявления нуждаемости в протезировании, М.С. Тиссенбаум (1936) работу жевательного аппарата оценивал по сократительной способности жевательной мускулатуры, которая определялась и регистрировалась аппаратом, установленным вне полости рта.

Модифицировав жевательную пробу С.Е. Гельмана, И.С. Рубинов при нормальном акте жевания применял различные по физическим свойствам продукты: орех, сухарь, свежий хлеб. Согласно полученным данным, у людей с полноценным жевательным аппаратом, разжевывание одного ядра ореха до акта глотания проходит, в среднем, за 14 сек. Это время удлиняется с потерей зубов. При разжевывании мягкой пищи патология жевательного аппарата мало отражается на времени.

Изучая функциональную способность жевательного аппарата, И.С. Рубинов предложил разработанный им метод мастикациогграфии (1938), с помощью которого он отметил роль рефлексов при обработке пищи в полости рта. Этот метод позволил получить данные о функциональном состоянии жевательного аппарата.

Для оценки состояния сохранившихся зубов были применены различные методы исследования: определение подвижности зуба, выявление наличия или отсутствия воспалительных процессов, определение выносливости зуба к нагрузке и т.д. Выносливость к нагрузке зубов устанавливалась с помощью специальных аппаратов — гнатодинамометров (А.Т. Бусыгин, И.С. Рубинов, М.С. Тиссенбаум и др.). Метод жевательной пробы, мастикациогграфия, гнатодинамометрия вошли в широкую поликлиническую практику и применяются в научно-исследовательской работе и в настоящее время.

Важным этапом в разработке показаний к протезированию стала новая концепция, разработанная профессором В.Ю. Курляндским, названная им «функциональной патологией» зубочелюстной системы. Ученый, анализируя состояние зубочелюстной системы, для обоснования выбора конструкции протеза, учитывал состояние пародонта, силовое соотношение зубных рядов. Состояние пародонта, функциональная ценность имеющихся зубов устанавливаются по степени атрофии костной ткани, которая выявляется как зондированием, так и рентгенологически. Ученый предложил фиксировать результаты клинического обследования состояния пародонта в специально разработанной схеме — пародонтограмме (амфодонтограм-

ме). Заполнение и анализ пародонтограммы дает наглядное представление о состоянии пародонта, степени атрофии лунок зубов, силовом соотношении зубов в единой зубочелюстной системе.

Опыт работы кафедры ортопедической стоматологии ММСИ, ряда поликлиник Москвы и др. городов страны показал, что клиническое обследование состояния пародонта, фиксируемое в пародонтограмме, дополненное рентгенологическими исследованиями, является основой диагностического процесса.

В работе «Клинические наблюдения о влиянии мостовидных протезов на пародонт опорных зубов» (1967) И.В. Ушаков при обследовании больных, для точной диагностики и правильного выбора конструкции протеза, для сравнения применял метод оценки состояния пародонта Н.И. Агапова и В.Ю. Курляндского с заполнением и анализом данных пародонтограммы. Автор пришел к выводу, что наиболее достоверным при постановке диагноза, выборе конструкции протеза является метод В.Ю. Курляндского, что позволило в 10 раз снизить количество врачебных ошибок при расчете числа опорных зубов для любой конструкции протеза.

Определяя жевательную эффективность зубочелюстного аппарата, И.М. Оксман, в 1955 году, разработал коэффициенты для утраченных зубов верхней и нижней челюстей, которые отличались от коэффициентов, предложенных Н.И. Агаповым. Ученый обозначил функциональную ценность жевательного аппарата в виде дроби, где числитель — коэффициент утраты жевательной эффективности верхних зубов, знаменатель — коэффициент утраты нижних зубов. Автор утверждал, что кроме учета функциональной ценности утраченных зубов, следует учитывать и функциональное состояние оставшихся зубов по их подвижности:

- зубы с патологической подвижностью I степени, леченные по поводу кариеса — нормальные,
- зубы с патологической подвижностью II степени — сохраняют 50 % жевательной ценности,
- зубы с патологической подвижностью III степени, многокорневые зубы с острым периодонтитом — считать отсутствующими.

И.М. Оксман учитывал не только потерю зубов, но и состояние оставшихся зубов, а также резервы жевательного аппарата. Предложенный И.М. Оксманом метод был внедрен в поликлиническую практику.

Вопросы разработки показаний и противопоказаний к протезированию отражены в работах А.М. Гузикова, А.Л. Грозовского, А.Я. Катца, М.С. Неменова, а в более поздние годы — в работах А.И. Бетельмана, А.Т. Бусыгина, Е.И. Гаврилова, В.Н.Копейкина, В.А. Пономаревой и др.

В работе «Новые методы изучения состояния пародонта при его функциональной недостаточности» Я.М. Збарж и Б.А. Мартинек модифицировали систему регистрации функционального состояния пародонта графическим изображением.

Экспериментальные и клинические исследования стоматологов позволили разработать показания и противопоказания к протезированию, установить взаимосвязь функции жевательного аппарата и работы пищеварительного тракта, оценить эффективность различных видов протезов.

В работах отечественных стоматологов значительное место отводится изучению роли акта жевания в регуляции функций желудочно-кишечного тракта и влиянию его на общее состояние организма.

Эти исследования, основанные на работах И.П. Павлова, подтвердили рефлекторную деятельность пищеварения, усиление сокообразовательной функции желудка и поджелудочной железы.

Исследования, проведенные Б.А. Торчинским в 1935-1937 годах, показали, что недостаточность жевательного аппарата до 9-15 % замедляет эвакуацию пищевых веществ из желудка на 2-2 1/2 часа. Восстановление жевательной функции путем протезирования восстанавливает и эвакуаторную способность желудка до 42-46 %.

Значительный вклад в изучение взаимосвязи между физиологическими процессами в желудочно-кишечном тракте и состоянием жевательного аппарата внесли Б.Н. Бынин, С.Е. Гельман, Б.А. Торчинский, Д.А. Энтин. По их мнению, нарушение деятельности одних процессов неизбежно отражается на состоянии других.

Развивая физиологическое направление в ортопедической стоматологии, А.И. Бетельман установил взаимосвязь между деятельностью органов полости рта с деятельностью всего организма в целом, взаимосвязь между формой и функцией жевательного аппарата. Исследования А.И. Бетельмана нашли отражение в его многочисленных работах: «Взаимосвязь между состоянием зубочелюстной системы и секреторной деятельностью слюнных желез» (1938), «Значение акта жевания в пищеварительном процессе» (1940) и др. Анализируя результаты экспериментов по влиянию различных питательных веществ на слюноотделение, А.И. Бетельман отметил, что во время акта жевания пища подвергается воздействию двух факторов: механического и секреторной деятельности слюнных желез. Продолжением исследований отечественных стоматологов по изучению взаимосвязи функции жевательного аппарата и желудочно-кишечного тракта явились работы И.С. Рубинова, который изучал функцию глотания и жевания, а также нервно-рефлекторную координацию жевательной системы, применив для этого новые, специальные методы исследования. Основные положения своего учения он изложил в работе «Влияние еды различных пищевых веществ на жевание, глотание и двигательную функцию желудка» (1944), в докторской диссертации «Клинико-физиологические исследования актов жевания и глотания в норме и патологии» (1952) и в монографии на тему «Физиология и патофизиология жевания и глотания» (1958). И.С. Рубинов отметил, что использование физиологических методов исследования (мастикациография, электромиомастикациография, мио-тонометрия) позволяет выяснить нейродинамические связи между отдельными элементами зубочелюстной системы в норме и при патологии.

Вопросами нейрофизиологии жевания, слюноотделения, механизмов болевых синдромов занимался В.А. Мечиташвили. Он и его ученики изучали вопросы функционального состояния, тонуса жевательной и мимической мускулатуры при дефектах и деформациях зубочелюстной системы и влияния на него ортопедического лечения. В 50-е годы XX века

В.А. Мечиташвили впервые ввел осциллографический метод исследования функционального состояния зубочелюстной системы, который позволил учитывать функциональное состояние не только жевательных мышц, но и их центральных иннервационных механизмов. Исследования ученого по нейрофизиологии жевания, решением XVII Международного стоматологического конгресса (Париж, 1961), были отмечены «Свидетельством признательности за вклад в стоматологию».

Изучение иннервации зубов, пародонта, слизистой оболочки полости рта и жевательных мышц способствовали пониманию физиологических функций и развития патологических процессов. Нейрогистологические исследования иннервации отдельных элементов зубочелюстной системы значительно расширили представления о рецепторном аппарате, микроморфологии и патологической анатомии различных структур зубочелюстной системы.

В докторской диссертации «Материалы к учению о морфологическом субстрате иннервации слизистой оболочки полости рта и ее дериватов в нормальном и патологическом состоянии» (1944) и в монографии «Материалы к учению об иннервации зуба и слизистой оболочки полости рта» (1947) И.М. Оксман показал, что «сравнительное морфологическое изучение иннервации слизистой оболочки полости рта в норме и патологии, а также в эксперименте имеет важное значение для понимания патогенеза и течения патологических процессов, возникающих в жевательном аппарате». В трудах И.М. Оксмана и его учеников: А.И. Яшиной, Я.С. Кнубовца и др., было выдвинуто положение о нервной регуляции жевательного давления при помощи рецепторов периодонта и его афферентной системы, с одной стороны, и двигательных нервов жевательных мышц, как эфферентной части рефлекторной дуги — с другой.

Исследования А.Т. Бусыгина, А.И. Дойникова, В.А. Пономаревой, К.Л. Хайт и др. значительно расширили представления о строении челюстей и суставов, изменений их морфологической структуры в зависимости от возраста, потери зубов, различных функциональных нарушений.

В работе «Возрастные особенности строения восходящей ветви нижней челюсти» (1953, 1961), а также в монографии «Строение челюстных костей» (1962) А.Т. Бусыгин описал новые данные о возрастных особенностях и нормальной структуре челюстных костей. Он разработал методику изготовления препаратов челюстных костей для изучения структур последних на границе макро- и микроскопической видимости. В докторской диссертации «Структуры челюстных костей взрослого человека в норме и при некоторых патологических состояниях» (1963) А.Т. Бусыгин выявил патологоанатомические различия между функциональной травмой и пародонтозом, обобщив свои исследования на основе болевой чувствительности пародонта к восприятию жевательного давления в норме, при пародонтозе и деформациях зубных рядов. Дальнейшие работы А.Т. Бусыгина и его учеников (В.Н. Гинали, Т.Д. Еганова, К.В. Ружковской) выявили новые данные о деформации височно-нижнечелюстного сустава при потере зубов, о строении слизистой оболочки протезного ложа, о восстановлении речи при протезировании беззубых челюстей.

Изучение различных факторов, приводящих к перестройке челюстных костей, в ММСИ проводил А.И. Дойников. В работе «Изменение структуры кости нижней челюсти в связи с потерей зубов» (1966) он отметил, что с потерей зубов происходит значительная атрофия альвеолярного отростка нижней челюсти и уменьшение площади кости в ее поперечном сечении. Внутри кости возникают склеротические изменения: балочки губчатого вещества уплотняются и уменьшаются по площади. В докторской диссертации «Изменение макроскопического и микроскопического строения челюстных костей в связи с возрастом и потерей зубов. Влияние зубного протезирования» (1967) А.И. Дойников, проанализировав значительный клинический и секционный материал, изучив макро- и микроскопическое строение челюстей, проведя экспериментальные исследования на животных, пришел к выводу, что костная ткань, несмотря на физическую прочность и относительную сложность строения, реагирует на физиологию

ческие и патологические процессы всего организма перестройкой и изменениями многих биологических структур. Макроскопическое и микроскопическое строение челюстных костей значительно меняется, в зависимости от частичной и, особенно, полной потери зубов. Ученый экспериментально доказал, что протезирование задерживает возникновение изменений в строении челюстных костей.

В.А. Пономарева, на основе клинических наблюдений и экспериментов на животных, сделала важный для практической и теоретической стоматологии вывод: полноценная функция зубов — одно из основных условий сохранения нормального уровня минерального обмена и структуры челюстной кости. Постоянное механическое давление на подлежащую костную ткань, по ее мнению, создает физиологическое раздражение, необходимое для поддержания обмена веществ в тканях пародонта. В докторской диссертации «Перестройка зубочелюстной системы при образовании зубочелюстных деформаций после частичной потери зубов и подготовка полости рта к протезированию (клинико-экспериментальное исследование)» (1968) В.А. Пономарева разработала диагностику выделенных ею клинических форм феномена Попова и дифференциальную диагностику сходных с ним форм, специальные методы подготовки полости рта к протезированию.

Физиологическое направление в ортопедической стоматологии успешно разрабатывалось на кафедрах Рижского, Краснодарского, Тбилисского и других медицинских институтов.

Д.А. Калвелис, И.Х. Пинский, И.М. Гагуа и др. продолжили клинико-экспериментальные исследования регуляции функции органов жевательного аппарата. На кафедре ортопедической стоматологии Рижского медицинского института, под руководством профессора Д.А. Калвелиса, основателя биоморфологического направления в стоматологии, были продолжены физиологические исследования челюстно-лицевой области. Ученый показал, что функциональная способность зубов зависит от ряда внут-

ренных и внешних причин. Д.А. Калвелис пришел к выводу, что рациональность и целесообразность определенного вида ортопедического лечения зависят не только от характера заболевания, но и от ответной реакции организма на лечебные мероприятия.

Физиологические и патологические процессы, происходящие в полости рта, качественные и количественные сдвиги в слюноотделении и секреции желудочного сока, при интактных зубных рядах, нарушении их целостности, пародонтозе и аномалиях прикуса были изучены И.Х. Пинским и его учениками. В докторской диссертации «Слюноотделительные рефлексы до и после укрытия различных рецепторных зон слизистой оболочки полости рта съемными протезами различных конструкций и материалов» (1967), в монографии «Изменения слизистой оболочки полости рта при ношении съемных протезов» (1968) И.Х. Пинский дал оценку реакции слюнных желез на локальные воздействия раздражителей, дозируя силу раздражителя и т.д. Ученым был сконструирован аппарат для электрозаписи движения нижней челюсти, количества выделившейся слюны в каплях, времени подачи раздражителя в точные интервалы времени.

Исследования слюноотделительной функции способствовали рациональному ортопедическому лечению больных с различной патологией зубочелюстной системы.

Врач-стоматолог Грузинской ССР И.М. Гагуа в кандидатской диссертации «Влияние материалов, применяемых в зубопротезировании, на некоторые составные части слюны» (1937), а в 1951 году — в докторской диссертации «Влияние механической обработки зубов различных видов на количество и состав слюны» изучил секрецию и состав слюны при заболеваниях зубочелюстной системы, ортопедическом лечении.

Протезирование при полном отсутствии зубов представляет собой одну из сложнейших проблем ортопедической стоматологии. Решение этой проблемы возможно только при комплексном изучении причин нарушения функции и анатомии жевательного аппарата, которые приводят

к полной утрате зубов. Учеными были изучены закономерности строения зубочелюстного аппарата, которые легли в основу методов ортопедического лечения при потере всех зубов, и формирования учения о протезировании беззубых челюстей.

Протезирование челюстей при полном отсутствии зубов, по мнению В.Ю. Курляндского (1955), состоит из трех взаимозависимых положений:

- фиксации и стабилизации протезов на беззубых челюстях;
- определении необходимой, строго индивидуальной величины и формы протезов для восстановления внешнего вида лица;
- конструировании зубных рядов в протезах для синхронной работы всех органов челюстно-лицевой области, участвующих в обработке пищи, речи, дыхании.

Поиск способов фиксации протеза имеет свою историю:

- использование отталкивающих пружин, магнитов, присосов;
- применение выдвижных захватов на уровне 1-го и --го моляров протезов (А.Я. Катц).

Однако, эти методы не нашли широкого применения в клинике ортопедической стоматологии.

В 60-е годы XX столетия была предпринята попытка применить хирургические методы для улучшения условий протезирования беззубых челюстей. В 1958 году В.Ю. Курляндский и М.В. Мухин провели операции по имплантации металлического каркаса в нижнюю челюсть. Б.К. Мироненко, под руководством В.Ю. Курляндского, в кандидатской диссертации «Хирургические методы формирования ложа для протеза на беззубой нижней челюсти при значительной или полной атрофии альвеолярного отростка фронтального участка» (1964) описал формирование ложа протеза хирургическим методом.

Однако широкого практического применения эти методы не нашли.

Известны случаи вживления в тело альвеолярного отростка челюсти инородных тел (имплантация), которые частично выступают над его по-

верхностью и служат для фиксации протезов кламмерами или другими приспособлениями (Э.Я. Варес и др.).

Ученые пытались увеличить объем атрофированного альвеолярного отростка путем ауто-, гомо-, гетеро- и аллопластики. Г.Б. Брахман подсаживала под надкостницу кусочки трупного хряща или имплантатов из пластмассы АКР-9 или ЭГмасс-12 для формирования альвеолярного отростка в местах наибольшей атрофии тела нижней челюсти.

Б.Н. Бынин и А.И. Бетельман придавали большое значение физическим методам фиксации протеза, к которым они относили адгезивность и функциональную присасываемость. Для достижения адгезивности поверхность зубного протеза должна точно отражать макро- и микрорельеф слизистой оболочки протезного поля, а между соприкасающимися поверхностями должен быть тонкий слой слюны, который обеспечивает максимальное прилипание протеза к слизистой.

Разработка методов фиксации и стабилизации при полном отсутствии зубов неразрывно связана с тщательным исследованием анатомо-топографических особенностей беззубых челюстей. А.И. Бетельман, Г.Б. Брахман, А.Т. Бусыгин, Б.Н. Бынин, Е.И. Гаврилов, В.Ю. Курляндский, И.М. Оксман и др. считали, что степень и характер атрофии при полной потере зубов прямо влияют на фиксацию протезов на челюстях.

Г.Б. Брахман в работе «Условия фиксации полного протеза на беззубой нижней челюсти» (1940), проанализировав анатомо-физиологические условия нижней челюсти, пришла к выводу, что хорошая фиксация протеза обеспечивается активной мускулатурой и слизистой оболочкой полости рта.

Изучая топографические особенности мест прикрепления мышц на беззубых челюстях, В.Ю. Курляндский разработал классификацию беззубых челюстей и описал ее в монографии «Протезирование беззубых челюстей» (1955). В основу классификации им были положены изменения топографии мест прикрепления мышц из-за отсутствия зубов и атрофии альвеолярных отростков. На верхней челюсти В.Ю. Курляндский выделил три типа, на нижней — пять типов атрофии челюстей.

Свою классификацию беззубых челюстей в 1962 году предложил И.М. Оксман. Беззубые челюсти (верхнюю и нижнюю) ученый разделил на 4 типа, по степени и равномерности их атрофии и конфигурации альвеолярного отростка, обобщив данные в монографии «Клинические основы протезирования при полном отсутствии зубов» (1962).

Для повышения качества протезирования беззубых челюстей, большое значение имеют исследования мягких тканей протезного поля: анатомическая и физиологическая структура слизистой оболочки, ее податливость и степень подвижности. Степень податливости при заданном давлении изучал М.А. Соломонов, применяя различные конструкции аппаратов.

В.И. Кулаженко, при изучении податливости неподвижной слизистой оболочки полости рта, учитывая разницу в податливости на сдавливание и растяжение, определял ее амплитуду.

Е.И. Гаврилов считал, что различная степень вертикальной податливости слизистой оболочки полости рта зависит от густоты сосудистой сети подслизистого слоя. Он ввел понятие буферных зон и описал их расположение в работе «Топография буферных зон верхней беззубой челюсти» (1963). Буферными зонами Е. И. Гаврилов называл участки слизистой оболочки твердого нёба с обширными сосудистыми полями, обладающими рессорными свойствами.

Для определения топографии буферных зон, автор провел гистологическое исследование тканей протезного поля верхней челюсти, что позволило ему «нанести на проекцию твердого нёба примерную схему расположения буферных зон протезного поля верхней челюсти». Е.И. Гаврилов выявил, что изменение слизистой оболочки и атрофия альвеолярного отростка связаны с нарушением трофики тканей.

Различная степень податливости слизистой оболочки протезного ложа служит основанием для использования так называемых компрессионных и разгружающих слепков. Стремление создать замыкающий клапан по краю протеза для лучшей его фиксации, стимулировало разработку мето-

дов получения индивидуальных ложек и функциональных слепков. Учет функционального состояния слизистой оболочки переходной складки, клапанной зоны и других анатомических образований, меняющих свое положение при работе жевательной и мимической мускулатуры, языка, движениях нижней челюсти, является основой всех функциональных методов получения слепков.

М.С. Неменов в работе «К технике функционального оттиска» (1929) отмечал, что для получения функционального слепка необходимо изготовление предварительной модели, затем индивидуальной ложки и снятие с ее помощью компрессионного слепка в центральном соотношении челюстей. В 1929 году А.Г. Лебит в статье «Проблема функциональных слепков и постановка зубов в анатомическом артикуляторе» указал на необходимость перехода от простых гипсовых слепков к функциональным. Под функциональным слепком Б.Н. Бынин подразумевал оттиск, точно отражающий рельеф мягких тканей челюстей во время их деятельности. Анатомический слепок, по Б.Н. Бынину, это отпечаток челюсти в покое.

Разногласия во взглядах по поводу границ протезов и методики снятия слепков нашли отражение в классификации слепков при протезировании беззубых челюстей.

Е.М. Гофунг различал протезный, ортодонтический и ортопедический оттиски. Протезный оттиск он подразделял на анатомический и физиологический, или функциональный.

А.И. Бетельман все слепки для беззубых челюстей разделил по двум признакам: по высоте краев и по степени отжатия слизистой оболочки. По первому признаку слепки подразделяются на анатомические, функциональные и присасывающие, по второму — на разгружающие и компрессионные.

В.Ю. Курляндский делил слепки на произвольные и ограниченные. Ограниченный слепок дает копию ткани будущего ложа протеза в различном состоянии, поэтому следует различать статический, компрессионный и функционально-компрессионный слепки.

М.А. Соломонов, положив в основу снятия оттисков анатомо-топографические изменения челюстей, предложил свою классификацию слепков.

Е.И. Гаврилов и И.М. Оксман в учебнике «Ортопедическая стоматология» (1968) за основу классификации взяли:

1) последовательность лабораторных этапов изготовления протезов и клинических приемов обследования больного, разделяя оттиски на предварительные (ориентировочные) и окончательные;

2) способ оформления краев оттиска, различая оттиски на анатомические и функциональные;

3) степень давления, различая оттиски под давлением (компрессионные) и без давления (некомпрессионные).

При протезировании челюстей при полном отсутствии зубов врачи, при снятии функциональных слепков широко применяли компрессионные слепки, считая, что большая или меньшая компрессия слизистой оболочки в момент снятия слепка дает возможность нагрузить или разгрузить слизистую от давления протеза. Это положение неоспорно, так как давление, оказываемое на слизистую оболочку при снятии слепка, трудно рассчитать по силе, характеру и направлению, развиваемому под протезом в момент пережевывания пищи.

Исследования, проведенные Г.Н. Троянским, В.Н. Копейкиным и Я.Б. Ковалевой при контурном наложении рельефа моделей, полученных по компрессионным и разгружающим слепкам, показали, что слизистая оболочка при компрессии не только уплотняется, но и значительно изменяет свои контуры. Искажение рельефа слизистой В.Н. Копейкин (1929-1998) тем сильнее, чем больше податливость тканей, оно еще более значительно при подвижных участках протезного ложа. Компрессионный метод не позволяет дифференцировать податливость слизистой оболочки, так как любая компрессия слизистой оболочки в момент получения слепка, ведет не только к сдавливанию всех морфологических структур, но и к резкому изменению ее истинного физиологического положения.

Протез, изготовленный по компрессионному слепку, при наложении его на челюсть, фиксирует слизистую в сдавленном состоянии, что ухудшает крово- и лимфообращение, ведет к развитию воспалительных процессов, а впоследствии — к атрофическим процессам. Жевательное давление, воспринимаемое слизистой оболочкой, фиксируемое протезом вне физиологических условий, усугубляет эти явления.

В ЦИУ врачей Л.В. Ильина-Маркосян применяла различные методы получения оттисков, под давлением и без него. Н.В. Калинина при получении оттисков соблюдала «принцип избирательного давления на отдельные участки протезного поля в зависимости от функциональной выносливости подлежащих тканей» с функциональным оформлением краев оттиска во всех отделах клапанной зоны с максимальным использованием площади протезного поля.

В 30-е годы XX столетия широкое распространение получил метод снятия функционального слепка (метод ЦИТО), предложенный Г.Б. Брахман и З.В. Коппом. Этот метод был описан в первом отечественном учебнике «Ортопедическая стоматология» (Н.А. Астахов, Е.М. Гофунг, А.Я. Катц, 1940), суть которого заключена в изготовлении восковой индивидуальной ложки. Восковая ложка обжимается на челюсти в полости рта больного, без предварительного получения гипсовой модели.

А.Я. Катц утверждал, что гипсовые слепки, снятые с помощью индивидуальных ложек, не являются «функциональными», и должны быть отнесены к категории «анатомических», в которых края имеют более правильную высоту и форму. Отпечатки подвижной слизистой оболочки во всех фазах ее функционального перемещения, не могут быть получены с помощью жидкого гипса, так как с момента схватывания гипса, заканчивается его формирование.

Метод создания клапана вокруг протеза для его лучшей фиксации на беззубых челюстях (особенно на нижней челюсти) был предложен в 50-х годах XX столетия венским врачом Гербстом.

В Московском и Казанском институтах проводилась работа по проверке этого метода: в ММСИ — Я.Б. Ковалевой и Н.И. Лариным (1958), в КГМИ — К.Н. Кутуевой (1959) и др. В дальнейшем, при использовании различных оттисковых материалов отечественного производства, были разработаны новые модификации этого метода (Я.Б. Ковалева, Г.Г. Насибулин и др.).

Для успешного протезирования беззубых челюстей большое значение имеет выявление закономерностей строения и функциональных взаимоотношений отдельных органов сформированной зубочелюстной системы, изучение артикуляции и окклюзии, построения зубных рядов.

Е.М. Гофунг, в 1913 году, дал определение окклюзии и артикуляции: «Под окклюзией надо разумеать соотношение зубных рядов между собой в момент покоя, причем обе челюстные головки покоятся на дне суставных ямок. Артикуляция же — это соотношение зубных рядов при естественных движениях нижней челюсти». Термином «артикуляция» А.Я. Катц определил всевозможные положения и перемещения нижней челюсти в отношении верхней при участии жевательной мускулатуры. Термином «окклюзия» он обозначил то положение нижней челюсти, при котором меньшая или большая часть артикулирующих зубов находится в контакте. Окклюзию он рассматривал как частный случай артикуляции.

Б.Н. Бынин назвал артикуляцию как соотношение зубных рядов при любых движениях нижней челюсти, а окклюзию — как соотношение зубных рядов при жевательных движениях.

Разрабатывая вопросы артикуляции и окклюзии, А.М. Гузиков (1930—1931) отметил, что в сложной системе артикуляционного равновесия принимают участие многие компоненты: форма зубных дуг, суставной путь нижней челюсти, жевательная мускулатура, «окклюзионная плоскость», высота бугров зубов. По мнению ученого, для рационального протезирования челюстей при полном отсутствии зубов роль каждого компонента очень велика.

Б.Н. Бынин придавал большое значение артикуляционному равновесию как фактору, определяющему терапевтическую эффективность ортопедического лечения. «Артикуляционное равновесие», по Б.Н. Бынину, это не столько соотношение зубных рядов, сколько их функциональная приспособляемость.

В.Ю. Курляндский утверждал, что выделение окклюзионных состояний в биодинамике зубочелюстной системы, имеет большое теоретическое и практическое значение, так как их изучение позволило установить наличие функциональной взаимосвязи между различными элементами этой системы.

В августе 1936 года на II Украинском стоматологическом съезде в Харькове, А.К. Недергин отметил, что протез, как инородное тело, должен быть точнейшим образом приспособлен к анатомическим условиям беззубых челюстей. Материалы доклада легли в основу работы «Ревизия основных положений учения об артикуляции» (1938).

В нашей стране широкое применение получили анатомические артикуляторы А. Гизи (1924), построенные на основе изучения механики движения нижней челюсти. В докладе на заседании Казанского одонтологического общества (1928) и в работе «Постановка зубов для беззубого рта по Гизи» (1931) И.М. Оксман отметил как положительные стороны, так и недостатки этой постановки.

Отечественные стоматологи-ортопеды, изучая строение и функцию жевательного аппарата, стремились создать аппаратуру, воспроизводящую движение нижней челюсти. В 1930—1931 годах Я.М. Хайт изготовил первый отечественный анатомический артикулятор СИА-1, Н.П. Сорокин предложил свою конструкцию артикулятора, которая была значительно проще иностранных.

Функциональная ценность протезов зависит от индивидуального строения зубочелюстного аппарата. Выявление этих закономерностей у лиц, утративших все зубы, достигается дополнительными исследованиями:

- запись сагиттального суставного пути (внеротовая и внутриротовая);

- запись угла резцового пути;
- запись угла бокового суставного пути;
- формирование окклюзионных кривых.

Запись всех движений нижней челюсти может быть произведена одновременно. Внутриротовая запись пришлифовыванием окклюзионных поверхностей для анатомической постановки зубов в шарнирном окклюдаторе с использованием феномена Христенсена, впервые была предложена А.Я. Катцем и З.П. Гельфандом (1937). Недостаток артикуляторов Гизи и Хаита, а иногда и отсутствие опыта обращения с ними, привели к тому, что постановку зубов осуществляли в окклюдаторах, по способу постановки по стеклу (М.Е. Васильев), имитирующему горизонтальную протетическую плоскость.

Антропометрические измерения беззубых челюстей проводились в Полтавском медицинском стоматологическом институте, под руководством М.Р. Мареля, результаты этих измерений легли в основу теоретического обоснования создания эталонов (форм и размеров) искусственных зубных рядов для протезирования беззубых челюстей.

При протезировании беззубых челюстей для определения размеров нижнего отдела лица широко применялся анатомо-физиологический метод. При определении центрального соотношения челюстей, для фиксации окклюзионной высоты нижнего отдела лица, были разработаны инструментальные методы.

В 1964 году Г.Г. Насибулин, под руководством И.М. Оксмана, в диссертации «Материалы к вопросу определения высоты прикуса и центральной окклюзии при протезировании беззубых челюстей», проанализировал антропометрический и анатомо-физиологический методы определения высоты прикуса. Ученый предложил свой метод определения центрального соотношения челюстей с помощью рентгенографии височно-челюстного сустава. Сконструированный им прибор «Краниостат», позволял стандартизировать укладку и тем самым получать идентичные снимки.

Одним из ответственных и сложных этапов определения центрального соотношения челюстей является формирование окклюзионной плоскости — важного ориентира при постановке зубов. В нашей стране был широко распространен метод формирования окклюзионной плоскости с помощью двух линеек. Я.М. Хаитом была предложена специальная линейка. Н.И. Ларин в 1960 году разработал новый метод одномоментного формирования окклюзионной плоскости при помощи сконструированного им аппарата, который позволял с помощью лицевой дуги определять высоту протеза на верхней челюсти и направление окклюзионной плоскости по отношению к камперовской горизонтали.

Под руководством Л.П. Турина, в Ставропольском медицинском институте была проведена большая работа по решению проблемы артикуляции в различных видах зубных протезов.

Для повышения функциональной эффективности зубных протезов, предупреждения воспалительных и атрофических процессов слизистой оболочки и костной ткани полости рта были разработаны и внедрены в практику двухслойные базисы (И.И. Ревзин и др.).

Е.О. Копыт в работе «Значение двухслойного базиса протеза в эффективности протезирования беззубных челюстей» (1967) показал, что при неблагоприятных анатомо-топографических условиях протезного ложа базис протеза должен быть дифференцированным.

В исследованиях ученых значительное место отводится технологии изготовления протезов для беззубых челюстей.

В.Ю. Курляндский (1955) предложил бесплепочный метод изготовления протезов.

В.Н. Копейкиным (1959) был разработан метод, позволявший получить базис протеза из быстротвердеющей пластмассы, одномоментно, непосредственно в полости рта больного.

Одновременно велись работы по изготовлению протезов с металлическим базисом при полном отсутствии зубов (З.С. Василенко, В.Н. Копейкин, В.Ю. Курляндский, И.С. Падарьян и др.).

Изучение роли нервно-рефлекторных механизмов в процессе пользования полными зубными протезами было проведено в Ленинградском медицинском институте на кафедре ортопедической стоматологии под руководством И.С. Рубинова. На основании анализа мастикациограмм, функциональных жевательных проб, данных миотонометрии и гнатодинамометрии было отмечено, что после перестройки рефлексов, ведущих к выработке наиболее рациональных совершенных движений нижней челюсти, жевательной мускулатуры и постановки зубов, обеспечивающей окклюзионный функциональный контакт в области передних зубов, наблюдалось улучшение эффективности жевания.

В настоящее время исследования по улучшению функции жевания при полном отсутствии зубов продолжаются. Последние годы принесли значительные успехи в этих разработках, благодаря внедрению новых слепочных масс, новых видов пластмасс.

Проблема заболеваний пародонта является одной из основных проблем стоматологии. Комплексное изучение вопросов клиники, этиологии, патогенеза пародонтоза позволило наметить пути лечения, основой которого является общее лечение организма, причем местной терапии, ортопедическим мероприятиям отводится значительное место.

Решение многих сложных вопросов протезирования при заболеваниях неразрывно связано с изучением патологических процессов в полости рта, которые приводят к потере зубов, а также с вопросами изучения артикуляционного равновесия и различных видов окклюзии.

На ранних стадиях лечения заболеваний пародонта ортопедическими методами основной задачей было укрепление расшатанных зубов путем изготовления различных конструкций протезов (М.С. Неменов, 1939).

Впервые в нашей стране Б.Н. Бынин в ряде своих статей и в учебнике «Ортопедическая стоматология» (1947) проанализировал роль артикуляционного равновесия в этиологии и патогенезе пародонтоза.

Новое, оригинальное направление в ортопедическом лечении пародонтоза было создано в период 1940-1970 гг. В.Ю. Курляндским и его уче-

никами. В 1953 году в монографии «Ортопедическое лечение при амфодонтозе» на основе большого опыта в изучении этиологии заболеваний зубочелюстной системы, установлении различных симптомов и характера морфологических и функциональных нарушений позволило В.Ю. Курляндскому впервые теоретически обосновать новый взгляд на этиологию и патогенез пародонтоза, разработать концепцию, названную им «функциональной патологией зубочелюстной системы». Главный стоматолог Министерства здравоохранения СССР, профессор В.Ф. Рудько, в своем докладе на IV Всесоюзном съезде стоматологов (1962), отметил: «... Профессор В.Ю. Курляндский в Московском стоматологическом институте обосновал новый подход к оценке роли зубного протеза и разработал проблему функциональной патологии зубочелюстной системы, развивая ее сейчас со своими сотрудниками и многочисленными последователями».

Разработке этой проблемы В.Ю. Курляндский посвятил более 30 лет своей научной деятельности. Результаты изучения болезней пародонта он описал в 5 монографиях и большом количестве статей. основополагающими работами были: «Ортопедическое лечение при амфодонтозе» (1953), «Ортопедическое лечение альвеолярной пиорреи (амфодонтоза) и травматической артикуляции» (1953, 1956), «Функциональная патология зубочелюстной системы. Диагностика и методы лечения» (1966). Системный подход к объяснению патологии, попытка свести аналитически разрозненные материалы в некое единство, помог создать модель заболеваний зубочелюстной системы в эксперименте и выделить различные нозологические формы ее поражения (прямой и отраженный травматические узлы, травматическая артикуляция, силовая диссоциация, травматическая окклюзия и т.д.) и впервые в истории ортопедической стоматологии говорить о строго научной дифференциальной диагностике этих заболеваний.

В.Ю. Курляндский так определяет функциональную патологию зубочелюстной системы: «Это патологическое состояние, обусловленное влиянием нормальной (при ослабленном морфологическом субстрате), вы-

ключенной, ослабленной или чрезмерной функции. Функциональная патология может возникать с момента рождения человека и протекать на протяжении всей жизни. Главными причинами возникновения функциональной патологии зубочелюстной системы являются последствия кариозной болезни, функциональной недостаточности твердых тканей зубов врожденного и приобретенного характера, функциональной недостаточности пародонта, врожденного и приобретенного характера, главным образом, в результате силовой диссоциации зубных рядов, возникающей в связи с первичной или вторичной частичной адентией. Функциональная патология особенно часто появляется в результате вторичной частичной адентии, которая является результатом осложненного кариеса или проявлением болезни пародонта.

Научные исследования по этой проблеме шли по разным направлениям, результаты исследований были весьма важными для развития стоматологической науки и практики, что способствовало дальнейшему научному обоснованию методов профилактики, ранней диагностики болезней пародонта, рациональному лечению и прогнозированию течения болезни.

Выделение им новых форм стоматологических заболеваний способствовало строго научной диагностике, совершенствованию методов ортопедического лечения, в связи с чем протез стали рассматривать как лечебное средство, которое качественно меняет зубочелюстную систему, что позднее было подтверждено В.Н. Копейкиным в докторской диссертации на тему «Клинико-экспериментальные обоснования ортопедических методов лечения пародонтоза» (1980) и многочисленными работами учеников.

Это направление функциональной патологии зубочелюстной системы в последующие годы развивалось клинико-экспериментальными работами учеников В.Ю. Курляндского. В диссертации «Вторичная частичная адентия и состояние костной ткани альвеолярных отростков челюстей» (1965) В.Ю. Миликевич доказал, что с помощью радиоактивных индикаторов можно выявить нарушения минерального обмена, которые при функ-

циональной патологии зубочелюстной системы носят генерализованный характер, а изменения обменных процессов в костных тканях предшествуют морфологическим и клиническим.

Теоретическое и математическое обоснование применения различных конструкций бюгельных и мостовидных протезов дал Г.П. Соснин. Ученый разработал показания к их применению на основании данных интенсивности и распределения нагрузки, силового соотношения и резервных сил пародонта.

В.А. Пономарева, на основании экспериментальных данных, показала, что после потери зубов, под влиянием измененной функции, происходит значительная перестройка в зубочелюстной системе, характеризующаяся изменением костной структуры в виде истончения и фрагментации балочек, а также выраженной остеокластической резорбции. Параллельно атрофии кости в недогруженном участке возникают значительные изменения в нервном аппарате пародонта.

Морфологические исследования и клинические наблюдения, которыми с 1952 года занимался И.М. Оксман, выявили значительные изменения нервного аппарата пародонта и пульпы зубов при пародонтозе.

Для диагностики ранних форм пародонтоза и сходных с ним заболеваний, И.М. Оксман предложил использовать капилляроскопию, электротермометрию и другие методы исследования, а для его лечения рекомендовал свои конструкции шинирующих аппаратов, укрепляющихся с помощью штампованных полукоронок и экваторных коронок в сочетании с литой балочной шиной, обеспечивающей надежную иммобилизацию подвижных зубов и удовлетворяющей клинические и эстетические требования.

А.И. Бетельман и его ученики при лечении пародонтоза опирались на следующие принципы:

- правильное распределение и уменьшение жевательного давления на оставшиеся в полости рта зубы;

- возвращение утерянного функционального единства в зубной системе;
- предохранение зубов от травмирующего действия горизонтальных нагрузок.

Исходя из этого, А.И. Бетельман рекомендовал применять, кроме выравнивания окклюзионной поверхности, ортодонтические и ортопедические мероприятия.

Вопросы патогенеза, клиники и лечения пародонтита и сходных с ним форм заболеваний зубочелюстной системы разрабатывались в Калининском медицинском институте профессором Е.И. Гавриловым и его учениками. В учебнике Е.И. Гаврилова и И.М. Оксмана «Ортопедическая стоматология» (1968) отмечено постепенное развитие травматической окклюзии при пародонтите, в начальных стадиях болезни пародонт приспосабливается к изменившимся условиям, справляясь с функциональной нагрузкой, которая некоторое время не проявляет своего «губительного» действия. Продолжающаяся дистрофия пародонта приводит к потере устойчивости зубов, что обуславливает развитие вторичного травматического синдрома.

Задачей ортопедического лечения пародонтита, по мнению Е.И. Гаврилова, является возвращение зубной системе утраченного единства, правильное распределение жевательного давления среди оставшихся зубов, уменьшение нагрузки на зубы, наиболее пораженные пародонтитом, за счет зубов, у которых пародонт лучше сохранен, предохранение зубов от травмирующего действия горизонтальной перегрузки.

В.И. Кулаженко в своих работах изучал компенсаторную возможность тканей пародонта, пораженного атрофическим процессом. В результате было выявлено, что она или снижена или совсем отсутствует в результате атрофии лунок зубов и потери опоры со стороны соседних зубов. Поэтому ортопедическое лечение должно быть направлено, как на восстановление жевательной функции, так и на укрепление оставшихся зубов.

При помощи сконструированного им аппарата, В.И. Кулаженко предложил вакуумный метод лечения пародонтоза (1962).

С 1953 года в Полтавском (бывшем Харьковском) медицинском стоматологическом институте, под руководством М.Р. Марeya, разрабатывались методы ортопедического лечения в комплексе с комплексной терапией пародонтоза. В работе «Применение ортопедических методов в комплексной терапии пародонтоза» (1958) он отметил, что лучшим методом лечения пародонтоза считается комплексный, включающий наряду с другими лечебными мероприятиями и фиксацию подвижных зубов путем шинирования: несъемные шины, шины-протезы, дуговые протезы, съемные капповые шины и капповые шины-протезы (Л.П. Григорьева, Н.А. Добитко, В.П. Климова, Л.Н. Манзюк, В.Л. Устименко и др.).

С 1961 года вопросы диагностики и лечения больных пародонтозом нашли отражение в работах кафедры ортопедической стоматологии Львовского медицинского института под руководством Я.М. Збаржа.

Разработка данной проблемы выявила ряд нозологических форм поражения зубочелюстной системы и открытие возможностей для патогенетической терапии (В.Н. Копейкин, 1980). Это дало основание для пересмотра тактики ортопедического лечения, особенно при профилактических мероприятиях. Для изучения функциональной патологии зубочелюстной системы необходимо тщательное клиническое обследование больного, установления этиологии и патогенеза форм поражения зубочелюстной системы и выявления значения эндогенных и экзогенных факторов в их развитии. Огромное количество форм поражения зубочелюстной системы требует специфической профилактики и терапии. Ведущая роль в этих поражениях принадлежит функции, которая по-разному может действовать на зубочелюстную систему с момента рождения и на протяжении всей жизни человека.

Об актуальности изучения вопросов этиологии, патогенеза и лечения пародонтоза и сходных с ним форм свидетельствует также тот факт, что

многие ортопеды нашей страны активно включились в разработку этих вопросов.

Ортопедическая стоматология в настоящее время находится на новом этапе развития. Дисциплина занимает равное положение среди других общеклинических специальностей. Развитию клинического направления в ортопедической стоматологии в значительной степени способствовала тесная взаимосвязь с научными достижениями терапевтической, хирургической стоматологии и других медицинских специальностей, целенаправленные исследования в области морфологии, физиологии, патофизиологии зубочелюстной системы.

Ортопеды-стоматологи изучают характерные заболевания зубочелюстной системы, их этиологию и патогенез, устанавливают функционально-морфологические изменения, разрабатывают основы диагностики и их лечения.

В последние десятилетия возросло число научных коллективов, которые вносят существенный вклад в развитие ортопедической стоматологии (С.-Петербург, Тверь и др.).

В 1896 году, на I съезде дантистов в Нижнем Новгороде, зубной врач А.И. Ковалев, выступая с докладом «Металлические капсульные коронки», первым в России, предложил метод изготовления коронок из алюминия. У этого метода оказалось много противников и работа была приостановлена. Однако вопросы применения алюминия в зубопротезировании стали предметом обсуждения на I и II одонтологических съездах (1896, 1899).

Для оказания специализированной ортопедической помощи населению страны в первые годы советской власти необходимо было срочно решать проблемы материального обеспечения развивающейся стоматологии. Для этого надо было наладить государственное снабжение зубоврачебных учреждений оборудованием, инструментарием и материалами, что требовало развития отечественной медицинской промышленности. Необходимо было разрабатывать новые, более дешевые и доступные металлы и сплавы.

Замена золота другими, более дешевыми, но по биологическим свойствам близкими к золоту сплавами, стала проблемой номер один.

Несмотря на тяжелые экономические условия, уже в 1921 году в мастерских Наркомздрава РСФСР было налажено производство первых отечественных материалов — ден тина, амальгамы, фосфатцемента и т.п. Поиск материалов, позволявших решать вопросы массового зубного протезирования, привели к зарождению важного раздела ортопедической стоматологии — материаловедения. Требовались материалы не только с высокими технологическими свойствами, но и абсолютно безвредные для организма человека.

В 1923 году для изготовления несъемных протезов И.А. Клейтман предложил алюминий, но его предложение осталось без внимания.

К 30-м годам в ортопедической стоматологии были разработаны и внедрены в практику два основных метода изготовления различных конструкций протезов с применением металлов и сплавов:

1) Гальванический метод с применением электролитической меди, серебра и сплавов, с последующим хромированием (Г.Г. Беркович, С.С. Шведов и др.) или золочением протезов.

2) Изготовление протезов из кислотоупорной стали (С.С. Асе и Д.Н. Цитрин).

Хромирование протезов было более перспективным, но технология такого изготовления протезов только зарождалась, опыта в работе с благородными металлами у врачей не было.

Прекращение исследований по изготовлению зубных протезов с помощью гальванического метода дало толчок к разработке кислотоупорной стали.

Нержавеющая сталь впервые была изготовлена в 1912 году, в Германии, на заводе Круппа. В 1926-1927 годах в России появились гильзы из крупновской стали, для изготовления коронок. Для термической обработки гильз требовалась специальная аппаратура, которой в стране практически не было.

В 1928 году на Златоустовском заводе инженером-металлургом Крутицким была изготовлена сталь, содержащая 18-20 % хрома, 7-9 % никеля и 0,2-0,4 % углерода, которая по своим свойствам была идентична крупновской. В испытаниях стали принял участие зубной врач из Свердловска С.С. Асе.

В 1929 году, в Свердловске, была организована научно-исследовательская лаборатория по разработке и изучению нержавеющей стали для зубного протезирования, руководить которой стал С.С. Асе. В том же году на Уралмаше была открыта опытно-штамповочная мастерская для производства кламмеров и зубов из нержавеющей стали. Позднее специальную нержавеющую сталь марки 2А освоили на заводе «Электро-сталь» (Московская обл.).

Экспериментальные работы, проведенные в Государственном институте стоматологии и одонтологии (ГИСО), выявили значительные экономические преимущества зубных протезов из стали, по сравнению с дорогостоящими протезами из золота.

8 июня 1932 года в Госплане СССР состоялось совещание, на котором обсуждался вопрос использования стали, для экономии золота, в зубном протезировании (1,5 т в год).

В 1931 году Д.Н. Цитрин впервые разработал рецепт припоя для нержавеющей стали, а в 1932 году — новый, улучшенный его состав (серебро, медь, никель, бериллий, марганец, цинк, магний, кадмий) без содержания золота.

По инициативе Д.Н. Цитрина в 1933 году в Государственном научно-исследовательском институте стоматологии и одонтологии (ГНИИСО) была создана центральная научно-исследовательская зубопротезная лаборатория для массового изготовления зубных протезов из стали. Лаборатория занималась изучением коррозионной стойкости различных материалов в среде, приближенной к среде полости рта. Популярность протезирования зубов нержавеющей сталью повышалась, за первые 5 месяцев 1933 года в

ГИСО было изготовлено 994 коронки из золота и 2063 — из стали (Г.Н. Троянский, 1970).

В 1937 году было отмечено, что освоенные лабораторией института и изготовленные на заводах СССР новые марки стали дали возможность при протезировании полностью заменить импортную сталь на отечественную (по рецепту ГИСО, ЭИ-95). Сталь ЭИ-95 лучше других удовлетворяла всем требованиям, была дешевой, высокотехнологичной, обеспечивающей хорошее качество зубных протезов. Разработка сплавов, приближающихся по своим свойствам к золотым, позволила делать протезы высокого качества. В создании таких сплавов участвовали Д.Н. Цитрин, И.О. Новик, М.С. Липец.

В 1939 году И.О. Новик разработал рецепт сплава из палладия, золота и серебра и припоя для него, который по составу был, идентичен основному сплаву. По качественным показателям «платинит», так он был назван, превосходил немецкий сплав «Альба».

М.С. Липец и А.И. Шпагат с 1943 года начали разрабатывать сплавы на серебряно-палладиевой основе.

В те времена сплавы на серебряно-палладиевой основе не были внедрены в практику ортопедической стоматологии.

Сороковые годы — это был новый этап в разработке сплавов металлов. Изучение ЭДС полости рта, проведение спектрального анализа слюны, гистологических и гистохимических исследований, изучение обменных процессов позволили получить новые данные по физиологии и патофизиологии зубочелюстной системы, реакции тканей полости рта на различные виды материалов протезов.

С.С. Асс, А.Т. Бусыгин, М.Р. Марей, А.М. Парфенова и др. выявили, что при пользовании протезами из нержавеющей стали, в полости рта могут возникать микротоки, которые вызывают сухость, жжение, красноту, боль слизистой оболочки полости рта, а также нарушение деятельности желудочно-кишечного тракта.

Поиск заменителя дорогостоящего золота привел к разработке метода гальванопластики в стоматологии, а технология ее применения дала толчок разработке специальной аппаратуры. С 1954 года, в научно-исследовательской лаборатории ММСИ, под руководством В.Ю. Курляндского, стали разрабатывать новые составы сплавов, припои. Были предприняты попытки заменить спайку деталей протезов бесприпойным методом. Спайка была заменена электронно-лучевой сваркой в вакууме и аргоно-дуговой сваркой, а позднее ультразвуковой и лазерной. Сравнение качества паяных и сварных соединений промежуточной части мостовидного протеза с коронками выявило, что в паяном соединении микротвердость припоя вдвое ниже микротвердости металла промежуточной части мостовидных протезов. При электронно-лучевой и аргоно-дуговой сварке микротвердость сварного шва практически не отличается от микротвердости металла промежуточной части мостовидных протезов. В 1968 году по проблеме «Применение сплавов металлов в стоматологии» была проведена Республиканская конференция, на которой было заслушано 55 докладов.

Основное внимание сотрудников лаборатории было сосредоточено на разработке сплавов на основе палладия, серебра и золота. Первые серебряно-палладиевые сплавы были разработаны в 1962 году совместно с Московским заводом спецсплавов. За 10 лет применения серебряно-палладиевых сплавов на кафедре ортопедической стоматологии ММСИ более 4000 больных получили зубные протезы из этих сплавов. Цены на такие протезы по прейскуранту розничных цен на зуботехническую продукцию из драгоценных металлов, разработанные Государственным комитетом цен при Совете министров СССР, были в 10 раз ниже стоимости золота.

В это же время на кафедре при изготовлении зубных протезов началось внедрение методов электрохимии (П.М. Яценко). Применение гальванотехники шло по двум направлениям: гальваностегии (тонкое покрытие готовых протезов) и гальванопластики (изготовление протезов). Оба этих

метода имеют свои преимущества: при гальваностегии используются драгоценные металлы для покрытия конструкций из хромокобальтовых сплавов, второй способ, благодаря индивидуальному исполнению, предполагает высокую точность прилегания протеза. Актуальность этих разработок очевидна и в настоящее время.

Для точности изготовления металлических конструкций зубных протезов были разработаны и внедрены в практику новые аппараты — параллелометр, аппарат для обработки гипсовых моделей, вакуумный вибростол, пескоструйный аппарат, аппарат для электрополировки и т. д. Создание этих и других аппаратов — результат совместного труда сотрудников Всесоюзного научно-исследовательского института хирургической аппаратуры и инструментария (М.П. Горячев, А.Н. Ковшов, Е.М. Любарский, С.М. Эйдинов и др.) и Московского медицинского стоматологического института (В.Ю. Курляндский, В.Н. Копейкин).

В Центральном научно-исследовательском институте стоматологии был разработан формовочный материал «Кристосил» для отливки огнеупорных моделей и литейных форм (И.И. Ревзин и др.). Улучшению качества бюгельных и шинирующих протезов послужил «Бюгелит» (В.Н. Копейкин, Е.М. Любарский), состоящий из высокопрочного гипса.

Ленинградский завод зубопротезных материалов совместно с ЦНИИ стоматологии выпустил кобальтохромовый сплав (КХС) для стоматологических целей.

В 70-е годы в ММСИ, под руководством В.Ю. Курляндского, коллектив кафедры ортопедической стоматологии и ГосНИИ стекла для изготовления индивидуальных зубных коронок и металлокерамических зубных протезов создал первый отечественный ситалл «Сикор». Ситаллы — это стеклокристаллические материалы, полученные из стекол определенных составов путем термообработки, в результате которой образуются мелкие кристаллы размером от долей микрона до 1—3 мкм и остаточная стеклофаза. Ситаллы, за счет их мелкокристаллической структуры, отличаются

от фарфоров лучшими физико-механическими свойствами. Свойства ситаллов можно заранее проектировать при расчетах их составов. Получение ситаллов, с заранее заданными свойствами, определяется их составами и режимами термообработки. По ряду характеристик ситаллы не имеют себе равных среди материалов минерального происхождения. Кроме того, в ситаллах меньше микротрещин, меньше объемных дефектов, неизбежных при обжиге изделий.

С 1979 года продолжались работы по синтезу, исследованию и внедрению в практику ситаллового покрытия «Симет» для металлических каркасов зубных протезов. Первое отечественное ситалловое покрытие «Симет», разработанное и синтезированное в ММСИ и Государственном институте стекла в 1979 году, отличается высокой адгезией к металлическим каркасам зубных протезов. Ситалл «Симет» рекомендован к производству в 1990 году.

В последнее десятилетие в ММСИ внедряются новые методы лечения вкладками из ситалла (компьютерное фрезерование), используется метод плазменного напыления при мостовидном протезировании, совершенствуются новые палладиевые и золото-платиновые сплавы «Супер-КМ», разрабатываются сплавы на основе титана и циркония для зубных протезов, золотого сплава-припоя, не содержащего кадмий и многое другое.

Ситаллы «Сикор», «Симет» и литевой ситалл предназначены для несъемного протезирования и являются индифферентными биосовместимыми материалами. Кроме индифферентных материалов на кафедре госпитальной ортопедической стоматологии ММСИ и НИИ стекла был разработан биоактивный ситалл для имплантации — биоситалл, для восстановления дефектов костных тканей челюстей, предназначенный для внутрикостного эндопротезирования. Биоситалл способствует регенеративным процессам в организме, ускоряя ее.

Серийный выпуск материала «Сикор» был осуществлен в 1983 году Ленинградским заводом «Медполимер», скоторым кафедра тесно сотрудничала (В.Н. Копейкин).

Позднее, под руководством В.Н. Копейкина, а в дальнейшем И.Ю. Лебедеко, были созданы четыре ситалловых материала, три из которых являются биоиндифферентными и предназначены для зубного протезирования, а также биоактивный «Биоситалл» для имплантации с целью восстановления костных дефектов челюстей.

Сотрудники кафедры госпитальной ортопедической стоматологии МГМСУ для контроля качества металлокерамических и металлокомпозитных зубных протезов применяют различные методы: акустический, тепловизиографический, капиллярный.

Целенаправленная разработка материалов и технологий изготовления протезов позволяет в настоящее время решать вопросы качественного и эстетически обоснованного ортопедического лечения населения.

Параллельно с разработкой металлов и сплавов стоматологи проводили и проводят исследования по созданию пластических масс для базисов съемных протезов. Начиная с 20-х годов XX века, развивая отечественную промышленность по созданию зубопротезных материалов, отечественная стоматология уже практически не зависела от поставок иностранных фирм.

Стоматологи установили (В.А. Аронсон, Д.Л. Горкин, В.Ю. Курляндский, К.Н. Кутуева, И.О. Новик, М.С. Тиссенбаум, Д.Н. Цитрин и др.), что каучук, как основной материал, для изготовления базисов протезов, имеет ряд недостатков. Это побудило исследователей к поиску более совершенных материалов. И.О. Новик в 1933 году для изготовления съемных протезов предложил применять крезолоформальдегидную смолу под названием трикаен, а в 1934 году, он, видоизменив ее, назвал стомалитом.

С.С. Шведов, на основе фенолформальдегидных смол, разработал пластмассу — эфнелит (1934), а в 1940 году О.М. Баркман, И.Г. Лукомский, Я.Л. Раев и М.С. Шнейдер предложили свою модификацию смолы, назвав ее альдолитом. Низкая эластичность, цветонеустойчивость, сложность технологического процесса, не обеспечивающая получения протезов более высокого, чем каучуковые, качества, не способствовали внедрению

указанных масс в практику. Поиск заменителей каучука не прекращался. В 1934 году на основе акриловых смол был предложен препарат неогеколит. Исследовательские работы по применению пластмасс акриловой группы начались в 1938—1939 годах.

В 1940 году А.М. Кипнис опубликовал первое предварительное сообщение о применении новой зубопротезной массы «Стомакс», которую он в 1941 году описал в монографии «Теория и практика зубопротезной массы «Стомакс».

В 1941 году Б.Н. Бынин сделал сообщение о клинко-экспериментальных испытаниях пластмассы АКР-7, разработанной сотрудниками Центрального института травматологии, ортопедии и протезирования (ЦИТО) совместно с сотрудниками Научно-исследовательского института пластмасс.

Препарат АКР-7, а в дальнейшем усовершенствованный АКР-10, разработанный Б.Н. Быниным, М.Б. Выгодской, А.Г. Голубковой, З.В. Коппом, М.Л. Манукяном, В.А. Марским, Г.С. Петровым, А.А. Пешехоновым, И.И. Ревзиным, С.С. Шведовым, получил широкое распространение в клинической практике.

К разработке новой пластмассы были привлечены как стоматологи, так и токсикологи, химики и др. специалисты. Широкому внедрению пластмассы акриловой группы способствовали и всесторонние экспериментальные исследования ее физико-механических и химических свойств.

За период с 1940—1953 годы авторским коллективом Центрального института травматологии и ортопедии было разработано около 10 рецептов пластмасс. Результаты исследований, проведенных стоматологами в лаборатории пластмасс ЦИТО, легли в основу применения пластмасс в различных отраслях медицины. В настоящее время пластмассы применяются в хирургии и общей ортопедии, офтальмологии, гистологии, анатомии и медицинской промышленности. Внедрение препаратов пластмасс в медицину было высоко оценено государством, присудившем в 1950 году

— Б.Н. Бынину, З.В. Коппу, М.Л. Манукяну, В.А. Марскому и И.И. Ревзину Сталинскую премию.

Внедрению пластических масс в стоматологию способствовала большая исследовательская работа, проведенная коллективом лаборатории пластмасс ЦИТО, научными работниками и врачами стоматологических учреждений, сотрудниками Харьковского и Ленинградского заводов зубо-врачебных материалов. В ортопедической стоматологии пластмассы акриловой группы стали основным материалом.

В 1954 году для фиксации пластиночных протезов М.А. Нападов применил быстротвердеющие пластмассы.

Результаты исследований свойств быстротвердеющих пластмасс были обнародованы А.Э. Рофесом и М.А. Нападковым, В.Д. Безуглым, Л.И. Мацем и В.И. Дмитриевой. В 1963 году вышла монография Я.М. Збаржа «Быстротвердеющие пластмассы в зубном и челюстном протезировании».

Быстротвердеющие пластмассы, или пластмассы холодного отвердения, нашли широкое применение в терапевтической стоматологии, ортодонтии, ортопедии, челюстно-лицевой хирургии и других разделах стоматологии.

Помимо работ по созданию и совершенствованию рецептур пластических масс, совершенствованию конструкций и методов изготовления из них зубных протезов, проведены многочисленные эксперименты по внедрению их в клинику

Токсикологические свойства пластмасс, их биологическую совместимость с тканями организма, влияние ее на ферменты слюны, микрофлору полости рта изучали: Г.Б. Брахман, Б.Н. Бынин, Э.Я. Варес, А.М. Кипнис, К.Н. Кутуева, В.Н. Копейкин, И.М. Оксман, И.И. Ревзин, Д.Н. Цитрин и др.

Клинические наблюдения, целью которых было выявление влияния съемных протезов на ткани полости рта, проводились А.В. Высоцкой, З.С. Василенко, Г.А. Кудиновым, В.Ю. Курляндским, И.О. Новиком,

Л.А. Пашковской, И.И. Ревзиным, Л.И. Солодиловым, Д.Н. Цитриным.

Эластичные пластмассы были применены в качестве имплантата (Г.Б. Брахман) при восстановлении альвеолярного отростка челюстей при чрезмерной его атрофии, для мягкой прослойки базисов пластиночных протезов (В.В. Андреев, Н.В. Калинина, И.И. Ревзин), для элементов obturаторов при дефектах мягкого нёба (Л.В. Ильина-Маркосян). Эластичным материалом, с улучшенными по сравнению с АКР-9 свойствами, следует признать препарат ЭГмасс-12 на основе полихлорвиниловых смол (И.И. Ревзин, В.А. Марский и др.), но клинические и экспериментальные наблюдения показали, что через 4-6 месяцев эластичность ЭГмасс-12 снижается.

В 1966 году на основе акриловых смол был разработан препарат «Эладент-66», предназначенный для мягкой подкладки под базис съёмных протезов.

В поисках массы со стабильными эластичными свойствами Е.В. Груздкова, Н.К. Власова, В.В. Паникаровский, Л.А. Бруслова совместно с инженерами-химиками Е.И. Смагиным, А.В. Зуевой и М.В. Крюковой провели экспериментальные исследования резин на основе полиметилвинилсилоксанового каучука марки СКТВ-1.

Экспериментальные исследования показали его биологическую индифферентность и стабильность эластических свойств.

Разработка новых пластмасс проводится в трех направлениях:

- 1) совершенствование рецептуры препаратов акриловой группы;
- 2) изучение и создание материалов на основе новых полимеров;
- 3) разработка новой технологии изготовления протезов.

Впервые в Советском Союзе метод химической пластификации (отказ от введения в пластмассу активных веществ, раздражающих ткани полости рта) начал осваивать В.Н. Копейкин (1959). Ученый совместно с сотрудниками научно-исследовательского института пластмасс В.Н. Котрелевым, Т.Д. Кострюковой и В.В. Тарасовым разработал рецептуру новой пластмассы на основе полиэфирных смол — поликарбоната, названной

ими «Карбодент». В.Н. Копейкин разработал технологию изготовления протезов из термопластических масс и сконструировал аппарат для изготовления протезов методом литья под давлением. Его исследования были продолжены В.Л. Гроссманом.

Качество лечения в ортопедической стоматологии тесно связано с совершенствованием и развитием стоматологического материаловедения. Успехи химии в разработке высокопрочных полимеров и полимеров с заданными свойствами позволят получить более совершенные материалы и пластмассы.

Зубные протезы изготавливают по моделям, полученным по индивидуальным слепкам, точность которых зависит от свойств слепочных материалов.

Самым распространенным слепочным материалом, применявшимся в клиниках ортопедической стоматологии многие годы, был гипс.

Массы «Стене», «Керра», гуттаперча и другие слепочные композиции — продукция иностранных фирм. Благодаря достижениям химии по разработке высокомолекулярных соединений и улучшению свойств различных полимеров, были созданы и внедрены в производство отечественные слепочные материалы.

В 1940 году О.И. Кругляков в Одесском научно-исследовательском стоматологическом институте проводил лабораторно-клинические исследования слепочного материала на основе агар-агара, который получил название «гидроколлоидная оттискная масса». При нагревании он становится пластичным и без компрессии слизистой оболочки полости рта, без смещения подвижных зубов, обеспечивает получение точных слепков.

Возглавив в 1952 году кафедру ортопедической стоматологии ММСИ и научно-исследовательскую лабораторию при ней, В.Ю. Курляндский определил круг задач, стоящих перед коллективом: изучение функциональной патологии зубочелюстной системы, разработка методов ортопедического лечения при кариозных поражениях зубов и связанных с

ними изменений в опорном аппарате зубов, челюстно-височных суставах и мышечном аппарате, исследование проблемы ортопедического лечения при болезнях пародонта, изыскание новых методов протезирования при дефектах челюстей, изучение и внедрение в практику новых медикаментов для обезболивания стоматологических манипуляций, создание инструментов, зубопротезных материалов, применяемых в ортопедической клинике, разработка новых и совершенствование существующих конструкций протезов, изучение этиологии, патогенеза и новых методов лечения аномалий развития зубочелюстной системы.

В научно-исследовательской лаборатории при кафедре были созданы исследовательские группы:

- металлы и их сплавы;
- гальванопластика в стоматологии;
- полимеры в стоматологии
- методы акустики в стоматологии;
- применение излучения квантового генератора в стоматологии;
- группа патофизиологии.

Группа сотрудников, которая занималась пластмассами и другими полимерными материалами решала следующие задачи: разработка модификаций различных полимерных материалов для зубного и челюстно-лицевого протезирования, изучение их действия на организм животных и человека с последующим внедрением этих материалов в практику.

Полимеры используются в восстановительной хирургии лица, при лечении переломов челюстей, при челюстно-лицевом протезировании, при пломбировании зубов, но наибольшее применение они нашли в ортопедической стоматологической клинике и зуботехнической лаборатории, где они служат в качестве базисных материалов для изготовления искусственных зубов и коронок, слепочных и других вспомогательных материалов.

К тому времени были достигнуты определенные успехи в разработке специальных полимерных материалов для стоматологии. Работы вели не-

сколько организаций Минздрава СССР и РСФСР, Минздрава УССР, Минмедпрома, Минхимпрома СССР и др.

Работники Харьковского завода медицинских пластмасс и стоматологических материалов вместе с сотрудниками ЦНИИСа разработали и наладили промышленный выпуск целого ряда полимерных материалов и изделий из них, в том числе искусственных зубов.

В 1960 году Б.Р. Вайнштейн разработал слепочные термопластичные массы на основе пентаэритритового эфира канифоли, которые стали выпускать под названием «масса оттискная термопластичная» и в зависимости от состава имеет различные качественные показатели и назначение — получение слепков с беззубых челюстей, слепков для перебазировки протезов в ортодонтии и челюстно-лицевой ортопедии. В 1963 году он предложил термопластическую массу «Стомапласт», которая приобретала пластичность при температуре полости рта. Масса предназначена для получения функциональных слепков с беззубых челюстей. Харьковский завод зубопротезных материалов разработал компрессионный слепочный материал «Дентафоль» на основе природных смол и полимеров. Д.Н. Цитрин предложил четыре композиции слепочных масс на основе эпоксидных смол.

Для получения слепков с беззубых челюстей П.А. Мороз в 1966 году рекомендовал применять массу на основе канифоли, в основу разработки («Стомапласт» и «Дентафоль») был положен принцип получения пластичности массы под влиянием температуры полости рта и получения слепков по методике, предложенной Гербстом.

Стремление к увеличению точности воспроизведения тканей протезного ложа, облегчению работы при снятии слепков, безболезненного выведения затвердевшей массы из полости рта, особенно при подвижных, конвергирующих и аномалийно расположенных зубах, стимулировало разработку эластичных слепочных материалов. Основным требованием при изготовлении слепочных материалов было создание на исходном этапе жидкой или пластичной консистенции, оказывающей минимальное или незна-

чительное давление на слизистую оболочку рта, что позволило применять разгружающие и не деформирующие слизистую оболочку полости рта, слепки.

Отечественная промышленность стала выпускать слепочные материалы на основе альгинатов — альгеласт, стомальгин, новальгин. Кроме того, были созданы слепочные материалы на основе синтетических полимеров, которые выгодно отличались от альгинатных, изготавливаемых из природного сырья.

В 1954 году появляются высокоэластичные тиоколовые, а в 1956 году — силиконовые материалы. Конец 50-х и начало 60-х годов XX века во многих странах мира, в том числе и в Советском Союзе, характеризуется разработкой значительного количества слепочных материалов с заданными свойствами. В основном ассортимент их пополнялся за счет материалов с эластичными после отверждения свойствами.

В настоящее время ассортимент материалов достаточно широк, и поставка их медицинской промышленностью удовлетворяет нужды лечебных учреждений. Химики и стоматологи большое внимание уделяли слепочным материалам на основе синтетических каучуков: полисульфидного и кремнийорганического. Выпускаемый отечественной промышленностью силиконовый материал «Сиаласт» был предложен в 1960 году М.М. Тернером, Е.Г. Ароновым и Р.М. Рапопортом.

С 1963 года в научно-исследовательской лаборатории по изучению стоматологических материалов для зубного и челюстно-лицевого протезирования ММСИ Л.И. Гиллером был предложен однокомпонентный слепочный материал на основе полидиметилсилоксанового каучука, который получил название «Силан».

В постановлении Совета министров СССР от 12 августа 1961 года «О мерах по улучшению стоматологической помощи населению» впервые в истории стоматологии была поставлена задача полностью удовлетворить потребности населения в стоматологической помощи. В целях обеспечения

своевременного и полного выполнения указанного постановления 2 сентября 1961 года был издан приказ министра здравоохранения СССР № 386 «О мерах по улучшению стоматологической помощи населению». Выполнение этих законодательных актов способствовало широкому применению высокочастотного литья, для чего был значительно увеличен выпуск заготовок из хромокобальтового сплава, альгинатных и силиконовых слепочных масс, сополимерных материалов для зубных протезов на основе метилметакрилата.

В 1967 году в лаборатории ММСИ были изучены свойства эластичной силиконовой пластмассы «Ортосил», мягкой прокладки в двухслойных базисах. Клинические испытания этой пластмассы показали: она нетоксична, без запаха и вкуса, не изменяется в размерах как при изготовлении, так и при пользовании ею. Пластмасса обладает минимальной водопоглощаемостью, стойкостью в слабых щелочах и кислотах, стойкостью к стиранию и прочной связью с жестким базисом протеза, со временем не теряет эластичность. «Ортосил» был рекомендован к применению в качестве зубопротезного материала для повышения функциональной эффективности при протезировании беззубых челюстей.

Важной проблемой в ортопедической стоматологии была проблема воздействия акриловых пластмасс на организм. Основное внимание исследователей было уделено изучению реакции слизистой оболочки полости рта на механические факторы воздействия со стороны протеза, токсическое влияние пластмасс, изменение состава слюны. Было отмечено, что пластмассовый протез может вызвать воспаление слизистой, атрофию подлежащей кости (вследствие повышенного давления) и механические травмы. Известно, что непереносимость к акрилатам может быть и аллергической природы. Возникла необходимость в изучении природы непереносимости протезов из акрилатов, а также в поиске средств и методов, позволяющих дифференцировать аллергическую природу этой непереносимости.

В 70-е годы в лаборатории ММСИ начались работы по внедрению спектрального анализа при изучении аллергологических реакций организма на пользование протезами. Было установлено, что явления непереносимости могут быть обусловлены химическим воздействием на слизистую оболочку полости рта, повышенной чувствительностью аллергической природы. Было обосновано применение некоторых аллергологических проб (реакция OVARY), на основании которых были разработаны критерии дифференциальной диагностики непереносимости к съемным протезам из акрилатов, от других видов поражения слизистой оболочки полости рта, что очень важно для клиники. В результате исследования было выявлено, что в сыворотке крови больных чаще определялись антитела к мономеру, реже к красителю, что говорит о более высокой антигенной активности мономера.

В последнее десятилетие разработано большое количество пластиковых масс нового поколения, позволяющих снимать точные слепки и избегать вредных воздействий на слизистую оболочку полости рта.

В настоящее время материаловедение включено в учебный план стоматологических институтов, т.к. знание свойств материалов при изготовлении зубных протезов, является гарантом их качества.

В 2000 году в МГМСУ была открыта первая в стране (в медицинских вузах) кафедра материаловедения.

4.4.5. Профилактика в стоматологии.

История профилактики в стоматологии тесно переплетается с развитием профилактики всего отечественного здравоохранения. В годы становления стоматологии, как науки, началось формирование профилактического направления. При совершенствовании методов и средств профилактики кариеса зубов и пародонтоза, стоматологи на первое место всегда ставили общебиологические, общемедицинские принципы. Начало этому направлению положил П.Г. Дауге. Его труд «Социальные основы совет-

ской стоматологии» до сих пор является основополагающим по этой проблеме. Ученый писал: «...профилактика заболеваний зубов должна быть организована так, чтобы врачи — ортопеды оказались без работы».

Основной целью профилактики является устранение причин возникновения и развития заболеваний, а также создание условий для повышения устойчивости организма к воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды.

Активное участие в разработке этого направления принимали профессор Е.М. Гофунг, Д.А. Энтин, И.Г. Лукомский и др.

Д.А. Энтин, первый из отечественных исследователей, обнаружил процесс реминерализации эмали, что позволило предупреждать не только возникновение кариеса зубов, но и его дальнейшее развитие.

И.Г. Лукомский сформулировал основные принципы профилактики самой распространенной патологии в стоматологии — кариеса зубов, с применением фтористого натрия. И.А. Мейсахович предложил применять для этих же целей хлористый стронций.

Большое значение для профилактики кариеса зубов имеет искусственное обогащение питьевой воды соединениями фтора, которое впервые было применено в конце 40-х годов XX столетия в США, Канаде и СССР. Постоянными исследователями эффективности фторирования питьевой воды были А.И. Рыбаков, Г.Д. Овруцкий и др. Фторирование питьевой воды находится под контролем органов государственного санитарного надзора, как в нашей стране, так и в других странах, где оно проводится. Оценка этого мероприятия может быть дана только в комплексе с гигиенистами, педиатрами, организаторами здравоохранения и другими специалистами.

Для профилактики кариеса зубов профессор И.О. Новик применял костную муку, которая содержит все вещества (соединения фтора, кальция и др.), необходимые для своевременного созревания зубов.

Для местных аппликаций зубов, профессор Г.Н. Пахомов, предложил

реминерализующий раствор — вытяжку из костей крупного рогатого скота, который носит название «реминерализующий раствор Боровского — Пахомова».

Существенный вклад в разработку методов профилактики кариеса зубов и других стоматологических заболеваний внес А.И. Рыбаков со своими сотрудниками. Отличительной особенностью этих исследований является изучение эпидемиологических условий в определенных географических и экономических регионах страны. Эта работа была высоко оценена ВОЗ, и ЦНИИС много лет являлся одним из ее региональных центров по изучению эпидемиологии стоматологической патологии. Эпидемиология кариеса зубов была изучена в Якутской АССР, Алтайском крае, Казахской ССР, в Москве.

А.И. Рыбаковым и А.В. Граниным были предложены индифферентные сорбенты и ионообменные соединения для регулирования физиологического созревания эмали зубов, очищения слюны от чуждых организму соединений. Наряду с местным управлением процесса созревания эмали зубов, в комплекс мероприятий по профилактике кариеса зубов, обязательно входят общемедицинские рекомендации по профилактике любой патологии: балансирование суточного пищевого рациона, коррекция двигательной активности, рациональный режим труда и отдыха, индивидуальные санитарно-гигиенические мероприятия.

Существенный вклад в развитие отечественной стоматологической профилактики внесли профессора Е.В. Боровский, А.А. Прохончуков, Т.Ф. Виноградова, Ю.А. Федоров.

Проблеме стоматологической профилактики были посвящены научные труды: «Основы стоматологической профилактики» А.И. Рыбакова (1968), «Профилактика в стоматологии» А.И. Рыбакова и А.В. Гранина (1975), «Профилактика кариеса зубов» А.И. Рыбакова и А.В. Гранина (1976), «Кариес зубов и его профилактика» Г.Н. Пахомова (1976), «Кариес зубов» Е.В. Боровского и П.А. Леуса (1979).

Наряду с предупреждением развития кариеса зубов большое значение имеет профилактика пародонтоза и патологии слизистой оболочки полости рта. Патология пародонта и слизистой оболочки полости рта характеризуется в большинстве случаев симптомами, присущими общей патологии организма, и предупреждение ее проводится именно в этом направлении. Яркий пример этому — пародонтоз. На основании исследований А.И. Евдокимова и его учеников, основными мерами предупреждения пародонтоза были предложены противосклеротические мероприятия. Этой теме посвящены работы Е.Е. Платонова, Т.Ф. Никитиной, Т.И. Лемецкой.

Значительный вклад в изучение вопросов профилактики в стоматологии внесли профессора В.Ф. Рудько, В.Ю. Курляндский, М.И. Грошиков. Предупреждение развития кариеса зубов и патологии пародонта — это одновременно и предупреждение заболеваний горла, носа, уха, легких, суставов, сердца, не говоря уже о значительном эстетическом эффекте здоровых зубов.

Первая и единственная кафедра профилактики стоматологических заболеваний была создана в 1986 году в ММСИ профессором П.А. Леусом, с 1990 года кафедрой руководит профессор Э.М. Кузьмина.

Под ее руководством реализуется комплексная программа исследований по профилактике стоматологических заболеваний, основными направлениями которой являются:

- эпидемиологическое стоматологическое обследование населения и формирование банка данных стоматологической заболеваемостью;
- обоснование новых методов и средств профилактики (экспериментальные и клинические исследования);
- разработка, внедрение и мониторинг программ профилактики среди различных групп населения в ряде регионов страны;
- создание модели стоматологического здоровья и выявление факторов риска, способствующих возникновению стоматологических заболеваний.

За последние 10 лет сотрудники кафедры участвовали во внедрении 8 программ среди детей и взрослых, анализ которых выявил их высокую эффективность. Эффективность профилактики кариеса фторированием молока, примененного впервые в России в городах Смоленске, Майкопе и Воронеже составила 60 %.

В последние годы профилактике уделяется особенно много внимания. В.К. Леонтьев сформулировал понятие профилактики: «Профилактика — это система государственных, социальных, гигиенических, медицинских и личных мер, направленных на обеспечение высокого уровня здоровья и предупреждения болезней». Этиологическое и патогенетическое обоснование основных направлений профилактики стоматологических заболеваний зависит от разработки методов профилактики. Предложенные В.К. Леонтьевым методы разделяются на 3 направления:

- воздействие на макроорганизм с целью общего оздоровления;
- мероприятия на снижение действия патогенных факторов в полости рта;
- усиление резистентности органов полости рта к патогенным воздействиям.

Для достижения эффекта от профилактики важную роль играет гигиеническое воспитание населения. Гигиеническое воспитание — это привитие полезных навыков на основе знаний правил здорового образа жизни и необходимости их выполнения. Гигиеническое воспитание в стоматологии играет очень важную роль, так как этиология и патогенез кариеса зубов в значительной мере обусловлены отрицательными привычками человека: неправильное потребление сахара, нарушение самоочищения полости рта, низкий уровень гигиены. Оно должно идти по двум направлениям: санитарно-просветительская работа и обучение навыкам гигиены полости рта.

Основой мотивации проведения исследований по профилактике стоматологических заболеваний является то, что лечение уже возникших стоматологических заболеваний обходится во много раз дороже, чем стоимость профилактических методов и средств. Методы профилактики стома-

тологических заболеваний делятся на 3 группы:

- коммунальные (фторирование воды, молока, соли);
- групповые (работа в организованных группах детского населения);
- индивидуальные (работа проводится с конкретным человеком, в соответствии с обнаруженными особенностями здоровья человека и зубочелюстной системы).

К наиболее эффективным методам профилактики стоматологических заболеваний относятся разработка и реализация профилактических стоматологических программ, которые могут иметь различный объем, цели, масштабы и способы выполнения. Программы должны носить либо государственный, либо региональный, либо учрежденческий характер.

5. МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ И ЗУБОВРАЧЕВАНИЕ В БАШКИРИИ ДО 1917 ГОДА

Первые сведения о башкирском народе дают арабские и персидские писатели IX-XIII веков (Ибн Даста, 912; Масуди, 943). По их свидетельству башкиры представляли из себя группу кочевых племён, живших в условиях патриархального строя. Занимаемая башкирскими племенами территория была довольно обширной, они кочевали по всему пространству прикаспийских степей между Волгой и Яиком. Основным занятием башкир было кочевое скотоводство — разведение в основном лошадей, овец и, в меньшей степени, коров, верблюдов. Значительный вес в хозяйстве занимали охота, бортничество, рыболовство. Разнообразие и богатство природных условий Башкирии создавали возможность использования и других форм хозяйства (С.И. Руденко, 1955; Х.Я. Тахаев, 1950; Н.Ф. Демидова, 1958). Башкиры со своим скотом кочевали в течение всего года. Их хозяйство находилось в полной зависимости от капризов природы. Гололеды, снежные заносы и сильные бураны несли населению разорение, ни-

щету, гибель. С переходом к оседлой жизни башкиры стали жить в небольших хибарках. Это были убогие, деревянные строения под соломенной крышей. Вместо окон в стенах делались отверстия с квадратный аршин, которые затягивались бычьими пузырями. Отапливались эти хибарки чучалами — конусообразной печью без заслонок и выюшек. Мебели в хибарках почти не было — её заменяли нары, на которых спали и ели. Освещались хибарки от горящих дров в чучале; только у некоторых имелись коптящие ночные керосинки. Жилье никогда не проветривалось и не убиралось. В зимнее время в избе находились и домашние животные, так как у большинства жителей никаких построек или сараев не было (В.В. Арнольд, 1894). Понятие о гигиене в башкирских деревнях отсутствовало. Тяжелые условия жизни порождали благоприятную среду для развития социальных болезней — трахомы, туберкулёза, цинги и др. Болезненность и смертность среди башкир доходила до ужасающих размеров. Причинами эпидемий и смертности были неблагоприятные жилищно-бытовые условия и недостаточное питание.

«...Тяжела, жалка и однообразна жизнь Башкиров зимою. Нет у них порядочных изб, лачужки едва держатся, ничем почки не покрыты. Нет пригона для скота. Лошади, коровы, овцы находятся почти всегда под открытым небом, потому что дворы только с боков защищены кое-какими плетенками. Зиму проводят башкиры в холоде, голоде и нужде. Нечем покрыть наготу, нет порядочной одежки. Сеют башкиры очень мало хлеба, хватает его только до половины зимы, остальную часть мучаются полуголодные, покупают втридорога проданный осенью хлеб» (Назаров, 1863).

Лотин в 1866 году, проезжая по Башкирии, тоже был поражен ужасающей нищетой. «...Были жилища, где не было решительно ничего съестного и сами жители заявляли, что они не ели ничего по несколько дней, чему можно было верить, глядя на их истощённые натуры. Большая часть бедных довольствовалась испеченными в золе лепешками из толченого проса или лебеды. Эти лепешки имели отвратительный промозглый

запах, неприятный вкус и с виду были похожи на засушенную глину. Другое кушание — болтушка из воды с мукой или отвар проса в воде. Проезжая много деревень, лошадиное мясо я видел только в одном доме» (В.М. Флоринский, 1874). Таким образом, народ фактически был обречён на вымирание. Численность башкирского народа с половины XIX века и до последних лет царизма сократилась более чем вдвое — от двух миллионов осталось меньше одного миллиона (Н.А. Шерстенников, 1940).

Царские чиновники, более заботившиеся о своих личных интересах, совсем не интересовались лечебно-санитарным делом. В лечебно-санитарном отношении башкиры были предоставлены сами себе. До появления земства башкиры даже не слыхали о существовании врача, фельдшера. При заболеваниях они были вынуждены обращаться за помощью к знахарям, шаманам, муллам и т.д. Правда, следует отметить, что, по данным некоторых авторов (Шиле, 1879; В.М.Флоринский, 1874), здоровье башкир было сравнительно хорошим, ибо организм их был гораздо более закален против стихийных невзгод, нежели у других инородцев, привыкших к жизненным удобствам. Башкиры не знали, что такое простуда и неудобоваримая пища.

Особенно хорошо у башкир были развиты органы чувств. Днём и ночью они могли различать предметы на недостижимом для нас расстоянии и улавливать звуки, далеко не долетающие до нашего слуха. Благоприятное влияние на здоровье башкир оказывали выезды в летний период на коши — места летних стойбищ, которые располагались в живописных местностях. С наступлением весны туда устремлялось всё население со своим скотом и необходимыми домашними принадлежностями. Наступала праздная жизнь — хождение друг к другу в гости, сабантуи и т.д. Искудаемые и подавленные духовно башкиры быстро поправлялись, становились подвижными и бодрыми и через какие-нибудь 2-3 недели их нельзя было узнать. К ним возвращалась веселость, просыпались врожденные инстинкты и склонности, появлялись игривость, отвага, юмор, изобретательность,

живость, в движениях (Назаров, 1863; Шиле, 1879; Д.П. Никольский, 1899).

Каким же образом проводилось в то время лечение различных заболеваний, а также зубов и слизистой полости рта в Башкирии? Из описаний арабских писателей XI века и из преданий самих башкир известно, что последние были идолопоклонниками. Поклонялись башкиры разным животным, а некоторые — 12 богам. Считалось, что эти боги управляют временами года — зимой и летом, дождём, ветром, растениями, водой, землёй, жизнью, смертью и т.п. (М.В. Лосиевский, 1883; Д.П. Никольский, 1889).

Бессилие первобытных людей перед грозными и непонятными явлениями природы рождало у них мысль о существовании особой сверхъестественной силы, способной либо благоприятствовать жизни, либо принести всякие бедствия. По древнебашкирским представлениям, болезни посылались злыми духами. Для каждого типа болезни практиковались определённые приёмы лечения и меры предосторожности. Одни болезни изгонялись бесогонителями, другие — знахарями. Путешествуя по Башкирии в 1772 году, И.И. Лепехин так описывает «бесовскую игру», очевидцем которой он был в деревне Красная Мечеть. «Когда трудные роды, судороги, то башкиры приписывают сие прикоснувшемуся нечистому духу и зовут на помощь своих чародеев, называемых Шайтан Куряза (чертовидец). Оные люди у них в отменном почтении. Шайтан Куряза, которого мы видели, был здоровый и молодой детина и искусство свое получил по наследству от деда. Хозяин, у которого была больна жена, должен был сделать пирушку. Тут собралось множество людей обоего пола. Поднялась их обыкновенная пляска в доме больной женщины с великим криком и шумом для того, чтобы нечистый дух, опасаясь множества людей, не входил в избу. В пляске и крике, или лучше сказать, в бешенстве Шайтан Куряза всех превосходит. Он имел обнажённую саблю и заряженную двумя пулями пицаль. Как пришла глубокая полночь, шайтан выбрал троих самых наиздоровейших людей, которым велел быть при себе неотлучными и

показывал, когда он вступит с нечистым в бой, то бы его сзади за кушак и за полы держали, ибо такие чертовидцы уверяли простаков, что нередко нападают на духов сильных, с которыми им должно через долгое время бороться. Отобрав своих телохранителей, к полуночи, неистовый на себя приняв вид, сам более походил на демона, нежели на человека. Тут уже крик и пляска переменились и чертовидец прилежно смотрел на все окна. Наконец, как бы увидел неприязненного духа, взяв пищаль, крался к окошку, как искусный стрелок под птицу и так громко выпалил, что мы опасались, дабы затрясшаяся башкирская хижина нас не задавила. Потом с великим воплем в провожании своих телохранителей и имея в руках обнажённую саблю, выскочил из избы и бежал до самой реки Ика, беспрестанно саблею махая. По его сказкам раненый черт ушел в воду и что шайтан или нечистый дух жены его посещать больше не будет. На том месте, где шайтан сидел, для большей доверенности показывал всем желающим парную кровь, что и мы в самом деле видели, но она у него была, ибо за недолго перед сражением выходил он во двор под видом, чтобы лучше удостовериться в приходе шайтана. Отправив сие позорище, тою же ночью убрался восвояси, больная поутру, как мы оставили деревушку, была при последнем издыхании».

В представлении северо-западных башкир болезнь была живым существом. Например, лихорадку представляли в человеческом образе, в рысьей шапке на голове. Болезни будто бы могли принимать вид животных, птиц, чаще сороки. Для предохранения и избавления от болезни уральские башкиры вместе с изречениями из Корана вешали на шею больных амулеты, медвежьи кости и клыки. Верили, что болезни, боясь их, как самого медведя, оставят больного.

Пытались также умиловить дух, который якобы послал болезнь. Например, приглашённая к больной знахарка расспрашивала, где больная ходила в то время, когда к ней могла привязаться хворь. Узнав это место, лекарка несла туда горшок с крупой, мясом и т.п. верили, что дух, послав-

ший болезнь, увидев горшок с пищей, подобреет и заберёт болезнь обратно. Любопытно, что башкиры встречали хворь, которая вела к падежу скота. Увидев, будто бы на бане болезнь в образе сороки, башкирка кланялась ей и приглашала её помыться в бане, приготавливала ей воду, веник и прочее, чтобы смилостивить её. Случалось, что ребенок 4-5 лет прибежал домой с поля или леса и вскоре заболел. Тогда мать снимала с ребёнка рубашку, обносила её несколько раз вокруг него со словами «оставь его, не играй с ним», затем несла эту рубашку на перекресток дорог и бросала её там. Такую рубашку не только нельзя было брать, но нельзя было и прикоснуться к ней, чтобы не навлечь на себя болезнь.

Кстати, несколько похожий обряд производился в Тульской губернии при заболеваниях детей. Изгнание болезни проводилось так, В сухой степи брали землю с трех полей и черпали девять кружек воды в слиянии трех рек. Смешивали все и этой грязью мыли ребенка. Рубашонку же, бывшую до этого времени на ребенке, оставляли на рубеже двух владений (Балов, 1891).

Часто при лечении болезней башкиры прибегали к помощи огня, добываемого путём трения. В нём люди видели чудодейственную силу. Больного человека или больное животное водили вокруг огня и окуривали.

Многие болезни, по мнению башкир, являлись результатом сглаза или порчи, напускаемой при содействии особых духов. Считалось, что сглазу особенно подвержены дети. Поэтому на одежду мальчикам, на их тюбетейки нашивали белый гусиный пух, перламутровые пуговицы, а чаще всего — раковину. Дурной взгляд якобы падал на раковину и сразу терял свою силу (С.И. Руденко, 1955; Р.Г. Игнатьев, 1883).

Башкиры считали, что все болезни происходят от трех причин: от колдовства врага, или от гнева каких-либо существ, местопребыванием которых служат реки, леса, высокие горы, ущелья и т.п., или, наконец, от власти злых духов, которые являются мстителями за совершённые грехи. Существовало также мнение, что болезнь — это «божий гнев» и что никто

из смертных, кроме, разве, муллы, не сможет помочь. Суеверие было особенно распространено в лечение детских заболеваний. Помимо знахарей, лечением больных занимались и муллы, приёмы их мало чем отличались от приёма знахарей. Они лечили больных нашептыванием, чтением Корана, дули и плевали больному в лицо, поили водой из чашки, на которой написаны были выдержки из Корана.

В некоторых случаях, когда в семье был тяжелобольной, в жертву приносили какое-либо животное, чаще овцу. Шкуру её получал мулла, а мясо съедалось присутствующими, только больной ничего не ел. Магические способы лечения не являлись только обрядами. Они в известной мере способствовали появлению в народе знаний, основанных на наблюдениях. Так зарождалась народная медицина. Из средств народной медицины башкиры при лихорадке пили настой осиновой коры или отвар полыни. Когда появлялся нарыв, то сначала больное место накрывали свежим овечьим калом и укутывали тряпочкой, когда нарыв прорывался и из него шёл гной, язву закрывали мышьиной шкурой. Если заживление шло медленно, то прикладывали сухой творог. Широко применялось лечение кумысом.

Подлинным народным бедствием в те времена была цинга, она вызвала огромную смертность, наносила урон боеспособности войск и трудоспособности населения. Причины цинги были неизвестны. Существовало свыше 20 теорий. Многие считали это заболевание заразным, так как оно носило массовый характер. Было замечено, что болезнь развивается весной (весенница) (Б.Д. Петров, 1962).

Для лечения цинги на Урале широко использовали щавель, молодые побеги сосны, клюкву, сосновый сок, орехи, бруснику, ели и сырую мороженую рыбу (В.Г. Селезнева, 1967).

Академик П. Паллас писал, что лучшим противцинготным и балзамическим средством в Сибири были молодые сосновые и кедровые вершинки. «Таковых сосновых вершинок, - отметил он, - вывозится из государства Российского в иностранные аптеки великое множество».

В некоторых районах Башкирии при цинге ели редьку и обкладывали ноги варёным картофелем (В.В. Арнольдов, 1894). Местами цинготные больные в течение нескольких дней посещали озимые и ели зеленую озимь. Туда и обратно больной должен был ползти на четвереньках, а озимь рвать зубами и губами. Все это делалось утром, до восхода солнца и при отсутствии свидетелей (А. Соколов, 1887).

Довольно распространённым заболеванием среди башкир был кариес зубов. По данным Назарова (1889—1890 гг.), при осмотре 180 человек кариес зубов был отмечен у 69 из них, что составляет 32,7% (прим. авт.: 69 из 180 = 38,3%). Назаровым же подробно описаны формы, размеры, расположение зубов у башкир. Например, он отмечает, что у 151 человека зубы были частые, у 30 — редкие, у 143 — крупные и т.д. Интересные данные приводит Д.П. Никольский (1889), который в своей диссертации «Башкиры» описывает зубы у 37 черепов, извлечённых из могил при раскопках башкирских кладбищ. Кариозные зубы он обнаружил только у 5, а стертые — у 6 черепов. Вместе с этим Д.П. Никольский отмечает, что у нескольких черепов зубы отсутствовали, так что по его данным трудно судить о частоте кариеса.

Заболевания зубов и слизистой полости рта были довольно широко распространены, поэтому народная медицина рекомендовала много разнообразнейших средств против зубной боли. По народному поверью, в поражённых костоедою зубах заводятся червяки, которые точат больной зуб и производят этим сильнейшую боль. В кариозную полость также закладывали ватку с концентрированной соляной кислотой, полоскали рот водкой, настоем шалфея и т.д. Чтобы убить червяков, в некоторых местах проводилось подкуривание блекотою. Например, в Полтавской области больного накрывали над миской с водой платком или простыней, зажигали высушенную с семенами блекоту и держали её у рта больного так, чтобы дым шёл в рот.

В губерниях Центральной России брали листья подорожника, всыпа-

ли в бутылку со спиртом или водкой и ставили на солнце до потемнения. При зубной боли эту жидкость на ватке клали в дупло.

Крестьяне Иркутской губернии брали чистую мамонтовую кость, скоблили её, клали в горшок с молоком, плотно закупоривали. Замазывали глиной и ставили в жар на 2—3 суток. Образующуюся кашицу прикладывали к больному зубу, а также давали детям при прорезывании зубов.

В Черниговской губернии при зубной боли употребляли корень конского щавеля. Корень этот собирался в мае, сушился, а затем заваривался как чай. Этим раствором производилось полоскание рта для уменьшения болей.

В Ярославской губернии брали головку печеного лука, завязывали с солью в тряпочку и клали на больной зуб. В больной зуб закладывали также чеснок, керосин, скипидар, деготь, отвар дубовой или ивовой коры, расколотый чернильный или грецкий орех.

В некоторых местах в больной зуб закладывали ватку с крепкой водкой или полоскали рот водкой с солью, с ладаном. Иногда брали черемуховый прутик, зажигали его с одного конца. Когда прутик гас, его еще горячим вкладывали в зуб. При сильных зубных болях подошвы ног прикладывали к горячей печи, делали ножные ванны из теплой или горячей воды с хреном.

В ряде районов России брали листья кошачьей травы (валерианы) и закладывали между зубом и щекой. В больной зуб также клали горький перец или сахар, сплавленный в виде леденца. Употреблялись семена лопуха с головками в виде отвара для полоскания.

В Вологодской губернии при зубной боли на раскалённый утюг сыпали белену и вдыхали в себя дым. В Енисейской губернии в дупло закладывали деготь (это средство широко применялось и в других местах), клали в дупло камфору, порошок с печёным луком, кору волчьего лыка (А. Балов, 1898). В некоторых местах Енисейской губернии курили повилику, грызли серебряную монету. При молочнице у ребёнка слизистую рта сма-

зывали мёдом, водкой, обсыпали сахаром. Помимо средств народной медицины в России, в том числе и в Башкирии, существовали различные поверья, заклинания, применялись заговоры. Например, в Архангельской губернии и в некоторых местах Вологодской губернии при зубной боли читали такой заговор⁶ «Встану я, раб божий, благословясь и перекрестясь, пойду из дверей в двери, из ворот в ворота, во чисто поле, под красно солнце, пойду в зеленые луга, во зеленые лугах стоит железная баба, на этой бабе стоит милостивый Ной. Помолюсь и покорюсь я милостивому Ною. Милостивый Ной! Сходи на тот свет, не болят ли там зубы, не ноют ли там скулы. Сходил Ной туда — не болят там зубы, не ноют там скулы, не пухнут десны. Вот так бы и у меня, раба божьего, не болели бы зубы, не ныли скулы, не пухли десны. Будь в моей статье ключи и замки в век по веку, отныне до века».

В Центральной России об исцелении зубов молились святому мученику Антипию. В Башкирии, чтобы избавиться от молочницы, бабки запрещали три недели катать белье своё и будущего младенца, а когда молочница всё же проявлялась, то мать заставляли беспрестанно про себя говорить: «Вчера приди, вчера приди, последний раз бьёшь» (Р.Г. Игнатьев, 1883).

В те давние времена появляются уже высказывания о профилактике заболеваний полости рта и зубов, необходимости ухода за зубами. Так, в 60 х годах XVII века Епифаний Славинецкий в своём труде «Гражданство обычаев детских» пишет: «...На всякое утро чистою водою вымыть зубы, а если при еде «что увязнет», но не ножом или ногтями следует вычищать, а лучше пользоваться «перьями птичьими или костками из курячих голеней взятыми» (Н.А. Богоявленский, 1960).

Очень характерно, что Лепехин (1772). Путешествуя по Башкирии, пишет, что «лиственную серу башкирки, подражая восточным народам, жуют, а пережевав, выбрасывают. Сим средством стараются они в белизне всегда содержать свои зубы и истребить из рта противный запах, которому они от нечистоты и сыроедания подвержены бывают».

Так исподволь зарождались идеи профилактики заболеваний зубов.

В XVIII столетии на территории Башкирии начали возникать первые лечебные учреждения — «военные госпитали» для военных чинов. В 1787 году в Уфе по приказу общественного призрения было положено начало в организации медицинской помощи населению (Н.А. Шерстенников, 1945).

Первая больница в Уфе была открыта в 1791 году. Медицинская сеть развивалась чрезвычайно медленно. Так, в 1882 году, когда население Башкирии составляло уже 1 732 704 человека, было всего 38 врачей, 102 фельдшера, 25 повивальных бабок, функционировало 7 аптек. В том же году в Уфе открылась на 20 коек психиатрическая больница и на 61 койку — земская больница. 5 мая 1882 года было организовано общество врачей в Уфимской губернии (В.А. Скачилов, И.И. Геллерман, 1966). Следует сказать, что в культурном отношении Башкирия была одной из наиболее отсталых окраин России, с незначительным процентом грамотного населения, крайне слабой сетью культурных учреждений, школ, библиотек, больниц. В Башкирии не было ни одного высшего учебного заведения, до революции не было письменности, литературного языка (С.З. Лукманов, 1958; Ф.Л. Саяхов, 1959). Тяжёлые условия жизни, низкая культура, неудовлетворительное медобслуживание приводили к тому, что этот район Урала по уровню смертности населения занимал одно из первых мест.

В городах Башкирии совершенно не было детских медицинских учреждений, смертность детей в 1913 году составляла 40,4% (С.Х. Хамитова, 1955). В 1913 году в Уфимской губернии работали 123 врача, из них 70 — в городах и только 53 врача обслуживали сельское население. В среднем на одного врача приходилось 43,7 тысячи населения.

В четырёх районах — Аургазинском, Бижбулякском, Стерлибашевском и Юмагузинском совсем не было ни лечебных учреждений, ни медицинских работников (Н.А. Шерстенников, 1940; М.Х. Камалов, 1961). В Башкирии первые сведения о количестве больных обратившихся по поводу болезней зубов, имеются в докладе Я.О. Левицкого на пятом совещании

врачей Уфимской губернии в 1901 году, где он отмечает, что амбулаторно за период с 1896 по 1900 год обратилось 2714 человек, госпитализированы 3 человека.

По имеющимся сведениям, первым дантистом в Уфе был А.С. Капитонов, приехавший из Риги в 1896 году и открывший первый кабинет на улице Большая Казанская, 4 (ныне улица Октябрьской революции). В 1902 году этот кабинет был куплен Мария Борисовна Буровой-Нейман, которая вместе с сестрой, также зубным врачом, работает в этом кабинете до настоящего времени, занимаясь зубоврачеванием, являясь революционеркой (по данным известного революционера Э.С. Кадомцева, 1963).

В 1903 году открылся кабинет врача М. Маркузе и зубного врача Д. Маркузе. В газете «Уфимские ведомости» от 26 декабря 1903 года писалось, что в этом кабинете проводится лечение зубов и десён, пломбирование и удаление зубов без боли, вставление искусственных зубов.

Первая частная зубная лечебница в Уфе была открыта в 1913 году. В печати того времени было сделано следующее объявление: «Первая частная Уфимская зубная лечебница (под наблюдением врача). Приём ежедневно с 9 до 5 часов. Такса: совет и лечение - 30 коп., удаление зуба - 30 коп., пломбирование зуба - 50 коп., искусственный зуб - 1 руб. Нижние чины и воспитатели народных школ — «бесплатно». В этот период в г. Уфе с населением свыше 100 000 человек работало всего лишь 15 частнопрактикующих врачей и несколько врачей работало в г. Белорецке, Бирске, Белебее и Стерлитамаке. В остальных городах и районах Башкирии зубных врачей вообще не было (А.А. Гуляев, 1913; В.А. Скачилов, 1968). Первая мировая война (1914—1918) больше ухудшила медико-санитарное дело в Башкирии: многие врачи, в том числе и зубные, были мобилизованы в действующую армию.

Таким образом, из-за крайне недостаточного количества медицинских работников народ вынужден был обращаться за помощью к различным невежественным знахарям и муллам, прибегать к примитивным средствам лечения.

6. РАЗВИТИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В БАШКИРСКОЙ АССР (РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН) С 1917 Г.

17 сентября 1918 года Наркомздрав РСФСР издал постановление «Об учёте зубо врачебных и зуботехнических принадлежностей и материалов, которое явилось первым шагом к предстоящей национализации всех зубо врачебных складов и предприятий, к созданию будущих государственных учреждений. Декрет правительства от 26 декабря 1918 года «О трудовой повинности всего трудоспособного населения» был дополнен двумя параграфами:

«О трудовой повинности медицинского персонала, в том числе зубных врачей и зубных техников...;

...О государственной организации зубо врачебной помощи в республике».

В постановлении было указано о необходимости организации общедоступной, бесплатной зубо врачебной помощи населению. Рекомендовалось уделить особое внимание на профессиональное заболевания полости рта, профилактику заболеваний зубов, предлагалось организовать широкую сеть школьных и детских зубных амбулаторий.

28 января 1919 года зубо врачебная секция Наркомздрава, возглавляемая П.Г. Дауге, издала подробную инструкцию «О порядке привлечения на государственную службу зубных врачей с учётом стажа, возраста, социального и семейного положения и о реквизиции частных лечебниц и кабинетов».

Были разработаны нормативы зубо врачебной помощи в соотношении:

- 1 зубной врач на 28 000 сельского населения;
- 1 зубной врач на 10 000 городского населения;
- 1 зубной врач 5 000 школьников (В.Н. Яковенко, 1967).

Организация здравоохранения в Башкирии началась в 1919 году после того, как территория бывшей Уфимской губернии была окончательно очищена от интервентов.

С 10 сентября 1919 года в Башкирии стал функционировать Народный комиссариат здравоохранения. В декабре 1919 года в ведении Наркомздрава было 9 врачей, из них 2 зубных, 84 фельдшера, 7 акушеров и 15 медицинских сестер. На одного врача приходилось 113 100 человек.

В 1919 году было получено централизованным путём 5 зубо врачебных кресел (Э.И. Гиккель, 1920; Г.Г. Куватова, 1923-1924).

Следует сказать, организация здравоохранения в то время проходила в очень тяжёлых условиях, особенно трудно было организовать специализированную медицинскую помощь, в частности, зубо врачебную. Трудность заключалась в том, что другие специалисты имели в прошлом подобие общественных организаций, каковыми являлись земские учреждения, зубные врачи ничего подобного не имели.

Было крайне недостаточное количество специалистов. Кроме того, для организации зубо врачебной помощи требовалось оборудование и инструментарий. В царское время ни то, ни другое в России почти не производилось, а импортировалось из Германии, Англии, Франции и других стран. Немалым препятствием в организации медицинской помощи был саботаж среди интеллигенции, в том числе и врачей.

Правительство принимало соответствующие меры по борьбе с саботажем. В Башкирии 17 октября 1919 года была проведена мобилизация медицинских работников на трудовой фронт через органы ЧК. Комиссию возглавлял М.С. Кедров. Таким образом, в тот период была сформирована группа зубных врачей для работы в первой советской зубо врачебной амбулатории в Уфе. Оборудование и инструментарий для амбулатории национализировали у частнопрактикующих врачей.

Организатором первой зубо врачебной амбулатории является зубной врач Л.С. Гольберг. Помещение для амбулатории было отведено в нацио-

нализированном доме Вайсермана на углу улиц Кирова и Ленина. Здесь стали работать зубные врачи А.Ф. Смирнова, М.С. Залескер, А.А. Шик. С первых дней опыт работы выявил необходимость организации и проведения дифференцированного приёма. Для осуществления этого организовали экстракционный кабинет на 1 кресло, лечебный — 3 кресла и кабинет для обслуживания детей — на 2 кресла.

В течение короткого времени амбулатория завоевала большую популярность среди населения Уфы, посещаемость больных быстро увеличивалась. Вскоре, чтобы более интенсивно использовать дефицитное оборудование и инструментарий, организовали вечерний приём, что значительно увеличило пропускную способность амбулатории.

Следует отметить, что уже в тот период создавалось мнение о необходимости организации зубоврачебных отделений в системе общемедицинских учреждений. И вскоре Губздрав вынес постановление о слиянии первой советской зубоврачебной амбулатории с вновь организуемой амбулаторией общего типа по улице Цюрупа, 40 (Чижовская амбулатория). Новое помещение позволило расширить существующие кабинеты и организовать первую в Башкирии зуботехническую лабораторию, которая также была оборудована в основном за счёт национализированного инструментария и материалов у частнопрактикующих специалистов. В амбулатории было организовано бесплатное зубопротезирование.

Первая советская зубоврачебная амбулатория явилась организующим центром и своего рода образцом зубоврачебного учреждения, по типу которого создавалась зубоврачебная сеть в кантонах. В 1920 году в системе Башкирского Наркомздрава было организовано 6 зубоврачебных кабинетов, где работали 22 зубных врача. Однако недород хлебов в 1921 году и холерная эпидемия поставили в крайне тяжелые условия советскую медицину в Башкирии. В 1921—1922 годах в республике голодало свыше 95% населения, умерло 97 500 человек. На почве недоедания стала развиваться цинга, сыпной и возвратный тиф. Так, в Стерлитамакском кантоне в январе

1921 года было зарегистрировано 728 случаев заболевания цингой, а уже в феврале — 4964 случая. Всего в республике болели цингой 16 774 человека (Г.Г. Куватов, 1923; Э.Ф. Ваннах, М.С. Кац, 1963; Н.А. Шерстенников, 1958).

Несмотря на тяжелейшую обстановку в стране и, в частности, в республике, сеть медицинских лечебно-профилактических учреждений, в том числе и стоматологических, продолжала развиваться и совершенствоваться. В 1921 году была открыта зубо врачебная амбулатория в Стерлитамаке в благоустроенном помещении. В ней был организован детский приём. В 1921 году, например, почти ежемесячно поликлинику посещало 700 взрослых больных и около 70 детей. Надо сказать, что Стерлитамакская поликлиника оказывала помощь и другим кантонам. Так один из зубо врачебных кабинетов города был в порядке помощи переведён в Ток-Чуранский кантон. Много усилий вложила в организацию зубо врачебного дела старейший врач М.Ш. Махмудова, проработавшая в Стерлитамаке с перерывами с 1919 по 1966 год. Ею был организован первый зубо врачебный кабинет в 1919 году (ул. Садовая, 20). Более 40 лет занимался зубо врачеванием в Стерлитамаке Иван Степанович Федотов, по образованию фельдшер. Он начал работать еще в земской больнице.

Сеть зубо врачебных учреждений в республике быстро росла. Были организованы зубо врачебные кабинеты в г. Белебее, где в органах здравоохранения стали работать опытные зубные врачи (Маркузин и Гиницианский), а с 1924 года Н.Ф. Берг и Осенина-Анисимова. Двум последним для работы были выделены тогда 2 кабинета. Н.Ф. Берг в основном принимала больных из сельской местности, а Осенина-Анисимова — городских. В то время впервые в Белебее Н.Ф. Берг начала проводить плановую санацию полости рта школьников. Осмотр и санация начинались с учащихся первого класса. После досмотра дети вызывались для санации в зубо врачебный кабинет.

В Белорецке до революции и в первые годы Советской власти рабо-

тал зубным врачом иностранец Гертман. Несколько позднее работали зубные врачи Кузнецова и Яковлева.

Таким образом, в 1924 году в Башкирской АССР функционировало уже 12 зубоврачебных кабинетов (не считая кабинетов при психиатрической больнице и исправдоме), из них 9 — в городах и только 3 кабинета в сельской местности. В этом же году по решению Губздрава в г. Уфе открыли центральную зубоврачебную поликлинику, где работало 5 зубных врачей. Обслуживали они в основном застрахованных граждан и их семьи. Была открыта школьная зубная амбулатория на 2 кресла, к ней прикрепили детей детдомов и трудовых школ Уфы в возрасте от 6 до 14 лет.

В 1928 году уже во всех городах функционировали зубоврачебные кабинеты и стало проводиться зубопротезирование. В 1929 году впервые при центральной зубоврачебной поликлинике открылся рентгеновский кабинет, что позволило более квалифицированно проводить обследование и лечение больных. В 1937 году экстракционный кабинет переименовали в хирургический, где стали производить все стоматологические операции амбулаторного типа, тогда как раньше больные выезжали на лечение в столичные города.

С 1935 года центральная зубоврачебная поликлиника стала учебной базой для студентов зубоврачебной школы, организованной в Уфе в 1934 году. К этому времени в поликлинике имелись лечебный кабинет с 6 креслами, хирургический — на 2 кресла, зубопротезный — с 4 креслами и зуботехническая лаборатория, где работало 7 зубных техников. Таким образом, в Уфе постепенно увеличивалось количество специалистов стоматологического профиля, открывались зубоврачебные кабинеты при поликлиниках.

В годы Великой Отечественной войны в Уфе работали госпитали для лечения раненых в челюстно-лицевую область. Ведущим хирургом являлся Л.С. Гольберг. Это один из старейших врачей и организаторов стоматологической службы в республике. В 1919 году Л.С. Гольдберг окончил

Варшавскую зубоврачебную школу. В том же году приехал в Уфу и работал в Центральной зубоврачебной поликлинике по 1937 год. В 1937 году закончил Башкирский медицинский институт. С 1941 по 1947 год работал начальником челюстно-лицевого отделения в госпитале. В 1948 году Л.С. Гольдбергом успешно защищена кандидатская диссертация на тему «Хирургическое лечение девиаций и дефектов ротового отверстия огнестрельного происхождения». В основу диссертации легли клинические наблюдения во время работы в госпиталях, где он прооперировал 570 раненых бойцов с повреждением этой области. Л.С. Гольдбергом предложена классификация девиаций, составленная с учётом локализации дефекта и заинтересованности окологлазничных органов и тканей, а также разработана методика операции при тотальных дефектах губ с применением Филатовского стебля, распластанного по длине. В послеоперационном периоде им стали применяться аппликации парафина, массаж и мимическая гимнастика. За большие заслуги в развитии стоматологической службы в республике в 1945 году Л.С. Гольдбергу было присвоено звание заслуженного врача БАССР. С 1939 по 1953 год Л.С. Гольдберг вёл курс стоматологии и челюстно-лицевой хирургии в Башкирском медицинском институте. В 1950 году ему присвоено звание доцента.

В Башкирии в период с 1946 по 1957 год проведена реорганизация всех районных и городских больниц с общемедицинского профиля на специализированный. Особенно углубилась организация специализированной медицинской помощи в Уфе. Республиканские и городские больницы, являющиеся клиническими базами медицинского института, оказались в состоянии расширить и углубить медицинскую активность, превратиться в базовые учреждения для подготовки врачей по 17-18 специальностям и стать организационно-методическими центрами для городов и районов республики (Н.А. Шерстенников, 1957). В 1948 году Первая городская советская больница по решению Совета Министров БАССР и Министерства здравоохранения РСФСР реорганизована в Республиканскую специализи-

рованную клиническую больницу, которая к 1956 году становится многопрофильной больницей и базой 8 кафедр Башкирского медицинского института (Р.М. Каплан, 1964).

На базе кафедры госпитальной хирургии организовали стационар для челюстно-лицевых больных, которых вёл доцент Л.С. Гольдберг, а с 1953 года — доцент П.Ф. Евстифеев.

В 1956—1961 годы в Уфе открыты еще 2 стационара для челюстно-лицевых больных. А в городах Стерлитамаке, Октябрьском, Кумертау, Белорецке и других для таких больных были выделены койки.

2 ноября 1956 года в Уфе организован Башкирский филиал Всесоюзного научного общества стоматологов. Правление избрали из семи человек, куда вошли стоматологи Е.М. Касьянова, П.Ф. Евстифеев, Н.А. Шинбирёв, В.Ф. Татаринов и зубные врачи Б.Д. Козлинер, О.К. Махиня, Н.С. Шарапова. Заседания общества проводились почти ежемесячно. Так, например, в 1957 году провели 11 заседаний, на которых заслушано 18 докладов на актуальные темы по теории и практике стоматологической службы. В настоящее время членов общества насчитывается около 100 человек.

В связи с тем, что Башкирия становилась крупным экономическим центром по добыче и переработке нефти, добыче угля, производству машин, химической и лесной промышленности, началось бурное развитие медицинских учреждений, в том числе и расширение сети стоматологических поликлиник и кабинетов. В 1935 году открылся первый зубоучебный кабинет в г.Ишимбае, где работали зубные врачи К. Фалолеева, а затем Т. Миронова. До открытия этого кабинета больные ездили лечиться в г. Стерлитамак.

В 1948—1949 годы появился новый город нефтехимиков Салават. В 1951 году в этом городе открылась Первая объединённая больница со стационаром на 25 коек. При этой больнице стоматологом Е.А. Девяткиной в 1951 году был организован зубоучебный кабинет. Город начал быстро

расти и в 1954 Году здесь работало 8 зубных врачей, один стоматолог и врач протезист П.П. Кучер, который организовал зубопротезную лабораторию. Зубоврачебный кабинет в то время находился в барачном помещении. В 1963 году в Салавате построена самостоятельная типовая стоматологическая поликлиника II категории, которую длительно возглавляла стоматолог Е.А. Девяткина.

В 1941 года открылся первый зубоврачебный кабинет в г. Октябрьском. Кабинет размещался в жилом бараке, где работала зубной врач Н.Д. Майборода и вела смешанный приём. Это был единственный в то время кабинет на весь Туймазинский район. В 1949 году для кабинета выделено новое помещение, в котором размещены 2 кресла. Работали врачи Н.П. Калинина, В.П. Мазанова и Е.А. Скритник. С 1951 года организован дифференцированный приём и выделен детский приём. В 1956 году построено типовое здание поликлиники, в котором было выделено помещение для зубного кабинета. Длительное время детский приём здесь вели зубные врачи А.С. Гумилевская, З.А. Масальская, Р.К. Бивзенко. В настоящее время при детской поликлинике работают 7 зубных врачей. Для плановой санации детей организованы три передвижных кабинета для обслуживания школ и детских садов. В практику введён бригадный метод санации полости рта. В городе созданы зубоврачебные кабинеты и на некоторых промышленных предприятиях. Активно проводится санация детей школьного возраста, школьников, больных ревматизмом, беременных женщин, подростков и призывников.

В 1965 году в городе организован ортодонтический кабинет, где оказывается помощь детям с врождёнными деформациями прикуса. А также проводится ортопедическая подготовка больных перед протезированием (Г.Е. Теклев).

В г. Туймазы развернуто 10 стоматологических кабинетов. В 1967 году открыто новое стоматологическое отделение в светлом, хорошем помещении. Отделение оборудовано всем необходимым, организован диф-

ференцированный приём, проводится санация полости рта школьников и рабочих промышленных предприятий.

В г. Сибай первый зубоучебный кабинет открыт в 1948 году, где начал работать выпускник Уфимской зубоучебной школы В.Г. Смирнов. В настоящее время в Сибее открыто 6 кабинетов.

Первый зубоучебный кабинет в г. Кумертау на одно кресло открылся в 1949 году. В 1957 году кабинет расширился и было выделено помещение на три зубоучебных кресла. В настоящее время в городе работают 17 врачей, из них 7 стоматологов.

В молодом городе нефтяников Нефтекамске первый зубоучебный кабинет организован в 1960 году, где работала зубной врач О.С. Потапенко. В 1964 году было организовано стоматологическое отделение. В поселке Николо-Березовке, который входит в черту г. Нефтекамска, впервые был открыт зубоучебный кабинет в 1937 году. С первого дня организации и до настоящего времени здесь работает зубной врач А.Ф. Шляева.

Дальнейшее развитие получила сеть стоматологических учреждений в старейших городах республики — Стерлитамаке, Белебее, Бирске, Белецке. Здесь открыты отделения и кабинеты на крупных промышленных предприятиях. Несколько медленнее развивалась стоматологическая помощь населению сельской местности. Например, в 1938 году в республике работало всего 80 зубных врачей и один стоматолог. Причем в местности — 23 человека, из них 19 зубных врачей работали при районных больницах. Только в шести райцентрах проводилось зубопротезирование, так как в республике всего насчитывалось 25 зубных техников. Кстати, первым стоматологом в Башкирии был Ширкин Леонид Агапович, который в настоящее время работает преподавателем в зубоучебной школе.

В 1948 году в Башкирской АССР трудилось уже 15 стоматологов и 110 зубных врачей, причем 43 из них работали в сельской местности. В 1951 году организована Республиканская стоматологическая поликлиника по ул. Тукаева, 48а. Абсолютное большинство зубных врачей и зубных техников,

работающих в Башкирии, являются выпускниками Уфимской зубоврачебной школы, которая за время своего существования выпустила около 3500 специалистов. Длительное время преподавателями специальных дисциплин в школе являлись врачи республиканской стоматологической поликлиники Е.М. Касьянова, А.Ш. Курамшина, А.А. Сатаева, О.К. Махиня, Н.С. Шарипова, В.И. Мамаева, зубной техник А.Т. Ломакин и др.

С увеличением количества специалистов и расширением стоматологических учреждений все большее значение стало придаваться плановой санации полости рта., особенно детскому населению. Так, с 1959 года были организованы детские стоматологические кабинеты при поликлиниках г.Уфы №1,2,4,7, а также в городах Стерлитамаке, Салавате, Ишимбае. Плановой санацией полости рта были охвачены учащиеся 102 школ. Из них 32 школы в г.Уфе, 10 — в Стерлитамаке, 8 — в Салавате, 6 — в Ишимбае, 9 — в Октябрьском, 8 — в Кумертау, 7 — в Благовещенске и т.д. В этот период начата санация рабочих промышленных предприятий, например, в г. Уфе на химическом, витаминном заводах, в Стерлитамаке — на крупных предприятиях. Правда, из-за недостатка кадров плановой санацией был охвачен незначительный контингент населения. Достаточно сказать, что в республике в то время насчитывалось около 5000 начальных, семилетних и средних школ, а санация проводилась только в 102 школах.

К 1961 году в городах и сельской местности были развернуты 192 зубоврачебных кабинета, в которых работало 57 стоматологов, 346 зубных врачей, 115 зубных техников. Из них в сельской местности работали 134 зубных врача и 54 техника.

В январе 1961 года была проведена первая республиканская научно-практическая конференция стоматологов и зубных врачей Башкирской АССР. С докладом о состоянии стоматологической помощи в республике и мерах по её улучшению выступила главный врач Республиканской стоматологической поликлиники Н.С. Шарапова. На конференции были заслушаны и обсуждены доклады по проведению плановой санации полости

рта, лечению и профилактике кариеса, лечению пульпитов, периодонтитов, воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области (Е.М. Касьянова, О.К. Махиня, Б.А. Сендерович, И.Н. Лапис, В.Ф. Татаринов, Н.А. Шинбирёв, Г.Л. Щедрин и др.). Обсуждены были также вопросы онкологии челюстно-лицевой области (доцент П.Ф. Евстифеев, М.З. Шагивалеев), лечение травм челюстно-лицевой области (В.Ф. Татаринов, Н.А. Шинбирёв). С докладами о роли стоматолога в диспансеризации и лечении заболеваний полости рта у больных ревматизмом и другими соматическими заболеваниями выступили главный терапевт Министерства здравоохранения БАССР Р.П. Клейман и главный педиатр А.Б. Гейлер. Обсуждались некоторые вопросы по ортопедической стоматологии (А.Ш. Курмашина). Участники конференции приняли активное участие при обсуждении докладов, ознакомились с постановкой работы в поликлиниках и челюстно-лицевых стационарах г. Уфы.

В ноябре 1961 года план мероприятий, направленных на улучшение стоматологической помощи в 1961—1965 годах, был рассмотрен в Совете Министров БАССР. Принято соответствующее постановление, где предусматривалось расширение сети стоматологических учреждений, укрепление материальной базы и улучшение организационных форм работы стоматологических учреждений.

В течение 1961—1965 годов Министерство здравоохранения БАССР при помощи партийно-советских органов проводило работу по выполнению мероприятий, предусмотренных этим постановлением. За этот период открыты 4 стоматологические поликлиники, 12 отделений, 40 стоматологических кабинетов в городах и 29 кабинетов в сельской местности. В целях улучшения стоматологической помощи населению Министерством здравоохранения БАССР приобретены 4 передвижные зубоврачебные амбулатории «Икарус-630». К сожалению, ряд мероприятий, предусмотренных в постановлении Совета Министров БАССР, не выполнен. В частности, до настоящего времени в Уфе и в республике нет единого стационара

для челюстно-лицевых больных. В Республиканской клинической больнице размещены лишь 10 коек. Столько же коек в 1961 году выделили в хирургическом отделении Первой городской больницы. Правда, в 1968 году стационар здесь расширен до 25 коек. В Республиканской клинической больнице с 1954 года хирургом-стоматологом работает В.Ф. Татаринов, который широко проводит операции по поводу врожденных пороков развития челюстно-лицевой области.

Им проводятся восстановительные операции после номы (прим. авт.: неомы), волчанки с использованием тканей филатовского стебля. Внедрена также аллопластика при деформациях челюстно-лицевой области с использованием пластмасс АКР-7, ЭГ-масс-12. Лечатся больные с огнестрельными ранениями лица.

В.Ф. Татаринов опубликовал методические письма по хирургической обработке ран челюстно-лицевой области, лечению переломов челюстей, по лечению больных с врождёнными пороками развития челюстно-лицевой области и др. (В.Ф. Татаринов, 1961-1967).

Активную хирургическую деятельность развил в челюстно-лицевом отделении при медсанчасти больницы №8 Н.А. Шинбирёв, занимавшийся в основном совершенствованием методики формирования и переноса филатовского стебля, а также пластики нёба и верхней губы. Н.А. Шинбирёвым в 1968 году под руководством завкафедрой госпитальной хирургии Башмединститута Н.Г. Гатауллина успешно защищена кандидатская диссертация на тему «Методика формирования, воспитания и переноса в дефект стебельчатого кожного лоскута В.П. Филатова» (Н.А. Шинбирёв, 1961-1967).

Работающий в Уфе доцент П.Ф. Евстифеев с 1953 по 1960 год занимался в основном лечением больных с воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области.

С 1961 года в Уфе работает челюстно-лицевой хирургом доцент Д.В. Воронцов, владеющий всеми видами восстановительных операций.

Особенно широко он занимается пластикой свободными кожными лоскутами и тканями филатовского стебля. Таким образом, хирургическая помощь челюстно-лицевым больным оказывается квалифицированными хирургами, но отсутствие единого стационара в Уфе значительно затрудняет работу.

Помощь с острыми заболеваниями и травмами челюстно-лицевой области в городах республики оказывается стоматологами, прошедшими стажировку в стационарах г. Уфы. Специализацию прошли стоматологи из Баймака, Белорецка, Нефтекамска, Белебея, Сибая и других городов республики. Для больных этой категории выделяются койки в хирургических стационарах. В октябре 1965 года состояние стоматологической помощи в республике обсуждено на расширенном медицинском Совете Министерства здравоохранения БАССР, куда были приглашены завгорздравотделами, главные врачи районов, главные врачи стоматологических поликлиник, заведующие кабинетами. С докладом выступил главный врач республиканской стоматологической поликлиники, главный стоматолог Министерства здравоохранения БАССР В.Ф. Татаринов, который был назначен на эту должность в апреле 1965 года. В основу доклада были взяты данные обследования стоматологической службы в 15 городах и 40 районах республики. Основное внимание было уделено вопросам плановой санации полости рта детскому населению, допризывникам, больным ревматизмом, беременным женщинам, рабочим промышленных предприятий, а также вопросам диспансеризации больных с парадонтозом, врождёнными пороками развития челюстно-лицевой области с заболеваниями слизистой полости рта. Работа эта проводилась еще недостаточно. Было отмечено, что еще сравнительно небольшой процент как детского, так и взрослого населения охвачен плановой санацией полости рта. Основная причина заключалась в том, что лечебные учреждения республики недостаточно были укомплектованы специалистами стоматологического профиля. В башкирской АССР в 1965 году проживало 3 700 000 человек. А работало всего 70

стоматологов и 475 зубных врачей. Таким образом, укомплектованность кадрами составила в городах 2,8 ед. на 10 000 населения (по нормативам 4), а в сельской местности 0,6 (по нормативам 1,8 ед.).

Неудовлетворительно обстояло дело с кадрами в сельской местности. Так, например, в Баймакском районе на 67 000 населения, в Илишевском районе на 48 000 населения не было ни одного зубного врача. В Федорском районе, Бураевском, Мишкинском, Салаватском и во многих других районах с населением 40-60 тысяч человек имелось по 1-2 зубных врача. Из 170 сельских участковых больниц в 105 не оказывалась зубо-врачебная помощь из-за отсутствия специалистов, причём в 23 участковых больниц имелись оборудованные кабинеты.

На совещании также было отмечено, что в ряде зубо-врачебных кабинетов имеет место низкая организация труда, недостаточная оснащённость оборудованием и инструментарием. В некоторых районах — Бижбулякском, Калтасинском, Кармаскалинском, Благовещенском и других — зубо-врачебные кабинеты размещаются в непригодных помещениях, где проводится приём больных одновременно несколькими специалистами. В ряде мест специалисты трудятся без вспомогательного персонала, что значительно затрудняет их работу, снижает производительность труда.

Не лучше обстояло дело с зубопротезированием. В 9 районах республики зубопротезная помощь не оказывалась из-за отсутствия специалистов. В 11 районах (Кигинском, Альшеевском, Бакалинском и др.) клинический приём вели зубные техники и сами же изготовляли протезы. Документация во многих местах оформлялась неправильно или вообще не велась. Во многих городах и районах стоматологи и зубные врачи большое количество времени тратили на пустые профилактические осмотры, не заканчивающиеся санацией полости рта. Например, в 1965 году всего было в республике осмотрено 402 977 человек, а санировано 238 358. Так, в г. Сибее осмотрено 5600 человек, а санировано 640, в Абзелиловском районе осмотрено 3430, санировано 452. Аналогичное соотношение осмотренных

к санированным отмечалось в Зианчуринском, Белокатайском, Аургазинском и других районах республики.

Помимо указанных недостатков в постановке стоматологической службы в республике, было также установлено, что при лечении зубов и слизистой полости рта имеет место многосеансовость, медленное внедрение новейших методов лечения физиотерапии.

Республиканская стоматологическая поликлиника не осуществляла постоянного контроля за работой стоматологических кабинетов, не являлась истинным организационно-методическим центром по улучшению медицинской помощи в республике.

Медицинский совет министерства здравоохранения БАССР, обсудив состояние стоматологической службы в республике, наметил план по устранению имеющихся недостатков. Прежде всего, учитывая большую нуждаемость в кадрах Совет Министров БАССР обратился с ходатайством в Министерство здравоохранения РСФСР об увеличении количества направляемых в республику стоматологов и зубных врачей и об организации стоматологического факультета при Башмединституте. С 1966 года в республику стали направлять молодых специалистов в 2-3 раза больше, чем в предыдущие годы, т.е. по 60-70 человек. Идея организации стоматологического факультета при Башкирском медицинском институте нашла поддержку во всех инстанциях, но из-за отсутствия необходимых условий осуществление её пока отложено на ближайшие годы.

В начале 1966 года вопрос о состоянии стоматологической помощи в г. Уфе и мерах улучшения был также обсуждён в горздраве г. Уфы. Основное внимание было уделено плановой санации полости рта детскому населению. Из 104 имеющихся средних школ и из 194 детских садов в 1964—1965 годах санацией полости рта были охвачены учащиеся только 30 школ и дети 70 садов. Санация детей-ревматиков, подростков, допризывников, беременных женщин, рабочих промышленных предприятий в основном проводилась по обращаемости.

Министерством здравоохранения БАССР было принято постановление и изданы соответствующие приказы по устранению имеющихся недостатков в организации работы стоматологических учреждений республики. При Республиканской стоматологической поликлинике был создан организационно-методический кабинет для осуществления планово-методической помощи стоматологическим учреждениям республики. С 1965 года во все города и в большинство районов республики ежегодно стали выезжать сотрудники Республиканской стоматологической поликлиники, проводить обследование работы отделений и кабинетов с последующим обсуждением совместно с руководством органов здравоохранения результатов проверки.

Оргметодкабинетом также были разосланы приказы Министерства здравоохранения БАССР по организации санации полости рта детского населения и допризывников, по упорядочению и ведению документации по зубопротезированию, выписки из приказов по расценкам оплаты труда зубных техников, прейскуранты цен на протезирование, инструкции по организации и устройству зубоврачебных кабинетов и зуботехнических лабораторий, методические указания и письма, полученные из Министерства здравоохранения РСФСР и СССР.

При Республиканской стоматологической поликлинике с 1965 года, а во 2-й стоматологической поликлинике г. Уфы с 1966 года организованы постоянно действующие курсы по повышению квалификации зубных врачей и зубных техников. Так, за период с 1965 по 1968 год прошли усовершенствование 180 человек. Помимо этого на специализацию и усовершенствование в центральные города было направлено 12 стоматологов, 18 зубных врачей и 5 зубных техников. Руководители отделений и кабинетов Республиканской стоматологической поликлиники с целью детального изучения постановки работы и обмена опытом ознакомились с деятельностью крупных стоматологических поликлиники городов Москвы, Ленинграда, Киева, Челябинска, Свердловска и др.

В Уфе для стоматологов и зубных техников был организован цикл занятий по челюстно-лицевой травматологии и шинированию. В 1966-1968 годы проведена аттестация стоматологов, зубных врачей и зубных техников. Высшая категория присвоена одному врачу, первая категория — 4 и 18 зубных врачей аттестованы по 1 категории.

Помимо этой работы оргметодкабинетом Республиканской стоматологической поликлиники ежегодно стал проводиться приём годовых отчётов от завгорздравотделами и главных врачей районов по состоянию стоматологической службы. Во всех случаях по отчёту составлялись справки с указанием положительных и отрицательных моментов в работе стоматологических учреждений и высылались для обсуждения и принятия соответствующих мер на местах. На основании годовых отчётов составляется сводный конъюнктурный обзор состояния стоматологической службы в республике. В оргметодкабинете заведена документация на все стоматологические учреждения, имеющиеся в городах и районах республики с указанием характеристики помещения, в котором размещается кабинет, обеспеченности оборудованием и инструментарием, количества стоматологов, зубных врачей и техников, их квалификации, стажа работы и так далее. На каждый город и район заведены папки, где хранятся все документы, имеющие отношение к стоматологической службе. Таким образом, стало возможным проследить динамику работы каждого стоматологического учреждения по всем количественным и качественным показателям, планировать выезды в города и районы, распределять дефицитное оборудование и инструментарий.

Республиканской стоматологической поликлиникой для оказания помощи сельскому населению посылаются в районы бригады врачей на передвижной зубоврачебной амбулатории «Икарус-630». Эти бригады ежегодно обслуживают 10-12 тысяч сельского населения. Однако следует сказать, что подобные передвижные зубоврачебные амбулатории типа «Икарус-630» не выгодны в экономическом отношении. К тому же в условиях бездорожья они могут выезжать только в летний период.

В Башкирии по примеру ряда стоматологических поликлиник городов Союза начато внедрение бригадного метода работы по проведению плановой санации полости рта в учебных заведениях и на промышленных предприятиях, где сейчас развернуто 40 стоматологических кабинетов. Так, стоматологическими поликлиниками №1 и 2 г. Уфы в 1966 году было создано 7 бригад в составе 2-3 врачей и 1-2 медицинских сестёр. За время работы было осмотрено 6557 человек и проведена санация 3706 рабочим из 5520 нуждающихся. Санация заканчивалась зубопротезированием.

С 1966 года в Уфе проводятся мероприятия по укрупнению стоматологических учреждений, так как мелкие кабинеты с малым количеством врачей имеют ограниченные возможности для приобретения современной аппаратуры. В них трудно организовать дифференцированный приём, внедрить бригадный метод обслуживания организованных контингентов населения, повысить качественные показатели, проводить диспансеризацию и т.д. В 1967 году в Уфе впервые организовано высокочастотное литье, дающее возможность широко внедрять бюгельное протезирование, индивидуальное литье. Укрупненные зуботехнические лаборатории газифицированы в них установлена надлежащая вентиляция, механизированы некоторые трудоемкие процессы изготовления протезов.

С 1966 года в Республиканской стоматологической поликлинике начато проведение ортодонтического лечения взрослых перед протезированием. Было установлено, что около 30% больных, поступающих на протезирование, нуждаются в ортодонтическом лечении. Вследствие физиологической стираемости зубов, атрофии костной ткани альвеолярных отростков и других причин происходят изменения в прикусе, т.е. его снижение. Протезирование таких больных стало производиться в два этапа. 1 этап — исправление прикуса путем предварительной перестройки мышечной рефлексов на растяжение (метод предварительного разобщения по И.С. Рубинову). 2 этап — проводится рациональное протезирование (Л.А. Ныркова, 1967).

В последние годы в стоматологических поликлиниках и отделениях шире стали применяться современные методы лечения как односеансовый метод лечения пульпита с помощью диатермокоагуляции, реплантации зубов. Имеющееся количество специалистов в республике позволило улучшить количественные и качественные показатели работы стоматологических учреждений. Стационарная помощь челюстно-лицевым больным осуществлялась в 1968 году в основном в г. Уфе, где развернуто 35 коек и в г. Салавате (10 коек). В этих стационарах проводятся все виды пластических операций челюстно-лицевой области (доцент Д.В. Воронцов, В.Ф. Татринов, Н.А. Шинбирёв). В остальных городах республики койки выделяются в хирургических отделениях, где проводится лечение островоспалительных заболеваний, травм челюстно-лицевой области и новообразований (кисты, эпюлиды и т.д.). Так, в 1968 году было госпитализировано и проведено хирургическое лечение 1070 больным. Всего в республике за 1968 год к специалистам стоматологического профиля было сделано 2 350 000 посещений. Из них свыше миллиона составили первичные больные.

В республике стало придаваться большое значение организации стоматологической службы в сельской местности. Имеется опыт организации этой службы в Дмитриевском врачебном участке Уфимского района. На этом участке проживает 14 000 человек, радиус участка 14-18 километров. В участковой больнице работают 3 зубных врача. Каждый из них имеет прикрепленный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), куда выезжают по графику два раза в неделю. Таким образом, ежедневно два зубных врача выезжают в прикрепленные пункты на больничном транспорте. Все фельдшерско-акушерские пункты имеют кресла, бормашины и необходимые инструменты. Таким образом, выезжающий врач не обременяет себя перевозкой зубоврачебного кабинета. Подобная организация стоматологической службы позволяет приблизить помощь населению, проводить санационно-профилактическую работу. В районной же больнице должно быть стоматологическое отделение с дифференцированным приемом. Такой

принцип организации вероятного следует считать наиболее целесообразным. Он может быть рекомендован на всех врачебных участках, но осуществить это можно будет только при достаточном количестве кадров, оборудования и инструментов.

В декабре 1967 года состоялась вторая Республиканская конференция стоматологов и зубных врачей. По вопросу состояния и улучшения стоматологической службы в республике выступил главный стоматолог Минздрава БАССР В.Ф. Татаринов, о состоянии этого вида помощи в г. Уфе сделала доклад главный стоматолог г. Уфы Е.М. Касьянова.

В докладах основное внимание было уделено организации плановой санации полости рта организованным контингентам населения, перспективах развития стоматологической службы в республике. О проведении санации полости рта детскому населению, рабочим промышленных предприятий и об организации диспансеризации больных с врождёнными пороками развития челюстно-лицевой области было сказано в докладах Л.М. Гибадуллиной, Г.Г. Байковой, Б.Я. Буратовской (Свердловск), С.З. Кантаровского (Волгоград). По вопросам распространенности кариеса в республике, а также лечения пульпитов, диспансеризации и комплексного лечения пародонтоза выступили Ф.Г. Гасимов (Казань), А.А. Сатаева, О.К. Махиня, Л.Н. Горбачева и др. Доцент Д.В. Воронцов, Н.А. Шинбирёв, В.А. Киреева остановились на вопросах лечения травм челюстно-лицевой области реплантации зубов. Вопросам зубопротезирования, ортодонтии были посвящены доклады З.П. Липсман (Москва), Л.М. Демнер (Казань), Б.Д. Козлинера, Л.А. Нырковой. Труды второй республиканской конференции стоматологов и зубных врачей республики изданы в виде монографии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Краткий обзор истории зубоврачевания и стоматологии за тысячетлетний период ее развития позволил выделить некоторые узловые моменты в становлении этого раздела медицины в России.

Возникновение научной медицины относится к XVIII веку. Реформы Петра I в области медицины дали импульс развитию научной и практической медицины, в том числе и зубоврачевания. Звание «зубной врач» появилось в период открытия постоянных военных госпиталей, госпитальных школ, преподавание в которых велось у постели больного, а хирургия, в недрах которой зарождалось зубоврачевание, развивалась на знании анатомии. Открытие Академии наук, университета позволило готовить отечественные научные кадры.

XIX век — это век развития хирургии, который был озарен гением Н.И. Пирогова, а также трудами И.В. Буяльского, П.А. Загорского и др.

Выдающиеся хирурги этого времени проводили различные операции, часть из которых относились к челюстно-лицевой области. Проведению сложных операций (односторонняя резекция верхней челюсти) способствовало открытие наркоза, изобретение хирургических инструментов и др.

Зубоврачеванием в этот период занимались цирюльники, зубные врачи, лекари. Великие естественнонаучные открытия в физике, химии, механике, оптике и др. явились основой развития медицины второй половины XIX века. Разработка новых методов обезболивания, открытие асептики и антисептики позволили отечественным хирургам проводить операции, каких в мире насчитывалось единицы. Операция по поводу двухсторонней резекции верхней челюсти, проведенная Н.В. Склифосовским, была доступна специалистам только такого уровня.

Благодаря усилиям передовых врачей, зубоврачевание, в конце XIX века, выделилось в самостоятельный раздел медицины. В России были открыты первые частные зубоврачебные школы, выпускники которых полу-

чали диплом зубного врача. Кроме дипломированных зубных врачей, зубоврачеванием во второй половине XIX века занимались дантисты, цирюльники, осваивающие специальность путем ученичества, а также лекари, выпускники университетов и медико-хирургической академии.

Особенностью второй половины XIX века было образование медицинских научных обществ, в том числе и зубоврачебных (одонтологических), созыв съездов, на которых поднимались насущные вопросы зубоврачевания: подготовка зубоврачебных кадров, проблема высшего одонтологического образования, решение научных проблем зубоврачебной науки, издание периодических одонтологических журналов. На повестке дня остро стоял вопрос о высшем одонтологическом образовании, инициаторами которого были: Н.В. Склифосовский, А.К. Лимберг, И.М. Коварский и др.

Первым профессором, посвятившим свои труды развитию детского зубоврачевания, профилактике и лечению одного из самых распространенных заболеваний зубов, кариесу, был А.К. Лимберг.

Конец XIX века ознаменован открытием первых доцентур и кафедр по одонтологии (зубоврачеванию), что имело большое значение для развития одонтологической науки. Открытие зуботехнических школ не состоялось.

Добиться разрешения правительства на высшее одонтологическое образование в тот период не удалось. XX век начался с войн, революций, голода и разрухи в стране, что осложняло становление и развитие здравоохранения в молодой советской республике. Народный комиссариат здравоохранения, во главе с Н.А. Семашко и руководителем зубоврачебной подсекции П.Г. Дауге, после революции 1917 года, приложил немало усилий для создания государственного зубоврачевания в стране. Основными задачами зубоврачевания на тот период были: организация массовой зубоврачебной и зубопротезной помощи, подготовка кадров, решение научных проблем зубоврачевания, а потом и стоматологии.

Главными из них были проблемы изучения этиологии и патогенеза

основных стоматологических заболеваний: кариеса и пародонтоза. Профессорами Д.А. Энтиным, И.Г. Лукомским, А.И. Евдокимовым, А.Э. Шарпенаном, Е.Е. Платоновым были сформулированы теории возникновения этих заболеваний.

А.И. Евдокимов, на основе исследований своих и учеников, сформулировал сосудистую теорию этиологии и патогенеза пародонтоза.

Е.Е. Платонов предложил свою концепцию развития альвеолярной пиореи (пародонтоза), обнаружив первичные изменения в нервных волокнах пародонта. Имели место и другие теории возникновения пародонтоза.

Отечественные и зарубежные ученые активно разрабатывали эти проблемы, понимая социальную значимость этих заболеваний.

Большое значение для изучения пародонтоза имел VI Всесоюзный съезд стоматологов (1975), который подвел итоги работы многих научно-исследовательских коллективов страны по проблеме «Пародонтоз». На этом съезде были обсуждены вопросы терминологии и классификации, этиологии и патогенеза, диагностики, профилактики и лечения болезней пародонта, что повлияло на дальнейшее изучение этой сложной и важной проблемы, как в нашей стране, так и в других странах.

Значимой проблемой, была и остается проблема кариеса, которой занимались: И.Г. Лукомский, Д.А. Энтин, А.Э. Шарпенан и др.

Ученые — стоматологи — разработали и внедрили в практику научные исследования по экспериментальному моделированию кариеса зубов (С.А. Никитин, М.Г. Бугаева, И.А. Бегельман, А.Э. Шарпенан и др.); пульпитов (О.В. Петрова, Е.И. Гаврилов, В.В. Паникаровский, А.С. Григорян и др.); периодонтитов и одонтогенных воспалительных процессов (Г.А. Васильев, В.В. Паникаровский, А.А. Прохончуков, А.С. Григорян, Н.А. Жижина, В.С. Иванов и др.); пародонтоза (А.А. Прохончуков, Н.А. Жижина, В.В. Паникаровский, В.Ф. Кускова и др.).

В результате многолетних экспериментальных, клинических и эпидемиологических исследований, в 1970 году была разработана рабочая

концепция патогенеза кариеса зубов, которая наиболее полно, с учетом достижений в области стоматологии и медико-биологических наук, отражает механизм развития этого заболевания, с учетом роли местных и общих нарушений в организме, приводящих к развитию кариеса.

Изучением заболеваний слизистой оболочки полости рта занимались: Е.М. Гофунг, Д.А. Энтин, И.Г. Лукомский, И.М. Старобинский, Я.С. Пеккер, Н.И. Агапов, Е.Е. Платонов, Б.М. Пашков, Н.Д. Шеклаков, М.И. Грошиков, В.К. Патрикеев, Б.Г. Стоянов, А.Л. Машкиллейсон и др. А.И. Рыбаков разработал модели стоматитов при заболеваниях внутренних органов, что позволило предложить эффективные методы лечения.

В СССР, впервые в мире, была создана научно обоснованная система медицинского наблюдения за каждым ребенком, что было реализовано и в стоматологии детского возраста. Были открыты первые в стране кафедры стоматологии детского возраста.

Стоматологическую помощь оказывали миллионам детей с момента их рождения и до совершеннолетия в специализированных детских стоматологических поликлиниках, кабинетах, созданных в школах и дошкольных учреждениях.

Ортодонтическая помощь, как взрослым, так и детям, претерпела качественные изменения. Диагностика, лечение, профилактика зубочелюстных аномалий достигли высокого уровня.

За годы советской власти значительно возрос научный уровень ортопедической стоматологии, была улучшена ее техническая оснащенность. Основными вопросами были: организация труда и повышение производительности работы врачей и зубных техников, централизация и механизация зуботехнических лабораторий, совершенствование экономических показателей, что создало предпосылки для массового изготовления самых современных и эффективных видов протезов. Благодаря разработке новых сплавов металлов, по своим свойствам не уступающих золоту, страна получила значительную экономию золота. Изготовление фарфоровых коронок,

цельнолитых металлических коронок облицованных фарфором — металлокерамикой, ситаллов, цельнолитых мостовидных протезов облицованных фарфором, цельнолитых съемных конструкций — бюгельных протезов — это шаг в улучшении эстетических свойств различных протезов.

Разработка новых материалов позволила улучшить и качество ортопедической помощи. Отечественные ученые-стоматологи принимали и принимают активное участие в обсуждении актуальных проблем стоматологии на международных симпозиумах, конгрессах и съездах.

Учебники и монографии отечественных стоматологов переведены на иностранные языки, что говорит о признании научных трудов наших ученых. А.И. Евдокимов, Л.В. Ильина-Маркосян, В.Ю. Курляндский, А.А. Лимберг, В.Ф. Рудько, А.И. Рыбаков и др. были почетными членами стоматологических обществ и ассоциаций многих стран мира (США, Франция, Финляндия, ГДР, ПНР, ВНР, НРБ и др.).

Советские стоматологи принимали самое активное участие в работе Всемирной организации здравоохранения: профессора В.Ф. Рудько, В.М. Безруков, П.А. Леус. Постоянным экспертом ВОЗ по разделу «Стоматология» был директор ЦНИИС, академик АМН СССР А.И. Рыбаков, профессор А.И. Дойников, консультантом Восточно-азиатского регионального бюро ВОЗ была заведующая кафедрой стоматологии детского возраста ЦОЛИУ врачей профессор Т.Ф. Виноградова.

Комплексная система профилактики стоматологических заболеваний, разработанная в Советском Союзе, была признана оптимальной моделью для использования во многих странах. В настоящее время комплексные мероприятия по профилактике среди населения разрабатываются совместно с органами управления.

Огромная армия стоматологов решает многие вопросы по улучшению качества стоматологической помощи населению страны, по подготовке кадров, по разработке научных проблем стоматологии.

С наступлением эры рыночных отношений в России, распада СССР,

в организации, в управлении и структуре стоматологической службы произошли серьезные изменения. В здравоохранение была введена система платных услуг. Реальное управление здравоохранением, в том числе и финансирование, переместилось в регионы. Создание системы обязательного медицинского страхования в России распространилась и на стоматологию.

В настоящее время значительное развитие получила отечественная промышленность, выпускающая стоматологическое оборудование и материалы хорошего качества. Большую роль в развитии стоматологии сыграло создание в 1993 году Стоматологической ассоциации России, которая во многом способствует активному реформированию стоматологии. С 1995 года ежегодно проводятся российские съезды СтАР, конференции, выставки.

В последние годы расширена стоматологическая печать. Кроме классического журнала «Стоматология» (1922), стали издаваться новые журналы «Новое в стоматологии» (Москва), «Пародонтология» (С.-Петербург), «Челюстно-лицевая хирургия» (Новосибирск), «Клиническая стоматология» (Москва), «Стоматология детского возраста и профилактика», которые делятся новой информацией в науке, способствуют объединению стоматологов для решения профессиональных проблем.

Значительное количество научных коллективов, которые с успехом решают как научные, так и организационные проблемы стоматологии (С.-Петербург, Москва, Тверь, Иркутск, Чита и др.), заняли передовые позиции в стоматологической науке. Московский государственный медико-стоматологический университет является головным институтом, разрабатывающим научные проблемы стоматологии, кузницей высококвалифицированных специалистов.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:

1. Когда образовалась Киевская Русь?
2. Кто занимался врачеванием на Киевской Руси?
3. В чём разница лечцов от лекарей?
4. Кто написал трактат по медицине «Мази госпожи Зои-царицы»?
5. Какие народные средства применялись для лечения зубной боли?
6. Что такое Аптекарский приказ (1620)?
7. Кто входил в штат Аптекарского приказа?
8. Кто оказывал медицинскую помощь царской семье?
9. В каком веке появились сведения о челюстно-лицевых ранениях военного времени?
10. Какое было проявление цинги (ротовая полость, зубы) в царской армии и каковы методы её профилактики?
11. Кого выпускала Лекарская школа, открытая в 1654 году?
12. Какие навыками медицинской помощи обладали: народные врачеватели (мастера): зелейники, травники, рудометы (кровопуски), зубоволоки, костоправы, камнесечцы, повивальные бабки, мастера очных, кильных дел?
13. Когда была создана школа И.М. Коварского?
14. В каком году был создан медико-санитарный отдел — первая организация по управлению здравоохранением в Советской республике?
15. В каком году учреждён Народный комиссариат здравоохранения РСФСР?
16. Кто возглавил зубоврачебную подсекцию в Народном комиссариате здравоохранения РСФСР?
17. В каком году было опубликовано «Положение о национализации зубоврачебной помощи в Советской республике»?
18. Кто руководил стоматологической помощью в Красной Армии в годы Великой Отечественной войны?
19. В каком году книга А.А. Лимберга «Математические основы местной пластики на поверхности человеческого тела» была удостоена Сталинской премии (Государственной премии)?
20. Какие виды оперативной помощи оказывали в эвакогоспиталях при огнестрельных ранениях?

21. В каком был издан Приказ министра здравоохранения СССР N 549 «Об улучшении стоматологической помощи населению»?

22. В каком году было издано Постановление ЦК КПСС и Совет Министров СССР N 517 «О мерах по дальнейшему улучшению здравоохранения и развитию медицинской науки в стране»?

23. В каком году было издано Постановление ЦК КПСС и Совет Министров СССР N 1166 «О мерах по дальнейшему улучшению стоматологической помощи населению»?

24. В каком году был издан Приказ МЗ СССР «О мерах по дальнейшему улучшению стоматологической помощи населению»?

25. В каком году был издан Приказ МЗиМП РФ «Об организации стоматологических учреждений в новых экономических условиях хозяйствования»?

26. В каком году издан декрет Народного комиссариата здравоохранения РСФСР и Народного комиссариата просвещения РСФСР о реформе зубоврачебного образования?

27. В каком году создан Государственный институт зубоврачевания (ГИЗ)? В каком году ГИЗ переименован в Государственный институт стоматологии и одонтологии (ГИСО)? В каком году ГИСО переименован в Государственный научно-исследовательский институт стоматологии и одонтологии (ГНИИСО)?

28. В каком году был организован Московский стоматологический институт (МСИ) на базе ГНИИСО?

29. В каком году был организован Центральный научно-исследовательский институт стоматологии (ЦНИИС)?

30. Какие основные труды А.Э. Рауэра — одного из основоположников челюстно-лицевой хирургии советского периода?

31. Сколько дантистов было указано в «Российском медицинском списке»?

32. Кто первая женщина среди дантистов?

33. Когда появилось первое упоминание о «зубном лекаре» и в каком году?

34. Кем могла оказываться зубоврачебная помощь в начале XIX века?

35. Какие три группы медицинских званий были для специалистов были известны согласно «Правилам врачей, фармацевтов, ветеринаров, дантистов и повивальных бабок», утвержденным в 1845 году?
36. Кто оказывал зубоврачебную помощь?
37. Значение для медицины открытия С.-Петербургской Медико-хирургической академии и Московского университета?
38. Какой вклад в развитие хирургии и зубоврачевания внесли П.А. Загорский, И.В. Буяльский, Х.Х. Саломон, П.А. Наранович, Н.И. Пирогов?
39. Какие вопросы зубоврачевания освещены в «Руководство к преподаванию хирургии» И.Ф. Буша?
40. Какие вопросы зубоврачевания освещены в «Анатомико-хирургических таблицах» И.В. Буяльского?
41. Какие челюстно-лицевые операции проводил Н.И. Пирогов?
42. Какие инструменты для челюстно-лицевых операций и зубоврачебного инструментария предложил Н.И. Пирогов?
43. Какие лекции по зубоврачеванию читал Н.И. Пирогов?
44. Чему посвящены основные главы в книге «Дентистика» А.М. Соболева, изданной в 1829 году?
45. Какие процедуры и мероприятия необходимо сделать при расшатанности зубов по А.М. Соболеву?
46. В каком году была издана книга «С.-Петербургский зубной врач», написанная зубным врачом Б.С. Вагенгеймом?
47. В каком году и где открыл Ф.И. Важинский первую в России частную зубоврачебную школу?
48. В каком году и кем была открыта Первая зубоврачебная школа в Москве?
49. В каком году был опубликован учебник И.И. Хрущова (1850-1916) «Полный зубоврачебный курс»?
50. Назовите известные работы академика П.П. Заблоцкого-Десятовского?
51. Какие новые операции и открытия совершил в стоматологии Н.В. Склифосовский?
52. Значение трудов А.К. Лимберга для одонтологии в России?
53. В какие годы состоялись I, II одонтологические съезды в России?
54. Какие основные положения учебной программы по одонтологии Н.Н. Знаменского?

55. Какие основные достижения в одонтологии Г.И. Вильги?
56. В каком году и где состоялся I съезд русских дантистов?
57. В чём самобытность народной медицины башкир?
58. Какие особенности эмпирического врачевания башкир?
59. Преставления башкирами о сущности болезни?
60. Какие принципы лечения и ухода за больными были у башкир?
61. Кто занимался врачеванием у башкир?
62. Какой арсенал лекарственных средств был в народной медицине башкир?
63. Какие целебные растения, применялись в народной медицине башкир?
64. Какие средства животного происхождения применялись в народной медицине башкир?
65. Какие минералы и вещества химической природы, использовались в народной медицине башкир?
66. Лечение природно-климатическими факторами в народной медицине башкир?
67. Характерные черты медицины дореволюционного Башкортостана?
68. Когда и где была создана Губернская земская больница?
69. Как развивалась земская медицина в дореволюционном Башкортостане?
70. Особенности начального периода развития земской медицины в Башкортостане?
71. Когда было открыто первое приказное медицинское учреждение г.Уфы?
72. Роль Уфимского губернского земства в организации типографии?
73. Каково влияние рабочего и социал-демократического движения на общество врачей Уфимской губернии?
74. Какая была врачебная деятельность в Уфе И.М. Любимова, будущего ректор Казанского университета?
75. Какая была роль «Башкирпомощи» в оказании медицинской помощи населению Башкортостана?
76. Какой вклад Ш.А. Худайбердина в становление и развитие Башкирской АССР?
77. Какой вклад Б.А. Шафеева одного из руководителей Башкирской АССР?

78. Какие были основные этапы жизнедеятельности первого наркома здравоохранения Башкирской АССР Г.Г. Куватова?
79. Какое было здравоохранение «Малой Башкирии»?
80. Какие были основные этапы жизнедеятельности наркома здравоохранения Башкирской АССР С.З. Лукманова в годы Великой Отечественной войны?
81. В каких городах были развернуты эвакуогоспитали на территории Башкирской АССР в годы Великой Отечественной войны и какие новые способы и методы использовались в лечении раненых и больных солдат и офицеров?
82. Каковы были условия быта у кочевого башкирского народа?
83. Как описывает академик И.И. Лепехин действия Шайтана Курязи (чертовидца) при изгнании болезни у башкир?
84. Какие три причины всех болезней считаются у башкир?
85. Какие особенности зубов у башкир описывает Д.П. Никольский в своей диссертации «Башкиры»?
86. Когда была открыта первая больница в Уфе?
87. Кто был первым дантистом в Уфе, открывший первый кабинет на улице Большая Казанская, 4?
88. Сколько в Уфе работало частнопрактикующих врачей в 1913 году?
89. В каком году был организован Народный комиссариат здравоохранения Башкирской АССР?
90. Какие основные вехи в биографии Л.С.Гольдберга?
91. В каком году в Уфе был организован Башкирский филиал Всероссийского научного общества стоматологов?
92. В каком году был организован ортодонтический кабинет в Уфе?
93. Какое значение Уфимской зубоврачебной школы было для пополнения кадров в Башкирской АССР?
94. В чём заключалась особенность применения филатовского стебля по В.Ф.Татинову при расщелинах неба?
95. Как оказывалась стоматологическая помощь сельскому населению в Башкирской АССР?
96. Сколько ежегодно сельского населения обслуживали передвижные зубоврачебные амбулатории «Икарус-630»?

97. С какого года в Республиканской стоматологической поликлинике начато проведение ортодонтического лечения взрослых перед протезированием?

98. В каком году состоялась вторая Республиканская конференция стоматологов и зубных врачей Башкирской АССР?

99. Кто является главным стоматологом в Республике Башкортостан в XXI в.

100. В каком году в БГМУ был открыт НИИ стоматологии?

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

1. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ БАШКИР (СДЕЛАТЬ СООТВЕТСТВИЕ).

- | | |
|--|---------------------|
| 1) лекарственные растения | А) шиповник |
| 2) лекарственные средства животного происхождения | Б) мёд |
| 3) Лекарственные средства минерального происхождения | В) серные квасцы |
| 4) лекарственные средства пчелиного происхождения | Г) кумыс |
| | Д) душица |
| | Е) зверобой |
| | Ж) прополис |
| | З) медный купорос |
| | И) маточное молочко |
| | К) корот |
| | Л) кальцит |
| | М) топлёное молоко |
| | Н) нефть |

2. В КАКОМ ГОДУ НАЧАЛАСЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИКАЗА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРИЗРЕНИЯ В Г. УФЕ:

- 1) 1677 году
- 2) 1787 году
- 3) 1907 году

3. ПЕРВЫЕ ВРАЧИ УФИМСКОЙ ГУБЕРНИИ:

- 1) Быстринский
- 2) Онуфриев
- 3) Герольд
- 4) верно все

4. ГОД ОТКРЫТИЯ ПЕРВОЙ БОЛЬНИЦЫ В Г.УФЕ:

- 1) 1890 год
- 2) 1790 год
- 3) 1690 год
- 4) 1990 год

5. ПЕРВЫЕ ВРАЧИ ИЗ БАШКИРСКОГО НАРОДА:

- 1) Р. Хамитов
- 2) А. Субханкулов
- 3) М.Шарипов
- 4) Г.Куватов

6. ЧЕМ ЧИСТИЛИ И ОТБЕЛИВАЛИ ЗУБЫ БАШКИРЫ ПО ДАННЫМ
ЭКСПЕДИЦИИ АКАДЕМИКА ПЕТЕРБУРГСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
И.И. ЛЕПЕХИНА (1772 Г.):

- 1) зубной порошок
- 2) лиственная сера
- 3) песок
- 4) торф
- 5) уголь

7. ГОД ОРГАНИЗАЦИИ УФИМСКОГО ОБЩЕСТВА ВРАЧЕЙ:

- 1) 1682 год
- 2) 1782 год
- 3) 1882 год
- 4) 1982 год

8. ОРГАНИЗАТОРЫ ГУБЕРНСКОГО ОБЩЕСТВА ВРАЧЕЙ:

- 1) Н.М. Нефтель
- 2) Н.А. Гурвич
- 3) В.П. Одинцов
- 4) А.И. Подбельский

9. В КАКОМ ГОДУ СОСТОЯЛСЯ ПЕРВЫЙ СЪЕЗД ЗЕМСКИХ ВРАЧЕЙ
УФИМСКОЙ ГУБЕРНИИ:

- 1) 1889 году
- 2) 1894 году
- 3) 1983 году
- 4) 1883 году

10. КТО ИЗ ИЗВЕСТНЫХ СТОМАТОЛОГОВ (ОРГАНИЗАТОР ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ В СССР) РАБОТАЛ В УФИМСКОЙ ЗЕМСКОЙ БОЛЬНИЦЕ И ПРЕПОДАВАЛ В УФИМСКОЙ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКОЙ ШКОЛЕ ДО ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ.

- 1) Воздвиженский
- 2) Гурвич Н.А.
- 3) Нагибин
- 4) Рауэр А.Э.
- 5) Подбельский А.И.

11. В КАКОМ ГОДУ ПРИЕХАЛ В УФУ ДАНТИСТ ИЗ РИГИ А.С. КАПИТОНОВ И ОТКРЫЛ ПЕРВЫЙ КАБИНЕТ ПО АДРЕСУ: УЛ. БОЛЬШАЯ КАЗАНСКАЯ, 4 (НЫНЕ УЛ. ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ):

- 1) 1896
- 2) 1897
- 3) 1898
- 4) 1899
- 5) 1900

12. ОРГАН ПЕЧАТИ САНИТАРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УФИМСКОЙ ГУБЕРНИИ:

- 1) Врачебно-санитарный журнал
- 2) врачебно-санитарная хроника
- 3) врачебно-санитарное обозрение
- 4) врачебно-санитарный вестник

13. В КАКОМ ГОДУ БЫЛ ОТКРЫТ В УФЕ КАБИНЕТ ВРАЧА М. МАРКУЗЕ И ЗУБНОГО ВРАЧА Д. МАРКУЗЕ:

- 1) 1900
- 2) 1901
- 3) 1902
- 4) 1903
- 5) 1904

14. В КАКОМ ГОДУ БЫЛА ОТКРЫТА В УФЕ ПЕРВАЯ ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА:

- 1) 1910
- 2) 1911
- 3) 1912
- 4) 1913
- 5) 1914

15. СКОЛЬКО СТОИЛО УДАЛЕНИЕ ЗУБА В УФИМСКОЙ ЗУБНОЙ ЛЕЧЕБНИЦЕ ДО ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ:

- 1) 30 копеек
- 2) 50 копеек
- 3) 1 рубль
- 4) 3 рубля
- 5) 5 рублей

16. СКОЛЬКО СТОИЛА УСТАНОВКА ИСКУССТВЕННОГО ЗУБА В УФИМСКОЙ ЗУБНОЙ ЛЕЧЕБНИЦЕ ДО ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ:

- 1) 50 копеек
- 2) 1 рубль
- 3) 3 рубля
- 4) 5 рублей
- 5) 10 рублей

17. В КАКОМ ГОДУ СОМАТИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА Г.УФЫ ПОЛУЧИЛА СТАТУС ГУБЕРНСКОЙ ЗЕМСКОЙ БОЛЬНИЦЫ:

- 1) 1776 году
- 2) 1836 году
- 3) 1876 году
- 4) 1976 году

18. ВРАЧИ УФИМСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ЗЕМСКОЙ БОЛЬНИЦЫ:

- 1) Ручинский
- 2) Нагибин
- 3) Ястрежемский
- 4) Соколов
- 5) Верно все

19. ГОД ОТКРЫТИЯ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ В Г.УФЕ.
СДЕЛАТЬ СООТВЕТСТВИЕ:

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| 1) глазная больница | А) 1912 году |
| 2) инфекционная больница | Б) 1910 году |
| 3) противотуберкулёзная больница | В) 1912 году |
| 4) роддом | Г) 1903 году |

20. ГОД ОТКРЫТИЯ ШКОЛЫ ФЕЛЬДШЕРОВ В Г.УФЕ:

- 1) 1913 год
- 2) 1803 год
- 3) 1903 год
- 4) 1933 год

21. УЧАСТНИК СЪЕЗДА ПИРОГОВСКОГО ОБЩЕСТВА ВРАЧЕЙ ПО
БОРЬБЕ С ХОЛЕРОЙ ОТ УФИМСКОГО ОБЩЕСТВА ВРАЧЕЙ:

- 1) В.П. Одинцов
- 2) В.Я. Галперов
- 3) Н.Н. Плаксин
- 4) Н.М. Нефтель

22. КОГДА ПРОИЗОШЛО ПЕРВОЕ СЕРЬЁЗНОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ
СТОЛКНОВЕНИЕ ОБЩЕСТВА ВРАЧЕЙ С ГУБЕРНАТОРОМ
УФИМСКОЙ ГУБЕРНИИ СОКОЛОВСКИМ:

- 1) 17 марта 1900 года
- 2) 17 марта 1917 года
- 3) 17 марта 1895 года
- 4) 17 марта 1905 года

23. «ГЛАЗНОЙ ДОКТОР» Г.УФЫ:

- 1) О.В. Аптекман
- 2) А.Ф. Федотов
- 3) И.М. Любимов
- 4) А.А. Абражанов

24. РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЩЕСТВА ВРАЧЕЙ УФИМСКОЙ ГУБЕРНИИ:

- 1) М.О. Куржанский
- 2) А.Ф. Федотов

3) И.М. Любимов

4) С.А. Каплан

25. РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ «БАШКИР-ПОМОЩИ»:

1) И.Н. Сухов

2) Артем (Ф.А. Сергеев)

3) А.Л. Нагибин

4) А.Г. Дауге

26. ПЕРВАЯ ЖЕНЩИНА ВРАЧ-БАШКИРКА:

1) З.И. Кудоярова

2) Ф.М. Кузяхметова

3) З.С. Терегулова

4) Р.А. Кутлубаева

27. ПЕРВЫЙ ЗАВЕДУЮЩИЙ УФИМСКОГО ГУБЗДРАВОТДЕЛА:

1) А.Е. Маневич

2) А.Л. Нагибин

3) И.Н. Сухов

4) Д.А. Воздвиженский

28. ДАТА СОЗДАНИЯ БАШКИРСКОЙ АССР

1) 1917 год

2) 1919 год

3) 1970 год

4) 1991 год

29. ДАТА СОЗДАНИЯ НАРКОМЗДРАВА БАШКИРСКОЙ АССР:

1) 1917 год

2) 1918 год

3) 1919 год

4) 1920 год

30. ПЕРВЫЙ НАРКОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БАШКИРСКОЙ АССР:

1) С.З. Лукманов

2) Б.А. Шафиев

3) Ш.А. Худайбердин

4) Г.Г. Куватов

31. В КАКОМ ГОДУ ЗУБНОЙ ВРАЧ Л.С. ГОЛЬДБЕРГ ОТКРЫЛ ЗУБОВРАЧЕБНУЮ АМБУЛАТОРИЮ В УФЕ НА УГЛУ УЛИЦ КИРОВА И ЛЕНИНА:

1) 1919

2) 1920

3) 1921

4) 1922

5) 1923

32. В КАКОМ ГОДУ БЫЛА ОТКРЫТА ЗУБОВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ В Г. СТЕРЛИТАМАКЕ:

1) 1920

2) 1921

3) 1922

4) 1923

5) 1924

33. В КАКОМ ГОДУ БЫЛА ОРГАНИЗОВАНА ЗУБОВРАЧЕБНАЯ ШКОЛА В УФЕ:

1) 1930

2) 1934

3) 1935

4) 1940

5) 1941

34. ГОДЫ ЖИЗНИ Ш.А. ХУДАЙБЕРДИНА:

1) 1886—1924 годы

2) 1876—1928 годы

3) 1893—1934 годы

4) 1905—1955 годы

35. ГОД ОТКРЫТИЯ БАШКИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА:

1) 1902 год

2) 1912 год

3) 1922 год

4) 1932 год

36. ПЕРВЫЙ ДИРЕКТОР (РЕКТОР) БАШКИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА:

1) Ф.Х. Камиров

2) Ю.А. Лоцманов

3) В.Г. Сахаутдинов

4) В.М. Тимербулатов

5) С.М. Трайнин

37. В КАКИЕ ГОДЫ А.И.ДОЛЬСКИЙ (БУДУЩИЙ ГЛАВНЫЙ СТОМАТОЛОГ СССР) БЫЛ ГЛАВНЫМ ВРАЧОМ УЧАСТКОВОЙ БОЛЬНИЦЫ В УЛУ-ТЕЛЯКЕ.

1) 1940—1941 годы

2) 1944—1945 годы

3) 1918—1919 годы

4) 1941—1942 годы

38. МЕДИКИ БАШКОРТОСТАНА, УДОСТОЕННЫЕ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА:

1) А.С. Давлетов

2) Г.А. Овчинников

3) Ф.Ф. Кургаев

4) П.А. Горошек

39. ГОДЫ ПРЕБЫВАНИЯ Н.А. СЕМАШКО В БГМИ:

1) 1940—1941 годы

2) 1944—1945 годы

3) 1918—1919 годы

4) 1941—1942 годы

40. ГОДЫ ПРЕБЫВАНИЯ В УФЕ ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ СТОМАТОЛОГИИ 1 ММИ ПРОФЕССОРА П.Г. ЛУКОМСКОГО

1) 1940—1941 годы

2) 1944—1945 годы

3) 1918—1919 годы

4) 1941—1943 годы

41. УЧЁНЫЕ, ЭВАКУИРОВАННЫЕ В БАШКИРСКУЮ АССР В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:

- 1) А.А. Богомолец
- 2) Н.А. Семашко
- 3) А.В. Палладин
- 4) П.И. Иванов

42. НАРКОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БАШКИРСКОЙ АССР В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:

- 1) Г.Н. Терегулов
- 2) И.И. Геллерман
- 3) С.З. Лукманов
- 4) Г.Х. Кудояров

43. СКОЛЬКО МЕДРАБОТНИКОВ ИЗ БАШКОРТОСТАНА БЫЛИ ПРИЗВАНЫ В РЯДЫ КРАСНОЙ АРМИИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:

- 1) 500
- 2) 1300
- 3) 5000
- 4) 2700

44. КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭВАКОГОСПИТАЛЕЙ БЫЛО РАЗВЕРНУТО В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НА ТЕРРИТОРИИ БАШКОРТОСТАНА:

- 1) 66
- 2) 33
- 3) 36
- 4) 63
- 5) 53

45. СКОЛЬКО РАНЕННЫХ И БОЛЬНЫХ БЫЛО ПРОЛЕЧЕНО В ЭВАКОГОСПИТАЛЯХ, РАЗВЕРНУТЫХ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НА ТЕРРИТОРИИ БАШКОРТОСТАНА:

- 1) 500 тысяч
- 2) 250 тысяч

3) 150 тысяч

4) 100 тысяч

46. ГОД ОТКРЫТИЯ ФАКУЛЬТЕТОВ БАШКИРСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
(ИНСТИТУТА). СДЕЛАТЬ СООТВЕТСТВИЕ:

- | | |
|---|--------------|
| 1) лечебный факультет | А) 1961 году |
| 2) педиатрический факультет | Б) 1976 году |
| 3) стоматологический факультет | В) 1932 году |
| 4) фармацевтический факультет | Г) 1992 году |
| 5) факультет высшего сестринского образования | Д) 1981 году |
| 6) медико-профилактический факультет | Е) 2006 году |
| 7) факультет социальной работы | Ж) 2000 году |
| 8) микробиологический факультет | З) 2007 году |

47. ГОД СОЗДАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ СЛУЖБ В БАШКОРТОСТАНЕ.
СДЕЛАТЬ СООТВЕТСТВИЕ:

- | | |
|--|--------------|
| 1) фтизиатрическая служба создана | А) 1945 году |
| 2) онкологическая служба – « - | Б) 1989 году |
| 3) дерматовенерологическая служба | В) 1921 году |
| 4) кардиологическая служба - « - | Г) 1981 году |
| 5) служба по профилактике ВИЧ-инфекции | Д) 1920 году |
| 6) санитарно-эпидемиологическая служба | Е) 1922 году |
| 7) службы профилактической медицины | Ж) 1935 году |
| 8) служба скорой медицинской помощи | З) 1941 году |

48. ГОД СОЗДАНИЯ УФИМСКИХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
ИНСТИТУТОВ. СДЕЛАТЬ СООТВЕТСТВИЕ:

- | | |
|---|--------------|
| 1) Уфимский НИИ глазных болезней | А) 1932 году |
| 2) Уфимский НИИ медицины труда
и экологии человека | Б) 1926 году |
| 3) Уфимский НИИ вакцин и сывороток
им. И.И. Мечникова «Иммунопрепарат» | В) 1955 году |

49. ПЕРВЫЙ ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ РАМН ИЗ БАШКОРТОСТАНА.

- А) Камилов Ф.Х.
Б) Лоцманов Ю.А.

В) Сахаутдинов В.Г.

Г) Тимербулатов В.М.

50. НАЗОВИТЕ ЧЛЕНОВ-КОРРЕСПОНДЕНТОВ АМН СССР,
УРОЖЕНЦЕВ УФИМСКОЙ ГУБЕРНИИ:

1) Шамов В.Н.

2) Яблоков Д.Д.

3) Смородинцев

4) Трайнин С.М.

5) Романкевич В.М.

6) Терегулов Г.Н.

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ

1.	1) А, Д, Е 2) Б, Ж, И 3) В, З, Л, Н 4) Б, Г, К, М	18.	5	35.	4
2.	2	19.	1 – Г 2 – Б 3 – А 4 – А	36.	5
3.	4	20.	3	37.	4
4.	2	21.	2	38.	2, 4
5.	2, 3	22.	4	39.	4
6.	2	23.	3	40.	4
7.	3	24.	1	41.	1, 2, 3
8.	4	25.	1	42.	3
9.	2	26.	2	43.	2
10.	4	27.	1	44.	5
11.	1	28.	2	45.	2
12.	1	29.	3	46.	1 – В; 2 – А; 3 – Б; 4 – Д; 5 – Г; 6 – Ж; 7 – З; 8 – Е.
13.	3	30.	4	47.	1 – В; 2 – А; 3 – Д; 4 – Г; 5 – Б; 6 – Е; 7 – В; 8 – Е.
14.	4	31.	1	48.	1 – Б; 2 – В; 3 – А.
15.	1	32.	2	49.	
16.	2	33.	2	50.	1, 2, 3
17.	3	34.			

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная:

1. Пашков К.А. Зубоврачевание и стоматология в России 1X-XX вв. Основные направления развития. М., 2009.
2. Научные работы врачей БАССР по стоматологии (Библиографический указатель 1932-1976 гг.)/ Под ред. доцента В.Ф. Татарина. Уфа, 1976, 24с.
3. Первая республиканская научно-практическая конференция стоматологов и зубных врачей Башкирской АССР (24-26 января 1961 года). Тезисы и доклады Уфа, 1961, 45 с.
4. Башкирская энциклопедия. В 7-томах. Т.1—7, 2005-2011 гг.
5. Башкирскому медицинскому институту 60 лет—Уфа.: Изд. БМИ, 1992, 242с.
6. Башкирскому государственному медицинскому университету 70 лет. Уфа, Изд-во СКИФ, 2002, 288с.
7. Башкирскому государственному медицинскому университету 80 лет. Уфа, БГМУ, 2012.

Дополнительная:

1. Кулагина А.А. Эвакогоспитали Башкирии в годы Великой Отечественной войны. Уфа, 1988, 126с.
2. Кулагина А.А. Развитие медицинской науки в Башкирской АССР. Уфа, 1989, 152с.
3. Лукманов С.З. Развитие здравоохранения Башкирской АССР. Уфа, 1958, 36с.
4. Магазов Р.Ш. 100 лет на страже здоровья. Уфа, 1976, 76с.

Шарафутдинова Назира Хамзиновна
Киньябулатов Азат Уранович
Павлова Марина Юрьевна

История стоматологии
Учебное пособие
для самостоятельной внеаудиторной
работы студентов

Лицензия № 0177 от 10.06.96 г.
Подписано к печати 18.11.2013 г.
Отпечатано на ризографе с готового оригинал-макета,
представленного авторами.
Формат 60х84 ¹/₁₆. Усл.-печ. л. 15,0.
Тираж 173 экз. Заказ № 15

450000, г. Уфа, ул. Ленина, 3,
Тел.: (347) 272-86-31
ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России